

Dr. Ryke Geerd Hamer

El testamento de una Nueva Medicina

Parte I

**Las 5 leyes biológicas de la naturaleza -
Fundamento de toda la medicina**

Los programas biológicos, sensatos, especiales de la naturaleza

**Psicosis
Síndrome
Cáncer en niños, embriones, animales, plantas
El surgimiento espontáneo de delitos**

+ Tabla de la Nueva Medicina:
"Psique – Cerebro – Órgano"
con registros

Agradecimientos

Mis agradecimientos son para todos los colaboradores, amigos, sponsors y ayudantes que han trabajado para que este libro pudiese ser publicado.

En particular quiero agradecer a los pacientes, que me han permitido hacer publico sus casos, a veces de manera anónima, a veces con fotografías o incluso con el nombre, de modo que su experiencia resultase útil a otros pacientes.

Mi agradecimiento a los vivos y mi respeto a los muertos, que están entre nosotros con su ayuda.

Este libro está dedicado, con respeto a los muertos y, con amor por la verdad, a los vivos.

A mi hijo DIRK, que a la edad de 19 años y mientras dormía fue alcanzado mortalmente por un príncipe italiano, que creía disparar sobre otra persona.

A causa de su muerte yo mismo enfermé de un DSH "DIRK-HAMER-SYNDROM" (Síndrome de Dirk Hamer), es decir, un conflicto de pérdida con cáncer de testículos.

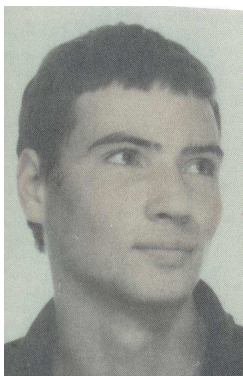
Esta extraña coincidencia de un shock conflictivo agudo y dramático y de una enfermedad tumoral me ha permitido llegar al conocimiento de la Nueva Medicina.

A mi querida esposa SIGRID, mi "sabia muchacha", que ha sido el primer médico en el mundo que ha reconocido la validez de la Nueva Medicina.

A mis pacientes difuntos, que se me hicieron queridos como hijos, pero que fueron atormentados y con ello obligados con fuertes presiones a retornar a los tratamientos de los médicos dominantes y que bajo los efectos de la morfina murieron de un modo miserable.

A los vivos que han tenido la suerte o el coraje de sustraerse de esas presiones de la llamada medicina oficial y que gracias a ello han recuperado la salud.

Que este libro sea uno de los que más felicidad dé a todos aquellos de buena voluntad y animo sincero que lo lean.



Dirk Geerd Hamer

Nacido el 11 de marzo de 1959 en Marburg,
herido mortalmente el 18 de agosto de 1978 en la isla de Cavallo, en Córcega,
muerto el 7 de diciembre de 1978 en Heidelberg,
enterrado bajo los muros de la ciudad junto a la Pirámide en Roma.

Dirk, hijo mío,

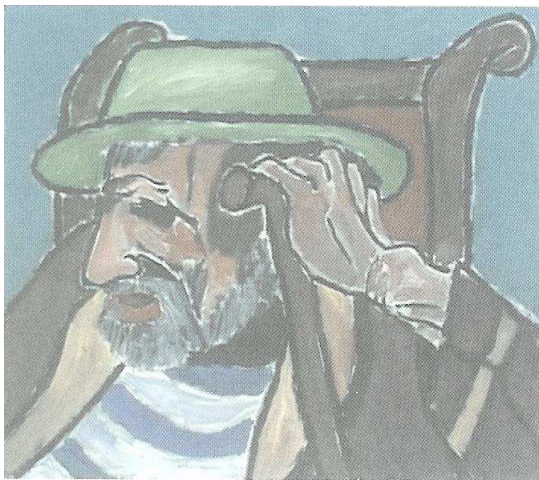
¡Hace dos años, un día como hoy, fue el mas negro de mi vida, la hora más difícil de mi vida! Mi amado hijo Dirk murió entre mis brazos. Nada, ni antes ni después, ha sido tan terrible, tan indescriptiblemente destructivo como ese momento. Pensé que quizás aquel sentimiento de impotencia, de abandono, de tristeza infinita se desvanecería lentamente, pero por el contrario cada vez es mas fuerte. No puedo seguir siendo la persona que fui. Pobre hijo mío, lo que has tenido que soportar, lo que has tenido que sufrir, y sin quejarte jamás. Que no habría dado por haber muerto yo en tu lugar. Cada noche vuelves a morir entre mis brazos, 730 noches que has vuelto a morir a mi lado y yo no quería dejarte ir, pero la atroz fatalidad te llevaba siempre. Cada vez me quedaba impotente hasta el final, gritando como hace dos años, gritando sin poderme contener y desconcertado, como en aquel momento, entre los pacientes graves y los médicos y enfermeras apáticos, brutales y crueles, que solo me dejaron estar a tu lado cuanto estabas muriendo.

Tú, chico maravilloso, has muerto como un rey, orgulloso, grande y aun así tan tierno, a pesar de todos los tormentos, de todos los tubos en las venas y arterias; a pesar de la intubación y del terrible decubito. Rechazaste la bajeza y la maldad de tus torturadores tan solo moviendo la cabeza: "Papá, son malos, muy malos". En los últimos días me hablabas solamente con los ojos, pero yo comprendí cada una de tus palabras.

¿Has entendido tú también todo aquello que te dije al final, que tu padre y tu madre te amarán infinitamente que siempre estarás presente haciendo todo junto a nosotros? ¿Y que ahora deberás ser muy fuerte y tener un sueño larguísimo? Asentiste y yo estoy seguro de que lo has comprendiste todo, a pesar de tu lucha contra la muerte.

Solo una vez, cuando ya habías cerrado los ojos y mis lágrimas caían en tu cara y oyéndome llorar, has movido un poco la cabeza contrariado. Querías decirme: “Papá, no tienes porque llorar, siempre estaremos juntos”.

No me avergüenzo delante de nadie, hijo mío. Lloro tan a menudo, cuando nadie me ve. No te lo tomes a mal. Sé que no has visto jamás llorar a tu padre. Pero ahora soy también tu alumno y estoy tristemente orgulloso de ti por la dignidad con la que nos has precedido a través de la gran puerta de la muerte. Pero ni siquiera ese orgullo puede calmar mi desesperación cuando cada noche vuelves a morir entre mis brazos y me dejas sumido en la desesperación.



Este dibujo lo pintó mi hijo a la edad de dieciocho años en Roma. Es un tipo particular de “Autorretrato” en el que se pintó con ochenta años, un año antes de su muerte.

Primero mi Dirk me enseñó a comprender el contexto global del cáncer; después, lentamente he abarcado la medicina entera.



Mi amadísima esposa, la doctora Sigrid HAMER, médico y compañera leal durante casi 30 años. Supo vencer cinco enfermedades tumorales, todas surgidas –mas o menos- a consecuencia del sufrimiento por su amado hijo Dirk. Murió el 12-4-85 entre mis brazos a causa de un infarto cardiaco agudo.

Prologo a la segunda edición hasta la séptima

Estimado lector:

Este libro “El legado de la nueva medicina” se ha convertido en la base para una nueva comprensión global de la Medicina. Lo que tan solo me había atrevido esperar en mis sueños más audaces ha ocurrido de verdad: Los lectores han comprendido que con esto se ha dado un giro de proporciones inimaginables en el pasado en la historia de la medicina.

Si bien el libro “El cáncer – Enfermedad del alma” de 1984 representó el primer estadio de esta forma de pensar, en el presente libro se han ido plasmando durante este tiempo los fundamentos que se pueden comprender y realizar en la práctica, ofreciendo así una nueva dimensión. En particular La Nueva Medicina ha hecho comprensible el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades onco-equivalentes de un modo extraordinariamente simple y sobretodo comprobable, de tal manera que se pueda utilizar realmente.

Las reacciones y las cartas de los lectores con respecto a este libro han sido no solo positivas, sino también entusiastas. Eso me ha compensado ampliamente por todos los sacrificios y fatigas. Los casi 20.000 volúmenes distribuidos hasta ahora entre los lectores se han propagado como el fuego en todo el mundo, tanto en alemán como en la traducción francesa “Fondements d’une Médecine Nouvelle”.

No se puede parar La Nueva Medicina, ni tampoco el nuevo modo de pensar que conlleva.

La peor forma de esclavitud del hombre, es decir el total alienamiento de si mismo, tendrá por fin un final. La angustia que nace de la perdida completa de la fe natural en uno mismo y en el propio cuerpo, de la capacidad instintiva para escuchar la voz del propio organismo, será abatida.

Con la comprensión de los nexos existentes entre psique y cuerpo, el paciente abarca también el mecanismo del pánico, de los miedos irracionales frente a procesos considerados inevitables por los pronósticos, que justamente por eso se convierten en inevitables y letales, por cuanto el paciente se los cree porque tiene miedo. De esta manera se pondrá fin también al pleno poder de los médicos, crecido sin medida debido a esta angustia por un “mecanismo tumoral autodestructivo”, por la “crecida ilimitada de las metástasis destructivas”, etc...

Los médicos deberán devolver a los pacientes la responsabilidad, de la cual realmente ellos ni se han hecho, ni han podido hacerse cargo.

Este libro puede significar la verdadera libertad para aquellos que realmente lo comprendan.

La experiencia más maravillosa para mi fue el hecho de ver que los pacientes, con el libro de la NUEVA MEDICINA en la mano, están en la situación de salvarse por sí solos. Leen el libro, lo comprenden, van con calma y tranquilidad a su doctor o catedrático, y le ponen el libro encima de la mesa diciéndole que quieren ser tratados únicamente con este método. Ningún catedrático en este mundo puede decir nada en contra, y ninguno ha podido hasta ahora argumentar nada en contra. Los histopatólogos, que hasta ahora eran los “dioses del destino” en medicina, son los que debían decidir si un tejido era canceroso o no. En la

confrontación con el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades onco-equivalentes deberán sin embargo desmentirse y darse por vencidos si su diagnóstico no se comprueba. Ahora se establecen unos criterios nuevos por completo y sobretodo demostrables. Además la diagnosis histológica y los presuntos pronósticos que circulaban en el pasado ("le queda tanto de vida y de tal manera; tiene tantas probabilidades de sobrevivir") ya no producen miedo, porque el paciente sabe que eso es lo que puede programar su pronóstico.

El paciente se ha emancipado y no mira mas como un conejillo asustado al medico jefe, de cuya boca esperaba oír tembloroso el pronóstico mortal (lo cual le causaba siempre el sucesivo conflicto con una llamada "metástasis"); el paciente está hoy día de frente al médico como un igual. El paciente puede incluso comprender la Nueva Medicina tan bien como el médico, mientras que entre los dos no estaban en situación de comprender el caos precedente de la vieja medicina, con todas sus excepciones inexplicables y sus hipótesis gratuitas. Los médicos se han comportado como si pudieran entender este absurdo o como si lo hubiesen entendido ya.

Por último un caso real, verificado en Bremen hace algún tiempo y que me ha marcado profundamente: una muchacha joven, de la que se había dicho en la clínica que estaba "llena de metástasis" y que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir, recibe a escondidas de una buena amiga este libro. Para poder leerlo en paz se va al bosque, se acomoda en un lugar tranquilo junto a unos árboles y... lee. Como había sido una secretaria maravillosa hasta aquel momento pudo leer muy rápido y con concentración durante horas. No sintió ni hambre ni cansancio; leyó febrilmente durante 6 horas, según ella dice. "Después" cuenta "se me abrieron los ojos. Comprendí con un alegre susto lo que significaba este libro. Salté tan alto como pude del tronco donde estaba sentada y le grité al bosque: ¡Ahora sé que puedo seguir viviendo"!.

No se equivocó. Ahora está bien y desde hace tiempo fuera de peligro.

Aunque este libro hubiese ayudado sólo a esta joven muchacha, una única persona, a sobrevivir, habría valido la pena escribirlo.

Vuestro Dr. Ryke Geerd Hamer

Prólogo a la séptima edición

Tras la aparición hace diez años de la primera edición de la obra “Fundamentos de una Nueva Medicina, vol. I”, se ha hecho necesaria de un modo urgente una mayor reelaboración.

Cuando miro hacia atrás pienso que con la primera edición de 1987 se dio un gran paso.

Las 4 leyes biológicas naturales, descubiertas entonces, se han revelado como completamente acertadas, aunque la cuarta ley biológica (sistema ontogenético de los microbios) no pueda ser verificada en muchos casos patológicos, ya que no presentan resultados bacteriológicos. Así, por ejemplo, se cree que la tuberculosis esté completamente erradicada, renunciándose por lo tanto en 9 de cada 10 casos a controlar correctamente los así llamados “bastoncillos acidorresistentes”. Sobre todo la medicina clásica oficial, como era previsible, tiene dificultades notables para entender la Nueva Medicina. Los conceptos “benigno” y “maligno” están tan profundamente arraigados que han impedido de un modo semireligioso avanzar en casi todos los campos de la ciencia.

De esta manera los que una vez fueron mis colegas simplemente no pueden o no quieren entender que, por ejemplo, un cáncer controlado del paleoencéfalo y una tuberculosis con la típica sudoración nocturna y temperaturas subfebriles pueden pertenecer al mismo programa especial (lo que anteriormente he denominado todavía como enfermedad), sólo que el cáncer es la fase conflictiva activa y la TBC la fase de curación.

En 1994 se añadió una quinta ley biológica a las cuatro de 1987, la considerada Quintaesencia:

“La ley de la comprensión desde el punto de vista evolutivo de cualquier enfermedad como una parte de un Programa Especial, Biológico y Sensato de la naturaleza (EBS)”.

Es obvio que esta quinta ley biológica ya estaba contenida implícitamente en la primera edición, ya que toda la Nueva Medicina se basa en el principio de esta comprensión. Sin embargo no había estado todavía definida con claridad. Con esta quintaesencia la Nueva Medicina se completa prácticamente de un modo lógico y coherente.

Con la quinta ley se supera mi opinión precedente. En el momento del descubrimiento de la ley férrea del cáncer y de la ley de las dos fases de las denominadas enfermedades (en la solución del conflicto), pensaba todavía que la DHS, el shock biológico conflictivo inicial, fuese un “cortocircuito” en el cerebro. Ya que por “cortocircuito” se entiende todavía una “avería”, un “fallo” del organismo, una degeneración maligna de la naturaleza no sensible. Pero todo eso no cuadraba. Por suerte no había metido estos embrollos inútiles en las dos primeras leyes biológicas, sino que las había formulado de un modo puramente científico.

Este modo de actuar ha dado sus frutos, ya que no he tenido necesidad de modificar ni la tercera ni la cuarta ley biológica. Podemos así llamar a estas leyes las cinco leyes biológicas de la naturaleza. Así pues este libro se completa solamente mediante la quintaesencia de la quinta ley biológica de la naturaleza.

Ahora tenemos un sistema científico preciso de 5 leyes naturales, sin hipótesis alguna.

A esto se opone la medicina clásica oficial, que juega el papel de “medicina de estado”, y se autodefine como “reconocida”, y por eso pretende reprimir los conocimientos de la Nueva Medicina desde hace 17 años con un desprecio casi inimaginable por la humanidad.

El “error reconocido” en el que persiste la “medicina de estado” solo puede apoyarse en algunos miles de hipótesis, pero jamás en ninguna ley biológica. Por lo tanto con la “medicina reconocida” no se ha podido verificar jamás nada científicamente en ningún caso patológico.

En la Nueva Medicina por el contrario, cada uno de los casos debe ser reproducible según las cinco leyes biológicas.

Los procesos patológicos, ahora ya reconocibles y comprensibles para el paciente y para el médico, le quitan al paciente todo el pánico. Hemos redescubierto al mismo tiempo la medicina originaria. Por esta razón en España se la denomina con cariño “medicina sagrada”.

Colonia, 24-12-95

Anexo al prólogo de la séptima edición,

escrita en la prisión Colonia-Ossendorf (“Klingelpuetz”) el 18 de agosto de 1997.

Estimado lector:

Hace hoy diecinueve años que mi hijo DIRK, mientras dormía en una barca, fue herido mortalmente, al alba, por la carabina de guerra de su asesino. Murió el 7 de diciembre de 1978.

Por desgracia pasaron dos años durante los cuales no fue posible imprimir este libro. Tras el caso de la pequeña Olivia Pilhar de Austria se llevó a cabo contra nuestra casa editorial y contra mi persona un increíble terrorismo por medio de graves calumnias y de los medios. Este terrorismo casi ha destruido nuestra casa editorial, pero al final no lo ha conseguido. (No quisiera detenerme aquí a hablar nuevamente del caso de Olivia e invito a todos los interesados a leer el libro escrito por su padre “Olivia – Diario de un destino”).

En este punto quisiera dar las gracias de un modo especial a algunos buenos amigos sin los cuales no lo habríamos logrado jamás.

Desde hace tres meses me encuentro en la prisión de Colonia, en la cárcel llamada “Klingelpuetz”. Y estoy orgulloso de tener, o poder estar en la cárcel por todos los pacientes, por todos aquellos que se han puesto, o se pondrán, de parte de la Nueva Medicina y por la verdad científica. Desde que pudimos ver los sumarios de la comisión ha sido posible ver con que desprecio por la humanidad y con que energía criminal nuestros adversarios han ido a por mí y a por la Nueva Medicina. Oficialmente estoy acusado de haber hablado gratuitamente de la Nueva Medicina con tres personas. Para preparar una condena, la prensa tenía que presentar el caso en tono dramático y con profundo odio: “Curandero de

Colonia – 40 muertos ya” y “Dr. Hamer: la lista de los muertos se hace cada vez mas larga”. Tras la lectura de los periódicos no sorprendería que muchos de los presos de la cárcel de Colonia hubieran querido saltarme al cuello.

No se puede hablar en absoluto de una verificación pública, honesta y científica de la Nueva Medicina. Con la ayuda de la justicia se me quiere obligar de hecho a no hablar mas sobre medicina, a no impartir ningún seminario mas, a no escribir ningún libro más. Según el Prof. Dr. Hanno Beck, catedrático de la materia “Historia de las ciencias” en Bonn, es “desde hace mucho tiempo la peor represión del conocimiento que haya visto jamás”.

Pensemos cuanto sufrimiento podría ser evitado preventivamente si el conocimiento de las 5 leyes biológicas no fuese negado sistemáticamente a la población. ¡Esta situación se transforma en el delito más grande de la historia de la humanidad!

Sé que estoy en prisión, condenado el 9-9-1997 a 19 meses de reclusión, por haber divulgado la verdad científica por todas las personas a las que todavía puede ser de ayuda la Nueva Medicina. Lo aguanto sin protestar, por haber, literalmente, “hablado tres veces con un paciente de Nueva Medicina, gratis”. De lo cual se desprende que por tres veces se trate de una consulta, tres tratamientos.

El juez que me debía juzgar en este proceso-farsa, rehusó en el último momento escuchar el testimonio de diez médicos y diez pacientes de la Nueva Medicina que en un principio si había aceptado. La sentencia ya estaba dictada a priori.

Vuestro Dr. Med. Ryke Geerd Hamer

ÍNDICE

1. Presentación

2. Las enfermedades (ahora comprendidas como programas especiales, biológicos y sensatos) del hombre, los animales y las plantas como un suceso de tres niveles.

2.1. ¿Qué significa la sincronía del desarrollo a tres niveles?

3. Introducción a la Nueva Medicina.

4. La sustancia de la Nueva Medicina. Definición respecto a la denominada “medicina académica”.

5. LA LEY FÉRREA DEL CÁNCER. LA PRIMERA LEY BIOLÓGICA DE LA NUEVA MEDICINA

5.1. El primer criterio de la ley férrea del cáncer

5.1.1. Definición del concepto de “conflicto” en la ley férrea del cáncer.

5.1.2. El síndrome de Dirk Hamer (DHS)

5.2. El segundo criterio de la LEY FÉRREA DEL CÁNCER.

5.3. El tercer criterio de la LEY FÉRREA DEL CÁNCER.

6. El sistema codificado del cerebro. El fundamento de los conflictos biológicos.

6.1. La evolución de los procesos biológicos del cáncer en comparados en el hombre y en el animal.

6.2. Comparación del conflicto biológico en el hombre y los animales

7. La ley de las dos fases de los programas especiales biológicos sensatos (en el pasado llamados enfermedades) en la solución del conflicto. La segunda ley biológica de la Nueva Medicina.

7.1. Fase simpaticotónica de conflicto activo – evolución del conflicto

7.2. Conflictolisis, solución del conflicto biológico.

7.3. La crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación explicada con el ejemplo del infarto cardíaco.

7.4. ¿Qué significa solución “biológica” de un conflicto?

7.4.1. Ejemplo: solución de conflicto biológico mediante carcinoma intersticial del testículo

8. La crisis epiléptica como pasaje normal en la fase de curación.

8.1. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide.

8.2. La naturaleza de la crisis epileptoide

8.2.1. Ejemplo: tren directo París-Colonia, 06/10/1984, salida a las 7:37

8.2.2. Ejemplo: el oficial ordenanza y el cadete.

8.2.3. Ejemplo: epilepsia desde los ocho años

8.2.4. Ejemplo: aventura amorosa en turco: la amante

8.2.5. Ejemplo: pura catástrofe.

8.2.6. Ejemplo: lucha hasta la última gota de sangre

8.2.7. Ejemplo: la muerte del venerado director de orquesta

8.2.8. Ejemplo: los cuatro espíritus malos

8.2.9. Ejemplo: los tocamientos prohibidos.

8.2.10. Ejemplo: Papa Noel.

8.3. Las crisis epilépticas y epileptoides más importantes

8.3.1. Ataques de hemicrania

8.3.2. Las crisis epilépticas (ataques epilépticos) del centro cortical motor.

8.3.2.1. Asma bronquial

8.3.2.2. El infarto de miocardio

8.3.3. Las crisis epilépticas del centro cortical sensorial (epitelio pavimentoso de la mucosa y de la piel) y postsensorial (periostio).

8.3.3.1. Desmayos en caso de neurodermatitis y soriasis.

8.3.3.2. Desmayo cuando está afectado el periostio

8.3.3.3. El desmayo en el infarto cardíaco izquierdo con úlcera del íntima coronario, bradicardia ventricular y arritmia.

8.3.3.4. Epilepsia por la úlcera del íntima de las venas coronarias con embolia pulmonar (infarto cardíaco derecho) con úlcera del cuello del útero al mismo tiempo.

8.3.3.5. La crisis epileptoide de la úlcera de las vías biliares con desmayo durante la hepatitis, lo que hasta ahora se había denominado "coma hepático".

8.3.3.6. La crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial con desmayo en "bronquitis", atelectasia bronquial o pulmonía.

8.3.3.7. La crisis epileptoide del denominado "glaucoma" (ofuscamiento del cuerpo vítreo del ojo)

8.4. El orgasmo

8.4.2. El orgasmo bilateral

8.4.3. La denominada "borrachera amorosa"

8.4.4. El orgasmo unilateral (a nivel cerebral)

8.4.1. El orgasmo unilateral

8.4.5. La frecuencia del orgasmo

8.4.6. ¿Qué relés del cerebro reaccionan como Focos de Hamer con el orgasmo unilateral o simple?

8.4.7. El denominado "saltar" de un conflicto y también del tipo de orgasmo de un hemisferio al hemisferio opuesto, en el caso de un conflicto activo en suspensión precedente o modificación de la situación hormonal. La impotencia.

8.4.8. Sexualidad en la denominada "constelación esquizofrénica"

9. Ritmo vegetativo: simpaticotonía – vagotonía

- 9.1. El sistema nervioso vegetativo: la central computerizada de los sucesos rítmicos biológicos de nuestro cuerpo.
- 9.2. Parasimpaticotonía o vagotonía y simpaticotonía
- 9.3. El sistema nervioso parasimpático
- 9.4. El sistema nervioso simpático

10. El descubrimiento de los FOCOS DE HAMER – un compendio histórico

- 10.1. Los presuntos artefactos en forma de anillo en la tomografía cerebral computerizada erróneamente interpretados por los radiólogos durante casi 20 años.
- 10.2. El cerebro central y el cerebro del órgano
- 10.3. El Foco de Hamer en la fase CA y en la fase PCL
- 10.4. Esquema del cerebro
 - 10.4.1 Nuestras tomografías cerebrales
- 10.5. El descubrimiento del primer Foco de Hamer
- 10.6. Ejemplo
 - 10.6.1. Ejemplo: un trabajador italiano emigrante.
 - 10.6.2. Ejemplo: la mujer de sesenta años de un rector universitario
 - 10.6.3. Ejemplo: paciente de cincuenta años tras la menopausia
 - 10.6.4. Ejemplo: FH activo con configuración concéntrica en el tronco cerebral
 - 10.6.5. Ejemplo: paciente diestro con conflicto de pérdida
 - 10.6.6. Ejemplo: zurda con parálisis parcial a la izquierda
 - 10.6.7. Ejemplo: una paciente con conflicto de miedo-asco
 - 10.6.8. Ejemplo: adenocarcinoma ductal de la mama
 - 10.6.9. Ejemplo: un empleado de banca londinense
 - 10.6.10. Ejemplo: conflicto de separación brutal
 - 10.6.11. En las dos fotografías siguientes vemos...
 - 10.6.12. Ejemplo: niña de cinco años con conflicto de miedo a morir de hambre
 - 10.6.13. Ejemplo: TBC y cáncer de mama
 - 10.6.14. Ejemplo: cáncer de mama adenoideo a la izquierda
 - 10.6.15. Ejemplo: muchachito francés
 - 10.6.16 Tres ejemplos de leucemia
 - 10.6.17. Un ejemplo de desprendimiento de la retina por un conflicto de miedo en la nuca
 - 10.6.18. Ejemplo de reparación de FH fuertemente gliomatosa
 - 10.6.19. Ejemplo: abusada por su padre a los 5 años
 - 10.6.20. Ejemplo: los corazones negros
 - 10.6.21. Ejemplo: abuso sexual por parte del padrino
- 10.7. El conflicto sexual femenino en la TAC cerebral.
- 10.8. El conflicto de territorio masculino en la TAC
 - 10.8.1. Ejemplo de una denominada constelación esquizofrénica en la TAC; aquí en presencia de una combinación de conflicto sexual y de territorio
- 10.9. Configuraciones concéntricas en el hígado

- 10.9.1. Conflicto de morir de hambre porque las cocineras se van
- 10.10. ¡Ninguna operación en el cerebro! Dos casos casi idénticos en comparación
- 10.11. Histología de los Focos de Hamer
 - 10.11.1. El denominado “tumor cerebral” (en realidad un Foco de Hamer)
 - 10.11.2. El denominado “ataque cerebral” (apopléjico)
 - 10.11.3. El Foco de Hamer en la fase de reparación
 - 10.11.4. Laceración del Foco de Hamer a causa del edema intrafocal
- 10.12. Una palabra para la técnica fotográfica: TAC cerebral o RM (resonancia magnética)
- 10.13. Intervenciones quirúrgicas e irradiaciones del cerebro
- 10.14. De la entrevista del Dr. Hammer con el Prof. Dr. P. Pfitzer, catedrático de patología y citopatología, decano de la facultad de medicina de la Universidad de Düsseldorf

11. El significado de ser zurdo o diestro

- 11.1 Zurdismo y dextrismo – el test del aplauso
- 11.2. La lactancia a la izquierda y a la derecha
- 11.3. Significado del zurdismo para el diagnóstico clínico
- 11.4. Los dos hemisferios de la corteza cerebral: zona del territorio izquierda = femenina, zona del territorio derecha = masculina

12. La recaída conflictiva

13. La vía conflictiva

- 13.1. Ejemplo: alergia al heno
- 13.2. ejemplo: vuelo Senegal-Bruselas
- 13.3. Ejemplo: dormido al volante
- 13.4. Ejemplo: el gato atropellado
- 13.5. Ejemplo: el bóxer en el furgón
- 13.6. Ejemplo: un atasco tras otro
- 13.7 Ejemplo: alergia a las nueces

14. El conflicto en suspenso o el conflicto en equilibrio

- 14.1. Ejemplo: las consecuencias del primer cigarro.

15. El círculo vicioso

- 15.1. Ejemplo: “metástasis” incluso en el dedo meñique
- 15.2. Ejemplo: círculo vicioso a causa del conflicto de miedo por el corazón con mesotelioma pericárdico.
- 15.3. Ejemplo: ascitis o hidropisia (fase de reparación después de un mesotelioma del peritoneo)
- 15.4. Ejemplo: círculo vicioso en los quistes de los arcos branquiales

16. El sistema ontogenético de los programas especiales de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. La tercera ley biológica de la Nueva Medicina.

- 16.1. La clasificación de los tumores
- 16.2. "Mesodermo del cerebelo" y "ectodermo del neoencéfalo"
- 16.3. El mesodermo del cerebelo
- 16.4. El ectodermo del neoencéfalo
- 16.5. Úlcera del estómago y del duodeno
- 16.6. Las enfermedades oncoequivalentes (ahora "programas especiales biológicos y sensatos oncoequivalentes")
- 16.7 Por qué no puede existir la metástasis

17. El sistema de los microbios condicionado ontogenéticamente. La cuarta ley biológica de la Nueva Medicina

18. El estadio avanzado y final de la fase de reparación del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes

- 18.1. a. El estadio final del programa especial, biológico y sensato de un cáncer con desarrollo biológicamente "normal".
 - 18.1.1. a) El programa especial, biológico y sensato del grupo directo del paleoencéfalo (tronco cerebral y cerebelo)
 - 18.1.2. b) El "estadio final" de los procesos directos del neoencéfalo.
 - 18.1.2.1. La úlcera reconstruida mediante reparación (por ejemplo callo) llamada "carcinoma" o "sarcoma" por la medicina oficial.
 - 18.1.2.2. El carcinoma cicatrizado o calcificado.
 - 18.1.3. c) Conflicto "reducido", en suspenso
- 18.2. El estadio final en el cáncer (o mejor EBS) con desarrollo no biológico

19. La ley del conocimiento de cada "enfermedad" como parte de un programa especial biológico sensato de la naturaleza comprensible bajo el perfil evolutivo – La quinta ley biológica de la Nueva Medicina (la quinta esencia)

- 19.1. El principio de la enfermedad cancerosa
- 19.2. La activación de un programa especial a través de un DHS – El inicio de la fase simpaticotónica.
- 19.3. La cuestión fundamental

20. La terapia del "programa especial biológico del cáncer"

- 20.1. El médico de la Nueva Medicina
- 20.2. Nivel psíquico: terapia práctico-psíquica con buen juicio
 - 20.2.1. Anamnesis del conflicto – Individualización del DHS
 - 20.2.2. Previsión de la evolución del conflicto a partir del DHS
- 20.3. El nivel cerebral: observaciones del desarrollo y la terapia de las complicaciones cerebrales

- 20.3.1. Orientación de la terapia: el código de nuestro cerebro.
- 20.4. El nivel orgánico: terapia de las complicaciones orgánicas
- 20.4.1. El paciente, libre de decidir respecto a todas las intervenciones en su cuerpo
- 20.4.2. Alternativas para una extirpación natural del cáncer
- 20.4.3. Unas palabras sobre las irradiaciones
- 20.4.4. Agoaspiraciones y biopsias
- 20.4.5. Un comentario sobre las intervenciones quirúrgicas
- 20.4.6. Reglas generales de comportamiento
- 20.4.7. Fármacos durante la terapia
- 20.4.7.1. Los dos grupos de fármacos
- 20.4.7.2. Unas palabras sobre la penicilina
- 20.4.7.3. Dosis aconsejado para el prednisolón
- 20.4.7.4. Unas palabras sobre la quimio pseudoterapia citostática
- 20.4.7.5. Recomendaciones en caso de recaída conflictiva o nuevo DHS
- 20.4.7.6. Eliminación de la cortisona, eventualmente con ayuda de ACTH
- 20.4.7.7. La crisis epileptoide –epiléptica
- 20.4.7.8. Unas palabras sobre los dolores y los analgésicos que contienen morfina
- 20.5. Resumen
- 20.6. El hospital ideal
- 20.7. Un ejemplo (Documentación de Celle)

21. LA LEUCEMIA – LA FASE DE REPARACIÓN TRAS EL CÁNCER DE HUESOS

- 21.1. Introducción
- 21.1.1. ¿Cómo se produce la hematopoyesis?
- 21.1.2. ¿Qué es la leucemia para la Nueva Medicina?
- 21.1.3. ¿Qué prevé todo el programa especial, biológico y sensato?
- 21.1.3.1. ¿Qué síntomas vemos en la fase de conflicto activo?
- 21.1.3.2. ¿Qué síntomas vemos en la fase de conflicto resuelto?
- 21.2. La leucemia aguda y crónica
- 21.2.1. La regla de la leucemia.
- 21.3 La leucemia según la medicina oficial
- 21.3.1. Contra el caos de los dogmas de la medicina oficial
- 21.4. Los distintos estadios evolutivos de la desvaloración de sí.
- 21.5. La frecuente presencia de la leucemia como síntoma añadido de la reparación de descalcificación del cuello del fémur, de la pierna y de la columna vertebral. Osteosarcoma.
- 21.5.1. Fractura del cuello del fémur – Necrosis de la cabeza del fémur – Reumatismo articular agudo.
- 21.5.1.1. Fractura del cuello del fémur
- 21.5.1.2. Callo
- 21.5.1.3. Necrosis de la cabeza del fémur – Reumatismo articular (agudo) de la cabeza del fémur
- 21.5.1.4. Reumatismo articular agudo.

- 21.5.1.5. El deporte agonístico y las descalcificaciones óseas (osteólisis = cáncer de los huesos), osteosarcomas y leucemia.
- 21.5.2. Las alteraciones esqueléticas de origen no traumático.
- 21.5.2.1. Esquema de la formación de la escoliosis
- 21.5.3. Los osteosarcomas.
- 21.5.3.1. Sentido biológico del osteosarcoma
- 21.6. La terapia de la leucemia
- 21.6.1. La terapia de la fase preleucémica de conflicto activo.
- 21.6.2. Terapia de la fase leucémica postconflictiva (segunda parte del programa EBS).
- 21.6.2.1. Primer estadio
- 21.6.2.1.1. Complicaciones del primer estadio de reparación y de terapia.
- 21.6.2.1.2. Anemia
- 21.6.2.2. Segundo estadio: todavía anemia y trombopenia pero ya presencia de leucocitos o leucemia
- 21.6.2.2.1. Complicaciones psíquicas.
- 21.6.2.2.2. Complicaciones cerebrales
- 21.6.2.2.3. Complicaciones orgánicas
- 21.6.2.2.3.1. Posibilidad de complicación a): anemia y trombopenia.
- 21.6.2.2.3.2. Posibilidad de complicación b): fractura ósea espontánea.
- 21.6.2.2.3.3. Posibilidad de complicación c): edema cerebral en la médula del neoencéfalo.
- 21.6.2.3. Tercer estadio: inicio de la difusión de los eritrocitos en la periferia, unas 4-6 semanas después del inicio de la invasión de los leucoblastos.
- 21.6.2.3.1. A nivel psíquico
- 21.6.2.3.2. A nivel cerebral.
- 21.6.2.3.3. A nivel orgánico
- 21.6.2.4. Cuarto estadio.
- 21.6.2.4.1. A nivel psíquico.
- 21.6.2.4.2. A nivel cerebral.
- 21.6.2.4.3. A nivel orgánico
- 21.6.2.5. Quinto estadio: regreso a la normalización.
- 21.7. El conflicto de hemorragia o de herida – Necrosis del bazo, trombocitopenia.
- 21.8. Advertencias preliminares para los casos de leucemia.
- 21.8.1. A nivel psíquico.
- 21.8.2. A nivel cerebral.
- 21.8.3. A nivel orgánico.
- 21.9. Ejemplos
- 21.9.1. Un grave accidente de tráfico y sus consecuencias
- 21.9.2. Desvaloración global de sí mismo por la muerte de la mujer
- 21.9.3. Leucemia linfoblástica aguda a continuación del abandono por parte del novio.
- 21.9.4. Desvaloración de sí en la relación con la hermana que le dice “eres un monstruo”.
- 21.9.5. Desvaloración de sí a causa de un “golpe bajo”
- 21.9.6. Desvaloración de sí a causa del despido de la mujer de la misma empresa y traslado a un nuevo ordenador.

- 21.9.7. Desvaloración de sí porque el paciente creía que se había vuelto “chatarra”
- 21.9.8. El procurador sustituto: desvaloración de sí padre/hija
- 21.9.9. Leucemia linfoblástica aguda a causa de una desvaloración de sí por un “cinco” en música
- 21.9.10. Desvaloración de sí con plasmocitoma a causa de la quiebra del negocio de la hija predilecta
- 21.9.11. Osteocondritis deformante juvenil
- 21.9.12. Leucemia aleucémica, el denominado síndrome mielodisplásico y carcinoma testicular por conflicto de desvaloración de sí y conflicto de pérdida por la muerte del tío
- 21.9.13. Desvaloración de sí de un escolar porque le sorprendieron haciendo peyas.
- 21.9.14. Conflicto de desvaloración de sí con conflicto de territorio y conflicto de marcar el territorio (femenino) por el suspenso definitivo del examen de jurisprudencia.
- 21.9.15. Conflicto de desvaloración de sí porque la mujer fue encantada por un pranoterapeuta
- 21.9.16. Carcinoma del útero; desvaloración de sí generalizada en concomitancia con osteólisis ósea, leucemia y carcinoma vaginal
- 21.9.17. Leucemia mieloide pseudo-crónica a causa de nuevos conflictos de desvaloración de sí cada vez diferentes. El padre dispara a su hijo.
- 21.9.18. Paciente de cincuenta y dos años muerto trágicamente por un error médico, porque fue catalogado como “enfermo de cáncer”
- 21.9.19. Un beso y sus consecuencias
- 21.9.20. Leucemia linfática crónica: desgracias cronológicamente repetidas en alternancia con éxitos religiosos como testigo de Jehová.
- 21.9.21. “Leucemia linfoblástica aguda con dos recaídas”, en realidad tres diferentes desvaloraciones de sí con respectiva leucocitosis linfoblástica o leucemia en la sucesiva fase de reparación
- 21.9.22. Leucemia linfoblástica aguda a causa de tres conflictos de desvaloración de sí
- 21.9.23. Diagnóstico: sarcoma de Ewing
- 21.9.24. Conflicto de desvaloración de sí y de intento de suicidio tras el suspenso del examen de madurez a los 16 años
- 21.9.25. Leucemia mieloide crónica en una mujer rica e infeliz
- 21.9.26. Leucemia indiferenciada aguda y cáncer hepático (en este caso llamado erróneamente infiltrado leucémico) por despido a los 45 años en condiciones humillantes
- 21.9.27. Locura de la medicina oficial: las denominadas “metástasis” osteoblásticas (=que forman tejido ósea)

Índice de la segunda parte

- 1. La influencia de las hormonas en el evento patológico.**
- 2. Las denominadas psicosis.**
- 3. Los síndromes en la Nueva Medicina.**
- 4. La aparición de crímenes espontáneos o delitos.**
- 5. El lenguaje biológico interanimal del hombre y los animales.**
- 6. El cáncer en las plantas o los programas especiales biológicos y sensatos en las plantas.**
- 7. El milagro de la creación.**
- 8. Desde el laboratorio artesanal de la Nueva Medicina: Trisomía 21, el denominado síndrome de Down o mongolismo.**
- 9. Las tres reglas biogenéticas fundamentales de la Nueva Medicina.**
- 10. “El hacha de Trnava”.**
- 11. Tabla de registros.**
- 12. Tabla científica de la Nueva Medicina.**
- 13. Verificaciones de la Nueva Medicina.**

1. Presentación

Este libro es el testamento de mi hijo DIRK. Yo lo llevo adelante como administrador de su legado. En ningún caso se le puede negar a quien lo necesite para sobrevivir. Pero nadie puede enseñarlo sin mi consentimiento explícito. Los denominados maestros de la medicina oficial han obstaculizado durante años este testamento por motivos incongruentes y fuera de la medicina.

Que para vosotros, mis pacientes, el testamento de mi hijo Dirk, contenido en este libro, sea vuestra esperanza. La mayor parte de vosotros podrá reencontrar la salud cuando comprenda y siga el sistema en el modo correcto y cuando haya médicos formados por mí con buenas manos y un corazón compasivo que os serán de ayuda.

Este sistema de la NUEVA MEDICINA será considerado entonces la más grande bendición de toda la medicina.

Todo lo que se ha escrito hasta aquí se ha hecho según la ciencia y del modo más cercano a la verdad, modificado sólo en la medida que la intimidad del paciente lo requería.

Os pido que mostréis respeto por las personas y sus destinos que se describen aquí y, si por casualidad pudierais saber de quien se trata, que seáis discretos. Los relatos ejemplificadores no se han incluido como un entretenimiento, sino para ser de ayuda a todos los que estéis enfermos.

Nadie puede decir que no se puede equivocar. Eso vale también para mí. Expresamente deseo que no me “creáis”, sino que os convenzáis vosotros mismos del fundamento de este sistema que es comprobable y comprobado con alta probabilidad.

El boikot contra la Nueva Medicina ha sido, por dramatismo e infamia, proporcional a la importancia de este descubrimiento del contexto ligado al suceso tumoral. Yo mismo enfermé en 1978 de un cáncer de testículos cuando mi hijo DIRK fue herido mortalmente en el sueño de un príncipe –que quería disparar premeditadamente a un médico romano- y murió entre mis brazos cuatro meses después. Aquello era el DHS, el SÍNDROME DE DIRK HAMER. Un suceso así de dramático puede ser percibido por las personas de nuestro alrededor como un shock.

Pero la mayor parte de los shock vividos de este tipo o parecidos se reflejan sólo en el interior del paciente, sin que se noten en el exterior. Por otra parte no son menos dramáticos ni menos activos en el organismo del paciente, porque lo único importante es lo que el paciente percibe o ha percibido.

Estos normalmente no pueden hablar de ello con nadie, aunque nada les gustaría más que hablar de su conflicto “con el corazón abierto”.

El SÍNDROME DE DIRK HAMER (“DHS”) es el cimiento y la base de toda la NUEVA MEDICINA y de la comprensión global del suceso tumoral o actualmente de todas las manifestaciones patológicas. El cáncer no se produce por una sucesión de conflictos (los denominados factores de riesgo) ni por “grandes” conflictos. Un DHS y por lo tanto el cáncer, están causados al contrario por un conflicto imprevisto, de manera chocante, que nos coge a contrapie. No son los 100 tiros a la portería del campo de fútbol los que hacen un gol, sino el tiro

inesperado o falseado a propósito, que coge al portero “a contrapie”, justo ese es el que llega imparable a la portería. Esto es el “conflicto biológico” que entiendo y que tenemos en común con las otras criaturas (los mamíferos) e incluso con las plantas.

El descubrimiento del contexto del cáncer era para los vivos aparentemente difícil. La ha descubierto... un difunto. Os paso su legado.

Con su muerte él nos ha dado la ocasión para descubrir estas correlaciones, pero creo que, también tras la muerte, siga siendo partícipe de este descubrimiento mucho más de lo que se pueda imaginar.

Esto sucedió de la siguiente manera: en septiembre de 1981, cuando por primera vez creí haber encontrado un sistema en la génesis del cáncer, es decir, el SÍNDROME DE DIRK HAMER, me “flojearon las piernas”, como se suele decir. Este descubrimiento me pareció demasiado grandiosa porque yo mismo me la creía. Por la noche tuve un sueño: con mi hijo DIRK, con el que sueño a menudo y con el que discuto en sueños, se me apareció, sonriendo con bondad, como hacía normalmente, y me dijo: “Lo que has encontrado, Geerd, es correcto, es del todo correcto. Te lo puedo decir porque ahora sé más de eso que tú. Has estado maravilloso descubriéndolo. Desencadenará una revolución en la medicina. Puedes hacerlo público bajo mi responsabilidad. Pero tienes que seguir estudiando, todavía no lo has descubierto todo. Todavía te faltan dos cosas importantes”.

Me desperté y memoricé cada una de las palabras de nuestra conversación. Estaba tranquilo y desde entonces totalmente convencido que el SÍNDROME DE DIRK HAMER era correcto. Hasta aquel momento había examinado cerca de 170 pacientes. Llamé al señor Oldenburg de la televisión bávara, que ya una vez había hecho un pequeño reportaje sobre el escarpelo de Hamer en el congreso quirúrgico de Munich en mayo de 1978. Vino a Oberaudorf e hizo una pequeña película que se emitió en Baviera el 4 de octubre de 1981: al mismo tiempo el evento se difunde con un reportaje también en la RAI.

Me puse a estudiar otros casos. Sabía bien que en poco tiempo me prohibirían el ejercicio en la clínica, porque mis resultados eran contrarios a los de la medicina oficial.

Habiendo no sólo recopilado otros casos, sino que habiéndolo hecho de un modo programado y sistemático, hice una constatación extraordinaria: por ejemplo, el cáncer del cuello del útero siempre tenía un contenido de experiencia conflictiva muy particular, es decir, sexual; por el contrario el cáncer de mama conllevaba siempre un conflicto humano general, a menudo incluso madre-niño; el cáncer de ovarios un conflicto de pérdida o tenía un contenido conflictivo genital-anal, etc. Al mismo tiempo constaté que cada tipo particular de cáncer tenía un tiempo particular de latencia de la manifestación tumoral, antes que la paciente notase su cáncer, o sea, más o menos 12 meses para el cáncer del cuello del útero; de 2 a 3 meses para el cáncer de mama; de 5 a 8 meses para el cáncer de ovarios.

Esto me parecía por una parte lógico y razonable, por otra parte demasiado razonables como para creerlo, dado que no sólo estaba en contra de los preceptos de la medicina clásica, sino que sobrepasaban toda la medicina. De hecho este descubrimiento demostraba nada menos que es la psique misma la que establece donde se forma el cáncer. De nuevo me “temblaron las piernas”. Todo el asunto

era demasiado grande para mí. La noche siguiente soñé nuevamente y en sueños hablé con mi hijo DIRK. Él me alabó y me dijo: "Santo cielo, Geerd, como lo has descubierto, y que bien que lo has hecho". Después sonrió de nuevo con su sonrisa incomparable y me dijo: "Sólo te falta una cosa todavía, y después ya lo habrás encontrado todo. Ahora no puedes darte por vencido, tienes que continuar indagando. Seguro que lo lograrás."

Nuevamente me desperté. De golpe estaba convencido totalmente de la certeza de mis resultados y me puse a investigar febrilmente cual podría ser la última cosa que me "faltaba" y que DIRK me había dicho. Estudiaba cada caso que me llegaba en base a los criterios que establecí y vi que los resultados eran correctos en todos los casos. DIRK tenía razón. Entonces volví a examinar a fondo no sólo todos los casos precedentes, para cada uno de los cuales había preparado un archivo, sino en especial también los casos de carcinomas "dormidos" así como los casos siguientes.

Era una carrera contra el tiempo. Sabía con precisión que pronto no me dejarían visitar ningún paciente. Por lo tanto mi última semana de servicio trabajé día y noche prácticamente. Y de repente se me apareció un conocimiento: en los casos en los que los pacientes habían sobrevivido el conflicto se había resuelto siempre, por el contrario el conflicto no se había resuelto en los casos de las personas que habían muerto o en los que la enfermedad había empeorado.

Me había ya acostumbrado a considerar correcto lo que los colegas, con los que intentaba hablar de estas cosas, consideraban simplemente sin sentido, sin querer saber más del asunto. Pero realmente este conocimiento era para mí excesivamente grande. Estaba anonadado y literalmente las piernas se me volvieron de mantequilla. En este estado casi no podía esperar la noche siguiente, en la que poder presentar mis problemas a mi maestro DIRK.

De nuevo soñé con DIRK, tan claramente como la última vez. En esta ocasión él estaba lleno de admiración y me sonreía con reconocimiento diciéndome: "No hubiera creído posible que lo consiguieses con tanta prisa. Sí, lo que has encontrado es correcto, completamente correcto. Ahora tienes todo, ya no te falta nada. Las cosas son exactamente así. Ahora puedes publicar todo bajo mi responsabilidad. Te prometo que no te arrepentirás de ello, porque es la verdad".

Cuando por la mañana me desperté y repasé el sueño con claridad, mis últimas dudas se habían disipado. A mi DIRK siempre le había podido creer, y ahora que estaba muerto con más razón.

(Extracto del libro CÁNCER – ENFERMEDAD DEL ALMA, cortocircuito del cerebro, el ordenador de nuestro organismo, la ley férrea del cáncer, febrero de 1984 en la edición "Amici di Dirk", Colonia).

En los últimos años ha habido muchas personas que han considerado el pasaje expuesto arriba como "no científico". De hecho no tiene pretensión de serlo, sino sólo de estar conforme a la verdad.

Del resto, según mi parecer es importante el hecho de que resultados y descubrimientos, que son válidos lógicamente y empíricamente además de reproducibles en cualquier momento, se verifiquen para establecer si son correctos o falsos. Pero si los resultados y los descubrimientos son correctos,

entonces no tiene ninguna importancia para su veracidad cómo y por quién han sido descubiertos.

Ni siquiera sirve perseguir al descubridlos con todos los medios imaginables de terror y descrédito para acallar el descubrimiento y para evitar las consecuencias de este. Haciendo esto la culpa se vuelve enorme. Y es justamente lo que ha sucedido estos últimos 17 años.

La medicina oficial dominante actualmente no es, en sentido estricto, una ciencia, aunque parezca muy científica.

Tiene miles de hipótesis y dogmas que se deben o se pueden creer, pero que son falsos, porque a su vez se basan en hipótesis no demostradas. (Por ej. el dogma de la metástasis, enfermedad como una “avería de la naturaleza”, dogma de las “células enloquecidas”, dogma de las “metástasis cerebrales”, dogma de los microbios como “agentes” patológicos, etc.).

Hay un chiste académico:

Tres estudiantes, uno de física, uno de biología y uno de medicina, tienen que aprenderse de memoria la guía telefónica. El estudiante de física pregunta si existe algún sistema en la guía. Le responden que, aparte del orden alfabético, no hay ningún sistema. Se niega a aprender una cosa tan sin sentido. El estudiante de biología pregunta si en la guía telefónica hay algún desarrollo o una evolución. La misma respuesta, ningún desarrollo, sólo tiene que aprendérsela de memoria. También se niega a estudiar algo tan estúpido. Al estudiante de medicina también le dicen que tiene que estudiar de memoria la guía telefónica a lo que sólo responde: ¿En cuánto tiempo?”.

En principio los médicos hemos tenido que recitar de memoria, para el examen de estado, las entradas de la guía telefónica. Ni el estudiante ni el profesor habían entendido nada realmente. La cualificación efectiva estaba en el número de páginas aprendidas de memoria.

Si se analizan los dogmas de la denominada “medicina oficial”, se ve que derivan del pensamiento bipolar de “bueno y malo” típico de nuestras grandes religiones (judía, cristiana, musulmana), que a su vez provienen de la concepción zoroástrica del mundo de los antiguos persas. Todo se divide coherentemente en “bueno” y “malo”. De aquí deriva lógicamente también la “mentalidad eliminatoria” marcial de los actuales “guerreros de la medicina” que sin embargo, en realidad, no es más que Edad Media: que no cree en los dogmas únicos verdaderos tiene que ser quemado.

Malignas eran, por ejemplo, todas las células cancerígenas y los microbios, todas las “reacciones de enfermedad” del organismo, además de las denominadas enfermedades del espíritu y del ánimo. La maldad estaría en el hecho de que la Madre Naturaleza comete continuamente errores, muestra desviaciones, averías que provocan cáncer, que se supone que es un crecimiento “incontrolado”, “invasivo” en los órganos vecinos, aunque se sepa que existen los denominados “límites de los órganos” (por ej. entre cuerpo del útero y cuello del útero).

Hoy, a la luz de las verdaderas relaciones contextuales, esta historia de la “maldad” resulta una locura tremenda. La Madre Naturaleza de hecho no comete ningún “error”. Nosotros éramos los ignorantes. Detrás de todo está simplemente

el hecho de que lo que resulta incomprensible se dice que es “maligno” y consecuentemente se combate. Sólo cuando se ha entendido, y ahora con las cinco leyes biológicas podemos hacerlo, no tenemos necesidad de destruir, sino que estamos en posición de comprender, reordenar, de integrar los hechos en un contexto biológico global, más bien cósmico.

En la Nueva Medicina existen sólo 5 leyes biológicas que son científicas y comprobables en cualquier momento. Tienen que ser válidas, en sentido naturalista, para cada caso particular y para cada síntoma particular, también de la enfermedad secundaria (que la medicina clásica llama todavía erróneamente “metástasis”).

Lo fascinante de la Nueva Medicina es ahora el hecho de que tenemos que reconocer que todos estos presuntos errores y averías “malignas” de la Naturaleza eran justamente los Programas Especiales Biológicos Sensatos (EBS), que por nuestra ignorancia hemos interpretado mal. Por lo tanto, todo lo que habíamos llamado “enfermedad”, en realidad formaba parte siempre de un programa especial (EBS). También los microbios, que hemos considerado malignos y a los que había que combatir, eran nuestros fieles colaboradores, por ejemplo, para descomponer el cáncer durante la fase de curación (micobacterias y bacterias) o para rellenar necrosis y úlceras (bacterias y virus) también en la fase de curación.

Universidad de Trnava.

Confirmación.

En los días 8 y 9 de septiembre de 1998 en el instituto oncológico de S. Elisabeth en Bratislava y el departamento oncológico del hospital de Trnava fueron examinados siete casos de pacientes por un total de otras 20 enfermedades en presencia del rector de la universidad de Trnava, del decano de la facultad de metodología curativa y social de la universidad de Trnava y de 10 profesores y catedráticos (los informes médicos de estos casos clínicos, redactados por el Dr. Hamer, están en el anexo). Se debía establecer si en base a las reglas naturales de la prueba de poder ser reproducidas en cada caso, se pudiese definir la verificación de su sistema.

Así ha sucedido.

En realidad no ha sido posible examinar, por falta de informes de examen completos, todos los 100 casos que en cada enfermedad particular se pueden examinar según las leyes de la Nueva Medicina, pero en aquellos en los que se ha hecho han demostrado que todas las leyes biológicas de la Nueva Medicina se confirmaban.

Los que firman consideran por lo tanto confirmado en modo muy probable que el Dr. Hamer, con su presentación en dos conferencias de verificación, ha probado su sistema con la máxima probabilidad. Tenemos en una estima grandísima a los enfrentamientos del empeño humano, ético e indulgente del Dr. Hamer y de su nuevo modo de tratar al paciente. Considerando todos estos factores, tenemos la impresión de que la cuestión de la aplicación cuanto más rápida posible de la “Nueva Medicina” es un tema que debe ser tratado urgentemente.

Trnava, 11-9-1998

Catedrático de psiquiatría, presidente de la comisión científica: Prof. Dr. J. Pogàdy.
Catedrático de oncología, decano de la facultad de metodología curativa: Prof. Dr. V. Kroméry.

Profesor de matemáticas, prorector de la facultad de investigación: Dr. J. Miklosko.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Explicación

A la confirmación por parte de la Universidad de Trnava de la verificación de la Nueva Medicina del 11-9-1998.

Desde el 11 de septiembre de 1998 la Nueva Medicina está oficialmente confirmada según la verificación efectuada el 8 y el 9 de septiembre de 1998 en la Universidad de Trnava (Bratislava, Eslovaquia occidental). El documento ha sido firmado por el prorector (profesor de matemáticas), por el decano (catedrático de oncología) y por el presidente de la comisión científica (catedrático de psiquiatría).

Por esta razón la competencia de los firmantes no puede ser puesta en duda. Desde hace 17 años las universidades de Europa occidental, en especial la Universidad de Tübingen (Alemania) se han negado categóricamente a efectuar una verificación científica similar.

Durante estos últimos años, con ocasión de 26 conferencias públicas de verificación, muchos médicos han procedido al examen y a la verificación de las Leyes Biológicas de la Nueva Medicina. Durante estas verificaciones todos los casos examinados siempre se han demostrado correctos: estos documentos, aunque acompañados de un certificado notarial, jamás fueron aceptados ni reconocidos. Siempre y de cualquier manera se ha “pretendido” que hasta que esta verificación no se produjese oficialmente en el ámbito universitario, esta no podría ser válida y por tanto la medicina oficial permanecía como la única medicina “reconocida”.

La Nueva Medicina con sus cinco leyes biológicas y sin hipótesis suplementarias, es válida para los hombres, los animales y los vegetales. Es tan clara y coherente que se habría podido, y debido, verificar fácilmente en cualquier paciente elegido al azar sólo con que se hubiese querido.

Las graves calumnias, campañas denigratorias de los mass-media, así como la prohibición de ejercer como médico, diferentes atentados contra mi vida y amenazas de tratamientos psiquiátricos forzados (por pérdida del sentido de la realidad) hasta mi encarcelación (juizado y detenido por más de un año por haber dado información gratuitamente sobre la Nueva Medicina en tres ocasiones), no deben y no pueden sustituir a las argumentaciones científicas indispensables para rebatir a un adversario científico. ¿No ha sido la represión de este

descubrimiento, como se puede ver claramente, sólo la expresión de la brutal fuerza para salvaguardar el poder y las posesiones de la “vieja” medicina?

La Nueva Medicina es la medicina del futuro. El impedimento de su aplicación se convierte en el más grande crimen cometido contra la humanidad.

Según las estadísticas oficiales como las del centro alemán de investigación contra el cáncer de Heidelberg, podemos constatar poquísimos pacientes, tratados por la medicina actual con la quimio, que todavía vivan tras cinco años...

Con ocasión de la persecución por parte de las autoridades austriacas del Centro de la Nueva Medicina de Burgau, se confiscaron 6.500 direcciones de pacientes (la mayor parte de los cuales afectados de cáncer en estadio avanzado o abandonados ya por la medicina oficial). El ministerio público de Wiener Neustadt tuvo que admitir que se comprobó que más de 6.000 seguían vivos tras cuatro o cinco años (más del 90%).

La pretensión de verificación por parte de una universidad ya está satisfecha. Ahora los pacientes tienen el derecho, para que se ponga fin al peor y más cruel crimen contra la humanidad, que todos puedan obtener la misma perspectiva de curación: el derecho de ser tratados según las cinco leyes biológicas naturales de la Nueva Medicina, oficialmente, dentro de las estructuras públicas.

Apelo a todas las mujeres y hombres honestos y sinceros, solicitando su ayuda.

Dr. Hamer

2. Las enfermedades (ahora comprendidas como programas especiales, biológicos y sensatos) del hombre, los animales y las plantas como un suceso de tres niveles.

Psique	Cerebro	Órgano
(=cerebro del órgano + cerebro de la cabeza)		
Programación	Ordenador	Máquina

Hasta aquí la medicina oficial se ha ocupado exclusivamente de los órganos. Si un órgano no funcionaba como debía se suponía que tenía una molestia mecánica o que le hubiesen atacado bacterias o virus o que reaccionase de modo alérgico contra algún anticuerpo. A ninguno se le ocurrió que quizás el órgano pudiese estar controlado por un ordenador, justo por el cerebro.

Si ahora alguien dijese que ya muchos pensaban que el cáncer tenía alguna relación con el estrés, la tristeza o los conflictos, eso no tendría nada que ver con las 5 leyes biológicas de la Nueva Medicina. En la medicina moderna se mantiene por una lado, tal y como se aprende en los libros, que hacen falta de 10 a 20 años para que un cáncer se manifieste. Por otro lado se tenía y se tiene una definición completamente diferente de "conflicto".

Un magistrado de Sigmaringen, el 17-12-86, le preguntó a un catedrático de psicología de la Universidad de Tübingen que qué entendía, por ejemplo, por conflicto sexual, lo cual el Dr. Hamer llamaba conflicto biológico. Respuesta: "Una enfermedad narcisista". Mi contra respuesta fue: "Entonces diría que también mi perra tiene una enfermedad narcisista cuando por un conflicto sexual análogo a uno del hombre presenta un Foco de Hamer en la zona periinsular izquierda con un cáncer del cuello del útero?"

Foco de Hamer: Foco que corresponde a un conflicto o a una enfermedad del órgano, descubierto por el doctor Hamer, en el cerebro, fotografiable. Al principio llamado de modo ridiculizante por los adversarios del Dr. Hamer "los extraños focos de Hamer". Se ven las configuraciones de anillos concéntricos, con cercos bien delimitados en los estratos correspondientes de la tomografía cerebral computerizada (TAC) en la fase de conflicto activo (fase CA), que los radiólogos llamaban equivocadamente "artefactos", pero que en la fase de curación (post-conflictiva = fase PCL) se vuelven en el mismo punto anillos edematosos hinchados.

Ninguna respuesta... Mi siguiente comentario: "Querido colega, todas las locuras de Freud son por lo tanto pura fantasía ferviente, como ve, porque usted mismo no se cree que mi perra tenga una enfermedad narcisista, pero por lo tanto según Hamer tiene un alma igual que el hombre".

De hecho los animales, como he podido probar con la ayuda de las imágenes de la TAC del cerebro, con el mismo tipo de conflictos sufren un foco de Hamer,

normalmente en el mismo punto del cerebro que lo sufriría un hombre. Y entonces también se tiene el correspondiente cáncer, por lo general, en el mismo punto del cuerpo, es decir, en el órgano análogo. Incluso se ha podido probar certeramente que el cáncer o la necrosis se vuelve cada vez más grande si se produce una nueva recaída del conflicto, y que vuelve a disminuir o desaparece del todo si el conflicto ha sido resuelto anteriormente en la medida en la que estaban presentes las micobacterias para los conflictos controlados del paleoencéfalo o para los tumores, es decir, eran posibles los procesos de regulación biológica arcaicos. (Estos aspectos se tratan seguidamente de un modo exhaustivo).

Obviamente se debe tener en cuenta las preprogramaciones específicas: por ej. un pato no sufre jamás un conflicto de líquido, frecuente por el contrario en el hombre. Una rata doméstica sufre muy fácilmente un conflicto causado por el humo, un hámster nunca. No tiene ningún código de alarma contra el humo. No tiene necesidad de ello porque vive bajo tierra.

Si se forma un cáncer en cualquier parte, la denominada medicina oficial, hasta ahora, lo combate de modo puramente sintomático, con “bisturí, rayos y química”, quiere curar realizando mutilaciones, quemando el tumor con rayos X y de cobalto y con el denominado tratamiento citostático (envenenamiento celular) a menudo por medio de la flebotomía. Lo único que se trata es el órgano. La psique del hombre o del animal o el cerebro no tienen ninguna consideración.

Parecía y todavía parece totalmente extravagante cuando mantengo que con la individuación y la resolución del conflicto psíquico, mediante la denominada “conflictividad” (resolución del conflicto) no sólo se puede parar y enquistar (encapsular) el crecimiento del cáncer, sino incluso (en el carcinoma del epitelio pavimentoso, por ej. carcinoma del cuello del útero) se puede llegar a la desaparición completa de la úlcera gracias a la reconstrucción de nuevos tejidos.

El problema fundamental de la medicina clásica “moderna” está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, en la denominada “patología celular” del señor Virchow. Esta en su tiempo era un avance, pero es grotesco que estas teorías, según las cuales la causa de una enfermedad se encuentra en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas en el siglo XXI por capricho de la industria y de los “investigadores” que viven de estos dogmas.

Las causas del cáncer y de otras denominadas “enfermedades” se estudian todavía indagando las condiciones de la célula o incluso de fragmentos de partículas proteínicas o virus. A estas cosas bizarras, que no ayudan a ningún paciente, se les conceden los premios Nobel.

Está claro que el alma o la psique del paciente aquí sólo puede molestar.

La Nueva Medicina no pone para nada en duda los hechos que, por ejemplo, se pueden reconocer en un microscopio. Sólo las conclusiones, es decir, los dogmas, que se sacaban y se siguen sacando, están a menudo equivocadas: obviamente examinando al microscopio una célula cancerosa de la glándula mamaria no se puede ver si ésta pone a la mama en posición de producir una cantidad doble de leche. Ni tampoco es posible entender que este crecimiento se produce para el bien del niño o que seguidamente se reducirá de nuevo, en tanto que haya micobacterias. Las células tienen mitosis, la mitosis es maligna y basta.

Hoy en día toda la medicina oficial o de estado depende de las concepciones ya superadas de Virchow. Por eso hasta ahora sólo hemos tenido desarrollo en los aparatos y en la técnica; los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposible a causa de estos dogmas. La medicina oficial no ha podido liberarse de esta camisa de fuerza de la "patología celular". Un catedrático me dijo: "Si, señor Hamer, si la patología celular es errónea, entonces falla todo". ¡Es errónea, y efectivamente, falla todo!

Aquí no se trata del hecho, que sería un poco difícil de probar, de que cada denominada enfermedad tenga un desarrollo a tres niveles, de la psique, del cerebro y del órgano, que están en interacción recíproca entre ellos, y que las 5 leyes biológicas de la Nueva Medicina son correctas. El escándalo, por el contrario, está en el hecho de que el resultado que comprueba esta experimentación no puede y no debe ser aceptado oficialmente por ninguna razón, por culpa de los muchos intereses en juego... Bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto.

Bastaría controlar si la tendencia en muchos pacientes (diestros) afectados de carcinoma del cuello del útero es tener un foco de Hamer en la zona periinsular izquierda del cerebro. Si se quiere estar seguro del todo, se controlarían primero los pacientes cuyo conflicto (de tipo sexual) se ha resuelto y por lo tanto tienen las manos calientes. En su caso el foco de Hamer tiene que tener un edema perifocal muy distinto. Y si después se quiere estar todavía más seguro respecto a los contenidos del conflicto, se elegirían sólo los pacientes zurdos, porque estos tienen que tener el foco de Hamer, en el caso de un conflicto sexual, en la región periinsular derecha. Todo esto se puede hacer fácilmente en una mañana.

Por el contrario se dedican miles de millones, hay que decir que deshonestamente, para empresas sin sentido de la medicina clásica, sólo porque muchas personas tienen un gran interés en que todo se quede como estaba. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pobres pacientes.

Quiero hacer ahora una pequeña anticipación de lo que será expuesto seguidamente para poder comprender ya en este punto la expresión "cerebro de la cabeza o cerebro central" y "cerebro del órgano", que aparece en el título del capítulo: todos los seres vivos tienen un cerebro del órgano. Pero el hombre y los animales tienen además un cerebro de la cabeza. Sobre el por qué sea así, sólo podemos hacer suposiciones. Yo creo que la razón es que el hombre y los animales

- a) no están ligados al lugar, sino que se mueven libremente,
- b) que la necesidad de movimientos rápidos y de una valoración rápida de las informaciones ha exigido un ordenador añadido.

Sin embargo el cerebro central no es sustancialmente diferente del cerebro del órgano, sino que constituye sólo un complemento de éste.

En la fase activa de un programa especial vemos en la TAC del órgano los mismos cercos concéntricos, bien delimitados, parecidos a los de una diana, del foco de Hamer del mismo modo y también con la misma frecuencia de oscilación que podemos observar en el cerebro central. Esto se explicará seguidamente de

un modo más exhaustivo. El cerebro del órgano, que comprende prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, los cuales están comunicados entre ellos, es casi como un gran disco de ordenador que ha memorizado no sólo todas las informaciones, sino también las órdenes de los órganos individuales. Hasta que punto cada órgano tenga su propio “disco duro parcial”, que por ejemplo ponga al hígado en posición de funcionar tras un trasplante, no lo puedo decir todavía. Sin embargo presupongo la existencia de ese disco para los órganos directos del paleoencéfalo; es decir, para los órganos del endodermo y del mesodermo del paleoencéfalo.

En el campo biológico nos falta estudiar todavía mucho. Aunque nos sentimos ya listísimos, por el hecho de intentar experimentos con los genes y clonar, tengo la sensación de que en realidad sabemos poquísimo.

La Nueva Medicina se contrapone a la denominada medicina clásica o sintomática, que se interesa casi exclusivamente por los síntomas orgánicos e intenta curarlos.

Para la Nueva Medicina el hombre, pero también cada animal y planta, es siempre un organismo que se puede considerar a tres niveles que proceden en sincronía entre ellos:

- la psique
- el cerebro (cerebro central y cerebro del órgano)
- los órganos

Comencé a meditar sobre estas relaciones tras un drama personal.

Todo empezó por un conflicto mío personal de pérdida, que me hizo enfermar de repente de un cáncer de testículos en 1978/79, justo tras la muerte de mi hijo Dirk entre mis brazos, entonces tenía 19 años, y al cual cuatro meses antes le había disparado un príncipe, traficante de armas de la jet-set internacional, maestro de la gran logia P2 (Propaganda due).

Este suceso, una clara coincidencia entre el drama vivido y mi enfermedad, fue entonces la ocasión para reflexionar como se producía la comunicación entre psique y organismo.

Mi hipótesis de trabajo en aquel punto era que podía tener lugar una comunicación psique-órgano sólo a través del cerebro.

Entonces todavía nadie se interesaba en el cerebro en relación al surgimiento de las enfermedades.

Como médico jefe de una denominada clínica oncológica perteneciente a la universidad de Munich encontré una clara correlación entre nuestros órganos y determinados conflictos, o grupos de conflictos. Se debería volver a encontrar esta sistemática, así lo postulaba, también en cualquier parte en el cerebro.

El contexto sistemático

- psique ↔ órgano que se amplia a
- psique ↔ cerebro central y cerebro del órgano ↔ órgano

Puse como modelo de razonamiento:

- psique – programador

cerebro – ordenador
órganos – máquina

Sorprendentemente fue y es el hecho de que, en la época de los ordenadores, se piense que complicadas máquinas industriales trabajen según este esquema, mientras que el más complicado organismo humano debería producir las denominadas “enfermedades” supuestamente sin cerebro ni psique, es decir, sin programador ni ordenador. El surgimiento de la enfermedad, se creía, se producía por casualidad, desviaciones, insuficiencias, degeneraciones.

Dado que en la medicina actual la causa del surgimiento de enfermedades, como el cáncer en la medicina actual, es todavía hoy desconocida, permanece “como deducción errónea” sólo la hipótesis del surgimiento ligado a la casualidad.

Es mucho más importante para nuestro diagnóstico y para la terapia (en particular también para la auto terapia) aclararse nuevamente a sí mismos que todo sucede de un modo sincrónico.

Por eso en la Nueva Medicina no se sigue hablando en sentido estricto ni de una denominada psiquiatría, que parte del supuesto de que los síntomas psíquicos son independientes del organismo, ni de una “medicina orgánica”, que sostiene que los órganos no tiene nada que ver con la psique. En realidad existía la denominada “psicosomática”, de hecho una rama mal evolucionada de la medicina que no ha tenido nunca una verdadera importancia ni habría podido tenerla, ya que no conocía la sincronía entre psique, cerebro y órgano.

Respecto a las afirmaciones generales como “el estrés provoca úlcera de estómago” o “el estrés provoca infarto cardíaco” no se conseguía salir de ahí. En las dos hay algo de verdad, pero faltando la idea de la sincronización, es decir, que todo sucede al mismo tiempo, se impedía a la psicosomática que continuase desarrollándose.

“De un modo coherentemente insensato” también en las leyes para los psicoterapeutas en Alemania y en Austria se cimentó la división de la medicina en medicina orgánica y psicomedicina, seguramente con la intención de impedir la aplicación de la Nueva Medicina. Para ésta última tales “especializaciones” no sólo son insensatas, sino incluso peligrosas, como veremos seguidamente.

La sincronía a tres niveles de psique, cerebro y órgano en la Nueva Medicina representa una presuposición totalmente decisiva del diagnóstico y del conocimiento del desarrollo patológico, que es de una importancia fundamental para el paciente y para su “autoterapia”.

Sólo por el hecho de que el paciente puede reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad (seguidamente este suceso será llamado Programa Especial Biológico Sensato) como el desarrollo completo como suceso biológico sensato en los tres niveles, el paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico. El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial biológico sensato (EBS). Esto lo convierte en jefe real y soberano de su propia “enfermedad”.

2.1. ¿Qué significa la sincronía del desarrollo a tres niveles?

En el pasado se podía imaginar eventualmente que el estrés psíquico prolongado tuviese como consecuencia modificaciones orgánicas. Sin embargo también estas eran solamente suposiciones, porque se desconocían las relaciones concretas: las 5 leyes biológicas de la Nueva Medicina (que seguidamente serán explicadas más ampliamente). Estábamos, sin embargo, a años luz de podernos imaginar que fuese posible una sincronía, una acción producida al mismo tiempo de psique, cerebro y órganos.

Y es justo lo que dice la Nueva Medicina: cada proceso psíquico se desarrolla al mismo tiempo en el cerebro central (e incluso en el cerebro del órgano) y en el órgano que está sujeto a este programa especial biológico sensato. Nunca sucede uno sin el otro, es decir, jamás existe un nivel sin el otro.

¿Qué significa realmente?

Si un programa EBS se verifica con un síntoma orgánico (lo que llamamos comúnmente enfermedad), entonces todo el organismo se ve afectado por el síntoma correspondiente, también en el plano psíquico, en el plano del cerebro central y del órgano.

La Nueva Medicina con sus cinco leyes biológicas no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama elegantemente medicina psicosomática, término que en cualquier caso nadie tiene claro.

La Nueva Medicina, que está estrictamente orientada a los conflictos y comportamientos biológicos, establece criterios totalmente nuevos. No es inhumana, por el hecho de tener una orientación biológica, sino al contrario, supera la medicina brutal sin alma. Nadie se vuelve pobre cuando admite un error. Nuestra actual medicina clásica con sus infinitas hipótesis no demostradas e indemostrables se revela como un gran error, y encima brutal por añadidura.

La medicina actual trabaja sin comprensión en el sentido más verdadero de la palabra. Se podría cerrar dos tercios de las secciones quirúrgicas, por cuanto resulta superfluo eliminar nódulos tumorales, de por sí inocuos, a base de bisturí de modo "radical, incluyendo el tejido sano".

Para reparar la psique, la programación o el cerebro, ordenador de nuestro organismo, se debería saber a ciencia cierta no sólo que seguro ha saltado, sino también por qué ha saltado. Ahora sabemos que existen programas especiales, o de emergencia, biológicos y sensatos.

Esto nos lleva a preguntarnos qué programa debería ser aplicado a nuestro organismo para el futuro: el programa biológico óptimo. De hecho el programa especial o de emergencia se produce sólo porque un DHS psíquico ha escapado al control del programa biológico normal de nuestro ordenador-cerebro, haciendo necesaria la inserción de ese programa especial.

Ejemplo: un niño pequeño sufre de noche un ataque de terror, el denominado "pavor nocturno". Los padres se han ido a una fiesta. Dado es el único hijo, como sucede hoy en día con frecuencia, puede sufrir un shock para el resto de su vida. Un caso así no está entre las condiciones que nuestro programa cerebral tiene como modelo de comportamiento. Normalmente (según la naturaleza) la madre no

se alejaría de su pequeño, además, normalmente hay suficientes hermanos a los que se puede agarrar el niño cuando por la noche tiene un sueño malo. Para poder programar a un niño (desde el punto de vista cerebral/psíquico) como hijo único, la naturaleza necesitaría probablemente un millón de años...

Todas las denominadas "enfermedades" funcionan visiblemente de acuerdo con nuestro cerebro ordenador, también las denominadas "enfermedades infecciosas". Simplemente tenemos que aprender a ver todas estas cosas desde un nuevo punto de vista.

Lo que esta civilización nos ha dado, lo vemos hoy en día lleno de horrores. Cuanto más ricos nos volvemos y cuanto más viejas se vuelven las personas (en las residencias) más arruinadas y sin hijos se vuelven nuestras familias y la sociedad, en contra de nuestro código.

Pongo este ejemplo para indicar que nosotros no podemos manipular arbitrariamente las denominadas estructuras sociales, si no queremos que aparezcan los conflictos que se derivan de ello. Por el contrario existe un código biológico, de reglas biológicas o un programa biológico incluido en nuestro cerebro, en base al cual debemos orientarnos, queramos o no. Todo lo demás causa conflictos añadidos y conduce al final a un círculo vicioso.

Sin embargo no se debe callar que también el programa biológico, si queremos llamarlo así, tiene sus conflictos biológicamente previstos y deseados. El hecho de que, por ejemplo, el joven ciervo dominante anule al viejo ciervo, causándole un conflicto de territorio, es un proceso deseado biológicamente, de hecho necesario; el correspondiente conflicto de territorio para el ciervo viejo y vencido es entonces una necesidad biológica.

Por el contrario es totalmente insensato desde el punto de vista biológico formar individuos de segundo rango, afeminados, que no sirven ya y no dan ningún valor al territorio, en base a cualquier programa ideológico arbitrario, haciendo pasar eso como una maravilla de la creación.

Se mira sospechosamente el modo en que nuestra sociedad hiperreglamentada con sus prescripciones y posibilidades de control, que cada vez se vuelven más rígidas, conduce obligatoriamente cada vez a más conflictos de territorio, también a causa de que falta la consideración del valor del individuo.

Incluso el conducir o la lucha por un aparcamiento pueden causar conflictos. Todas estas cosas son míseras alteraciones de un orden maravilloso que se encuentra en nuestros cosmos, así como en nuestro organismo.

Sobre estas opiniones se podría discutir, obviamente, sin límite.

Al final cada uno parte de una visión diferente del mundo de cuyos presupuestos depende la discusión y la valoración y las correlaciones existentes en nuestros cosmos y en nuestro organismo.

En cualquier caso estas correlaciones en sí mismas no pueden ser negadas. Al final se implica también la cuestión de si se mantiene un Dios o un principio divino "vencedor" (es decir, destructor) o el realizador de la propia creación magnífica. En el primer caso la puerta está abierta a cualquier perversión de la naturaleza.

Nuestro Occidente cristiano sufre ya desde hace 1500 años por el hecho de que la estrecha relación que ligaba a nuestros antepasados con sus animales (los germanos y sus caballos) se ha sustituido por la mentalidad estúpida del

confrontamiento con los animales de las iglesias judeo-cristianas, que abiertamente no le reconocen alma a los animales (por no hablar de las plantas).

Consecuentemente se llega a realizar experimentos con animales.

La Nueva Medicina constata antes que nada que en nuestro organismo todo sucede como en un ordenador moderno, solo que de forma más grandiosa, porque en el programa está incluida gran parte de las otras especies animales y vegetales; decimos que los diferentes programas están “unidos en red”. Pensemos en las colibacterias del intestino, o en todas las bacterias que hasta ahora nos han enseñado a tratar como nuestros enemigos, lo que en realidad no son.

Pensemos en los denominados parásitos, piojos, pulgas, chinches, mosquitos y similares, que nos han acompañado fielmente durante millones de años, antes de que el hombre intentase exterminarlos con los insecticidas. Muchos han empezado ahora a comprender el precio que tendremos que pagar todavía por nuestros ríos y mares, que han perdido el equilibrio biológico y apestan como cloacas. Que nos comportemos en base a nuestro código cerebral o no, aposta o por ignorancia, no tiene importancia: el código en el cerebro siempre es el mismo.

Este código determina nuestros conflictos y también nuestras denominadas enfermedades, que es lo mismo que decir los programas especiales o de emergencia biológicos y sensatos de la naturaleza: la enfermedad más visible de todas, la enfermedad del cáncer, de la que todo el mundo ha afirmado hasta ahora que no tenía ningún sentido en sí misma, que se trata de “células enloquecidas” que causan estragos. Un residuo funesto de la “patología celular” de Virchow. El cuerpo no estaría en posición de combatir estas “células enloquecidas”.

Nada de esto es correcto. En toda la medicina y en la biología no existe ningún sistema más grandioso y más lógico que el fenómeno del cáncer. Naturalmente, mientras que sólo se consideraba un nivel, el de los órganos, y dentro de éste sólo el histológico de las células, no era posible descifrar este sistema. Para mí, que he descifrado esta escritura, aunque se me retiró prácticamente la autorización para ejercer la profesión de médico por el resto de mi vida, este descubrimiento no se puede parar.

Hay ya buenos médicos en toda Europa que trabajan casi perfectamente según este sistema, obteniendo los mejores éxitos. Lo que a la denominada medicina clásica le cuesta tanto comprender es la necesidad de tener que cambiar radicalmente el propio modo de pensar. No se trata de aceptar la Nueva Medicina como completación de todo lo hecho hasta ahora, sino de ser conscientes que casi todo lo que se ha hecho antes estaba equivocado, porque la verdadera causa de las enfermedades no se han encontrado jamás.

Hasta ahora ha habido, fundamentalmente, sólo dos tipos de médicos: los brujos del bosque virgen, que con sus méritos curativos naturales junto con el conocimiento de las hierbas han comprendido correctamente en cierta medida las correlaciones psíquicas de las diferentes enfermedades. Por otra parte están los modernos médicos tradicionales, que consideran a las personas más o menos como una “masa de proteínas”, en cuya manipulación la psique del paciente se altera y por lo tanto tiene que ser inmovilizada, es lo que se llama “tratamiento sedante” medicinal.

Los brujos del bosque, en general eliminados, eran sin duda los médicos más inteligentes. Sólo les faltaba una sistemática dentro de la cual reordenar las cosas. Lo fascinante del sistema

psique – cerebro – órgano

es el hecho de que se trata de un sistema predeterminado. Si conocemos bien uno de los tres niveles podemos deducir y determinar precisamente los otros dos. Si, por ejemplo, estoy bien informado de los procesos psíquicos, entonces puedo imaginarme con precisión el estado del órgano pertinente y el estado de la región cerebral correspondiente (Foco de Hamer). Por el momento eso parece todavía un poco difícil de concebir, Pero no se necesitará mucho tiempo para poder acertar casi con exactitud el estado del órgano afectado a partir de la lectura cerebral, con la ayuda de un ordenador, en el que estarían memorizadas miles de variantes detalladas.

Probablemente, dentro de no mucho tiempo, la parte principal de la visita de un paciente consistirá en la indagación y la interpretación de la TAC de su cerebro. De la TAC cerebral se puede sin embargo sacar información muy precisa sobre las causas psíquicas: puedo ver de que tipo de conflicto se ha tratado, en que estadio se encuentra ahora (fase de conflicto activo o de postconflictividad, abreviado PCL), puedo deducir la duración del conflicto anterior y eventualmente su intensidad. Con un panel así, y con el crecimiento de la experiencia, las imprecisiones en los diferentes detalles cada vez son más pequeñas. A partir del conocimiento preciso de uno de los tres niveles, conociendo también unos pocos datos básicos como el sexo de la persona, si es zurda o diestra, joven o vieja, podemos determinar con efectividad el estado de los otros dos niveles.

Querido lector, cuídate bien de entender el trabajo con las cinco leyes biológicas de la Nueva Medicina como un deporte intelectual. Aquí se trata de una persona viva, como tú y como yo, con un alma enferma a causa de un conflicto que quizás te parezca banal, incluso ridículo, pero que para este paciente ha sido de tanta importancia como para correr el riesgo de que le destruyese. Sólo las personas con un corazón compasivo y con manos calientes y con una sana comprensión de la realidad humana tienen derecho de “escuchar la confesión” de estos enfermos. Que ningún “medicucho” se acerque a estos pacientes: sería como un puñetazo en el ojo, tanto si quiere tratar localmente el tumor como si busca la “enfermedad narcisista”. Aquí no hay sitio para los dogmas facilones y estos conflictos biológicos elementales no tienen nada en común con los problemas psicológicos o intelectuales.

La mayor parte de nuestras reacciones y acciones sucede espontáneamente y sin que reflexionemos, igual que en el reino animal. Nadie se preocupa del denominado “conflicto de territorio” del macho. A pesar de eso muchísimos hombres mueren justo como consecuencia de un conflicto así, de infarto cardíaco. Fundamentalmente una parte muy grande de nuestra realidad inconsciente, y también consciente, se desarrolla según estos modelos de comportamiento biológico.

Por este motivo la Nueva Medicina desencadenará la más grande revolución médica y social en la memoria del hombre. Cada sentencia judicial, por ejemplo, puede asesinar a un hombre a causa del probable shock conflictivo (DHS); en realidad sólo una sola palabra lo puede matar. A los niños en particular, las palabras que dicen los adultos sin reflexionar les pueden causar conflictos fácilmente, porque en general los niños están sometidos y dependen de ellos.

No sé si sobreviviré a los diferentes atentados que se cometen contra mí el suficiente tiempo para ver la irrupción de la Nueva Medicina. Pero eso no cambia ningún hecho. Todo lo que expongo aquí seguidamente lo dejo como testamento de mi hijo muerto, DIRK.

Si tu, lector, eres inteligente, intentarás entenderlo y aplicarlo.

3.Introducción a la Nueva Medicina.

Este libro presenta la primera clasificación sistemática, no sólo de todos los tumores, sino de toda la medicina en base a:

1. Pertenencia a la hoja embrional
2. Distinción en ámbitos conflictivos
3. Clasificación de los Focos de Hamer en las localizaciones cerebrales determinadas
4. Distinción en base a las formaciones histológicas
5. Subdivisión en base al sentido biológico de cada enfermedad, reconocida como parte de programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza (EBS).

Con la aplicación de la Nueva Medicina toda la medicina y la biología encuentran automáticamente un orden. Cualquiera que lea el libro dirá: "Es verdad, no puede ser de otra manera". Las pruebas son demasiado aplastantes. Incluso mis adversarios durante este tiempo han tenido que admitir que el sistema de la Nueva Medicina presenta una coherencia francamente fascinante. Pero es cierto, uno mismo no se debe alabar. Pero tú, querido lector, tras la lectura del libro darás un veredicto sobre este sistema más objetivo que el que yo haya podido dar.

Es fascinante ver juntos como toda la medicina se desarrolla de un modo tan sensato y natural, por el que todos los procesos, hasta ahora incomprensidos y aparentemente casuales, se vuelven lógicos y comprensibles.

Tras el descubrimiento de la Nueva Medicina y de los Focos de Hamer en el cerebro, la comprensión de la evolución ha sido para mí la llave para llegar al orden grandioso que abarca toda la medicina y la biología. Este orden se extiende a los ámbitos de comportamiento humanos y animales así como a la ubicación de los Focos de Hamer en el cerebro y a la distinción de la pertenencia de los tumores a varios órganos.

Si hasta ahora habíamos considerado la enfermedad como algo adverso, incluso maligno, como un castigo de Dios, ahora ésta aparece como un signo de una modificación sustancial temporal de nuestro organismo. Esta modificación sucede siempre de un modo sincrónico en los tres niveles que hemos definido como psíquico, cerebral y orgánico, que de hecho constituyen un único organismo. Una cosa no existe sin la otra, todo sucede siempre simultáneamente con ritmo uniforme. ¡Una sinopsis que quita la respiración!

Una cosa no puede existir sin la otra, todo se produce siempre simultáneamente con ritmo uniforme. Una sinopsis que realmente quita el hipo.

También nuestro comportamiento respecto a las bacterias y "parásitos" debería ser modificado radicalmente.

En efecto, desde hace muchos millones de años, bajo el perfil evolutivo, las bacterias de la tuberculosis y los estafilococos o los estreptococos han tenido la función, tanto en nuestra raza como en los animales, de eliminar los tumores (por ejemplo del tracto intestinal). Estos microbios son casi nuestros "buenos cirujanos"

intestinales, nuestros simbioses y amigos, a los que se les ha consentido estar activos sólo con la aprobación de nuestro organismo justo en la fase de reparación tras la solución del conflicto y al mismo tiempo de la parada del crecimiento del cáncer.

Sólo quien conoce la historia evolutiva del hombre y de los animales sabe que también los alvéolos pulmonares forma embriológicamente parte del “tracto intestinal”, igual que las amígdalas de la faringe, las vegetaciones adenoideas de la cavidad de la faringe y el oído medio. Así las bacterias de la tuberculosis también son los buenos barrenderos de los adenocarcinomas que se forman en los pulmones, que son “caseificados” y expectorados. En el lugar del adenocarcinoma permanece una caverna.

Llamamos a esos fenómenos “sistemas biológicamente unidos”.

Jamás en el pasado habría osado pensar que podría abrazar toda la medicina en un único sistema fascinante. Espero conseguir, querido lector, convertirte de este éxito concluyente y llevarte al origen de nuestro ser en sentido estrictamente científico.

Yo me había propuesto, en realidad, dedicarme, tras la investigación de los tumores, a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías. La cosa me cayó del cielo, porque todas estas enfermedades mentales y psicopáticas son formas especiales de enfermedad tumoral, en particular también de los denominados “conflictos en suspensión”.

Si nuestro cerebro es el computer de nuestro organismo, entonces lo es para todo. La idea de que alguno de estos procesos del organismo estén fuera del control de este ordenador no tiene ningún sentido. Hay que modificar toda la medicina radicalmente.

En cualquier caso es extraño que jamás nadie haya pensado que el cerebro, en cuanto a ordenador de nuestro organismo, pudiese estar programado también para todas las denominadas “enfermedades”.

Si se hubiese considerado esta posibilidad, aunque sólo hubiera sido de lejos, no me habrían combatido durante 18 años. Sí, toda la medicina hasta ahora se basaba sólo en los síntomas. Las enfermedades se consideraban enfermedades del órgano y, como tales, se trataban de un modo puramente orgánico-asintomático. Eso ha regido la medicina moderna sin alma, en la que la psique parece provocar solamente molestias. Todo se cura con flebotomía y bisturí. La psique se considera “no científica”, una “cosa de locos”.

Los valores hemáticos, las radiografías y las imágenes TAC de los órganos se consideran “hechos”. La psique y el cerebro, por las que se regula todo en nuestro organismo, no interesan para nada.

Y es así de fácil: nuestro organismo funciona exactamente como una máquina moderna, en cualquier caso lo podemos imaginar así: la psique es el programador, el cerebro el ordenador y el cuerpo es la máquina. El sistema es por lo tanto todavía más fascinante por cuanto el ordenador crea de sí mismo también al programador (la psique) de la que es programado a su vez.

Por eso digo: el ser humano cree que piensa, pero en realidad es pensado.

Todo está establecido en el momento del DHS. En realidad (lo que nos cuesta imaginar) todo sucede naturalmente al mismo tiempo, es decir, de un modo sincrónico, en los tres niveles que hemos definido.

El concepto de que no sólo las enfermedades tumorales, sino prácticamente todas las enfermedades, no son casuales o accidentales, sino que son la expresión y el efecto de un determinado programa de ordenador conectado con todos los otros seres vivos de este mundo, y ya presente en mi tesis de habilitación de septiembre de 1981.

Entonces todavía no había visto una TAC cerebral. Suponía y postulaba sin embargo que en nuestro cerebro tendría que haber complementos responsables de la evidente correlación entre el contenido conflictivo y el “órgano relativo”, como en el caso de una mujer diestra que sufre un conflicto sexual con DHS y se enferma siempre de cáncer del cuello del útero.

En 1983 descubrí los Focos de Hamer en el cerebro, los relés de los ámbitos de comportamiento biológico, que se desarrollan en el caso de un DHS en simpaticotonía permanente.

Así nació la LEY FÉRREA DEL CÁNCER, la primera ley global y completa de nuestra medicina.

El esquema mental simple: programador = psique, computer = cerebro, máquina = órgano (cuerpo) es a simple vista tan correcto y es siempre tan reproducible en cada caso individual de enfermedad tumoral, que hace que mis adversarios enfurezcan.

Habrán muchas personas que afirmarán que de alguna manera ya se sabía todo eso. Pero no es correcto. Por ejemplo, pretender que el hecho de haber tenido rencores y conflictos 20 años antes aumente la incidencia del cáncer, es un simple y banal error.

El DHS que nos afecta hoy es la causa del cáncer que sufrimos hoy.

He tenido que olvidar casi todo lo que he aprendido de la medicina clásica, he tenido que tirar todos sus dogmas. Era la medicina de los presuntuosos aprendices de brujo que al final me han impuesto la prohibición de ejercitar la profesión por no “haber abjurado de la ley férrea del cáncer” y por “no haberme reconvertido a la medicina oficial”.

Desde 1994 la Nueva Medicina, con la quinta ley biológica, la denominada quintaesencia, está completa. Sé esta Nueva Medicina rigurosamente científica, así como la validez de sus 5 leyes biológicas ya hubiesen estado reconocidas, y se hubiese aparecido un médico “alternativo” que hubiese inventado una medicina sintomática basada en miles de hipótesis, sin una sola ley biológica que la pudiese confirmar, se le habría considerado como a un loco.

Sin embargo como lo precedente era esta medicina llena de hipótesis, basada en la sintomática, todos creen en las hipótesis, y se las creen realmente.

La Nueva Medicina es un regalo divino, útil para el hombre, los animales e incluso para las plantas. En esta Nueva Medicina las denominadas “enfermedades”, que durante miles de años se han considerado “insuficiencias”, “defectos de la naturaleza”, “aberraciones”, “maldad”, “castigo divino”, etc, ahora son: programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza.

Estamos frente a un milagro de la naturaleza divina y se nos ha permitido ver como Madre Naturaleza ha ordenado todo del modo más sensato.

No era la naturaleza la que era insuficiente, sino nosotros, ignorantes médicos cegados por los dogmas.

Desde ahora en adelante cambia también nuestra función: para cada síntoma, cada conflicto, tenemos, lo primero de todo, que buscar el sentido biológico del programa especial. De esta manera comprendemos si el evento está todavía en la fase activa o ya en la fase de curación, y si, según a qué hoja embrional pertenece, el sentido biológico se realiza en la fase activa (fase CA) o se realizará en la fase de reparación (fase PCL).

Los polipragmáticos ignorantes que siempre habían sostenido que había que curar lo más rápidamente posible, tratar químicamente, operar, trasplantar, etc, todo lo que aparentemente está "fuera de la norma", esos ya han sido superados.

Los futuros médicos de la Nueva Medicina son cordiales pastores de almas, inteligentes y expertos observadores del suceso que tranquilizan a los pacientes, de modo que madre naturaleza puede llevar a cabo su trabajo. Cautamente ayudarán a los pacientes a dirigir su barca en la dirección correcta. Los pobres pacientes asustados, que se quedan temblando y con los ojos llenos de miedo (por el diagnóstico) como los conejos ante una serpiente, pertenecen al pasado.

Ahora los denominados "pacientes" (=los que soportan) pueden entender la Nueva Medicina tan bien como cualquier médico. Ellos son los verdaderos jefes del proceso, tan pronto comprendan el modo de actuar de Madre Naturaleza.

Es el comienzo de una nueva era.

4. La sustancia de la Nueva Medicina. Definición respecto a la denominada “medicina académica”.

Cuando hablo de una Nueva Medicina en contraposición a una “vieja medicina”, antes que nada tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina.

Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por: psique, que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos; cerebro, como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos; órganos, como suma de todos estos procesos.

De hecho la cuestión es naturalmente todavía más complicada, porque nuestro cerebro-ordenador gobierna al programador (la psique) y por lo tanto a sí mismo. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo.

En realidad nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada “medicina moderna” se haya dedicado siempre únicamente a los órganos, como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia en la convicción de ser monstruosamente “sabio”.

Sólo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médicos se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador-cerebro.

Los médicos modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual; no sólo sus órganos, sino también su psique y su cerebro. Por lo tanto no han podido encontrar jamás una relación entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos.

Esta falta aparece en toda la historia de la medicina, con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobretodo y fatalmente, en la medicina moderna, como un hijo conductor a través de los siglos. La denominada medicina clásica actual se resiente del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo, totalmente superada, del siglo XIX. La patología celular de Virchow, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos en o cerca de las células, se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque sólo con el razonamiento totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico (el paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante).

Se conocía y se conoce sólo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer, a diferencia de la Nueva Medicina, ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades.

Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido una sola vez, bien a fondo un único paciente, se habría podido o tenido que descubrir como se originan las enfermedades.

Retrospectivamente hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos-sacerdotes de nuestros antepasados, que con sus rituales, fórmulas de conjuro y runas intentaban curar ante todo el alma.

Los brujos del bosque, de los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del bosque virgen de África trataría a ningún paciente de modo sintomático sin haber curado primero su alma.

Mis colegas del pasado creían que daría la vuelta a toda la medicina, en el sentido literal de la palabra. Y es justo así.

Y ya ha habido muchos médicos sabios que han expresado opiniones parecidas a las mías. Yo las he recogido en una sistemática, en una forma reproducible y comprobable en cualquier momento y, dado que mis viejos colegas no me han querido ayudar en nada, me he visto obligado a volver a examinar las diferentes enfermedades y todos los detalles relativos.

La Nueva Medicina no abarca sólo la relación entre psique, cerebro y órganos; proporciona además las explicaciones embriológico-ontogenéticas explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro. Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales. De hecho en cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico de tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico.

Por lo tanto cada tejido, que deriva de la hoja embrional interna (= endodermo), es tejido adenoideo, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma.

Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa (=ectodermo), que producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación, tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso, porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso.

El denominado carcinoma del epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, el rellenarse de la úlcera.

Entre el endodermo y el ectodermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media (=mesodermo).

Los órganos controlados por el cerebelo producen tejido “en exceso” en la fase de conflicto activo, como los órganos controlados por el tronco cerebral. Los órganos mesodérmicos controlados por el neoencéfalo en la fase de conflicto activo, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también “reducciones”, es decir, osteólisis, necrosis del tejido conector, depresión de la hemopoiesis.

En la fase de reparación vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo “sarcoma”, aunque en general sea inocuo.

Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que sé no ha sido considerado jamás, aún siendo tan fácil y lógico.

En la Nueva Medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito comprende la correlación entre psique, cerebro y órganos; el segundo la correlación entre modelos de comportamientos y conflictivos en relación a las

hojas embrionales correspondientes. Sin embargo podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal (familia, estirpe, manada, grey, etc.) y por otra parte el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años.

Desde este punto de vista es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como “producción de carne” o “producción animal”. Esto va tanto contra cualquier código de nuestra naturaleza, que ya no tenemos el derecho de llamarnos hombres hasta que no pongamos en orden esta deformación religiosa de la raza humana.

Mis adversarios quieren ridiculizarme: “Para Hamer incluso los animales tienen alma, ¿quién se puede creer algo así?”. Estoy convencido. De hecho lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre, y si consideramos nuestra alma como la integral de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras “co-criaturas”, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes, posean un alma?. Igual que hoy en día no se acepta la idea de la esclavitud, de la misma manera espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales.

La Nueva Medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante, por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y con cualquier caso.

Incluso la distinción conceptual entre psique, cerebro y órgano es ficticia académicamente.

Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra.

La Nueva Medicina es un sistema global y lógico donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, no conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo los síndromes (aparición al mismo tiempo de varios síntomas).

Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos, cuyos Focos de Hamer se encuentran en distintos hemisferios cerebrales.

Las depresiones son conflictos de territorio con “balance hormonal” o conflictos sexuales en las mujeres zurdas.

También el lupus eritematoso, hasta ahora temido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados.

La leucemia es la segunda parte del programa EBS, la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos.

El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio.

La gota es la presencia al mismo tiempo de leucemia y conflicto del prófugo activo o carcinoma de los tubulos colectores renales, y así todo.

Cuando podemos reconocer el mecanismo de las interacciones, entonces la curación no es difícil.

La esquizofrenia es una enfermedad que se puede sanar completamente. Ya tras la conflictolisis, es decir, la solución de uno solo de los dos conflictos, el paciente ya no tiene la “mente dividida”. Tras la solución (posiblemente definitiva) de los dos conflictos estará completamente sano igual que una persona que siempre haya tenido buena salud.

Con los conocimientos de la Nueva Medicina, no siempre podremos resolver los conflictos, y algunas veces incluso tendremos que evitar hacerlo. Sin embargo conociendo los conflictos podremos curar a la mayor parte de los enfermos, aunque no a todos.

Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las 5 leyes biológicas.

La quinta ley biológica, la denominada “quintaesencia” es un desarrollo de las anteriores cuatro leyes biológicas de la Nueva Medicina.

Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes, válida tanto para el hombre como para los animales y plantas.

Incluso para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos.

Esto significa: hoy por primera vez podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas, en el verdadero sentido de la palabra. Podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica, se basa en leyes científicas naturales reproducibles en todo momento.

Seguidamente añadido una tabla en la que he contrapuesto las diferencias más importantes entre la Nueva Medicina y la medicina clásica:

	MEDICINA CLÁSICA	NUEVA MEDICINA
Visión del mundo	Visión mecanicista-materialista del mundo del s. XIX: parte todavía hoy del presupuesto de que las causas patógenas se encuentran dentro o cerca de la célula (patología celular de Virchow). Especialización: unidad siempre más pequeña, por ejemplo, genes o su manipulación, virus o parte de virus.	El cosmos del hombre, el animal y las planta; en la naturaleza se manifiesta lo divino con las 5 leyes biológicas. Todos los seres vivientes tienen alma. “Dado que en realidad todo es uno y una cosa no se puede concebir sin la otra”. Visión de conjunto, sinopsis.
Pensamiento	Monodimensional: conoce sólo un nivel, el nivel del órgano o de la célula. En	Pluridimensional: conoce tres niveles (psique, cerebro, órganos).

	este sentido también el cerebro se considera un "órgano". Pensamiento lineal exclusivamente.	Pensamiento en diferentes circuitos o ámbitos de coordinación = pensamiento correlativo.
Definición del concepto de enfermedad	Defecto, molestia, avería de la naturaleza. Células enloquecidas, proliferaciones insensatas, autodestrucción del organismo, maldad. La medicina clásica legitima continuas intervenciones "reguladoras" en todos los procesos.	"Enfermedad" como parte de un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza (EBS).
Tratamiento médico	Operaciones	Dar ayuda estando junto al paciente y dando explicaciones, motivos, visión de las causas de la enfermedad y comunicando el proceso de curación que seguirá. Estar atentos hasta que la naturaleza ha cumplido su trabajo.
Pacientes	"El que aguanta" sin derecho a hablar, porque "no entiende nada de medicina", el médico asumiría la "responsabilidad" del paciente, aunque realmente no lo hace.	Jefe del proceso, se le deja hablar y comunicar, ya que solamente él tiene la responsabilidad de su cuerpo, puede tomar por él mismo las decisiones.
Terapia	De modo sintomático en base a los "conocimientos" estadísticos de los "protocolos" internacionales. (por ej. Quimio).	En base a las causas, en los tres niveles, individualmente, siguiendo la naturaleza o siguiendo el programa especial, biológico y sensato.
Causa de la enfermedad	Desconocidas, se suponen sólo a nivel orgánico.	Conocidas, DHS.
Adquisición de conocimientos	Estadísticas, probabilidad.	Empirismo, leyes biológicas, cada caso individual es reproducible al milímetro científicamente.

5. LA LEY FÉRREA DEL CÁNCER. LA PRIMERA LEY BIOLÓGICA DE LA NUEVA MEDICINA

La LEY FÉRREA DEL CÁNCER es una ley biológica descubierta empíricamente que hasta ahora ha demostrado que es exacta, sin excepciones, en más de los 30.000 casos que he estudiado.

La LEY FÉRREA DEL CÁNCER es un sistema superdeterminado de tres funciones correlativas, por las cuales, si se conoce bien uno de los tres niveles, se puede deducir y determinar con precisión los otros dos.

La LEY FÉRREA DEL CÁNCER dice:

Primer criterio

Todo programa especial, biológico y sensato (**EBS**) se origina por un **DHS** (síndrome de Dirk Hamer), lo que equivale a decir por un shock

inesperado
extremadamente agudo, dramático y
vivido con sentimiento de aislamiento

que se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los tres niveles

psíquico
cerebral
orgánico

Segundo criterio

El contenido del conflicto determina, en el instante del **DHS**, tanto la localización del programa **EBS** en el cerebro como Foco de Hamer (FH), como la localización orgánica como tumor o enfermedad oncoequivalente.

Tercer criterio

El desarrollo del programa **EBS** en los tres niveles (psique-cerebro-órgano) es **sincrónico**, desde el DHS hasta la solución del conflicto (conflictolisis = CL) incluida la crisis epiléptica/epileptoide al final de la fase PCL de reparación y el regreso a la normalidad (normotonía).

5.1. El primer criterio de la ley férrea del cáncer

El descubrimiento de la LEY FÉRREA DEL CÁNCER comenzó con la muerte de mi hijo Dirk, que, golpeado mortalmente por un príncipe italiano frente a la isla de

Caballo, cerca de Córcega, en el alba del 18 de agosto de 1978, en condiciones terribles, murió entre mis brazos en la clínica universitaria de Heidelberg casi 4 meses más tarde, el 7 de diciembre de 1978.

Enfermé entonces de un carcinoma testicular, más exactamente de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Intenté oponerme a los catedráticos de Tübingen que aconsejaban operar el testículo tumefacto. Ya en aquel tiempo tenía la vaga sospecha de que, a causa de la muerte de mi hijo me había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal, porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. El corte histológico evidenció un teratocarcinoma intersticial. Tras mi convalecencia decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto que pudiera.

La ocasión se presentó en 1981 cuando comencé a trabajar como médico jefe interno en una clínica de oncología.

La LEY FÉRREA DEL CÁNCER, descubierta el verano de 1981, parecía al principio que sólo era válida para los cánceres de tipo ginecológico. Pero enseguida resultó que se podía aplicar a todos los tipos de cáncer. Al final vi que efectivamente todas las denominadas “enfermedades” eran o bien cánceres o enfermedades oncoequivalentes, es decir, algo parecido al cáncer. Por lo tanto era lógico que la LEY FÉRREA DEL CÁNCER se pudiera aplicar a todas las enfermedades consideradas en medicina. Esta ley vale para toda la medicina. Su nombre no se ha cambiado, aunque bien se podría llamar: “LEY FÉRREA de toda la medicina”.

5.1.1. Definición del concepto de “conflicto” en la ley férrea del cáncer.

Un conflicto siempre se debe poder definir de tal modo que la definición pueda valer en líneas generales para todos los seres vivos. Yo, con la palabra conflicto, conceptualmente, entiendo “conflicto biológico”.

Un profesor universitario de psiquiatría, como ya hemos mencionado, fue interrogado por el juez, que quería saber como definiría en su lenguaje, por ejemplo, el conflicto sexual que el Dr. Hamer había encontrado en un proceso conflictivo en el que la mujer había cogido al marido in fraganti y ahora presentaba un “Foco de Hamer” encima del oído izquierdo.

Respuesta: “Lo llamaría una ofensa narcisista”.

Mi contrapregunta fue: “¿Usaría usted los mismos términos para definir un conflicto semejante en mi perra?” No hubo respuesta. Aquí nos caemos del burro: nuestras definiciones de conflicto en la medicina oficial siempre se han producido de un modo religioso-filosófico-psicoanalítico, justo dogmático.

Para mí no existen dogmas que puedan limitar una ciencia. Si descubro que el hombre y el animal se enferman por un mismo tipo de conflicto biológico y que se pueden observar los mismos procesos y las mismas modificaciones en el ámbito psíquico, cerebral y orgánico, entonces las conclusiones, las reglas o las leyes tienen que adaptarse a estos hechos y no viceversa.

En el sistema conceptual de la Nueva Medicina el conflicto no se entiende por lo tanto en el sentido del denominado psicoanálisis, es decir, como una construcción llevada por decenios de una “constelación conflictiva”, sino como un conflicto

biológico. Este conflicto biológico, que en el momento del DHS ataca al hombre y al animal como si cayese un rayo encima se produce instantáneamente y causa un Foco de Hamer en el cerebro dando inicio al programa especial biológico en el organismo entero. Obviamente también la personalidad entera se ve involucrada en el contexto de un conflicto biológico. Pero en general eso no es un factor decisivo. Puede bastar una única palabra (por ejemplo “cerdo”), dicha durante una pelea violenta con la suegra a causa de los niños, para producir un DHS. En ese mismo instante se define el contenido conflictivo percibido por el paciente.

Este por ejemplo enferma de un conflicto de no poder marcar el territorio, con un Foco de Hamer (FH) a la derecha periinsularmente y a nivel orgánico de una úlcera de la mucosa de la vejiga. Desde ese momento todos los elementos de la pelea de este conflicto biológico transcurren en esta “vía de contenido conflictivo”. La suegra también habría podido gritar “imbécil”. Entonces el paciente habría podido sufrir un conflicto de desvaloración personal y el resto de la pelea habría tenido como base la falta de autoestima del paciente, que se preguntaría si es imbécil o no. Habría tenido una “vía conflictiva” completamente distinta.

El conflicto biológico se decide en el instante del DHS, es decir, en ese segundo se define el contenido conflictivo en cuya vía, a su vez, transcurre todo el conflicto biológico.

Una mujer, por ejemplo, que ha cogido a su marido “in fraganti”, no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual, ni cualquier otro conflicto biológico. Sufrirá un conflicto sólo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperada. Cuando después se llega a un DHS, existen una serie de distintos contenidos conflictivos posibles:

Primera posibilidad: la paciente en el DHS vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída (de no aparearse). A nivel cerebral sufriría un FH a la izquierda periinsularmente, a nivel orgánico una úlcera de la mucosa del cuello del útero con el consiguiente carcinoma (si se trata de una diestra), con úlcera en las venas coronarias del corazón.

Segunda posibilidad: la paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido. En el momento del DHS vive la situación como una afrenta y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del DHS sufre un conflicto del nido a causa del partner, a nivel cerebral un FH en el cerebelo a la izquierda y a nivel orgánico un cáncer de mama derecha (si se trata de una diestra).

Tercera posibilidad: la paciente en el momento del DHS experimenta a la joven rival como un conflicto de caída de la autoestima. “Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar”. La paciente en este caso sufriría en el momento del DHS

un conflicto biológico de desvaloración de la autoestima, un FH en la médula occipital y una osteólisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos.

Cuarta posibilidad: la paciente quizás ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría, en el momento del DHS, experimentar la misma situación como un conflicto de territorio con un FH a la derecha periinsularmente y un carcinoma intrabronquial o si se trataba de un “conflicto de no poder marcar el territorio” con el atributo “que asco”, un carcinoma de la vejiga (si se trata de una diestra).

Quinta posibilidad: a menudo se produciría sin embargo un carcinoma de los ovarios, como conflicto de pérdida y “con fondo semisexual repugnante” con un FH en la zona paramediana occipital.

Vemos por lo tanto que un suceso, una situación no se perciben jamás de un solo modo. Solo el modo de vivirlos en el instante del DHS determina el contenido conflictivo y por lo tanto las “vías” sobre las que correrá el resto del conflicto biológico.

Estos nexos vuelven absurdas también las propuestas infinitamente ignorantes de los denominados “estudios prospectivos”.

La “no convertibilidad” de un sistema no es una debilidad científica, sino que deriva forzosamente del hecho de que es casi imposible para un investigador pronosticar con una cierta seguridad, en que dirección o sobre que “vía” vivirá o sufrirá el paciente un conflicto pensado prospectivamente.

También los parientes más próximos son a menudo muy estúpidos, si han estudiado, por ejemplo, que conflicto podría haber causado el cáncer diagnosticado al paciente.

A menudo dicen: “Sólo puede haberse tratado de esto o aquello”. Si se interroga al paciente frente a sus parientes, a menudo dice: “No, eso no me ha afectado para nada”. Y eso que ha causado realmente el DHS y el conflicto nos deja a todos atónitos. Seguidamente, cuando han entendido la cuestión, a menudo dicen: “Sí, no podía ser de otra manera”.

Un muy buen ejemplo de esto fue el caso de un paciente de la clínica universitaria de Erlangen, al que pude visitar en su habitación de reposo.

Había sufrido un infarto cardíaco agudo. Entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio con DHS.

Se nos preguntó cual había sido el conflicto de territorio. En presencia del médico del departamento le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Respuesta: ninguno. Era un hotelero renombrado, en su ejercicio servía a notables de todo el país, tenía dos hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien, no se podía hablar de ningún conflicto de territorio.

Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar. Respuesta: desde hace seis semanas. Tras el electrocardiograma pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé: unas seis semanas antes tenía que haberse producido la conflictolisis; el conflicto podía haber durado como máximo 3 o 4 meses. Le dije: "Hace seis meses ha tenido que pasar cualquier cosa grave, que le ha impedido dormir por algunas noches. Y hace 6 u 8 semanas la cosa se ha solucionado". "Si, doctor, ahora que me lo dice, pero yo no puedo ni imaginarme que una cosa así me haya podido causar un infarto". Había sucedido lo siguiente.

La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban estos pájaros.

No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar iba a la jaula y contemplaba sus pájaros, que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta: todos los pájaros habían desaparecido. "Ladrones" fue su primer pensamiento, provocando así su DHS. Los ladrones han entrado en mi territorio. Vinieron los vecinos, examinaron toda la jaula. Al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra: "comadreja".

Desde ese momento el paciente sólo tenía un pensamiento en la cabeza, capturar la comadreja.

Tras algunos intentos fallidos consiguió que cayera en la trampa. Sólo entonces fue posible reconstruir la jaula, "a prueba de comadrejas", y adquirir nuevos pájaros. Tras unos 3 meses y medio todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente.

Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso (en el período de conflicto activo) de haber perdido un par de kilos. Pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros dos kilos.

Durante toda la conversación el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado atónito. Entonces se levantó y dijo: "Señor Hamer, estoy muy desconcertado. Quizás se está echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso su demostración me ha superado".

Incluso el paciente dijo: "Si reflexiono ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con que se me podría haber golpeado más fuerte que robándome los pájaros".

Esto no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa de hecho si el conflicto parece todavía importante, cuando ya todo se ha "normalizado". Entonces en el instante del DHS el paciente lo ha sentido como tal, y eso ha sido decisivo. Seguidamente el conflicto ha desarrollado una dinámica propia.

Alguien, aunque se tratase sólo de una pequeña comadreja, había entrado en el territorio del paciente.

Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no, eso no le dejaba tranquilo, como se dice normalmente.

Sólo cuanto hubo neutralizado al adversario pudo reconstruir "en paz" su territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto de territorio.

5.1.2. El síndrome de Dirk Hamer (DHS)

El DHS es la base de la Nueva Medicina, constituye la piedra angular de todo el diagnóstico.

Cada vez es una nueva experiencia, aunque ya la haya vivido muchos miles de veces.

No son conflictos cualquiera que, comenzando lentamente, causan la enfermedad del cáncer, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante, inesperado, que cae sobre las personas dejándolas de piedra e incapaces de decir una sola palabra, consternadas.

Dieses Sportfoto einer Zeitung aus Lyon soll veranschaulichen, wie ein Torwart „auf dem falschen Fuß“ erwischt wird, konsterniert dem ganz langsam ins linke Toreck trudelnden, abgefälschten Ball nachsieht. Er hatte den Ball ins andere Eck erwartet.



Eine ähnliche Konstellation im übertragenen Sinne finden wir beim DHS, dem Konflikt-Schock, bei dem der Patient auch „auf dem falschen Fuß“ erwischt wird. Denn eine Konfliktsituation, auf die er sich vorher einstellen konnte, die macht ihm kein DHS. Genauso wie ein Torwart die fantastischsten Glanzparaden liefern kann und den Ball aus dem äußersten Toreck herausfaustet, wenn - ja, wenn der Ball dorthin fliegt, wohin ihn der Torwart herechnet hatte; so können wir Menschen alle ein Vielfaches an Konflikten ertragen, ohne davon krank zu werden, wenn wir vorher Zeit haben, uns darauf einzustellen.

Wir Menschen haben heute weitgehend die Beziehung zu unserer Umwelt und zu unserer Mitkreatur Tier verloren. Nur so konnte die mehr oder weniger instinktlose Vorstellung von intellektuellen Konflikten entstehen, die keinerlei Beziehung haben zur biologischen Realität. Man hatte sich eben weit von der Empirie⁶³ entfernt und Fälle konstruiert, die gar nichts mit dem wirklichen Erleben des Menschen zu tun haben, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Krankheitsentstehung.

Der Mensch fühlt und empfindet aber in Wirklichkeit nach archaischen biologischen Regelkreisen, empfindet eben biologische Konflikte, während er sich einbildet, losgelöst von der Natur zu denken.

Durch die moderne Zivilisation, die sich ja an keinerlei biologische Grundformationen hält, kommen wir Menschen in ein furchtbares Dilemma. Folgen wir den Verhaltensmustern, die uns die Natur vorgegeben hat, so müßten wir alle Arten von gesellschaftlichen Nachteilen in Kauf nehmen, die uns

⁶³ Empirie = Erfahrung, auf Erfahrung beruhende Erkenntnis

Esta fotografía, cogida de un periódico de Lyon, muestra como un portero es cogido a contrapié y mira consternado el balón, que desviado rueda lentamente hacia la esquina izquierda de la portería. Él se esperaba que el balón llegase por la otra esquina.

Encontramos una constelación parecida, en sentido figurado, en el DHS, en el shock conflictivo, en el que también el paciente es cogido “a contrapié”.

De hecho una situación conflictiva, que ya esperaba de antemano, no le causa ningún DHS. Igual que en el caso en el que un portero puede realizar la parada más fantástica golpeando el balón para desviarlo desde el ángulo más extremo de la portería, cuando el balón llega por el sitio que el portero esperaba.

Del mismo modo todos nosotros podemos soportar gran número de conflictos, sin enfermar, si con anterioridad hemos tenido tiempo de prepararnos.

Hoy en día hemos perdido en gran parte el contacto con nuestro ambiente y con nuestros compañeros los animales.

Sólo así podía surgir la idea –mas o menos falta de instinto- de conflictos intelectuales que no tiene ningún tipo de relación con la realidad biológica.

También nos hemos alejado del empirismo, construyendo casos que no tienen que ver nada con la experiencia real del hombre, y jamás con un nexo con el origen de la enfermedad.

Pero el hombre en realidad siente y percibe según reglas biológicas arcaicas e incluso percibe los conflictos biológicos mientras cree que piensa de un modo cercano a la naturaleza.

A causa de la civilización moderna, que no se basa en ningún modo en las formaciones biológicas fundamentales, los hombres vivimos un terrible dilema. Si seguimos los modelos de comportamiento que la naturaleza nos ha dado, nos encontramos forzosamente en la situación de tener que aceptar cualquier tipo de desventaja social que nos llevaría a la ruina. Si por el contrario seguimos las normas que nos han creado los políticos, juristas y la iglesia, que en su mayoría son contrarias a nuestro código arcaico personal, entonces vamos de cabeza al conflicto que ya estaba programado.

Realmente bajo el perfil teórico es posible, aparentemente, manipular a placer a los hombres con leyes cualquiera, pero la cuenta que pagamos es terrible.

Siempre ha habido adaptaciones a las condiciones ambientales modificadas del tipo más diverso; justo de eso depende la evolución de la naturaleza. Estos cambios (“mutaciones”) normalmente duran muchos cientos de miles de años. Por el momento y para los próximos 100.000 años eso no nos ayuda en nuestro dilema.

Hasta ahora la mayor parte de las personas no eran conscientes de esto o no se rendían cuenta del modo correcto.

La Nueva Medicina asume el ejercicio de buscar y de encontrar una respuesta. No por esto dejaremos de tener conflictos, conflictos biológicos. Porque también el conflicto biológico forma parte de la naturaleza y no es ni bueno ni malo. Simplemente es una realidad y en la naturaleza representa un medio para la selección y la conservación de la especie. Y yo creo que seremos más felices si vivimos nuevamente según el código de nuestro cerebro.

En el caso de un conflicto biológico el DHS (SÍNDROME DE DIRK HAMER) es un shock grave vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. El DHS desencadena el programa especial,

biológico y sensato (EBS) de la naturaleza como reacción coherente a un accidente o un caso de emergencia al cual el organismo no ha podido reaccionar (desde el comienzo). Representa por lo tanto una posibilidad de recuperación que la naturaleza ofrece.

Nótese:

El DHS tiene las siguientes características y los siguientes significados:

1. El DHS se origina como experiencia de shock imprevista por un conflicto biológico, casi en un instante.
2. El DHS determina el contenido conflictivo, con más precisión, el contenido del conflicto biológico. Sobre esta "vía" corre el sucesivo conflicto.
3. El DHS determina la localización del Foco de Hamer (FH) en el cerebro a través del contenido del conflicto biológico.
4. El DHS determina la localización de la enfermedad cancerosa en el órgano definiendo el contenido del conflicto biológico y definiendo la localización del FH en el cerebro.
5. El DHS y, en el caso en el que se produzca, la conflictolisis son importantes pilares de sustento de toda anamnesis de conflicto biológico. En cualquier caso es indispensable descubrir exactamente el DHS, también cuando el conflicto se ha resuelto ya, ya que sólo es posible evitar una recaída conflictiva cuando se conoce con precisión el DHS originario.
6. El DHS modifica inmediatamente no sólo el tono vegetativo causando la simpaticotonía permanente, sino que modifica también la personalidad, como bien se puede notar en el denominado "conflicto en suspensión".
7. El DHS causa desde el primer momento un tipo de simpaticotonía permanente en el cerebro en el punto del Foco de Hamer. En este cambio está involucrado, más o menos, todo el cerebro.
8. El DHS causa desde el primer momento un cáncer o una enfermedad oncoequivalente en el órgano.

El cáncer en el órgano tiene diferentes formas de manifestación:

- A. Fuerte crecimiento celular por mitosis si están afectados los órganos de la hoja embrional interna (endodermo).
 - B. Hoja embrional media:
 - a) El mesodermo del cerebelo produce un crecimiento mitótico durante la actividad conflictiva.
 - b) El mesodermo del neoencéfalo (médula cerebral) causa necrosis en la fase de conflicto activo, en la fase de curación una reconstitución de la necrosis que se llama sarcoma.
 - C. Reducción celular con úlcera del ectodermo del neoencéfalo. Modificaciones de la función en caso de activación del tronco del simpático (sistema endocrino, de la hipófisis, de la tiroides, de las células insulares alfa y beta del páncreas), sin reducción celular.
9. Si un DHS ha desencadenado un conflicto biológico que todavía está activo y tiene su FH en un hemisferio cerebral y se añade a otro DHS que tiene su FH en la corteza cerebral del hemisferio opuesto, entonces se produce la

constelación esquizofrénica. El paciente delira o se vuelve furioso sólo cuando el conflicto está fuertemente acentuado en el lado cerebral izquierdo, maníaco y tiene una constelación denominada “agresivo-biomaníaca”. La constelación esquizofrénica también puede surgir en el caso de un único DHS doble (donde los conflictos activan al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales).

10. Por “DHS doble” entendemos un conflicto que tiene dos aspectos, por ej. un conflicto de territorio con desvaloración de sí o un conflicto madre/niño con desvaloración de sí en el ámbito madre/niño al mismo tiempo (por ej. el niño dice: “tú eres una madre muy mala, una madre sin corazón”).
11. El DHS es la posibilidad biológica que el individuo recibe de madre naturaleza para equilibrar nuevamente un “suceso que desgasta”. Sin el DHS, por ejemplo, el ciervo no tendría ninguna posibilidad de reconquistar su territorio. En el instante del DHS la madre naturaleza pasa ya a un “programa especial” para superar el obstáculo en la segunda tentativa. El DHS es la señal de partida hacia la posibilidad biológica del programa especial, biológico y sensato (EBS).
12. Si un DHS junto a una “vía principal” de DHS tiene también otra “vía secundaria”, que llamamos en parte cáncer o enfermedad oncoequivalente, por ej. las “alergias” (las percepciones ópticas, acústicas, olfativas o gustativas en el momento del DHS), el paciente puede volver a meterse en la “vía principal” “apoyándose” momentáneamente en una sola de estas “vías secundarias” y sufrir una recaída del conflicto. Ejemplo: cada vez que un hombre usa una determinada loción para la barba, piensa en el novio de su mujer, su rival, que utilizaba esa loción. Cada vez sufría dolores en el corazón, una recaída de su antiguo conflicto de territorio con angina de pecho.

Si se toca el argumento del DHS de una persona, a ésta normalmente se le vienen las lágrimas a los ojos, signo de su carga emotiva. Cada recaída conflictiva tiene lugar no poco a poco, sino solamente con un nuevo DHS. Es esto lo que llamamos “binario”.

Obviamente el DHS de recaída, que nos vuelve a meter en la vía conflictiva, no conlleva necesariamente la fuerza emotiva de la primera vez. Podríamos llamarla también “memoria intensa”.

Las vías, a menudo son incluso más de una, no son algo negativo, una especie de avería permanente de la naturaleza, sino que en la naturaleza son un modo, importante para la supervivencia, de refrescar la memoria: “Atención, en un caso similar en el pasado sucedió una catástrofe, estate atento”. Podemos llamar también a esta vía: alergia.

Repetimos: el conjunto de los factores presentes en una experiencia conflictiva inesperada de shock, es decir el DHS, causa el conflicto, no al revés. Si no se hubiese producido esta situación particular, probablemente no se habría llegado jamás a un conflicto biológico. No se trata de entender este conjunto particular de factores conflictivos, aparente o realmente casuales que desencadenan el DHS, dado que no podemos entender los sucesos casuales. Estos conflictos de DHS biológicos son, sin embargo, accidentales sólo en un “sentido restringido”. En un ámbito biológico más vasto estos procesos naturalmente tienen su sentido, por ejemplo, como regulación para la conservación de la especie.

Esto no sirve de consolación al individuo concreto que se sacrifica para conservar la especie. Pero tampoco los hombres tenemos escrúpulos con nuestros animales y aceptamos con algo sensato sacrificar los animales de modo que nuestra especie homo sapiens pueda continuar viviendo.

Quizás para algunas personas, que con gusto querrían ver una “intervención atribuible a un dios personal”, es difícil entender que Dios se entromete en su vida con esas constelaciones aparentemente “casuales”. La ignorancia de los conflictos biológicos y de sus consecuencias les hacía creer que el mundo espiritual humano y metafísico era dominable y valorable.

Esto es ciertamente un “pío” error.

Una cuestión como el DHS, que se encuentra en el mismo instante en el cerebro como foco de Hamer, no se puede negar mucho más tiempo tampoco desde el punto de vista religioso-filosófico, es una pura y simple realidad.

5.2. El segundo criterio de la LEY FÉRREA DEL CÁNCER.

Si una persona (o un animal o una planta) sufre un DHS, es decir, un shock extremadamente agudo, dramático y vivido en un sentido de aislamiento, a nivel de su subconsciente asocia el contenido del conflicto biológico desencadenado por el DHS a un ámbito biológico conceptual, por ejemplo, al ámbito de la relación madre/niño o al ámbito “territorio” o al ámbito “agua” o “miedo en la nuca” o “autoestima” o a otros ámbitos parecidos.

También aquí, “en el instante del DHS”, el subconsciente sabe hacer distinciones precisas: jamás una desvaloración de sí mismo en la esfera sexual (debida por ejemplo a una palabra como “blandengue”) causa osteólisis de las vértebras cervicales, sino siempre osteólisis de la pelvis, con el consiguiente cáncer óseo de la pelvis en la fase de curación. Jamás un conflicto de desvaloración de sí en la relación madre/niño (“madre desnaturalizada”) causaría osteólisis de la pelvis, pero sí una osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo (en las diestras).

Creemos que pensamos. En realidad la naturaleza “piensa” con nosotros.

A cada ámbito conceptual biológico le pertenece un determinado relé en el cerebro, que en el caso de enfermedad llamamos “Foco de Hamer”.

Cada ámbito conceptual biológico tiene su “propio relé”.

En el instante del DHS, unos códigos particulares van del FH al órgano correspondiente a este FH. Se puede por lo tanto decir que cada FH tiene “su órgano”. Así el suceso a tres niveles psíquico, cerebral y orgánico en realidad es un suceso con curso sincrónico del FH al órgano con la diferencia de una fracción de segundo.

La mayor parte de los pacientes saben indicar el DHS con una precisión casi al minuto, porque se trata siempre de un momento dramático.

Por lo general los pacientes estaban “rígidos por el miedo”, “incapaces de hablar”, “como paralizados”, “profundamente asustados” etc, etc. Por medio de la TAC (tomografía computerizada) se puede ver el DHS que en el cerebro ha atacado a

partir del primer segundo, que aparece como una configuración concéntrica de anillos nítidos (FH activo), mientras que en el órgano se vuelve a encontrar desde el primer segundo como un tumor que comienza a crecer en ese instante (o como necrosis en los órganos directos del cerebro).

En el instante del DHS todo está ya programado o previsto: en correspondencia con el contenido del conflicto biológico en el instante del DHS, como hoy bien podemos determinar con las tomografías computerizadas, se produce una “conmutación” (activación) en un área cerebral bien definida, establecida desde el principio (Foco de Hamer).

En el mismo momento se inician también las modificaciones del órgano, expuestas con precisión en la tabla “psique-cerebro-órgano”, pronosticables mediante observaciones empíricas: puede tratarse tanto de una proliferación como de una reducción celular o de alteraciones funcionales (en las denominadas enfermedades oncoequivalentes).

Por eso he hablado de “conmutación”, porque, como veremos seguidamente, el DHS es “sólo” un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación imprevista.

No existe una “enfermedad” en el sentido estricto según la definición que se nos ha enseñado en el pasado en las universidades.

Según aquel concepto, considerábamos que la “enfermedad” era un error de “Madre Naturaleza”, por ejemplo que el supuesto “sistema inmunitario” (entendido como el ejército de defensa de nuestro organismo) estuviese “enloquecido”. Pero “Madre Naturaleza” no comete semejantes errores, se trata por el contrario de errores aparentes, deseados, que tienen su sentido.

5.3. El tercer criterio de la LEY FÉRREA DEL CÁNCER.

El tercer criterio de la Nueva Medicina dice que el decurso de toda la denominada enfermedad, incluida la fase de curación, es sincrónica en los tres niveles. Este sincronismo está definido por criterios precisos que tienen que ver con los síntomas típicos de conflicto activo en los niveles psíquico, cerebral y orgánico y con los típicos síntomas de la fase de reparación en conflicto resuelto, también en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. A estos se añaden también los típicos síntomas en los tres niveles de la crisis epiléptica o epileptoide que son un poco diferentes para cada enfermedad, pero nuevamente del todo típicos, tanto si se trata de síntomas cerebrales y orgánicos (por ejemplo el infarto cardíaco como crisis epileptoide de la úlcera de las coronarias), como si se trata de síntomas psíquicos y vegetativos.

Con este instrumento, es decir, con el conocimiento de la regularidad y el conocimiento de los síntomas típicos en el transcurso en los tres niveles, ahora, por primera vez en la medicina, se puede trabajar correctamente en base a las causas y de un modo prácticamente reproducible.

6. El sistema codificado del cerebro. El fundamento de los conflictos biológicos.

Cuando se habla de conflictos biológicos hay que definir que es la sustancia de tales conflictos biológicos.

En el capítulo dedicado al sistema ontogenético de los tumores encontrareis, queridos lectores, cuales son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos.

Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son sólo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos biológicos.

Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico o que deberían seguir una cierta regularidad, en el cerebro del individuo tienen que tener algún principio que posibilita tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo "sistema codificado del cerebro".

Podríamos también hablar, al contrario que de comportamiento codificado, de "suma de modelos comportamentales".

En sustancia todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice. Importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin; además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es sólo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Esto sí que es un concepto nuevo.

Existe ya toda una serie de experimentos y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos, es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. La formaldeide o HCHO , según la fórmula química, o aldeide de ácido fórmico, un gas incoloro, de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues bien, habría producido cáncer en las ratas.

Normalmente las ratas se mantienen alejadas del formol que se emplea en una dilución normal para desinfectar las salas de operaciones porque ese olor les molesta muchísimo.

Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta aversión y habían preparado el formol en una concentración mil veces superior para (no os lo perdáis) echarles varias veces al día esta sustancia tan concentrada en el morro. Los pobres animales, a los que obviamente se les negaba que poseyesen un alma, sufrían diariamente una recaída de DHS causada por los investigadores.

Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron “liberados” poco a poco y se examinó su morro en el microscopio: los primeros ratones asesinados tenían “sólo” una úlcera de la mucosa nasal.

Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco tras el experimento y que entraron en una fase PCL (con rellenado de la úlcera por multiplicación celular) tenían un cáncer de la mucosa nasal.

¿Es que podría haber sido de otro modo?

Y dado que según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un shock de conflicto biológico, sólo quedaba una conclusión posible: la formaldeide causa cáncer. Un resultado fruto de la estupidez.

Realizando el mismo experimento con una sustancia apestosa concentrada también cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal.

Pero hoy en día los investigadores de este tipo, puramente intelectuales, son ajenos incluso a la sola idea de estas reflexiones.

Según mi modo de interpretar, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura provocando una nueva recaída del DHS, se causa siempre un cáncer en el animal. Sin embargo todavía nadie ha conseguido provocar un cáncer en un órgano que estaba separado del cerebro, es decir, en un órgano in vitro.

In vitro se pueden cultivar, en la práctica, solo sarcomas, es decir, proliferaciones de tejido conectivo.

Estas células de tejido conectivo contienen en su propio bagaje, por decirlo así, el impulso de proliferación gracias al cual, en los procesos de cicatrización, tienen la función de reparar curando rápidamente las heridas del cuerpo. También el tejido fetal posee un “impulso de crecimiento” análogo durante un tiempo relativamente breve (en el hombre hasta nueve meses, como máximo la duración del embarazo).

A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan, en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales.

Seguidamente veremos que, por ejemplo en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir dos o tres años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio.

Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la “enfermedad”, que se considera simplemente un enemigo o un mal, un castigo de Dios.

Todo esto son proyecciones superadas, que derivan del Antiguo Testamento, de una imagen del mundo bastante primitiva en la que la enfermedad es algo malo, innatural, donde los animales no tienen alma, sólo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer.

El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento.

Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie al final se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto: un gado no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante, sin embargo huye inmediatamente si ve de lejos un perro. Así cada raza animal y también cada raza humana ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento codificado con el que puede o podría vivir en su reserva ecológica.

Un patito es capaz de nadar desde el primer día de vida sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de la madre.

Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral en relación al territorio, defendiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece a su código "interno".

Y así es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente del modo correcto, como sonámbulos, en base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización.

Las mujeres, durante millones de años, han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. La madre siempre ha sabido como tenía que parir su hijo, es decir, en la posición acurrucada, que es la más fácil fisiológicamente, y también sabía que tenía que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo limpiado. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer, en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia, hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a practicar la denominada cesárea, nos deberíamos preguntar como nos tenemos por inteligentes. Por suerte en tiempos recientes las mujeres han reconquistado nuevamente el derecho a un parto natural a los médicos, en su mayoría hombres...

También para crear los propios hijos los hombres tenemos que leer grandes libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual denominado pedagógico, que en su mayoría no funcionan en la práctica.

Cualquier perra madre y cualquier gorriona madre lo hace mucho mejor sin universidad. Ciertamente es también que no hay ninguna raza animal sobre la tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado de la raza humana civilizada.

Pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro, en la práctica cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de este código de comportamiento. Y sin embargo las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso: cada DHS es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y Foco de Hamer, órgano y cáncer. Jamás hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo entre los hombres y "sus" bacterias, todo esto junto constituye la ley de la naturaleza. Cada trasgresión es una especie de asesinato o suicidio. Sólo los "aprendices de brujo", a causa de su ignorancia, intentan algo así.

6.1. La evolución de los procesos biológicos del cáncer en comparados en el hombre y en el animal.

Un animal no tiene nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro. El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que este se resuelva en realidad o hasta que el animal muere por un conflicto no resuelto y el cáncer.

Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada “enfermedad cancerosa” no es un error, no se trata de una célula que ha perdido el control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable.

En el animal observamos, lo que en el hombre podemos sólo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior no previsto en la naturaleza, para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad (más individuos pero menos fuertes).

También sucede así para los hombres, cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza que todavía no está manipulada por los hombres, vemos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos, que han sufrido con un DHS, y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver “psicoterapeuticamente” la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de un territorio, sino que lo tienen que hacer de un modo real.

Sin embargo vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar un conflicto.

Pensemos solamente en los rituales fúnebres, que todos conocemos, de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada.

¿No hacemos lo mismo los humanos con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación, para después velarlo.

Prescindiendo de estas “ayudas rituales” de los mamíferos más desarrollados, en general los animales tienen que soportar solos su enfermedad cancerosa, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares, o de otro modo el individuo se “descalifica”. Por ejemplo, el viejo ciervo, cada año, tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven y cuando llega el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir.

Por lo tanto, en general, la “terapia” del conflicto biológico es la solución real del conflicto. Esta solución real puede consistir tanto en el restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. Por lo tanto, por ejemplo, o el ciervo viejo reconquista su territorio o expulsa al ciervo joven del territorio.

Una perra que haya perdido un cachorro, o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros o se pone de nuevo en celo (este último es el caso más frecuente).

Durante el embarazo, en general, reina la tranquilidad, es decir, no es posible ninguna actividad conflictiva, porque un embarazo, tras el primer tercio de la duración, transcurre en vagotonía y tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente.

Dado que normalmente los animales, a diferencia de los humanos, viven según el ritmo natural, la pérdida de un cachorro, por ejemplo, ya está prevista como algo “normal” en esta programación natural e igualmente la solución de ese “conflicto normal” por medio del sucesivo embarazo.

Por el contrario no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, en realidad no tiene mucho que ver con la biología.

Además, son poco frecuentes los innovadores sociales que se puedan considerar personas normales. Sustancialmente han sido una cruz para la humanidad; no se puede hablar de sabiduría si admitimos que la sabiduría fundamental conlleva el vivir lo más posible en armonía con el código preexistente en el cerebro y también con el de la psique o del alma. Para mí el más sabio sería aquel que nos hiciese entender a los hombres cómo se puede vivir en armonía con el código que la naturaleza nos ha dado, el lugar de realizar perversiones en guerras que eliminan la vida humana.

Si consideramos que el hombre y el animal (el mamífero) sufren de un modo análogo los conflictos que provocan el cáncer, podemos decir que también el cáncer a nivel orgánico es igual o comparable. También el Foco de Hamer en el cerebro del animal, en un punto correspondiente al del hombre, es igual o comparable. Pero si estos dos niveles son iguales o comparables, entonces hay un buen motivo para creer que también el nivel psíquico sea igual o por lo menos comparable.

Cuando digo que un animal ha sufrido un conflicto, entiendo un conflicto biológico, y esta afirmación resulta en general aceptable. Si añado que el animal, igual que el hombre, no tiene apetito, no consigue dormir, está en simpaticotonía, también se acepta, pero si afirmo que el animal “piensa” día y noche o revive su conflicto biológico y de noche sueña con ese conflicto, eso lleva inmediatamente a la indignación y el rechazo. Se sostiene que estos son atributos del pensamiento, algo exclusivo del ser humano. Pero no es verdad. El conflicto es análogo en el caso del hombre y el animal, es decir, en los dos sucede en los tres niveles. (¿No habéis oído nunca gemir a vuestro perro en sueños?).

Para muchos de nosotros, sobretodo aquellos que tienen determinadas ideas religiosas o ideologías, esta es una cuestión difícil de aceptar. Para mí, por el contrario, es la cosa más normal del mundo.

Por ejemplo, el contenido del conflicto de envidia por el alimento es ligeramente diferente para cada tipo de raza animal; diferente en el hombre, el contenido conflictivo está solamente traspuesto. Pero también los conflictos biológicos traspuestos del hombre se pueden reconducir siempre al modelo fundamental arcaico. La tabla siguiente, en la que se han seleccionado los tipos individuales de conflicto, os lo debería aclarar.

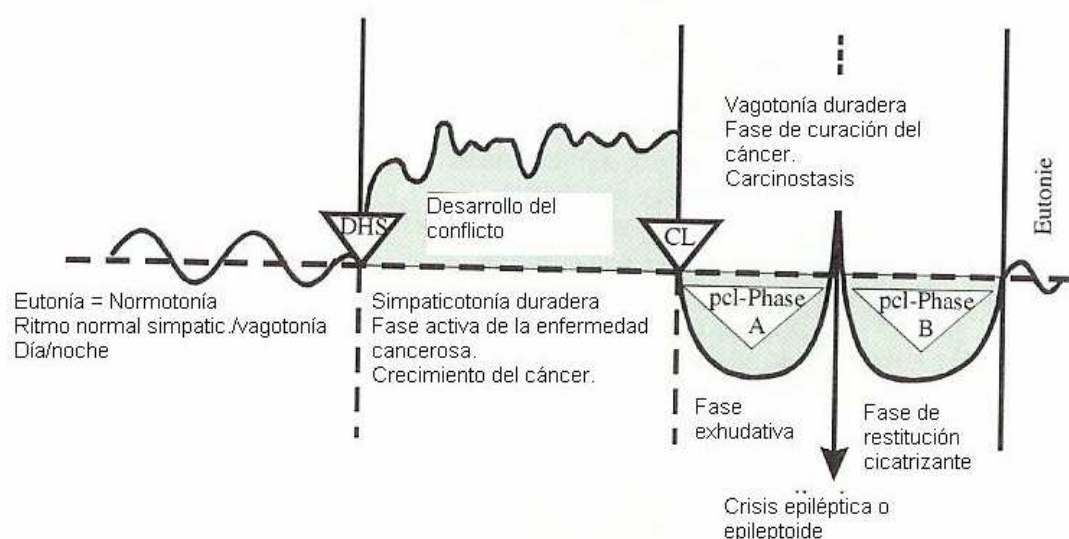
6.2. Comparación del conflicto biológico en el hombre y los animales

	HOMBRE	MAMÍFERO
Carcinoma de mama / carcinoma de los conductos latíferos, pecho izquierdo	Conflicto madre / niño Ej. niño desgraciado	Conflicto de territorio-nido. Ej. a la vaca le quitan el ternero.
Úlcera de los conductos biliares y colédoco	Conflicto de rencor en el territorio. Rencor, normalmente, hacia los parientes y a causa de dinero. Ej. peleas por la herencia	Conflicto de rencor en el territorio/de envidia por el alimento. Ej. el Teckel le quita los mejores bocados al pastor alemán jefe.
Úlcera del íntima de las coronarias. Úlcera de la mucosa bronquial	Conflicto de territorio Conflicto de territorio amenazado. Ej. pérdida del puesto de trabajo. La mujer o la novia se va con otro.	Ej. el ciervo joven echa al viejo de su territorio, la cierva se aleja del territorio y entra en el de otro.
Carcinoma del cuello del útero	Conflicto sexual femenino. Ej. la mujer sorprende al marido "in". Conflicto biológico arcaico por el hecho de que la otra es poseída y quizás embarazada su lugar.	Conflicto de no ser poseída. Ej. la perra en celo se tiene siempre lejos del macho, no puede tener cachorros.
Cáncer de los huesos (en fase de reparación leucemia)	Conflicto de desvaloración de sí mismo. Ej. el empleado no promociona, alguien no supera un examen o se le dice "tú tienes cáncer".	Ej. el perro no puede correr durante un determinado tiempo; el ciervo, en la lucha se daña los cuernos; el elefante se daña la trompa.

	UOMO	MAMÍFERO
Carcinoma de los testículos	Conflicto de pérdida Ej. el padre pierde al hijo o a un compañero	Ej. el perro pierde la persona de referencia o el compañero de juego
Carcinoma del recto Carcinoma de la vejiga	Conflicto de identidad Ej. al paciente le dice "tú	Ej. el ciervo rival del territorio colindante

	no sabes quien es tu padre". Conflicto de no poder marcar el territorio. Ej. la hija casada duerme siempre con otro hombre (carcinoma de la vejiga).	sobrepasa continuamente los límites de su territorio
Adenocarcinoma alveolar	Conflicto de miedo de la muerte. Ej. "tú tienes cáncer, no hay esperanza" o: el paciente sueña todas las noches con un accidente de coche que parece mortal.	Ej. En la experimentación con animales a los ratones se les echa humo continuamente, el gato está al acecho delante del nido del ratón, el ratón tiene que conseguir pasar.
Adenocarcinoma de los túbulos colectores renales	Conflicto del prófugo o de lucha por la propia existencia. Ej. al niño pequeño se le lleva de repente con una abuela que vive a 100 Km de distancia, donde todos le son desconocidos. El agua se retiene para no "deshidratarse". El niño, al nacer, es metido en una incubadora, que si que está caliente, pero donde la faltan los movimientos y la voz de la madre. Un elevado número de neonatos puestos en incubadora sufre una denominada "insuficiencia renal" = retención de líquidos.	Ej. la vaca es vendida y llevada con vacas que no conoce, sufre el conflicto del prófugo, acumula agua (retención de líquidos). El nuevo cachorro de una manada pierde de vista a la madre a causa de un accidente. Gracias a la retención hídrica añadida al conflicto obtiene dos días de tiempo para encontrar a la madre.

7. La ley de las dos fases de los programas especiales biológicos sensatos (en el pasado llamados enfermedades) en la solución del conflicto. La segunda ley biológica de la Nueva Medicina.



En este esquema se puede ver representado a la izquierda el ritmo normal día/noche.

Tras el DHS tenemos la fase de conflicto activo llamada fase de estrés, fase de día permanente o también de simpaticotonía permanente.

Tras la solución del conflicto (CL=conflictolisis) sigue la fase de reparación o fase nocturna permanente, llamada también vagotonía permanente, interrumpida por la crisis epiléptica o epileptoide, que es el punto de cambio de la fase de reparación. Desde ese momento en adelante el organismo tiende a retomar de nuevo la normalidad. Al final de esta fase de reparación se vuelve al ritmo normal día/noche.

Cada enfermedad o cada programa especial biológico de toda la medicina sigue un decurso de dos fases, es decir, primero se produce una fase de conflicto activo, fría, simpaticotónica a partir del DHS (fase CA) y después, si se llega a una solución del conflicto (conflictolisis), una fase de reparación o de solución del conflicto, denominada también fase caliente (fiebre) o vagotónica. Llamamos también a esta fase "fase de postconflictolisis", abreviadamente "fase PCL".

Toda enfermedad que conlleve una conflictolisis prevee también una fase CA y una fase PCL. Y toda fase PCL, si no se interrumpe por una recaída de conflicto activo, tiene una crisis epiléptica o epileptoide en el momento de la vagotonía más profunda.

La ley del decurso de dos fases de todas las enfermedades de la medicina entera da la vuelta totalmente a los conocimientos que creíamos tener.

Si hasta ahora conocíamos, aproximadamente, algunos cientos de las denominadas "enfermedades", con una observación mejor resulta que en cerca de la mitad de esas supuestas enfermedades el paciente tiene las manos frías, las zonas periféricas frías y que en la otra mitad de las supuestas "enfermedades" el paciente tiene las manos calientes y normalmente fiebre. Realmente sólo se han encontrado cerca de 500 "tamdems": primero (tras el DHS) una fase fría, simpaticotónica, de conflicto activo y seguidamente (tras la CL) una fase de reparación caliente, vagotónica, de conflicto resuelto. Este esquema del decurso de dos fases es una ley biológica natural.

Todas las “enfermedades” que conocemos transcurren de esta manera si se llega a una solución del conflicto. Si miramos hacia atrás vemos que la medicina tradicional no ha interpretado jamás una sólo enfermedad del modo correcto. En las denominadas “enfermedades frías” no se consideraba la sucesiva fase de reparación o se la interpretaba erróneamente como enfermedad en sí misma (por ejemplo “gripe”); en las denominadas “enfermedades calientes”, que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación que sigue a la fase de conflicto activo, se pasaba por alto la fase fría que había precedido o, nuevamente, se había interpretado como una enfermedad en sí misma.

En el cerebro las dos fases tienen su propio Foco de Hamer en el mismo punto, sin embargo con un aspecto distinto: en la fase de conflicto activo (fase CA) hay siempre cercos nítidos que forman la denominada configuración en anillos concéntricos. En la fase PCL de conflicto resuelto el Foco de Hamer está hinchado, edemizado. El edema del anillo más interior también se llama “edema intrafocal” y el del anillo externo “edema perifocal”. Esto sin embargo sólo son definiciones imprecisas para una cosa que en sí misma es muy clara. Desde el inicio de la fase de reparación el foco, normalmente, es más o menos evidenciable con medios de contraste, más tarde, al final de la fase de reparación encontramos en el Foco de Hamer un aumento variable de tejido glial que se acumula ahí como signo de la reconstrucción de la sinapsis de las células nerviosas. Estos gliomas, por sí mismos inocuos, se han considerado hasta ahora, como bien sabemos, como “tumores cerebrales” y las “metástasis cerebrales”, en realidad y por suerte eran Focos de Hamer en fase de reparación o curados.

La primera fase:

A Nivel psíquico	Actividad conflictiva: -pensamientos conflictivos obsesivos -inervación de estrés para superar el conflicto -ritmo de día permanente
Nivel vegetativo	Simpaticotonía: -inapetencia -adelgazamiento -vasoconstricción: manos y pies fríos, piel fría -insomnio, revelamientos frecuentes tras quedarse dormido -presión sanguínea alta
B. Nivel cerebral	Formación en círculos concéntricos del Foco de Hamer en el cerebro en el punto relativo al conflicto y al órgano
C. Nivel orgánico	a) órganos directos del paleoencéfalo: proliferación celular como suceso sensato para la solución del conflicto. Al mismo tiempo se multiplican las micobacterias (micobacterias tuberculosas acidorresistentes) en sincronía con la tasa de velocidad motórica en el órgano, aunque sólo pueden comenzar su trabajo de descomposición tras la conflictolisis. b) órganos directos del neoencéfalo:

	necrosis o úlcera, según el órgano. ¡Reducción celular! Suceso sensato para la solución del conflicto de la persona individual o suceso sensato como programa de autoeliminación para la conservación de la especie (alimento para los leones).
La segunda fase:	
A. Nivel psíquico	fase de conflicto resuelto (fase PCL) -gran tranquilidad -ritmo nocturno permanente
Nivel vegetativo	fuerte cansancio -vagotonía -mucho apetito -sensación de bienestar -fiebre -dificultad para dormirse hasta las tres de la mañana (=al alba, inicio biológico del día), para los “animales presa” menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores gracias a la luz del día, -vasos periféricos dilatados: manos y pies calientes, piel caliente, presión sanguínea baja.
B. Nivel cerebral	los anillos concéntricos del Foco de Hamer se edematizan en la fase PCL, a menudo desaparece del todo en el edema (edema intrafocal y perifocal). A partir de la fase de reparación (fase PCL), el FH se colorea gracias al líquido de contraste y entonces se interpreta erróneamente como “tumor cerebral”. La coloración con el líquido de contraste es posible gracias a un metabolismo notablemente acelerado en el ámbito del Foco de Hamer y a la acumulación de tejido conectivo cerebral glial con el fin de reparar la zona alterada. Como consecuencia el FH se vuelve más duro, rígido, menos elástico. Si seguidamente se produce un nuevo proceso igual en el mismo relé, se puede llegar a una laceración (quistes) del tejido cerebral. Al final de la fase PCL, es decir, tras la denominada fase diurética (frecuente micción) el edema desaparece de nuevo espontáneamente, como signo del Foco de Hamer curado.
C. Nivel orgánico	a) órganos directos del paleoencéfalo: reducción de las células que han proliferado en exceso (sólo de las células tumorales) en la fase PCL por obra medio de hongos o micobacterias (TBC) hasta volver a la situación original. Si faltan los microbios (a causa de un malentendido sentido de higiene de nuestra civilización), el tumor permanece, pero desde el momento de la CL ya no tiene mas actividad de mitosis; falta la descomposición biológica de las células.

	b) órganos directos del neoencéfalo: reconstitución de las células que falta a causa de la reducción celular precedente, es decir, se rellena la necrosis y las úlceras con la ayuda de bacterias (órganos directos de la médula cerebral) o de virus (órganos directos de la corteza cerebral).
--	---

El ignorar la manifestación regular de este sistema en el sentido medicoclínico siempre nos ha impedido encuadrar correctamente la medicina o poder ver las “enfermedades” del modo correcto.

Sin el conocimiento de estos sucesos biológicos regulares no podíamos ni reconocer el cáncer en su contexto, que siempre hemos considerado incurable, dedicándonos por lo tanto a combatir los síntomas de la enfermedad cancerosa a nivel orgánico (lo que, como veremos seguidamente ha sido el más grande de todos los errores a nivel biológico), ni hemos tenido la posibilidad de entender de ninguna manera las denominadas “enfermedades infecciosas”, porque no las considerábamos fases de reparación, sino fases patológicas agresivas en las que los microbios nos querían “destruir”.

Las cosas son muy diferentes. Los pacientes que morían lo hacían por coma cerebral o en la crisis epileptoide independientemente de la presencia de microbios. Con eso no se niega que la fase de reparación conlleve peligros, como por ejemplo en el caso del infarto cardíaco, del que todavía hablaremos más adelante.

En algunos decursos patológicos la fase de reparación es precisamente mucho más peligrosa que la fase de conflicto activo.

Por la ignorancia de esta regularidad biológica nos resultaba imposible no sólo conocer y entender realmente cualquier “enfermedad”, sino que tampoco podíamos curar a los pacientes de un modo científicamente correcto, porque como ya hemos dicho, habíamos que la fase de reparación era una enfermedad en sí misma.

7.1. Fase simpaticotónica de conflicto activo – evolución del conflicto

Durante el momento del DHS todo el organismo se encuentra en simpaticotonía permanente, en fase de estrés permanente. Ya hemos visto que este estrés se produce a nivel biológico como un medio sensato para coger “la última posibilidad” de superar el conflicto. A este fin hay que dedicar todas las fuerzas. El individuo que no lo consigue en un determinado tiempo, ha desperdiciado su “oportunidad biológica”. Aunque el conflicto se resuelva (pero ya demasiado tarde) el individuo morirá en cualquier caso. Son una excepción, por un lado, el denominado conflicto activo en suspenso (con el que se puede llegar a una edad avanzada), que se transforma, pero que en sustancia permanece activo hasta la muerte, y por otro

lado la constelación esquizofrénica, con la que no se acumula ninguna masa conflictiva y se puede llegar también a una edad avanzada.

Durante la fase de conflicto activo, la fase de estrés, el organismo funciona a un ritmo acelerado con el perjuicio del organismo. También aquí, hablar de enfermedad significa no haber entendido nada. ¿Cómo puede un individuo “salir bien” de su conflicto si no moviliza todas sus fuerzas? En el pasado el cáncer en los órganos nos parecía un efecto secundario indeseado o no previsto de esta fase de estrés permanente. Pero el tumor en el órgano forma parte de este programa especial, biológico y sensato de la naturaleza.

Yo personalmente he considerado en cierta medida el tumor en el órgano también como una especie de “selección orgánica” y al mismo tiempo un método de selección de la naturaleza para el ámbito representativo biológico y psíquico correlativo (por ejemplo, órgano: huesos – ámbito representativo biológico: autoestima). En otras palabras, si un individuo no supera durante largo tiempo el método de selección inflexible de la naturaleza dentro de un ámbito representativo y del órgano correspondiente, se le elimina de la competición.

En este método de selección los “órganos viejos” están menos expuestos que los órganos recientes. Los “órganos viejos” tienen sus centros de relé en el paleoencéfalo, los “recientes” en el neoencéfalo. Mientras que los órganos del paleoencéfalo son indispensables para la vida, los órganos del neoencéfalo sólo lo son en parte, aunque de hecho en los relés del territorio (neoencéfalo) la fase PCL puede ser a veces muy peligrosa (infarto cardíaco izquierdo, embolia pulmonar).

Durante la fase de conflicto activo el paciente tiene poco apetito o no tiene ninguno, duerme mal, piensa continuamente en su conflicto o su problema. La circulación sanguínea periférica está limitada a causa de la constricción capilar, todos los procesos vegetativos de recuperación se reducen al mínimo, el cuerpo está en “movilización general” para superar el problema/conflicto. Durante este período de conflicto activo se desarrolla un cáncer, se genera una necrosis o sucede sólo una modificación del funcionamiento celular, según de que conflicto se trate.

En este período de conflicto activo desde el DHS hasta la conflictolisis, es decir, hasta la solución del conflicto, el Foco de Hamer está en el cerebro como “estrés especial” o “inervación especial”.

Sólo por medio de este estrés especial se llega a la proliferación celular, a la necrosis o a la modificación del órgano. Cuanto más amplio es el Foco de Hamer, más grande son también los tumores, la necrosis o la alteración de las células. Cuanto más intenso es el conflicto, más rápidamente crece el tumor, más grande es la necrosis y más intensa la modificación del funcionamiento celular en los tipos de cáncer que no previenen ninguna proliferación celular por mitosis ni necrosis.

Los datos anamnésticos más importantes son el DHS y, si tiene lugar, la CL, la conflictolisis. Conociendo estos datos y la dimensión del DHS y la intensidad del suceso conflictivo obtenemos un esclarecimiento sobre la gravedad de las alteraciones que tenemos que tener presentes (masa conflictiva), pues el crecimiento del tumor ya no nos da esa información. No sabemos con precisión si en la simpaticotonía permanente durante la fase de conflicto activo las células alfa en el páncreas se estimulan continuamente, de modo que se reduzca la

producción del glucagón, y por lo tanto el hígado movilice el glucosio eliminándolo de la reserva del cuerpo, bloqueando o reduciendo fuertemente la digestión.

En cada caso el organismo está en estado de alarma y parece como si la fatiga de la digestión fuese solamente una molestia.

En esta fase simpaticotónica de conflicto activo tiene lugar también la multiplicación de los hongos o de las micobacterias (TBC) pertenecientes a los órganos directos del paleoencéfalo en sincronía con la proliferación celular en el órgano, casi, podríamos decir, como reserva para la destrucción del tumor en la fase PCL (caseificación), que tiene su inicio en la conflictolisis.

7.2. Conflictolisis, solución del conflicto biológico.

Todas estas relaciones se modifican repentinamente cuando se produce la solución del conflicto.

Nosotros, aprendices de brujo, éramos demasiado tontos e ingenuos para reconocer este sistema. Justo tras la conflictolisis el organismo puede relajarse. En ese punto la urgencia es regenerar y reparar la infraestructura de sustentamiento, el paciente siempre tiene hambre y la digestión tiene preferencia sobre el resto.

Todo el organismo entra en profunda parasimpaticotonía o vagotonía. El conflicto está resuelto, el Foco de Hamer en el cerebro empieza a sanarse en cuanto que se acumula abundante tejido conectivo glial al que se añade a su vez el edema intra y perifocal dentro y entorno al FH. La proliferación tumoral en el órgano se detiene de repente. También el tumor es edematizado, se caseifica o es demolido y reabsorbido o consumado con la ayuda de las micobacterias acidorresistentes amasadas en la fase CA. Al final se sana.

Como recordatorio, en el punto en que antes había un tumor queda una cicatriz o una caverna. Pero el paciente vuelve a estar sano sólo cuando ha superado esta fase de reparación.

En los órganos directos del neoencéfalo las necrosis o úlceras se llenan. En el neoencéfalo vemos procesos análogos a los del paleoencéfalo.

La fase de reparación, de hecho, es un suceso muy alegre, nadie debería morir por ella. De hecho para las eventuales complicaciones, que se pueden prever sólo en un bajo porcentaje de los casos de cáncer, tendríamos a nuestra disposición las posibilidades mejores de medicina intensiva.

Una enfermedad cancerosa sólo tendría una mortalidad del 3% si fuese tratada por los médicos y enfermeros inteligentes según los criterios de la Nueva Medicina. Pero la premisa necesaria es que el médico de cabecera o el personal médico en el tratamiento clínico, los parientes y los amigos, la gente que tiene que ver con el paciente, entiendan el sistema de la Nueva Medicina. Porque todo lo que hasta ahora hemos considerado bueno (por ej. una "circulación estable", en realidad debida a la simpaticotonía) ahora se vuelve malo, indica al final una posible recaída o nuevo pánico.

Todo lo que hasta ahora se consideraba malo (por ejemplo una "insuficiencia circulatoria" debida en realidad a la fase de curación vagotónica) ahora es un síntoma positivo. Hasta ahora se dormía con morfina a los pacientes que se encontraban en la más profunda vagotonía, antes de que pudiesen finalizar su curación, porque siempre se daba de lado al paciente que se encontraba en una profunda vagotonía.

En el caso de un cáncer de huesos este es siempre el punto en el que normalmente se manifiestan los que son los mayores dolores.

En realidad el hueso, que en la fase de curación se recalifica y edematiza fuertemente, no duele. Muchos más dolores le provoca al paciente la dilatación del sensibilísimo periostio, que se hincha como un balón por efecto del edema óseo. Los dolores del periostio son el mejor signo de la curación en curso del hueso correspondiente.

Con los controles radiológicos del hueso se puede ver muy bien este proceso de curación, es decir, la recalificación del hueso y en el cerebro la coloración oscura de la médula cerebral, que desaparece nuevamente con el aumento de la calcificación. Esta conlleva la acumulación de edema cerebral, puede causar dolores de cabeza y se va acompañado de leucemia es uno de los mejores síntomas de curación (y no una enfermedad).

Cierto que existen muchas complicaciones posibles, en la esfera de la psique, en la del cerebro y naturalmente también de los órganos. Y piénsese sólo esto: sólo el tres por ciento de los pacientes no lo consigue, mientras que los otros sobreviven si se tratan correctamente desde el principio y no sólo cuando los médicos ignorantes los han abandonado medio muertos declarándoles "terminales".

A causa de esta ignorancia hoy en día muere más del 95% de todos los pacientes enfermos de cáncer. Entre estos hay muchos casos con viejos cánceres inactivos que se han desarrollado 10 años antes.

7.3. La crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación explicada con el ejemplo del infarto cardíaco.

Toda acumulación de edema en la fase de reparación tiene su punto culminante o punto de retorno.

En el caso de la úlcera del íntima de las coronarias, por ejemplo, sucede a las 3-6 semanas tras la CL, la solución del conflicto. La crisis epiléptica o epileptoide indica que la expansión edemática se bloquea, regulada por el mismo organismo.

Llamamos crisis epiléptica o epileptoide a esta breve fase del punto de retorno o del inicio de la contraregulación ("epiléptico" en sentido estricto es solo la convulsión tónica o clónica en el conflicto motor), en la curación de la úlcera de las coronarias hablamos de infarto cardíaco.

El paciente a menudo ya ha superado su “enfermedad” cuando ha sobrepasado esta crisis epiléptica y el estado de conflictolisis permanece estable, es decir, sin pánico y sin recaídas conflictivas.

Sin embargo estas cosas ya eran evidentes antes de Hamer, a propósito del infarto cardíaco, porque la mayor parte de los casos de muerte por infarto cardíaco se producen durante esta crisis epileptoide.

A nivel psíquico el paciente experimenta nuevamente y sufre todo su conflicto de un modo acelerado en unos pocos minutos, horas o días.

Este es un truco de madre naturaleza: frena la vagotonía con una recaída conflictiva psicofísica, casi natural, de fuerte entidad. Es como un potente prodigio negativo el hecho de que hayamos necesitado muchos miles de años para llegar a este simple, pero genial, “truco” de la madre naturaleza: la crisis epileptoide es una recapitulación acelerada, que comprende todo el conflicto.

Que hasta ahora se sepa realmente tan poco respecto a las crisis epileptoides y así como de la realidad del infarto cardíaco, depende del hecho de que los cardiólogos simplones creen todavía en la máxima de los vasos coronarios bloqueados, aunque ya en 1984, en el estudio vienés sobre el infarto cardíaco, haya podido demostrar sin ningún tipo de duda que el infarto o lo que consideramos como tal, es sólo un resultado del cerebro, con más precisión, de un edema cerebral periinsular derecho.

Como escribí en mi libro “El cáncer – Enfermedad del alma” de 1984, la parada cardíaca no deriva de una falta de rendimiento en el interior del corazón, sino del edema de reparación en el centro de relé del cerebro para el ritmo cardíaco.

La crisis epiléptica, que señala más o menos fuerte y caracteriza dramáticamente cada fase de reparación tras una enfermedad cancerosa o su fase de conflicto activo, se origina siempre sobre la base de un edema cerebral. Incluso la más pequeña crisis epiléptica presupone un edema cerebral.

Más a menudo estas crisis epileptoides (e infartos cardíacos) se producen por eso de noche, en el punto más profundo de la vagotonía, y nunca en estado de tensión o en simpaticotonía, sino durante una fase de relajación, de reposo o de convalecencia.

Los cardiólogos jamás se han parado a reflexionar sobre el porqué el infarto cardíaco o cualquier crisis epileptoide normalmente se produce de noche, cuando por ejemplo el corazón está en condiciones óptimas de reposo.

La crisis epileptoide puede llevar a breves parálisis de las extremidades o de la cara si el edema se extiende hasta el centro motor del giro precentral o si un conflicto de miedo tiene allí su FH.

Ésta siempre tiene los típicos síntomas cerebrales que vemos en el infarto cardíaco: centralización, sudor de miedo, conatos de vómito, vértigos, vista doble, calambres, dolores de cabeza, pánico, a menudo también desmayos, porque el íntima coronaria es sensible e inervada desde la corteza sensorial.

Las crisis epileptoides que derivan de un FH en la corteza cerebral, pueden alargarse por toda la corteza y causar calambres tónico-clónicos, mordedura de la lengua, baba en la boca, etc.

Por su naturaleza la crisis epileptoide es un regreso al estado de shock del organismo gracias al cual se debería poder expulsar el líquido edemático intra y perifocal del Foco de Hamer, porque a causa del edema intrafocal el relé cerebral se comprime perdiendo su funcionalidad. Este edema causa la parada cardíaca, o el mal funcionamiento del centro de ritmo cardíaco si el conflicto ha durado mucho tiempo (más de 9 meses). Dado que los cardiólogos no se quieren ocupar del cerebro, dan flebotomías a todos los infartados, lo que se ahoga en el edema cerebral.

Es muy peligroso tratar un shock central, que está condicionado por el edema cerebral y por lo tanto representa una crisis epiléptica, aumentando el volumen del líquido seguido a un shock de falta de volumen en el caso de desangramiento.

Durante muchos millones de años la naturaleza ha desarrollado el estado de shock y también la terapia correspondiente.

Sin embargo no queremos callar nuevamente que la crisis epiléptica está prevista o construida por la naturaleza también como un criterio de selección.

Con una duración conflictiva superior a 9 meses, así lo ha demostrado nuestro estudio vienes sobre el infarto cardíaco, disminuyen notablemente las posibilidades de supervivencia en base al estado actual del tratamiento.

La situación mejorará considerablemente cuando se pueda efectuar el tratamiento ya en las 3-6 semanas precedentes a la crisis epileptoide o el infarto, consiguiendo reducir el edema cerebral con ayuda de cortisona y el enfriamiento de la cabeza.

En mi opinión se podría reducir la mortalidad por infarto cardíaco a menos de la mitad.

Atención: he tenido la experiencia de muchos casos en los que con la crisis epileptoide el azúcar en sangre descendió hasta casi cero. La aportación de glucosa por lo tanto es correcta, la mayor cantidad posible con poco líquido.

Atención: si en una esquizofrenia en la que hay dos FH en los dos hemisferios distintos y si los dos conflictos en suspenso se resuelven al mismo tiempo, con la crisis epileptoide se puede producir un breve estado de delirio pasajero.

7.4. ¿Qué significa solución “biológica” de un conflicto?

A menudo recibo ofertas de colaboración por parte de psicólogos, “terapeutas” de la hipnosis, operadores de bioresonancia o de PNL, que no puedo aceptar.

Estas personas, que en su mayoría no tienen ninguna experiencia clínica, sostienen que pueden resolver los conflictos, conflictos biológicos, con “métodos superficiales”.

Por no hablar de que también un psicólogo con su método, que se ha revelado erróneo, puede meterse por casualidad en un conflicto actual y discutiendo con el paciente llegar a la solución, mientras que a menudo ese conflicto, a nivel biológico no debería haber sido resuelto. Estos psicoterapeutas inexpertos en la Nueva Medicina no saben que es un conflicto biológico y el correspondiente EBS.

También los hipno-terapeutas puede a veces resolver un conflicto, aunque no saben encuadrarlo biológicamente. Además, la hipnosis profunda tiene la gran desventaja de crear a menudo un nuevo DHS que no se sabe si podrá ser resuelta como se esperaba.

Conozco muy bien estos dos tipos de personas del tiempo en que trabajaba en la psiquiatría y los considero peligrosos por su ignorancia. Sostengo que PNL y bioresonancia son una gran ilusión por lo que respecta a la solución de conflictos biológicos y de programas especiales, biológicos y sensatos (EBS).

Todos sus métodos presuponen que estos programas EBS son malos, “malignos”, por lo que todos los conflictos (también biológicos) tienen que ser “eliminados con la terapia”.

En realidad la solución de los conflictos biológicos, obviamente de aquellos que se pueden resolver, es mucho más fácil y... también mucho más difícil.

Estamos profundamente apegados a los errores de los últimos 2000 años, durante los cuales la medicina ha estado organizada en base al Antiguo Testamento (la enfermedad entendida como pecado), concepción de la cual la mayoría no consiguen alejarse ni un ápice. Una madre nota el conflicto biológico de su hijo sin ningún “método”, igual que cualquier hembra animal.

Estas madres encuentran instintivamente la causa, el medio justo, el momento justo, las palabras justas para consolar o reprender, normalmente hacen todo del modo biológicamente correcto, es así de fácil.

El intelectual loco que quiere hacerlo todo “con método” lo arruina todo.

Lo mejor sería que no se ocupasen de nada.

La Nueva Medicina, al contrario que la medicina de estado que cree en 5000 hipótesis, es una ciencia natural exacta sin hipótesis. Por lo tanto es mucho más sabia que la vieja medicina de estado, y sin embargo no nos consultan esos expertos intelectuales cerrados estúpidamente en su mundo. No existe ni psiquiatría ni cerebroiatría, sino sólo una iatria (iatroi= médicos).

El médico de la Nueva Medicina tiene que tener el máximo posible de conocimientos, pero sobretodo tiene que ser un amigo cordial de los pacientes con la sana capacidad de entender a las personas y dar buenos consejos al “paciente jefe”.

El paciente necesita un buen consejero y un consejo válido respecto a la solución de su conflicto biológico, si se puede resolver o es mejor que no se resuelva.

Es importantísimo decir siempre que el programa especial, biológico y sensato es un hecho sensato y no “malo”, ni siquiera en el caso del cáncer, y que con cáncer se sobrevive en un 95-98% de los casos.

Con estas posibilidades de supervivencia ya no se transmite la sensación de pánico.

La elevada mortalidad, que había condenado al pánico a todos nuestros pobres pacientes, deriva sólo de la ignorancia o de la consciente falta de aplicación de los conocimientos de la Nueva Medicina por parte de la medicina actual.

Si, como hemos dicho, en la Nueva Medicina se sabe que todos los procesos llamados en el pasado “malignos” tiene un sentido biológico, y también la solución del conflicto y lo que con ella se consigue, por ejemplo la leucemia en el caso del conflicto de desvaloración de sí, el paciente no se asusta cuando se le verifica eso.

Tomemos el ejemplo que hemos utilizado ya varias veces: una madre que ha sufrido un DHS cuando su niño tiene un accidente ante sus ojos. Entonces el niño va al hospital y ella sufre un cáncer de mama. El sentido biológico sería que a través de este cáncer de mama se produzca más leche para el niño de modo que este pueda equilibrar la detención del desarrollo con una mayor cantidad de leche.

Mientras que el niño se encuentra en el hospital no es posible que se produzca una solución. Incluso cuando el niño sale del hospital (normalmente se soluciona el conflicto) y sufre todavía durante tiempo los daños del accidente, una solución del conflicto biológico no es sensata desde el punto de vista biológico. El niño todavía necesita una mayor oferta de leche. El programa biológico, sin embargo, se desarrolla incluso aunque la madre (“moderna”) no dé de mamar al niño.

Por lo tanto tenemos que explicar cautamente a esta madre las correlaciones, incluida la de la caseificación espontánea del cáncer de mama, si tiene micobacterias (TBC), lo que normalmente se puede descubrir preguntando a la paciente si ha tenido fases de sudor nocturno en ocasiones precedentes. Ella tiene que saber también que un tumor no reducido en la mama por la falta de micobacterias (TBC), es decir, un tumor enquistado, es totalmente inocuo, biológicamente no es necesario, pero no es de ninguna manera peligroso para la supervivencia.

Dado que estos pacientes no son más estúpidos que nosotros y dado que se trata de su propio cuerpo, normalmente entienden rápidamente, de hecho mucho más rápido de lo que creemos.

Quiero describiros brevemente dos casos, que en parte se mencionan en otro punto del libro, sólo para mostrar que la solución biológica de un conflicto con programa EBS en los tres niveles no es una solución psíquica, sino justamente biológica.

7.4.1. Ejemplo: solución de conflicto biológico mediante carcinoma intersticial del testículo

Este caso de un joven médico puede mostrarnos lo que hace falta calcular en la nueva medicina; él había venido a mí porque, tras una ablación del testículo izquierdo, que se había hinchado hasta hacerse tan grande como un huevo de oca (quiste del testículo) en abril de 1998 en un control con TAC abdominal (el 27-10-98), le habían dicho que las células malignas del testículo le habían producido

metástasis en el vientre. En ese punto (junio de 1999) todo el abdomen estaba lleno de metástasis y ya no se podía hacer nada.

nicht mehr davor,
ter hat ein DHS
. Nun liegt es im
Biologische Sinn
as Kind erzeugt,
tes Milchangebot

solange das Kind
em Krankenhaus
ngere Zeit Schä-
Konflikts biolo-
das vermehrte
r dann ab, wenn
en dieser Mutter
e der spontanen
ic) hat, was man
Patientin fragt,
Anlässen gehabt
er Tumor in der
so ein eingekap-
logisch unnötige
e Patienten nicht
r geht, verstehen

nuches nochmals
zeigen, daß die
enen eben nicht

sung durch

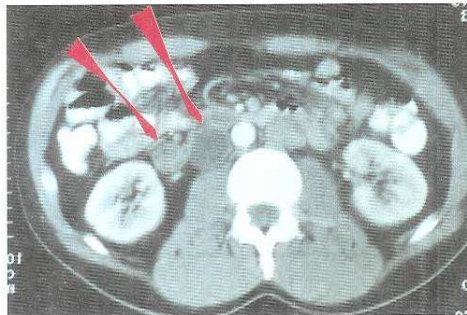
dieser Fall eines
einer Exstirpati-
is (Hodenzyste)
gesagt hatte, nun

seien die bösartigen Hodenzellen doch schon in den Bauch metastasiert.
Nun (Juni '99) sei im Bauch alles voller Metastasen, es sei nichts mehr zu
machen.

Hodenzyste, April
'98



Bauch-CT vom
27.10.98
Nierenzyste links
(Pfeile)



Der zugehörige Flüssigkeits-Konflikt war rasch aufgeklärt: Der Patient
hatte im Mai '98 in der Notambulanz in einem primitiven ausländischen
Krankenhaus, wo er arbeitete, ein 5jähriges ertrunkenes Mädchen reanimie-
ren wollen. Wegen mangelhafter Ausrüstung des Krankenhauses, für die er
sich aber z.T. selbst verantwortliche fühlte, war das Kind, genau im Alter
seines eigenen Kindes, gestorben. Das ging ihm, wie er berichtete „durch
Mark und Bein“. Er erlitt einen Flüssigkeits-Konflikt, den er aber ein halbes
Jahr später lösen konnte. Die Nierenzyste, die zu diesem Zeitpunkt schon
größtenteils induriert war, wurde erstmals im Oktober '98 entdeckt und als

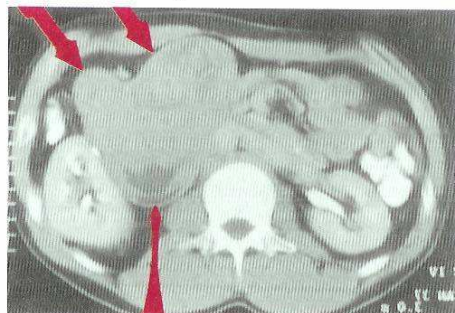
TAC abdominal del 27-10-98.

Quistes del riñón a la izquierda (flechas)

El correspondiente conflicto de líquido se explicó rápidamente: el paciente, en mayo de 1998, quiso reanimar a una niña ahogada de 5 años durante el transporte en ambulancia de un hospital extranjero poco preparado donde trabajaba. A causa de la falta de medios, de lo cual él mismo se sentía un poco responsable, la niña, que tenía la misma edad que su propia hija, murió. Eso había provocado que “se le congelara la sangre en las venas”, como contaba él mismo. Sufrió un conflicto de líquido, que sin embargo consiguió resolver seis meses más tarde. El quiste del riñón, que en aquel punto se había endurecido ya en gran parte, se descubrió en octubre del 98 y se malinterpretó como un linfonodo, en junio del 99 se diagnosticó erróneamente como una aglomeración de metástasis.

TAC abdominal del 10-6-99.

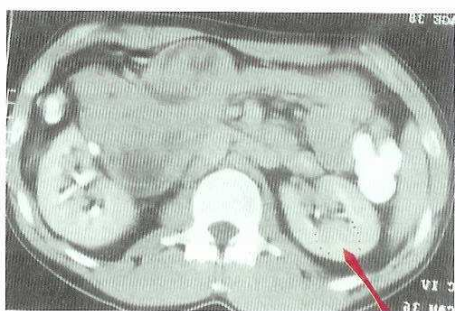
Lymphknoten renigedeutet, im Juni '99 dann als riesiges Metastasen-Konglomerat fehldiagnostiziert.



Bauch-CT vom 10.6.99

Man erkennt gut das große Nephroblastom (= indurierte Nierenzyste), siehe Pfeile. Dorsal scheint sich ein zusätzliches Nierenbecken auszubilden. Denn das Nephroblastom produziert ja Urin und scheidet ihn über die schon

vorhandenen ableitenden Harnwege aus. Das Erstaunliche ist die Inhomogenität des Nephroblastoms. Die beiden oberen Pfeile zeigen die beiden anfänglichen Nephroblastom-Anteile, die man schon auf den Aufnahmen vom 27.10.98 sehen kann.



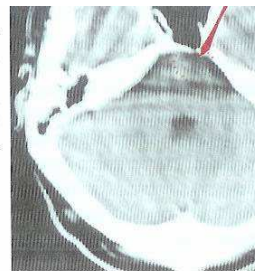
Bauch-CT vom 10.6.99

Später scheint ein großer Nephroblastom-Teil hinzugekommen zu sein, den wir früher nicht erklären konnten. Jetzt können wir das Phänomen erklären; Denn ein Blick auf den Stamnhirnschnitt vom 10.6.99 zeigt uns einen in-

zwischen nachträglich in Lösung befindlichen HH für das Sammelrohr-Relais der rechten Niere. Das zugehörige Sammelrohr-Ca sehen wir auf obigem Bild (Pfeil). Dieses Flüchtlingskonflikt-SBS hat das Nephroblastom nachträglich wieder „aufgepumpt“. Den Flüchtlings-Konflikt erlitt er offenbar zusammen mit dem Verlust-Konflikt, als er seine Familie verlassen mußte, um nach Südamerika zu ziehen. Der Flüchtlings-Konflikt scheint auf dem nachfolgenden CT gelöst zu sein.

10.6.99

In pcl-Phase befindlicher HH des Sammelrohr-Relais der rechten Niere, das das in Induration begriffene Nephroblastom nachträglich nochmals „aufgepumpt“ hat (siehe Kapitel über Sammelrohr-Syndrom).



10.6.99

Der Pfeil zeigt den HH für das Nephroblastom der linken Niere. (Flüssigkeits-Konflikt, weil das ertrunkene Kind nicht reanimiert werden konnte, wofür sich der Doktor einen Teil der Schuld selbst zuschrieb).



9.6.98; HH im Relais des lin- mäßig großes, in Rückbild- ches Heilungsödem.

Aber eine andere Sache war für uns beide, kaum daß der junge Sache richtig zu verstehen begonnen hatte, viel wichtiger:

Wenn eine Hoden-Exstirpation in der Heilungsphase des SBS men wird, wie es ja bei mir selbst auch gewesen ist, dann läuft trotzdem - also trotz Herausnahme des sog. „Erfolgsorgans“

Se ve bastante bien el gran nefroblastoma (=quiste renal endurecido), ver las flechas.

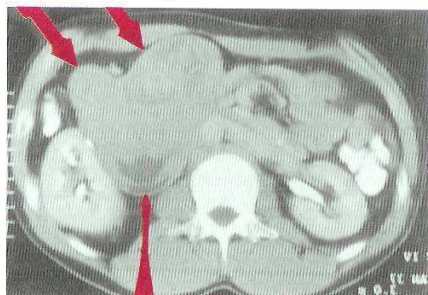
Dorsalmente se ve la formación de una cuenca renal añadida. El nefroblastoma produce orina y la expulsa por medio de los conductos urinarios de desviación ya presentes. Lo sorprendente es la falta de homogeneidad del nefroblastoma. Las dos flechas superiores indican las dos partes iniciales del nefroblastoma que se pueden ver ya en las fotografías del 27-10-98.

TAC abdominal del 10-6-99.

Más tarde se ve como se añade una gran parte de nefroblastoma que antes no podíamos explicar. Ahora sí podemos explicar este fenómeno: de hecho una ojeada a la sección del tronco cerebral del 10-6-99 nos muestra un FH que durante ese tiempo se encuentra en solución tardía para el relé del tubo colector del riñón derecho. En la imagen de arriba (flecha) vemos el carcinoma correspondiente del tubo colector. Este programa EBS de conflicto del prófugo ha “hinchado” de nuevo el nefroblastoma. El paciente ha sufrido visiblemente el

conflicto del prófugo junto a un conflicto de pérdida cuando ha tenido que dejar su familia para irse a vivir a Sudamérica. En la siguiente TAC se ve que el conflicto del prófugo se ha resuelto.

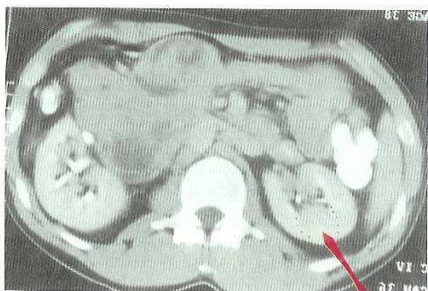
Lymphknoten renigedeutet, im Juni '99 dann als riesiges Metastasen-Konglomerat fehldiagnostiziert.



Bauch-CT vom 10.6.99

Man erkennt gut das große Nephroblastom (= indurierte Nierenzyste), siehe Pfeile. Dorsal scheint sich ein zusätzliches Nierenbecken auszubilden. Denn das Nephroblastom produziert ja Urin und scheidet ihn über die schon

vorhandenen ableitenden Harnwege aus. Das Erstaunliche ist die Inhomogenität des Nephroblastoms. Die beiden oberen Pfeile zeigen die beiden anfänglichen Nephroblastom-Anteile, die man schon auf den Aufnahmen vom 27.10.98 sehen kann.



Bauch-CT vom 10.6.99

Später scheint ein großer Nephroblastom-Teil hinzugekommen zu sein, den wir früher nicht erklären konnten. Jetzt können wir das Phänomen erklären; Denn ein Blick auf den Stammhirn-Schnitt vom 10.6.99 zeigt uns einen in-

zwischen nachträglich in Lösung befindlichen HH für das Sammelrohr-Relais der rechten Niere. Das zugehörige Sammelrohr-Ca sehen wir auf obigem Bild (Pfeil). Dieses Flüchtlingskonflikt-SBS hat das Nephroblastom nachträglich wieder „aufgepumpt“. Den Flüchtlings-Konflikt erlitt er offenbar zusammen mit dem Verlust-Konflikt, als er seine Familie verlassen mußte, um nach Südamerika zu ziehen. Der Flüchtlings-Konflikt scheint auf dem nachfolgenden CT gelöst zu sein.

106

10-6-99

FH que se encuentra en la fase PCL del relé del tubo colector del riñón derecho que además ha provocado nuevamente la “hinchazón” del nefroblastoma en fase de endurecimiento (véase el capítulo sobre el síndrome de los túbulos colectores).

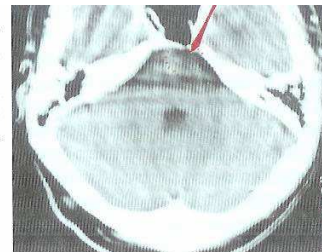
10-6-99

La flecha muestra el FH para el nefroblastoma del riñón izquierdo (Conflicto del líquido por no haber podido reanimar a la niña ahogada, de lo que el doctor se echaba en parte la culpa).

9-6-98

10.6.99

In pcl-Phase befindlicher HH des Sammelrohr-Relais der rechten Niere, das das in Induration begriffene Nephroblastom nachträglich nochmals „aufgepumpt“ hat (siehe Kapitel über Sammelrohr-Syndrom).



10.6.99

Der Pfeil zeigt den HH für das Nephroblastom der linken Niere. (Flüssigkeits-Konflikt, weil das ertrunkene Kind nicht reanimiert werden konnte, wofür sich der Doktor einen Teil der Schuld selbst zuschrieb).



9.6.98; HH im Relais des linken Hoden mäßig großes, in Rückbildung befindliches Heilungsoedem.

Aber eine andere Sache war für uns beide, kaum daß der junge Doktor die Sache richtig zu verstehen begonnen hatte, viel wichtiger:

Wenn eine Hoden-Exstirpation in der Heilungsphase des SBS vorgenommen wird, wie es ja bei mir selbst auch gewesen ist, dann läuft das SBS trotzdem - also trotz Herausnahme des sog. „Erfolgsorgans“ zielgesteuert

10

FH en el relé del testículo izquierdo: edema de reparación bastante grande en vías de reducción.

Y otra cosa fue muy importante para los dos justo cuando el joven doctor empezó a comprender la cuestión del modo correcto: si se lleva a cabo una ablación del testículo en la fase de reparación del programa EBS, como también fue mi caso personal, el programa EBS prosigue en cualquier caso coherentemente hasta el final, a pesar de la extirpación.

La Hipófisis y la corteza suprarrenal intervienen y hacen que se produzca más testosterona respecto al inicio del programa EBS.

Todavía no sabemos precisamente si la producción de testosterona añadida tenga lugar en la corteza suprarrenal o en el testículo que queda. En cualquier caso el nivel de testosterona es y permanece más alto.

Así la mujer de este paciente zurdo, que se describe a sí mismo como un macho afeminado en el pasado, dijo que desde hacía algún tiempo se había vuelto más masculino de lo que era antes de que le extirpasen el testículo. Él mismo se sentía mucho más masculino. Su mujer lo prefería como era antes. También mi mujer me dijo casi lo mismo casi un año después de la muerte de mi hijo Dirk, después de la ablación del testículo.

weiter. Hypophyse und Nebennierenrinde springen ein und bewirken, daß deutlich mehr Testosteron produziert wird als vor Beginn des SBS. Wir wissen noch nicht genau, ob die Produktion des zusätzlichen Testosterons in der Nebennierenrinde stattfindet oder im verbliebenen sog. „Resthoden“. Jedenfalls ist und bleibt der Testosteron-Spiegel erhöht. So hatte die Ehefrau dieses linkshändigen Patienten ihm, der sich selbst für die frühere Zeit als Softi beschreibt, erst kürzlich gesagt, er sei seit einiger Zeit viel männlicher geworden, was er vor der Hoden-Exstirpation nicht gewesen sei. Er selbst fühlt sich auch wesentlich maskuliner. Seine Ehefrau fand das nicht gut, sie hätte ihn lieber wie früher gehabt. Fast die gleichen Worte hatte mir auch meine eigene Frau etwa ein Jahr nach dem Tod meines Sohnes Dirk, bzw. der Hoden-Exstirpation, gesagt.



10.6.99

Man sieht noch den Oedemsaum. Aber offenbar hat der Verlust-Konflikt wieder Aktivität bekommen, weil der Patient vermeinte, nunmehr zum Sterben nach Südamerika zu fliegen und seine Eltern nun definitiv nie mehr wiederzusehen. Der dunkle Punkt in Richtung des Pfeils markiert das Zentrum. Die Schießscheiben sind innerhalb der Vernarbung nicht zu sehen.

Im rechten Revierbereich besteht jetzt „hängende Heilung“.

Der linke Revierbereich bleibt unverändert aktiv.

Auch der Verlust-Konflikt war rasch geklärt: Anfang 1998 verzog die Familie von Deutschland nach Südamerika, in die Heimat der Ehefrau. Der Patient hatte geglaubt, seine Eltern, insbesondere seine von ihm sehr verehrte Mutter, nicht mehr lebend wiederzusehen. Als er aber 3 Monate später nochmals nach Deutschland flog und der Exodus nach Südamerika doch nicht mehr so definitiv erschien, hatte er diesen Verlust-Konflikt einstweilen lösen können. Unmittelbar darauf begann der linke Hoden zu schwellen.

Links deshalb Mutter („ein etwas ödipal“)

Aber nun dierten (ein daß er im Lösungsod konnte er schmerzen. konnte ja st Konflikt wa gen hatte. S gend“ aktiv

Aber den den. Und de ten: Revier

Seine Elte Patient und und stellten schwunden, aktiven Rev umtrieb, Konflikt erl

Für uns gin

1. War de worden

2. Der 2. gewesen gelöst u sterben. hatte, „zwang: der links aktiv ge

Ergebnis: 1 ausschließl gelöst werd

10-6-99

Se ve todavía el borde del edema. Pero visiblemente el conflicto de pérdida ha retomado la actividad porque el paciente ha pensado volver a Sudamérica para morir allí y no volver a ver a sus padres. El punto oscuro indicado por la flecha corresponde al centro del FH para el testículo izquierdo. Los signos concéntricos no se ven en el interior de la cicatrización. En la zona del territorio a la derecha

ahora hay una “solución en suspensión”. La zona del territorio izquierda permanece activa sin modificaciones.

También el conflicto de pérdida se aclara rápidamente: a comienzos de 1998 la familia se había trasladado de Alemania a Sudamérica, al país de la mujer. El paciente creía que no volvería a ver nunca más a sus padres, en particular a su madre, a la que quería mucho. Pero cuando 3 meses después volvió a Alemania y el éxodo en Sudamérica no era ya tan definitivo, entonces fue posible que resolviera temporalmente este conflicto de pérdida. Justo después el testículo izquierdo empezó a hincharse.

Por eso a la izquierda (como es zurdo, el lado del partner), porque siempre había admirado a su madre (“una mujer muy guapa pero muy severa”) preferentemente de un modo un poco edípico como una partner.

Pero todo comenzó a aclararse cuando hemos estudiado juntos la TAC cerebral (siempre pido una TAC cerebral como condición), porque se veía que en el ámbito del territorio a la derecha, como se puede ver fácilmente, tenía un gran edema en solución. También debió sufrir un infarto cardíaco. Consiguió acordarse de que en 1998 tuvo arritmia ventricular y dolores cardíacos. Se había tratado de un ligero infarto cardíaco izquierdo, porque el lado derecho podía haber estado activo sólo en constelación esquizofrénica. El conflicto era que su mujer doce años antes lo había traicionado con un amante. Desde entonces tenía un conflicto activo en “suspensión” en el lado cerebral derecho periinsularmente.

Pero el hombre zurdo tiene que sufrir el primer conflicto a la izquierda cerebralmente. Y eso es lo que había pasado, como él mismo bien sabe, cuando tenía cuatro años: conflicto de miedo en el territorio, de territorio y de rencor en el territorio, 34 años antes. Sus padres se habían ido a una fiesta creyendo que el paciente, que entonces tenía 4 años, y su hermanito, estaban dormidos. Sin embargo los dos se despertaron en medio de un gran miedo porque estaban convencidos de que los padres habían desaparecido para siempre. El paciente sufrió un conflicto de territorio, activo todavía hoy, a la izquierda cerebralmente. Desde entonces, como él mismo admite, se vio afectado de manías y a los 26 años se volvió maníaco-depresivo cuando sufrió el segundo conflicto de territorio sorprendiendo a su mujer con un amante.

Ahora nosotros tenemos que responder a las preguntas:

1. ¿El conflicto de territorio cerebralmente a la derecha había llegado a la solución efectiva o se había resuelto “biológicamente” con el aumento del nivel de testosterona?
2. Este segundo conflicto ha tenido lugar exclusivamente en constelación esquizofrénica, por lo tanto no había formado ninguna masa conflictiva y el

paciente, que lo había resuelto, lo pudo hacer porque no estaba en peligro de morir de infarto cardíaco izquierdo (cerebralmente a la derecha). La cuestión era si, cuando se hubiese producido la “solución biológica”, permanecía el peligro de resolver “como consecuencia” de modo biológico también el conflicto de territorio cerebralmente a la izquierda. Eso era peligroso porque el conflicto de territorio cerebral izquierdo (para los zurdos) había estado activo “desde hacía sólo” 22 años. Una solución habría dado como resultado una embolia pulmonar probablemente mortal.

Resultado: parece que con un aumento del nivel de testosterona se resuelvan de modo biológico e inevitable los conflictos de territorio cerebralmente a la derecha, si el conflicto de pérdida ha formado suficiente masa.

El paciente vive y está bien. Dado que “el órgano concéntrico” (testículo izquierdo) había sido extirpado, no podía notar la nueva solución de la recaída conflictiva de pérdida salvo por el nivel de testosterona y por la sensación de una masculinidad nuevamente aumentada. Ahora ya no es maníaco-depresivo, sino sólo maníaco, lo que nuestra sociedad interpreta a menudo erróneamente como “hiperactivo”.

Aquí el asunto ha terminado bien únicamente porque el paciente es zurdo. Un caso análogo en un hombre diestro terminaría casi obligatoriamente de un modo trágico.

Hace de “contrapeso” al caso precedente, aunque no en constelación esquizofrénica, el de una paciente de 82 años, que durante 50 años, tras un estupro sufrido por una soldadesca rusa durante la guerra, había estado amenorreica, es decir, el ciclo había desaparecido sin que lo volviera a recuperar y desde entonces la paciente reaccionó de un modo “masculino”.

Este conflicto sexual (la señora jamás fue a ningún ginecólogo) se resolvió consecuentemente de un modo biológico después de 50 años de actividad, con la formación de un gran quiste ovarial como fase de reparación de un conflicto de pérdida (con fondo semisexual repugnante). A partir del estadio en el que el quiste se había endurecido haciendo aumentar notablemente el nivel de estrógeno la anciana señora tuvo la menstruación de forma regular (durante tres meses hasta su muerte) y nuevamente era completamente “femenina”.

La familia y yo sabíamos ya semanas antes que la anciana con una probabilidad muy grande no podría superar esta solución biológica del antiguo conflicto tras la crisis epileptoide.

Esta llegó, en vez de durante las siguientes 3-6 semanas como es corriente, tras 3 meses en forma de un infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. La familia ya había decidido anticipadamente que no ingresarían a la madre en un departamento de cuidados intensivos, pues en cualquier caso las esperanzas habrían sido nulas, sino dejarla tener una muerte digna. Falleció con calma y en paz.

También la Sara del Antiguo Testamento, la mujer de Abrahán, debió haber sufrido un quiste ovarial endurecido de este tipo, de manera que pudo tener nueva actividad ovarial y quedar embarazada. Pero no tenía ningún conflicto sexual añadido.

Sin un conflicto sexual activo precedente el quiste ovarial es o mejor que le puede suceder a una mujer: parece 10 o 20 años más joven y sus coetáneos dicen: "Oh, ha mantenido un aspecto muy juvenil".

Ahora, queridos lectores, quizás podéis intender por qué jamás hablo de una solución psíquica del conflicto, sino de una solución "biológica".

La denominada solución psíquica de un conflicto biológico (EBS) es siempre "biológica".

Quizás podréis entender también por qué un "iatros" (médico) tiene que saber muchísimas cosas antes de osar proponer a un paciente una solución de su conflicto, que en las manos de un ignorante puede volverse fácilmente mortal.

Yo soy del parecer quizás un poco anticuado, pero siempre conciliable con la conciencia, que con los pacientes no hay que hacer nada diferente de lo que uno haría para sí mismo o para sus seres queridos. Y si los médicos jefes de oncología solicitan para si mismos y para sus parientes el ser curados con las terapias de la Nueva Medicina, para aprovecharse del 95-98% de posibilidades de supervivencia, en lugar de dejarse asesinar con una probabilidad del 95 al 98% por la quimio de la que ellos mismos hacen propaganda, entonces ninguna persona honesta consigue comprender porque estos corifeos de la medicina de estado al final imponen la quimio a sus pobres pacientes "extraños".

Una pequeña curiosidad: cuando la mujer traicionó al marido con un amante, mientras que estaba en Alemania, éste lo supo y volvió inmediatamente sin avisarla. La sorprendió in fraganti, lo que le causó en 1987 su segundo conflicto de territorio a la derecha periinsularmente (ahora en fase de solución en suspensión a causa del mayor nivel de testosterona).

La mujer sufrió un conflicto de "no haber podido obtener el pedazo de información (respecto a su regreso)" (oído medio derecho, absorción del pedazo a la derecha).

Dado que a menudo se encuentra con el amante por la ciudad, la inflamación del oído medio permanece crónica con solución en suspensión. Siempre que el paciente se acostaba con su mujer, le daba nauseas el olor (TBC) que salía del oído derecho de la mujer. La relativa diabetes por suerte no fue diagnosticada. Durante ese tiempo el conflicto se ha resuelto (figura de abajo).

er Ho-
nflikt-
Männ-
ressiv,
„dyna-

händer
zu fast

onstel-
gewal-
ar, d.h.
hrt und

wurde
als sich
ogenita-
nduriert
e Dame
d - wie-

mit größ-
onfliktes
leptoide
naten in
te schon
; verlegt
sondern
h einge-

ne solche
Eisprung
sexuellen

cks-Zyste
10 bis 20
e hat sich

Ihr versteht jetzt vielleicht, liebe Leser, warum ich nie von einer psychischen Konfliktlösung spreche, sondern von einer „biologischen“. Die sog. psychische Lösung eines Biologischen Konflikt (SBS) ist auch eine „biologische“.

Und jetzt versteht Ihr vielleicht auch, warum ein Iatros erst sehr viel wissen muß, bevor er es wagen darf, einem Patienten eine Lösung seines Konfliktes vorzuschlagen, die in den Händen eines Ignoranten leicht mortal enden kann.

Und ich habe da die vielleicht etwas veraltete, aber mit dem Gewissen stets gut zu vereinbarende Ansicht, daß man mit Patienten niemals etwas anderes machen sollte, als was man mit sich selbst und seinen nächsten Angehörigen auch machen würde. Und wenn die Onkologen-Chefärzte oder -Präsidenten sich selbst und ihre eigenen Angehörigen nach der Neuen Medizin therapieren zu lassen versuchen, um die 95 bis 98%ige Überlebensrate zu nutzen, anstatt sich durch die von ihnen propagierte Chemo mit 95 bis 98%iger Wahrscheinlichkeit umbringen zu lassen, dann kann kein redlicher Mensch mehr verstehen, wie diese Koryphäen der Staatsmedizin anschließend wieder Chemo propagieren für ihre armen „Fremdpatienten“.

Ein kleines Kuriosum: Als die Ehefrau den Patienten mit einem Liebhaber betrog, während er in Deutschland war und es erfuhr, flog der Patient umgehend zurück, ohne seine Frau zu verständigen. Er ertappte sie „in flagranti“, was ihm seinen rechts periinsulären 2. Revier-Konflikt 1987 einbrachte (jetzt in hängender Heilung wegen der vermehrten Testosterone).

Die Ehefrau erlitt einen Konflikt „Den Informations-Brocken (seine Rückreise) nicht erhalten zu haben“ (rechtes Mittelohr, Brockeneingang rechts). Da sie den Liebhaber in der Stadt öfters trifft, bleibt die chronische Mittelohrentzündung in hängender Heilung. Immer wenn der Patient mit seiner Frau schlief, ekelte ihn der Gestank (TBC) aus dem rechten Ohr seiner Frau. Der zugehörige Diabetes wurde glücklicherweise nicht diagnostiziert. Inzwischen ist der Konflikt gelöst (Bild unten).

Bild vom 9.6.99

Oberer Pfeil rechts bezeichnet den aktiven HH im Zucker-Zentrum, überwiegend einem (nicht diagnostizierten) Diabetes entsprechend, weniger (links paramedianer Anteil) einer Unterzuckerung. Sog. „labiler Diabetes“! Wäre der Patient Rechts-händer gewesen, hätte er eine überwiegende Unterzuckerung erlitten (links-cerebral).

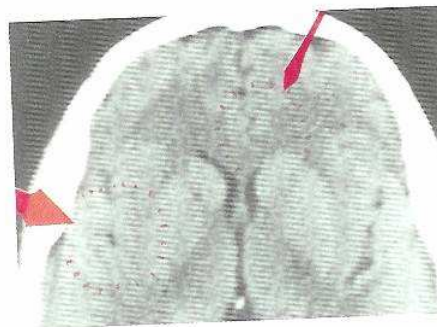


Imagen del 9-6-99

La flecha de arriba a la derecha indica el FH en el centro del azúcar, que corresponde sobretodo a una diabetes (no diagnosticada), y menos a una hipoglucemia (parte paramediana a la izquierda). La denominada "diabetes lábil". Si el paciente hubiese sido diestro habría sufrido sobretodo de hipoglucemia.

8.La crisis epiléptica como pasaje normal en la fase de curación.

Todo programa especial, biológico y sensato (EBS) tiene determinados puntos que los marcan.

Estos son:

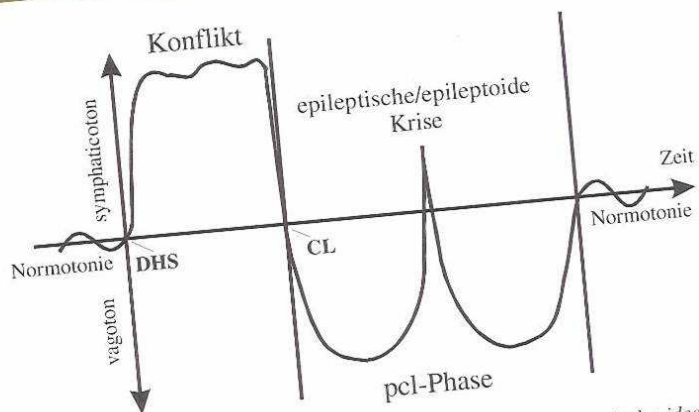
- 1.DHS = inicio de la enfermedad, inicio de la actividad conflictiva.
- 2.CL = inicio de la fase de reparación, final de la actividad conflictiva.
- 3.CE = crisis epileptoide = punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema (en el cerebro y en el órgano).
- 4.RN = renormalización vegetativa.

En este contexto se produce también cada denominado transcurso de la enfermedad cancerosa.

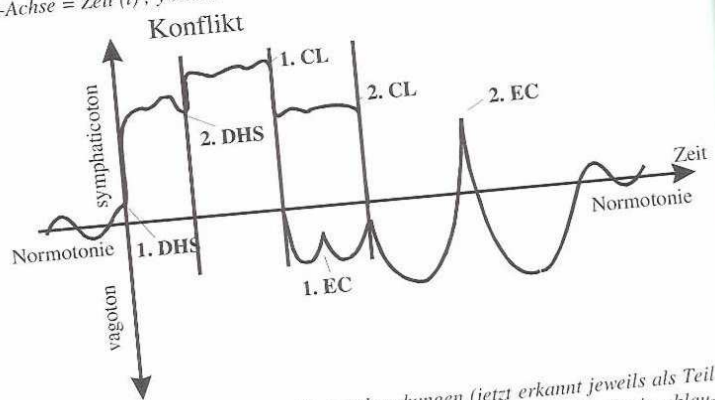
Sin embargo el esquema vale en el caso de que haya un único programa EBS. Si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades: pueden encontrarse, respecto al trascurso, en la misma fase o en fases distintas (inervación mixta).

La cuestión, como casi todo de lo que hablamos aquí, es en principio muy simple, pero se complica cuando pasamos a los detalles.

Naturalmente si dos conflictos se inician con el mismo DHS y son conflictos parecidos a nivel cerebral, es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro (por ej. corteza cerebral), en teoría se puede hablar, en cierta medida, de fases contemporáneas, sobretodo si se resuelven en el mismo tiempo. Sin embargo ya aquí se encuentra la primera dificultad sistemática: los procesos de reparación raramente son simultáneos. Esto depende del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración no son necesariamente iguales; por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente, sin que los dos conflicto tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que un conflicto está "todavía en suspenso".



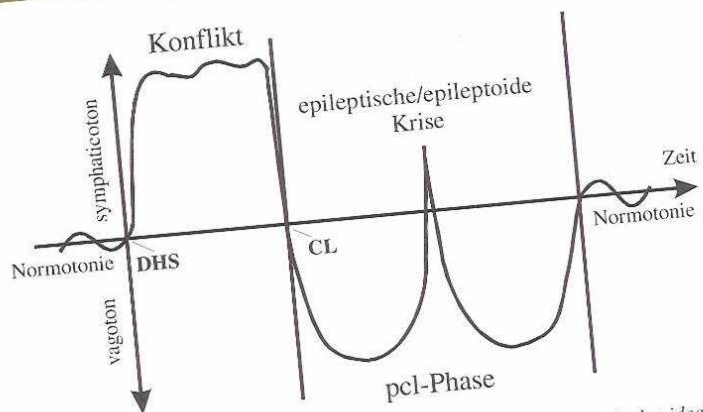
Dargestellt sind: Eutonie¹⁰¹, d.h. normaler Tag/Nacht-Rhythmus sowie das ideale Schema des Konfliktverlaufs einschließlich anschließender Heilungsphase, die nicht unterbrochen wird von Konfliktrezidiven und daher mit einer einzigen epileptischen Krise bis zur Re-Normalisation ausheilen kann.
 x-Achse = Zeit (t); y-Achse = Konfliktintensität



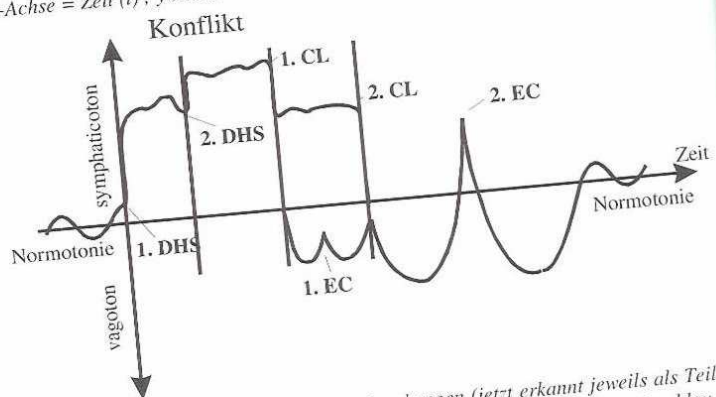
Das obige Schema zeigt 2 sog. Krebserkrankungen (jetzt erkannt jeweils als Teil eines Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms) die verschiedenphasig ablaufen, sowohl was den Zeitpunkt des DHS betrifft, als auch den Zeitpunkt der CL und damit auch der epileptischen/epileptoiden Krise.

¹⁰¹ Eu- ... Wortteil mit der Bedeutung gut, normal

Están representadas: la eutonía, es decir, el ritmo normal día/noche, así como el esquema ideal de la evolución del conflicto incluida la fase final de reparación, que no se interrumpe por recaídas conflictivas y entonces se puede volver a la normalidad con una única crisis epileptoide.



Dargestellt sind: Eutonie¹⁰¹, d.h. normaler Tag/Nacht-Rhythmus sowie das ideale Schema des Konfliktverlaufs einschließlich anschließender Heilungsphase, die nicht unterbrochen wird von Konfliktrezidiven und daher mit einer einzigen epileptischen Krise bis zur Re-Normalisation ausheilen kann.
 x-Achse = Zeit (t); y-Achse = Konfliktintensität



Das obige Schema zeigt 2 sog. Krebskrankungen (jetzt erkannt jeweils als Teil eines Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms) die verschiedenphasig ablaufen, sowohl was den Zeitpunkt des DHS betrifft, als auch den Zeitpunkt der CL und damit auch der epileptischen/epileptischen Krise.

¹⁰¹ Eu- ... Wortteil mit der Bedeutung gut, normal

Este esquema muestra dos denominadas enfermedades cancerosas (ahora reconocidas como parte de un programa especial, biológico y sensato) que transcurren con fases distintas, por lo que respecta tanto al momento del DHS como al momento de la CL y por lo tanto también de la crisis epiléptica/epileptoide.

Otras dificultades se presentan necesariamente cuando el comienzo de los conflictos (DHS) aparece en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente porque el paciente sufre el segundo DHS cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico, y enferma de un segundo cáncer.

La cosa se vuelve todavía más complicada cuando durante ese tiempo se llega a las conflictolisis, que sin embargo se alternan con nuevas recaídas conflictivas.

En muchos casos un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los “conflictos en suspensión”. En esos casos el paciente no tiene las manos calientes, sanas, sino que el paciente está “medio estresado”, dado que se mezclan la simpaticotonía permanente y la vagotonía permanente.

Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotonía, pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo.

En nuestra medicina actual no se toman en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que no es normal puede ser, como mucho, una “disonía vegetativa” (en otras palabras: “estás loco”).

Antes que nada se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender de nuevo que significa una “crisis epiléptica o epileptoide” en el proceso de curación y cual es su naturaleza, cuando se produce y en qué forma.

En sentido estricto, sólo en los conflictos motores la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos.

Para simplificar en adelante llamaremos a todas crisis epilépticas y epileptoides (=parecidas a la epilepsia) crisis epileptoides.

Nótese:

1. la crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación de edema hacia la fase de eliminación de edema. Es una fase intermedia simpaticotónica (punto culminante).
2. cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programa especial, biológico y sensato de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y un punto de cambio y al mismo tiempo un punto de cambio del edema de reparación (fase de hidratación) hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema.
3. estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de Hamer en el cerebro.
4. Sólo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral, las otras denominadas crisis epileptoides del cerebelo, del tronco cerebral o de la

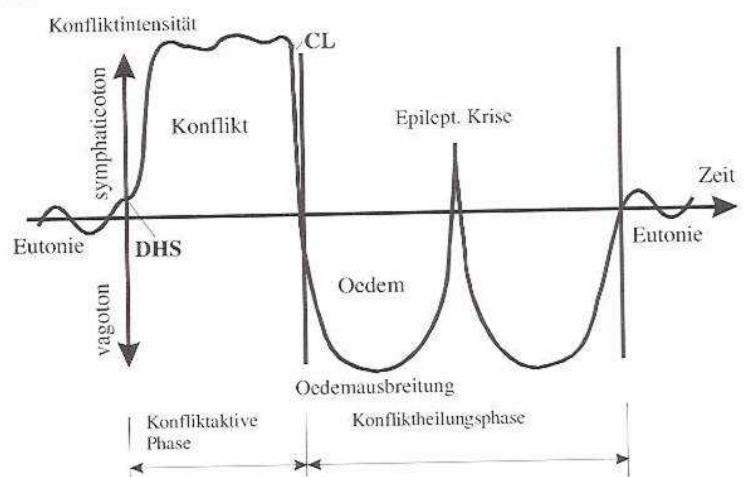
médula cerebral tienen cada una un cuadro clínico propio sin calambres tónico-clónicos ("los días fríos").

5. tras la crisis epiléptica/epileptoide el edema cerebral se reduce de nuevo.
6. Cada segundo o tercer cáncer también tiene su "propia" crisis epileptiforme en el transcurso de la curación. Una conflictolisis de varios conflictos al mismo tiempo puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa, porque en varias partes del cerebro tienen lugar, al mismo tiempo o en sucesión, una epilepsia o un proceso epileptoide.
7. La epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es, también en los casos de crisis epilépticas frecuentes, una "constelación del proceso de reparación" que se representa de modo crónico.
8. El infarto cardíaco, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia.

Seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación: vemos primero el caso "normal":

4. Nur die corticalen motorischen epileptischen Krisen haben tonisch-klonische Krämpfe durch Beteiligung des motorischen Zentrums im Gyrus praecentralis, die anderen sog. epileptoiden Krisen des Kleinhirns, Stammhirns oder Zwischenhirns haben jede ein eigenes klinisches Bild typischer Prägung ohne tonisch-klonische Krämpfe („Die kalten Tage“).
5. Nach der epileptischen/ epileptoiden Krise schwillt das Heilungsoedem wieder ab.
6. Auch jeder Zweit- oder Drittkrebs hat im Heilverlauf „seine“ epileptiforme Krise. Eine gleichzeitige Conflictolyse mehrerer Konflikte kann deshalb gefährlich werden - eventuell aber auch günstig sein, weil dann in mehreren Hirnteilen gleichzeitig eine Epilepsie oder ein epileptoider Vorgang abläuft oder eben hintereinander.
7. Die Epilepsie ist deshalb keine eigene, durchgehende Krankheit, sondern - auch bei häufigen epileptischen Anfällen - eine chronisch wiederkehrende „Heilverlaufs-Konstellation“!
8. Der Herzinfarkt ist, wenn die corticalen Teile der insulären Region betroffen sind, eine Art von Epilepsie!

Nachfolgend wollen wir, um die Sache nicht zu unübersichtlich zu machen, nur zwei Möglichkeiten der Konstellation herausgreifen: Zunächst den „normalen“ Fall:



Auf deutsch heißt dies:

Die Fläche, die die Verlaufskurve der Konfliktintensität in der konfliktaktiven Phase vom DHS bis zur Conflictolyse (CL) bildet, entspricht etwa der Fläche, die der Grad der Vagotonie, meßbar an der Stärke der Oedembildung, ebenfalls mit der x-Achse bildet. D.h.: Je mehr Konfliktintensität

En otras palabras esto significa:

La superficie que la curva del desarrollo de la intensidad conflictiva forma en la fase de conflicto activo del DHS hasta la conflictolisis (CL) corresponde más o menos a la superficie que el grado de vagotonía, medible por la intensidad de la formación de edema, forma con el eje x. Es decir, cuanto más intensidad conflictiva y cuanto más tiempo dure el período conflictivo, tanto mayor y duradera es la presencia del edema.

Podemos decir: el eje vertical o eje y indica la intensidad del conflicto, el eje horizontal o eje x representa el tiempo.

De esto resulta que la integral, es decir, la superficie entre la “curva conflictiva” y el eje x comprendida entre DHS y CL, es parecida a la integral entre CL y RN (vuelta a la normalidad).

Por lo tanto la superficie del conflicto (arriba) es igual a la superficie de la fase de reparación (abajo).

Si suponemos que cada programa especial, biológico y sensato en una fase de reparación tiene también su tipo de crisis epileptoide “propio” y especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del Foco de Hamer, entonces es importante saber:

1. ¿Cuál ha sido el conflicto?
2. ¿Cuándo se ha producido el DHS?
3. ¿Cuánto ha durado el conflicto?
4. ¿Se ha resuelto ya el conflicto?
5. ¿Cuándo hay que atender la crisis epileptoide?
6. ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide?
7. ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide?
8. ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide, o eventualmente cómo se puede mitigar o incluso aumentar?

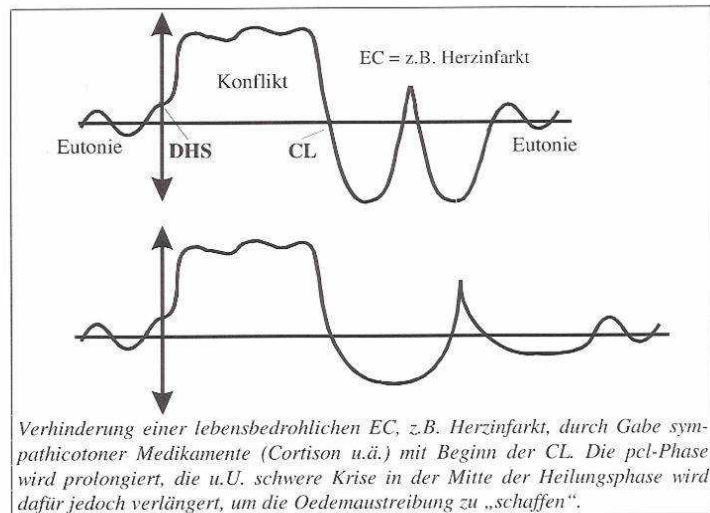
El infarto cardíaco es una crisis sensorial-epileptoide. Ocasionalmente también motora-epiléptica, en la que el Foco de Hamer se encuentra a la derecha en la zona insular del cerebro. En base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes, y en la mayor parte de los casos, con una probabilidad que se acerca a la certeza, si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de la medicina oficial.

De nuestro estudio vienés sobre el infarto cardíaco resulta que no ha sobrevivido ni un paciente (bajo tratamiento médico tradicional) que haya tenido un conflicto de territorio prologado durante más de 9 meses, y siempre que hubiese una actividad conflictiva “normal”.

Con una actividad conflictiva reducida un paciente que reciba la terapia denominada corriente, podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de un año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide 3-6 semanas tras la conflictolisis y en algunos pude prever esta crisis, basándome en mi experiencia, casi precisando el día.

Así aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto cardíaco.

So sieht der Verlauf bei der epileptischen Herzinfarkt-Krise schematisch aus:



Für die Prophylaxe¹⁰⁴ der cerebralen Komplikationen, die ja im System und deshalb eigentlich auch völlig normal sind, ist es natürlich für den Patienten lebenswichtig, daß der Arzt weiß, welche Komplikationen er wann zu erwarten hat.

Hier soll uns vor allem die epileptische Krise interessieren, die nicht nur obligat ist für jeden Heilverlauf nach krebssaktiver Phase, sondern auch sehr gefährlich ist! Hatte der Patient mehrere Krebserkrankungen mit entsprechenden DHS-Schocks, dann hat auch jede dieser ca-Phasen nach Conflictolyse „ihre“ epileptische Krise. Oftmals ist diese Krise verschleiert.

¹⁰⁴ Prophylaxe = Vorbeugung

Impedimento de una CE peligrosa para la supervivencia, por ejemplo el infarto cardíaco, mediante administración de medicinas simpaticotónicas (cortisonas y otras) con inicio de la CL. La fase PCL se prolonga, la crisis, eventualmente grave a la mitad de la fase de reparación, se prolonga sin embargo para “procurar” la eliminación del edema.

En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales, es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa que complicaciones debe atender y cuando.

Aquí nos debe interesar sobretudo la crisis epileptoide, que no sólo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino que es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas con el correspondiente shock-DHS, cada una de estas fases CA tras la conflictolisis tiene su “propia” crisis epileptoide. A menudo esta crisis se enmascara.

8.1. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide.

1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas: si se llega a una crisis epileptoide y si durante ese tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser “enmascarada”. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos.
2. Localización del Foco de Hamer como criterio para el tipo de crisis epileptoide: podemos reconocer bien algunas formas de la crisis epileptoide, por ejemplo la crisis epileptoide en la que el FH se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de desvaloración de sí, un conflicto de agua o de madre-niño, incluso aunque todos estos conflictos tengan su crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptiformes. En el conflicto de desvaloración de sí encontramos el síntoma reconocible en la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar durante horas o días, y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca (en realidad una centralización). La presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de desvaloración que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o sólo arenilla.
3. Enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas: de toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos el médico ya no sabe ni cuando, ni

donde, ni como actúa un determinado medicamento. En general está todo equivocado. En efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también a propósito de los supuestos “cancerígenos”, lo que en ningún caso puede ser así. Pero si el cerebro, al que se han añadido las medicinas, se encuentra en una inervación modificada por los Focos de Hamer, a menudo notamos las denominadas “reacciones paradosales”, que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de numerosos fármacos se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera.

Una de las “reacciones paradosales” más frecuentes y más peligrosas es la “taza rápida de café” por la noche en la autopista cuando el organismo se encuentra en la fase PCL de un programa EBS. La vagotonía profunda tiene aquí un “mecanismo que impide el sueño” gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase PCL de noche se disminuye con el café, el organismo se puede adormentar inmediatamente. Se obtiene por lo tanto una denominada “reacción paradosa” adormeniéndose inmediatamente al volante... con las terribles consecuencias que eso conlleva.

La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más lleno de consecuencias de todo el sistema de la Nueva Medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución del conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral.

Nótese:

La crisis epileptoica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictolisis es una de las causas de muerte y complicación más frecuente de la fase de curación. Su debilitación es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la Nueva Medicina el 2-5% de los pacientes no sobrevive; en efecto, pero se salva el 95-98%.

8.2. La naturaleza de la crisis epileptoide

Tras esta larga discusión todos se preguntan ansiosos: “Si, pero entonces ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide?”.

Lo formularé como sigue:

1. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto el inicio de la contraregulación.
2. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para “apretar” de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces no

tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos (por ej. cortisona).

3. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto como “instrumento” para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpaticotónica revive de un modo acentuado (por ej. los dolores cardíacos en el infarto) toda su evolución conflictiva. Cuanto más intensamente experimenta esta “recaída conflictiva biológica” mayores son sus posibilidades de sobrevivir.

8.2.1. Ejemplo: tren directo París-Colonia, 06/10/1984, salida a las 7:37

En este viaje de tren de París a Colonia que hice con mi amigo el conde D'Oncieu, sucedió lo siguiente: en el andén había algunas jóvenes francesas de 12 o 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor, y saludaban a sus amigos alemanes a los que habían hospedado durante seis u ocho semanas sus familias. Toda una clase de estudiantes de la escuela superior de 14 o 15 años de Hamburgo fue distribuida en las familias francesas, y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo.

Dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimento y me despertó mi amigo a las 9.39. Todavía medio dormido oí al jefe de tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había que fuese corriendo al compartimento tal y tal. Salimos corriendo los dos y seis compartimentos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo (ataque de gran mal), y se estaba recuperando de la pérdida de consciencia. Normalmente en casos parecidos se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho esperaban que ordenase eso.

Pero habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro me faltaba solamente el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo.

Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente y le pregunté cuanto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo: “Desde hace un año”. Desde entonces había tenido dos o tres crisis parecidas. Le pregunté que sucedió antes del primer ataque. Me dijo: “Nada”. (Era verdad a medias). Le pregunté que era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en el buen camino. El joven dijo: “Nada”, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino, entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros (un muchacho de 14 años no debería tener miedo...).

Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté que era lo peor que le había pasado era la “historia de la ambulancia”. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento

total, el pánico cuando le dejaron solo con aquella luz azul y atravesó todo Hamburgo, unos 20 km, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían al hospital, donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. Uno o dos días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide.

Esta situación de pánico, de miedo de estar solo, de abandono y aislamiento se habían repetido otras dos veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones.

Calmé al joven y le explique que el dolor de la separación de la familia francesa, con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia, conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años (yo mismo vi como lloraban en el andén), había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces, cuando tuvo que atravesar la grande Hamburgo durante casi una hora con las sirenas sonando y la luz azul. Dijo: "Sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces".

Pero en el tren su clase lo había retomado haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo; el conflicto se había resuelto rápidamente.

El jefe de tren francés me preguntó si tenían que llevarse al muchacho. Respondí: "No, está todo bien". Le dije al muchacho que fuese al vagón restaurante a beber una taza de café o de té. Dado que me dijo que no tenía más dinero le di cinco marcos, dos compañeras lo cogieron bajo los brazos y entre gritos de triunfo toda la joven banda se fue al restaurante del tren.

El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podría haber pasado al muchacho es haber sido transportado de nuevo en ambulancia delante de todos los compañeros, esta vez en Francia, una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado un año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida, o habría permanecido así por ese motivo.

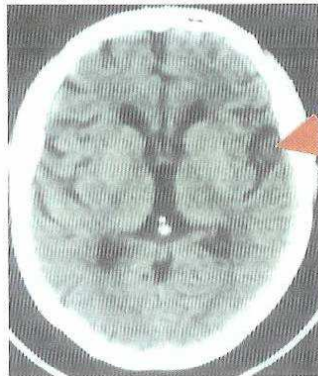
Expliqué a la profesora la situación y la pedí que tuviese cuidado del muchacho. Con el tiempo, creciendo, seguramente tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la "epilepsia juvenil". Le di además mi libro para que lo leyese; una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren, y que sólo gracias a un golpe de suerte se había evitado una catástrofe para el muchacho. Me dijo: ¿Dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan como trátala? Le respondí: "¿Y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota, para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo: "Quizás tenga razón".

8.2.2. Ejemplo: el oficial ordenanza y el cadete.

El paciente protagonista del siguiente ejemplo, tenía una denominada epilepsia, es decir, sufría ataques convulsivos epilépticos.

8.2.2 Fallbeispiel: Der Ordonnanz-Offizier und der Kadett

Der Patient, von dem das nachfolgende Bild ist, hatte eine sog. Epilepsie, d.h. er bekam epileptische Krampfanfälle. Das Erstaunliche war, daß er diese Anfälle nahezu regelmäßig alle 4 Wochen bekam, und zwar seit Herbst '79. Niemand konnte sich einen Vers darauf machen. Sonst war er gesund, ein maskuliner Typ, klein und drahtig, früher Offizier.



Der Patient hatte einen Revier- und einen Revierärger-Konflikt mit Epilepsie, d.h. der Patient hatte einen Revier-Konflikt, der die motorische Hirnrinde einschloß. Er bekam jeden Monat ein Rezidiv, jeden Monat eine Lösung und nach dieser Conflictolyse jeweils seinen epileptischen Anfall.

1979 hatte der Patient einen neuen Chef bekommen. Der Patient war älter als der neue Chef, außerdem war er im Krieg Offizier gewesen, der Chef aber nur Kadett. Als der neue Chef kam, und beide durch die Tür gehen wollten,

sagte der Patient: „Bitte, die Jugend hat den Vortritt!“ Das war ein Affront, der neue Chef verstand, von da ab war Krieg zwischen dem ehemaligen Offizier und jetzigen Untergebenen und dem ehemaligen Kadetten und jetzigen Chef. Jeden Monat bekam der Patient vom Chef eine neue Arbeit zuge- teilt, die er schriftlich auszuarbeiten hatte. Dann knisterte die Luft nur so vor Spannung. Immer glaubte der Patient - und wie sich später herausstellte nicht zu Unrecht -, daß der Chef nur die Gelegenheit suche, ihn einmal her- einzulegen. Das war jedesmal das Rezidiv-DHS. Von da ab war der Patient dann im Streß, in Sympathicotonie, besonders gegen Ende der Zeit, bevor er seine schriftliche Arbeit vortragen und mündlich begründen mußte. Den mündlichen Vortrag machte er stets brillant. Da war er wieder ganz der Ordonnanz-Offizier, der Chef wieder der Kadett, wenn der Patient seinen Vortrag zelebrierte und die Einwände des Chefs, des Kadetten, locker ad absurdum führte.

In der Nacht darauf bekam er regelmäßig einen kleinen Herzinfarkt, eine Magen-Ulcus-Epilepsie und seinen epileptischen Anfall. Und seltsamerwei- se bekam er ihn im Urlaub nie!

Ich verriet ihm den Namen „Hamerschen Herd“ zwischen seinen immer wiederkehrenden Revier- ner regelmäßigen vierwöchigen Epilepsie. Zufä- darauf pensioniert. Er ging zu seinem Chef und sagte der Chef: „Auf Wiedersehen, Herr Ordon- antwortete: „Auf Wiedersehen, Herr Kadett!“ E ganz großen, gleichsam abschließenden epileptis- einen, denn von da ab blieb der Chef für immer d

Der Pfeil zeigt auf den kleinen, mit Oedem cortical rechts im „Reviergebiet“ insulär. So sieh- sagen: „Revierkonflikt-Epilepsie“ aus. Jeden M- findet man diesen oedematisierten HH so vor, da- flikt-aktiven Phase das Oedem verschwunden. S Epilepsien. In Wirklichkeit hat der Patient je- Rezidiv und ein motorisches Konfliktrezidiv, Schicht nicht erfaßt ist.

8.2.3 Fallbeispiel: Epilepsie seit d

Diese inzwischen 26 Jahre alte Frau hat seit d- Anfälle nach einem schrecklichen Angsterlebn- chen Erlebnissen immer panische Angst, träum- alles wieder in Ordnung ist, bekommt sie ihren d

Der Vater starb vor einem Jahr an Leukäm- Frau Selbstmord begehen. Da auch das früher- ter zu tun hatte und der Vater immer ihr große- sterlebnisse und Träume jetzt noch schlimmer a

Auf dem Hirn-CT sehen wir einen corticalen Hamerschen Herd links frontal. Er hat deutlich Oedem, scheint im übrigen aber schon recht vernarbt zu sein. Man kann davon ausgehen, daß es seit dem 8. Lebensjahr, als sie zum ersten Mal einen epileptischen Anfall bekam, immer der gleiche Hamersche Herd gewesen ist.

Den linken HH kann man nicht übersehen durch das ihn umgebende Oedem. Den nehmen mir die Leser auch ab. In den ersten Ausgaben meiner Bücher, bei denen ich auch schon gese- hen hatte, „daß da noch was war“, traute ich mich oftmals nicht, solche kreisförmigen Gebil-

Lo más sorprendente era el hecho de que estos ataques se manifestaban casi regularmente cada cuatro semanas, y justo a partir del otoño de 1979.

Nadie conseguía entender nada. Por lo demás estaba sano, un tipo masculino, pequeño y robusto, y había sido oficial en el pasado. El paciente tenía un conflicto de territorio y uno de rencor en el territorio con epilepsia, es decir, tenía un conflicto de territorio que incluía a la corteza cerebral motora.

Cada mes tenía una recaída, cada mes una solución y tras esta conflictolisis cada vez el correspondiente ataque epiléptico.

En 1979 el paciente había tenido un nuevo jefe, que era más joven que él y era sólo un cadete, mientras que él había sido oficial en la guerra. Cuando el nuevo jefe llegó y los dos quisieron pasar por la puerta, el paciente dijo: "Pase, los

jóvenes tienen preferencia”. Esto fue una ofensa para el nuevo jefe y desde aquel momento se declaró la guerra entre el exoficial hoy subalterno y el excadete ahora jefe. Todos los meses el jefe le encargaba al paciente un nuevo trabajo que tenía que elaborar por escrito. La tensión estaba en el aire. El paciente creía siempre (y no sin razón, como al final resultó) que el jefe buscaba las ocasiones para echarlo por tierra. Eso era lo que cada vez constituía la recaída del DHS. Desde ese momento el paciente había estado en estrés, en simpaticotonía, particularmente cuando tuvo que referir los informes de viva voz. Siempre hacía un informe perfecto. En aquella ocasión se sentía nuevamente oficial de ordenanza, el joven volvía a ser el cadete cuando el paciente celebraba su informe y echaba por tierra las objeciones del jefe, es decir del cadete.

La noche siguiente tenía regularmente un pequeño infarto cardíaco, una crisis epileptoide de la mucosa gástrica y su ataque epiléptico motor. Curiosamente eso nunca le sucedió durante las vacaciones.

Le revelé la llave del tesoro, es decir, la relación entre sus continuas recaídas de conflicto de territorio y la epilepsia que se manifestaba regularmente cada cuatro semanas.

Por casualidad le hicieron pensionista poco tiempo después. Fue a despedirse de su jefe, y el jefe le dijo: “adiós, señor oficial de ordenanza” a lo que él respondió: “adiós, señor cadete”. Seguidamente tuvo un fuerte ataque epiléptico, por así decir, concluyente, y ya no más, porque desde aquel momento el jefe se quedó para siempre como el cadete. La flecha indica el pequeño Foco de Hamer lleno de edema, por el conflicto de territorio, en la corteza periinsular derecha. Así aparece una típica, podríamos decir, “epilepsia de conflicto de territorio”.

Cada mes, tras la conflictolisis, se encuentra este FH edematizado, por el contrario durante la fase de conflicto activo el edema desaparece. Así se desarrollan sustancialmente todas las epilepsias.

En realidad el paciente tenía cada vez una recaída de conflicto de territorio y una recaída de conflicto motor cuyo FH no se reconoce en esta toma.

8.2.3. Ejemplo: epilepsia desde los ocho años

Esta mujer, que ya tiene 26 años, sufre de ataques epilépticos desde los ocho tras una terrible experiencia de miedo. Desde entonces, en caso de experiencias parecidas, cae siempre en pánico e incluso lo sueña.

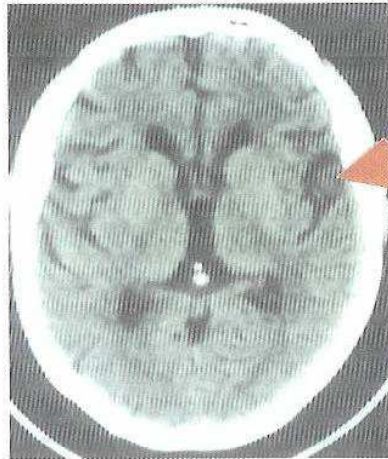
Cuando todo vuelve a la normalidad tiene la crisis epiléptica.

El padre había muerto un año antes de leucemia y entonces la joven mujer quería suicidarse.

Dado que la experiencia precedente de miedo también tenía que ver con el padre, que siempre había sido su gran modelo, ahora sus miedos y sus sueños son peores que antes.

8.2.2 Fallbeispiel: Der Ordonnanz-Offizier und der Kadett

Der Patient, von dem das nachfolgende Bild ist, hatte eine sog. Epilepsie, d.h. er bekam epileptische Krampfanfälle. Das Erstaunliche war, daß er diese Anfälle nahezu regelmäßig alle 4 Wochen bekam, und zwar seit Herbst '79. Niemand konnte sich einen Vers darauf machen. Sonst war er gesund, ein maskuliner Typ, klein und drahtig, früher Offizier.



Der Patient hatte einen Revier- und einen Revierärger-Konflikt mit Epilepsie, d.h. der Patient hatte einen Revier-Konflikt, der die motorische Hirnrinde einschloß. Er bekam jeden Monat ein Rezidiv, jeden Monat eine Lösung und nach dieser Conflictolyse jeweils seinen epileptischen Anfall.

1979 hatte der Patient einen neuen Chef bekommen. Der Patient war älter als der neue Chef, außerdem war er im Krieg Offizier gewesen, der Chef aber nur Kadett. Als der neue Chef kam, und beide durch die Tür gehen wollten, sagte der Patient: „Bitte, die Jugend hat den Vortritt!“ Das war ein Affront, der neue Chef verstand, von da ab war Krieg zwischen dem ehemaligen Offizier und jetzigen Untergebenen und dem ehemaligen Kadetten und jetzigen Chef. Jeden Monat bekam der Patient vom Chef eine neue Arbeit zugeteilt, die er schriftlich auszuarbeiten hatte. Dann knisterte die Luft nur so vor Spannung. Immer glaubte der Patient - und wie sich später herausstellte nicht zu Unrecht -, daß der Chef nur die Gelegenheit suche, ihn einmal hereinzuliegen. Das war jedesmal das Rezidiv-DHS. Von da ab war der Patient dann im Streß, in Sympathicotonie, besonders gegen Ende der Zeit, bevor er seine schriftliche Arbeit vortragen und mündlich begründen mußte. Den mündlichen Vortrag machte er stets brillant. Da war er wieder ganz der Ordonnanz-Offizier, der Chef wieder der Kadett, wenn der Patient seinen Vortrag zelebrierte und die Einwände des Chefs, des Kadetten, locker ad absurdum führte.

In der Nacht darauf bekam er regelmäßig einen kleinen Herzinfarkt, eine Magen-Ulcus-Epilepsie und seinen epileptischen Anfall. Und seltsamerweise bekam er ihn im Urlaub nie!

Ich verriet ihm uer
zwischen seinen im
ner regelmäßigen vi
darauf pensioniert.
sagte der Chef: „Au
antwortete: „Auf W
ganz großen, gleich
einen, denn von da a

Der Pfeil zeigt au
cortical rechts im „E
sagen: „Revierkonfl
findet man diesen o
flikt-aktiven Phase
Epilepsien. In Wir
Rezidiv und ein m
Schicht nicht erfaßt

8.2.3 Fallbeispiel

Diese inzwischen 2
Anfälle nach einem
chen Erlebnissen in
alles wieder in Ord

Der Vater starb
Frau Selbstmord be
ter zu tun hatte und
sterlebnisse und Tr

Auf dem Hirn-CT
Hamerschen Herd l
Oedem, scheint im
vernarbt zu sein. Ma
es seit dem 8. Leben
einen epileptischen
gleiche Hamersche

Den linken HH
durch das ihn umg
mir die Leser auch
meiner Bücher, bei
hen hatte, „daß da
mich oftmals nicht,

En la TAC vemos un Foco de Hamer en la corteza frontal a la izquierda. Tiene un visible edema, pero por el resto se ve que ya está cicatrizado. De esto se puede deducir que desde los ocho años, cuando tuvo por primera vez un ataque epiléptico, se ha tratado siempre del mismo foco de Hamer.

No se puede ver el FH izquierdo que está rodeado por el edema. En las primeras ediciones de mis libros, en las que ya había visto “que había algo”, a menudo no me atrevía a describir tales formaciones porque la mayor parte de los médicos, y también de los lectores bienintencionados, a menudo decían: “Tendría que haberse limitado al Foco que está claro. Por el contrario lo ha complicado todo nuevamente”. Hoy mantengo que imágenes similares son muy interesantes. En realidad tenemos un segundo FH en el lado derecho del cerebro, que corresponde al lado izquierdo del cuerpo o también al lado madre/niño, ocasionalmente también a l lado padre/niño.

Si miráis atentamente, veréis la configuración en anillos concéntricos indicada por la flecha, pero dentro podéis notar otra formación circular sin edema. Este es un fenómeno francamente sorprendente: una gran configuración en anillos concéntricos (con el centro indicado por una pequeña flecha), como se observa en la fase de conflicto activo, puede ser casi “electromagneticamente homogénea”, entonces los cercos son casi del todo uniformes. Pero también puede ser no homogénea y consistir en una serie de formaciones circulares con o sin edema. En este caso todos los Focos de Hamer dentro de la gran configuración de cercos dispuestos concéncticamente muestran actividad conflictiva. Sin embargo ninguno puede resolverse separadamente, en virtud de una situación o una evolución conflictiva especial y específica.

En el presente caso tenemos un conflicto de miedo-asco que avanza hacia la izquierda (hipoglucemia), conflictos motores de las dos piernas, conflicto del oponer resistencia, conflicto de desvaloración de sí mismo en la relación padre/niño, así como un conflicto sensorial padre/niño.

Cuanto mejor van siendo nuestros aparatos, mejor podemos reconocer y distinguir las cosas particulares.

Como hemos dicho, en el lado cerebral derecho están todos los FH en actividad conflictiva, según mi opinión desde hace 18 años. La muchacha entonces entró, en la práctica, en una constelación esquizofrénica con un sólo conflicto que, sin embargo, tenía distintos aspectos. Hay que suponer que la paciente no permaneció durante mucho tiempo en esta constelación esquizofrénica, pero que tuviese recaídas conflictivas.

Esto hay que entenderlo del siguiente modo: mientras que a la izquierda hay actividad conflictiva, existe claramente la constelación esquizofrénica. Si el conflicto a la izquierda se resuelve, porque un aspecto, es decir, el susto, desaparece, entonces la constelación esquizofrénica se anula. Sin embargo otra vez se produce un retroceso, y debido a la duración de la crisis epiléptica. Esta es la razón por la que anteriormente se ha considerado la denominada epilepsia como una enfermedad “del espíritu o psicopatía”. Una parte de los pacientes no tenía sólo las convulsiones, sino que estaba “loca” coincidiendo con el ataque. Justo como los que hemos descrito aquí. La constelación esquizofrénica con un sólo suceso conflictivo pero que tiene varios aspectos, se manifiesta con la siguiente particularidad: cerebro izquierdo: el conflicto de susto y el conflicto de miedo-asco pertenecen al lado cerebral izquierdo, porque una joven diestra es normalmente ya una “pequeña mujer”.

Cerebro derecho: si el conflicto tiene que ver con la madre, o en algunos casos también con el padre, el niño reacciona, desde el período embrional hasta la

muerte, en el lado izquierdo del cuerpo, como el padre diestro reaccionaría en el lado izquierdo del cuerpo por su niño.

Una cosa análoga sucedería y sucede, por ejemplo, a un hombre si su mujer amada se va del territorio y del “brazo derecho del partner”. FH por el conflicto de territorio a la derecha en el cerebro, conflicto motor y sensorial para el lado derecho del cuerpo “lado del partner” a la izquierda en el cerebro.

El hombre diestro entra instantáneamente en constelación esquizofrénica, es decir, “enloquece”. Sin embargo no sucede siempre necesariamente que se sienta de este modo doble.

8.2.4. Ejemplo: aventura amorosa en turco: la amante

Este y el caso siguiente se podrían titular “Aventura de amor en turco”.

Este escáner con el típico foco de conflicto de miedo en la nuca pertenece a una mujer turca zurda, que tenía una relación íntima con el primo de su marido. Ella sabía muy bien lo que le sucedería si la descubrían. Por lo tanto siempre iba a la cita llena de miedo, volviendo continuamente la cabeza para controlar que nadie la seguía. Bien tras el encuentro o como muy tarde el día después tenía un ataque epiléptico.

Solamente una persona conocía la relación y ocasionalmente tenía que jugar el papel de “centinela de amor”, era la hija de dieciséis años del amante.

La siguiente imagen es la de la hija, que también tenía epilepsia.

meinende Leser
belassen, der ist
t.“

In Wirklichkeit
nseite, entspre-
legendlich auch
r die durch die
r könnt Ihr eine
radezu atembe-
(Zentrum durch
ise sehen, kann
Kreise ziemlich
einer Reihe von
l sind alle HHe
on alle in Kon-
zieller und spe-
lösung gehen.
den Angst-Ekel-
z, Konflikt des
erhältnis, sowie
eden, desto bes-

Konfliktaktivität,
amals quasi mit
in die schizo-
lange in dieser
ineinkam durch

fliktaktivität ist,
ikt links wieder,
rt, dann ist die
mal zurück, und
ien Anfalls. Das
z „Geistes- und
at nicht nur ge-
solche, wie hier

ehen mit meh-

Ekel-Konflikt ist
erin ist gewöhn-

nanchen Fällen
eit bis zum Tod,

auf der linken Körperseite, wie ja der rechtshändige Vater bei seinem Kind auch entsprechend auf der linken Körperseite reagieren würde.

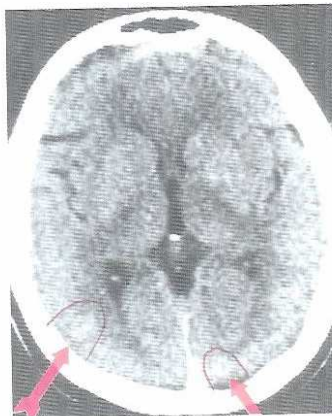
Analoges würde z.B. passieren und passiert auch, wenn einem Mann die heißgeliebte Partnerin „aus dem Revier und aus dem rechten Partnerarm“ läuft. Revierkonflikt-HH rechts, motorischer und sensorischer Konflikt für rechte „Partnerseite“ des Körpers im Gehirn: Links. Dann ist der rechtshändige Mann augenblicklich in schizophrener Konstellation, d.h. „er dreht durch“. Er muß aber nicht immer in dieser doppelten Art empfinden.

8.2.4 Fallbeispiel: Liebesabenteuer auf Türkisch: Die Geliebte

Diesen und den nächsten Fall könnte man überschreiben mit „Liebesabenteuer auf türkisch“. Dieser Scanner mit dem typischen Angst-im-Nacken-Konflikt-Herd gehört einer linkshändigen türkischen Ehefrau, die ein intimes Verhältnis mit dem Vetter ihres Mannes hatte. Was ihr passieren würde, wenn das herauskommen würde, war ihr klar. Und deshalb ging sie immer zitternd vor Angst, sich ständig umdrehend, ob auch niemand ihr gefolgt sei, zu den Stelldicheins. Entweder kurz nach dem Stelldichein oder spätestens am nächsten Tag bekam sie einen epileptischen Anfall.

Nur eine Person wußte von dem Verhältnis und mußte wohl gelegentlich sogar den „Postillon d' amour“ spielen, das war die 16jährige Tochter des Liebhabers. Von ihr stammt das nächste Bild, auch sie hatte eine Epilepsie.

Der rechte Pfeil bezeichnet den HH des Angst-im-Nacken-Konfliktes für linken Glaskörper (Angst vor Ehemann), der linke Pfeil bezeichnet den weiblichen Reviermarkierungskonflikt-HH der dem rechten Nierenbecken zugehört und ein Nierenbecken-Ulcus macht. Rechts markiert der Identitäts-Konflikt (wegen Linkshändigkeit rechts), dadurch schizophrene Konstellation.



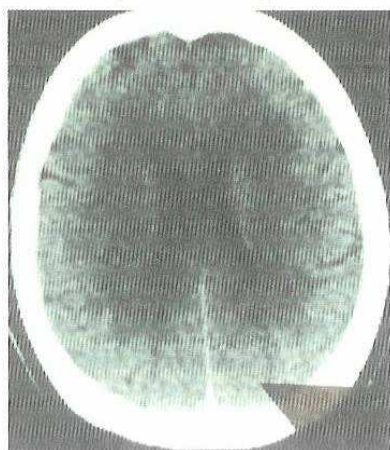
La flecha derecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca para el cuerpo vítreo izquierdo (miedo del marido), la flecha izquierda indica el FH del conflicto de marcar el territorio femenino que pertenece al cáliz renal derecho y causa una úlcera del cáliz renal. A la derecha se delinea el conflicto de identidad (a la derecha a causa de ser zurda), por lo tanto constelación esquizofrénica.

La imagen de abajo es de la hija del primo del marido, que estaba al corriente de la relación y sentía un miedo-pánico (en la nuca) de que a su padre lo asesinará el marido enfurecido de la turca.

Cada vez que el padre se ausentaba la muchacha se quedaba en la cama temblando y escuchando y sólo se calmaba cuando el padre volvía a casa. Siempre en esa misma noche tenía un ataque epiléptico, o tenía desmayos el día siguiente.

Wenigstens das Bild der Tochter des Vaters ihres Mannes. Sie wußte über das Verhältnis und hatte eine panische Angst (im Nacken), daß ihr Vater eines Nachts bei den Schäferstündchen ermordet werden würde durch den wütenden Ehemann der Türkin.

Jedesmal, wenn der Vater weg war, lag das Mädchen zitternd am ganzen Körper und lauschend im Bett und war erst wieder erlöst, wenn der Vater heimkehrte. Stets bekam sie in der gleichen Nacht eine epileptische Krise oder hatte am nächsten Tag Absenzen.



Der Pfeil zeigt auf den Angst-im-Nacken-Konflikt-HH rechts. Sowohl die Türkin als auch die Tochter ihres Liebhabers hatten Sehprobleme mit dem linken Auge (Glaskörper).

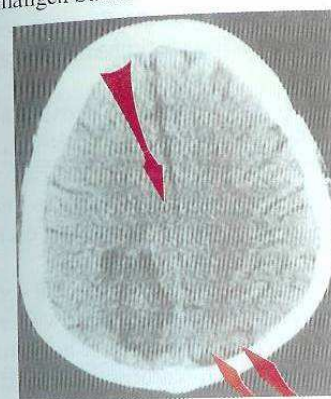
Die motorischen Herde im Gyrus praecentralis, die bei beiden die Epilepsie auslösten, sind auf diesen Schnitten nicht zu sehen. Sie wären auf weit höheren Schnitten gelegen. Beide Frauen haben aber an der gleichen Stelle ihren HH für den Angst-im-Nacken-Konflikt. Die junge Türkin (Rechtshänderin) empfand für ihren Vater (= Eltern, nicht Partner!) Angst-im-Nacken vor dem Ehemann der Geliebten.

8.2.5 Fallbeispiel: Katastrophe pur

Die folgenden Bilder stammen von einem Gastarbeiter, der verheiratet ist und seit 18 Jahren in Deutschland lebt. Vor 15 Jahren verliebte er sich in ein 16jähriges Mädchen aus seiner Heimatstadt, das damals auch in Deutschland lebte, in der gleichen Stadt wie er. Sie wurde schwanger. Eines Tages kam die Nachbarin zu dem Patienten und berichtete, das 16jährige Mädchen sei bei der Geburt in Italien gestorben. Der Patient erlitt ein DHS, fiel buchstäblich um und zitterte am ganzen Leibe. Später erzählte es ihm auch seine Frau. Es war für ihn wie Stiche mit glühenden Nadeln.

15 Jahre später schrieb ihm eine Frau aus seinem Heimatort, sie möchte ihn gerne sprechen. Da erlitt er ein erneutes DHS-Rezidiv, denn er dachte natürlich nichts anderes, als daß sie mit ihm die damalige Sache besprechen wolle und daß sie damals von dem Mädchen ins Vertrauen gezogen worden sei. Wieder zitterte er am ganzen Leib, als er den Brief gelesen hatte.

Er traf dann diese Frau auch und so nichts mit der damaligen Affäre zu tun. seinen ersten epileptischen Anfall, der denn er träumt noch des öfteren, man maligen Sache.



Und so sieht so etwas dann im Gehirn o HH links parieto-occipital¹⁰⁸, der ein und, wie auf dem rechten Bild zu sehen Gehirns) der Hirnrinde reicht. Dieser eine sensorische epileptoide Absence. große Oedemherd von links hinten nach aus unabhängigen Hamerschen H untereinander gelegen sind, wie ein e hen. Daneben gibt es nämlich in d gleichzeitig noch einen halb gelöste Nacken-Konflikte (rechte Sehrinde, Pfe noch nicht gelöste, HHe mit scharfe rechts, betreffend Kind, Alimenten-Ang ren scharfrändigen Schießscheibenrin oben).

Am Fall dieses rechtshändigen jung bens-Konfliktgeschichte nachvollzi Nacken-Konflikten (rechts und links noch die links-cerebralen Herde für

¹⁰⁸ parietal = seitlich, wandständig, zur

La flecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca a la derecha. Tanto la turca como la hija de su amante tenían problemas de vista en el ojo izquierdo

(cuerpo vítreo). Los focos motores en el giro precentral que causaban las dos epilepsias no se ven en esta toma. Estarían situadas en estratos mucho más altos. Las dos mujeres tienen sin embargo el FH del conflicto de miedo en la nuca en el mismo sitio. La joven turca (diestra) tenía miedo en la nuca por su padre (=padre no partner) a causa del marido de la amante.

8.2.5. Ejemplo: pura catástrofe.

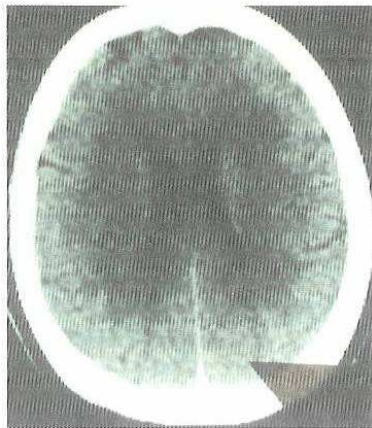
Las imágenes siguientes provienen de un trabajador extranjero, que está casado y vive desde hace 18 años en Alemania. Hace quince años se enamoró de una chica de dieciséis de su ciudad natal, que por aquel entonces también vivía en Alemania, en la misma ciudad. La muchacha se quedó embarazada. Un día la vecina se acercó al paciente y le informó que la muchacha había muerto durante el parto en Italia. El paciente sufrió un DHS, cayó literalmente sobre el suelo y le temblaba todo el cuerpo. Seguidamente se lo contó a su mujer. Para él fue como si le atravesarán con agujas.

Quince años más tarde le escribió una mujer de su patria diciendo que quería hablar con él. De nuevo le afectó una recaída de DHS, porque obviamente pensó que sólo podía querer hablar de lo que había pasado entonces, suponiendo que la muchacha se había confiado a esta mujer. Nuevamente sufrió temblores tras leer la carta.

Después, cuando se encontró con esta mujer vio que su visita no tenía nada que ver con aquella historia. El día después tuvo su primer ataque epiléptico, que desde aquel momento se repite a menudo porque sueña todavía que alguien quiere ponerse en contacto con él por aquel asunto del pasado.

weiter unten das Bild der Tochter des Vaters ihres Mannes. Sie wußte über das Verhältnis und hatte eine panische Angst (im Nacken), daß ihr Vater eines Nachts bei den Schäferstündchen ermordet werden würde durch den wütenden Ehemann der Türkin.

Jedesmal, wenn der Vater weg war, lag das Mädchen zitternd am ganzen Körper und lauschend im Bett und war erst wieder erlöst, wenn der Vater heimkehrte. Stets bekam sie in der gleichen Nacht eine epileptische Krise oder hatte am nächsten Tag Absenzen.



Der Pfeil zeigt auf den Angst-im-Nacken-Konflikt-HH rechts. Sowohl die Türkin als auch die Tochter ihres Liebhabers hatten Sehprobleme mit dem linken Auge (Glaskörper).

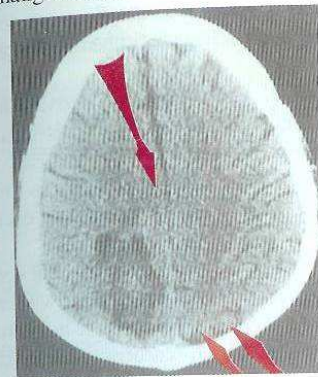
Die motorischen Herde im Gyrus praecentralis, die bei beiden die Epilepsie auslösten, sind auf diesen Schnitten nicht zu sehen. Sie wären auf weit höheren Schnitten gelegen. Beide Frauen haben aber an der gleichen Stelle ihren HH für den Angst-im-Nacken-Konflikt. Die junge Türkin (Rechtshänderin) empfand für ihren Vater (= Eltern, nicht Partner!) Angst-im-Nacken vor dem Ehemann der Geliebten.

8.2.5 Fallbeispiel: Katastrophe pur

Die folgenden Bilder stammen von einem Gastarbeiter, der verheiratet ist und seit 18 Jahren in Deutschland lebt. Vor 15 Jahren verliebte er sich in ein 16jähriges Mädchen aus seiner Heimatstadt, das damals auch in Deutschland lebte, in der gleichen Stadt wie er. Sie wurde schwanger. Eines Tages kam die Nachbarin zu dem Patienten und berichtete, das 16jährige Mädchen sei bei der Geburt in Italien gestorben. Der Patient erlitt ein DHS, fiel buchstäblich um und zitterte am ganzen Leibe. Später erzählte es ihm auch seine Frau. Es war für ihn wie Stiche mit glühenden Nadeln.

15 Jahre später schrieb ihm eine Frau aus seinem Heimatort, sie möchte ihn gerne sprechen. Da erlitt er ein erneutes DHS-Rezidiv, denn er dachte natürlich nichts anderes, als daß sie mit ihm die damalige Sache besprechen wolle und daß sie damals von dem Mädchen ins Vertrauen gezogen worden sei. Wieder zitterte er am ganzen Leib, als er den Brief gelesen hatte.

Er traf dann diese Frau auch und so kam nichts mit der damaligen Affäre zu tun hat seinen ersten epileptischen Anfall, den er so denn er träumt noch des öfteren, man wolle maligen Sache.



Und so sieht so etwas dann im Gehirn aus. Die HH links parieto-occipital¹⁰⁸, der ein ausgeht und, wie auf dem rechten Bild zu sehen, in der Gehirns) der Hirnrinde reicht. Dieser HH ist eine sensorische epileptoide Absence. Aber große Oedemherd von links hinten nach links, untereinander gelegen sind, wie ein einziger. Daneben gibt es nämlich in diesem gleichzeitig noch einen halb gelösten Angst-im-Nacken-Konflikt (rechte Sehrinde, Pfeile rechts, noch nicht gelöste, HHs mit scharfen Scherfranken rechts, betreffend Kind, Alimenter-Angst?) und links scharfrandigen Schießscheibenringen (oben).

Am Fall dieses rechtshändigen jungen Mannes Lebens-Konfliktgeschichte nachvollziehen. Angst-im-Nacken-Konflikten (rechts und links occipital) noch die links-cerebralen Herde für die rechts-

¹⁰⁸ parietal = seitlich, wandständig, zum Scheitel hin

En el cerebro la situación aparece así. El paciente tiene un nuevo FH de miedo a la izquierda parieto-occipitalmente, que produce un edema perifocal alargado y, como se ve en la foto de la derecha, llega al punto más alto de la corteza cerebral. Este FH es visiblemente la causa de un desmayo epileptoide sensorial. Pero este gran foco edematoso, homogéneo bajo el perfil óptico, de derecha a izquierda arriba, se compone funcionalmente en realidad de Focos de Hamer independientes que, encontrándose por casualidad cerca o superpuestos, tienen el aspecto de un único foco. Además, en esta TAC hay al mismo tiempo un conflicto de miedo al ladrón y de miedo en la nuca (retina derecha, flecha a la derecha abajo) resuelto a medias, igual que FH todavía activos, es decir, no resueltos, con anillos concéntricos evidentes (flecha en el centro de la imagen de la derecha, que tiene que ver con el miedo de tener que pagar los alimentos del niño) y un FH con anillos concéntricos bien visibles (paramediano a la izquierda, flecha de arriba a la izquierda).

En el caso de este joven hombre diestro se puede reconstruir una verdadera y propia historia conflictiva de su vida. Además de los dos conflictos de miedo en la nuca (a la derecha e izquierda occipitalmente), que están resueltos a medias, hay todavía focos cerebrales a la izquierda, para la mitad derecha del cuerpo, o sea, que tienen que ver con la partner o la novia.

Nos podría chocar saber que la muerte de la novia embarazada constituyó gran parte del primer DHS, pero también fue, bajo el aspecto biológico, la solución del conflicto.

Con la recaída todo se representa de nuevo. Este conflicto o conflicto parcial que forma parte del gran foco edematoso de arriba, junto con conflicto motor-sensorial, conflicto sexual de desvaloración de sí que tiene que ver con el cáliz derecho, conflicto del tálamo, que tiene que ver con el centro de la personalidad, está resuelto en principio, excepto el conflicto motor-sensorial.

El FH a la derecha cerebral no está resuelto, y tiene que ver con el niño, que vivió. Por una parte se sentía separado de este niño, por otra quería permanecer separado. Habría sido una catástrofe si el niño hubiese aparecido para exigirle derechos, lo habría arruinado. Este miedo continúa totalmente o ampliamente activo.

Si reconstruimos la vivencia tenemos que tomar cuenta de que el paciente tanto entonces, hace 15 años, como ahora, ha estado temporalmente en "constelación esquizofrénica". Probablemente vuelve a estarlo hoy en día, porque el conflicto motor-sensorial a la izquierda cerebralmente está resuelto solo a medias, y al mismo tiempo en el exterior tiene todavía una marcada configuración de anillos concéntricos, con un poco de edema al centro. Casi se puede decir: todo el hombre ha sido y es un gran pánico.

Si nos preguntamos de donde vienen los ataques epilépticos (motores) del paciente, podemos decir claramente que el único ámbito motor es el cerebral a la izquierda (que tiene que ver con su amante); este con las recaídas siempre se pone en solución cuando se acuerda de los hechos y el relativo edema confirma que antes siempre ha estado en actividad.

El foco en el lado cerebral derecho está continuamente activo, causa una constante parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, porque por lo que concierne al niño no puede llegar a una solución, en cualquier caso no hasta este momento.

No es para nada fácil individuar una terapia o autoterapia que se pueda aconsejar a este paciente. Los síntomas de los ataques epilépticos, que normalmente deseamos “curar sintomáticamente” o eliminar, desaparecen de dos modos diferentes principalmente: o cuando definitivamente ya no piensa más en su amante o cuando pensando en ella no se llega ya a una solución del conflicto.

En este último caso se encontraría en constelación esquizofrénica permanente.

Si él, en teoría, resolviese el conflicto de su niño, tendría otra crisis epiléptica.

Veis como lo que en teoría es muy fácil en la práctica a menudo es complicado, sobretodo si no se puede valorar antes lo que podría suceder seguidamente según como se comporte el paciente y como piensa, siente, sueña, espera, desea, teme, etc...

8.2.6. Ejemplo: lucha hasta la última gota de sangre

Seguidamente vemos las imágenes TAC de una señorita diestra de 16 años que estaba de campamento con otras muchachas.

Una tarde tuvo una pelea con una muchacha algeriana y sospechaba que esta llevaba un cuchillo. Estaban solas en la playa y fue una lucha a vida o muerte. La lucha terminó por el total cansancio de las dos. Pero durante las siguientes cuatro semanas de campamento la muchacha tuvo constantemente miedo de que su violenta compañera la sorprendiese, esta vez sin darle tregua.

A la mañana siguiente de la pelea tuvo su primer ataque epiléptico con mordedura de la lengua y calambres tónico-clónicos. Durante el campamento tuvo algunos ataques epilépticos. Antes siempre soñaba con “guerra”.

Después del campamento los sueños y los ataques permanecieron. Soñaba siempre con “guerra” y en el sueño siempre sentía pánico. La cosa duró durante dos años y la vista de su ojo derecho fue empeorando cada vez más. Después conoció a mis amigos de Chambéry, que naturalmente comprendieron al momento de que se trataba y hablaron con ella.

Por primera vez la muchacha tuvo el coraje de contar la terrible lucha nocturna, sus miedos en los sueños, el miedo de morir, el miedo en la nuca, que en el sueño experimentaba cuando creía que la compañera se preparaba para agredirla. También estaba en condiciones de hablar (ya habían pasado dos años) del hecho que desde entonces se sentía cambiada sin poder explicar como, simplemente “ya no era normal”.

Se llegó a una completa solución de los conflictos de miedo.

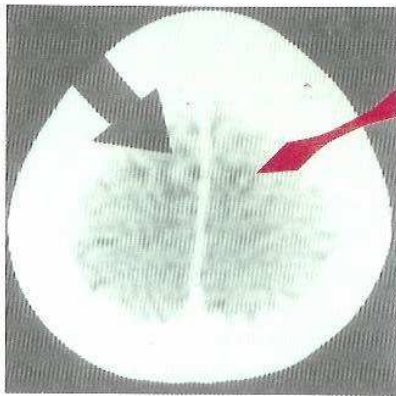
El conflicto motor paracentral de ambos lados que en nuestras fotos aparece todavía sin terminar de solucionarse, durante este tiempo también ha entrado en solución. La muchacha, que había estado en “constelación esquizofrénica” (ver el capítulo sobre las psicosis), ha vuelto a la normalidad, las pesadillas han desaparecido y también los ataques epilépticos. La muchacha está nuevamente sana. Lo particular había sido el hecho de que nunca había podido hablar con

nadie de sus miedos, porque se avergonzaba, aunque hubiera deseado ansiosamente poder discutirlos con otra persona. Por eso en cuanto encontró a las personas que querían hablar con ella de eso lo contó todo. Estaba agradecida, feliz y aliviada.

En la primera imagen vemos en el estrato superior de la TAC, es decir, en la corteza cerebral bajo la vuelta craneal, dos Focos de Hamer, de los que el derecho pertenece a un conflicto de miedo en el núcleo del tálamo y desde la corteza se extiende hasta el tálamo derecho. El FH paramediano izquierdo está limitado a la corteza. Los dos focos parecen haber tenido un reducido edema.

gewünscht, als daß sie mit einem Menschen darüber hätte reden können. Deshalb sprudelte es nur so aus ihr heraus, als sie nun Menschen fand, die gezielt darüber mit ihr sprechen wollten. Sie war so dankbar, glücklich und erleichtert!

Auf dem ersten Bild sehen wir in der obersten Schicht des Hirn-CTs, also in der Hirnrinde unter dem Schädeldach zwei Hamersche Herde, von denen der rechte zu einem Thalamuskern-Angstkonflikt gehört und praktisch von der Cortex bis zum rechten Thalamus durchgeht. Der linke paramediane HH scheint cortical geblieben zu sein. Beide Herde scheinen gerade ein bißchen Oedem bekommen zu haben.



Sehr interessant: Wenn man zwei solche Herde auf verschiedenen Hirnseiten sieht, dann ist der eine den Partner betreffend, der andere bekanntlich die Mutter oder ein Kind. Nun, der links-cerebrale Herd, betreffend die Oberschenkel/ Hüftmuskulatur rechts, betrifft den oder die Partner, in diesem Fall, wo es ja um eine gefährliche Rivalität um den Jungen ging, den beide begehrten, ging es möglicherweise um das Festhalten des Partners in der Umarmung des (rechten) Oberschenkels oder die Eifersucht, daß sich der gemeinsame Freund und die Rivalin mit ihren Oberschenkeln in der sexuellen Liebesumarmung festgehalten hatten. Aber, was ist nun mit Mutter oder Kind? Mit der Mutter des Mädchens hatte es nichts zu tun, dies scheidet also aus. Aber mit einem gewünschten Kind hatte das bei der damals 16jährigen schon wirklich zu tun! Es ging ihr damals wirklich darum, den Freund festzuhalten, gleichzeitig aber auch ein Kind von ihm zu bekommen, wie sie verriet. Das sei ja eigentlich der wahre Grund der Eifersucht gewesen. Und bei einem 16jährigen, südfranzösischen Mädchen, das über beide Ohren in den jungen Mann verliebt war, kann man sich das auch vorstellen. Der Kinderwunsch muß in diesem Moment sogar so gravierend gewesen sein, daß der Konflikt bis in den Thalamus-Bereich durchgeschlagen ist, also quasi bis in den Kern der Persönlichkeit!

Auch hier können wir die „ganze Geschichte“ wieder anhand unserer CTs psychisch bis ins Detail rekonstruieren:

Links-cerebral sehen wir einen großen HH im sexuellen Bereich, biologisch gesprochen entsprechend einem Konflikt des „Nicht-begattet-Werdens“. Dieser Konflikt ist in beginnender Lösung, was wir daran sehen, daß das linke Vorderhorn etwas imprümiert ist. Links ist ein sog. „raumfordernder Prozeß“. Rechts

fronto¹⁰⁹-basal¹¹⁰ finden wir den Konflikt, die linken Nebenhöhlen vergegenwärtigen, die beieinander, jedes das andere. Rechts und links occipital. Konflikte: Der rechts-cerebrale Partnerin (nach rechts) an der Sache gemeint, die mit der



Links ist die Sache etwas anders. Links¹¹¹ Pfeil, der auf einen Konflikt zeigt, der zuständig ist, die nach links gerichtete Tätigkeit gleichsam doppelt gemacht. Es ist ein Konflikt des rechten Glaskörners, der eine frische Lösung, wie bei einem Konflikt fronto-basal.

Dieser Angst-im-Nacke-Konflikt bedeutet einen Angst im Nacken, der bedroht. Die Patientin hat das Messer bei sich haben und freibekommen, ihr das Messer. Der Konflikt ist natürlich rezidiv. Rezidive gemacht durch

¹⁰⁹ frontal = stirnwärts, s.
¹¹⁰ basal = an der Basis l.
¹¹¹ lateral = seitlich, seitw.

Muy interesante: cuando se ven dos focos parecidos en distintos lados cerebrales, uno tiene que ver con el partner y el otro, como ya sabemos, a la madre o al niño. El foco cerebral izquierdo, para la musculatura de pierna/fémur derecha, tiene que ver con el o la partner, en este caso, en el que se trata de una rivalidad peligrosa por el chico que las dos deseaban, se trató probablemente del hecho de retener al

partner en el abrazo del muslo derecho o de los celos por el hecho de que el amigo común y la rival se habían apretado con los muslos en el abrazo amoroso sexual. Y ¿qué decir del conflicto de la madre y del niño? Se descarta la hipótesis de la madre de la muchacha, que no tenía nada que ver con el asunto. Por el contrario hay que tener en cuenta al niño que la adolescente de 16 años realmente había deseaba. Para ella se trataba de retener al amigo, pero también de tener un hijo con él, como confesó.

Este había sido el verdadero motivo de los celos. Y bien se puede imaginar en una muchacha de 16 años de Francia meridional, enamorada hasta los huesos del joven.

El deseo de tener un niño tiene que haber sido tan fuerte en ese momento como para provocar el conflicto en la zona del tálamo, es decir, caso hasta el núcleo de la personalidad.

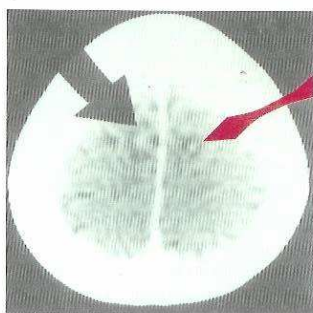
También aquí podemos reconstruir al detalle “toda la historia” a la luz de nuestra TAC:

A la izquierda cerebralmente vemos un gran FH en la zona sexual, correspondiente biológicamente a un conflicto de “no ser poseída”. A la derecha frontal-basal encontramos un “conflicto de miedo olfativo” que está en solución, que tiene que ver con los senos paranasales izquierdos. Si recordamos nuevamente la lucha, las muchachas se habían peleado con las caras muy cerca una de la otra.

Finalmente tenemos a la derecha y a la izquierda occipitalmente los dos conflictos de miedo en la nuca: el cerebral a la derecha referido a las dos mitades izquierdas de la retina que ven al partner (hacia la derecha). Con esto se entiende claramente el miedo de algo que tiene que ver con el partner.

gewünscht, als daß sie mit einem Menschen darüber hätte reden können. Deshalb sprudelte es nur so aus ihr heraus, als sie nun Menschen fand, die gezielt darüber mit ihr sprechen wollten. Sie war so dankbar, glücklich und erleichtert!

Auf dem ersten Bild sehen wir in der obersten Schicht des Hirn-CTs, also in der Hirnrinde unter dem Schädeldach zwei Hamersche Herde, von denen der rechte zu einem Thalamuskern-Angstkonflikt gehört und praktisch von der Cortex bis zum rechten Thalamus durchgeht. Der linke paramediane HH scheint cortical geblieben zu sein. Beide Herde scheinen gerade ein bißchen Oedem bekommen zu haben.



Sehr interessant: Wenn man zwei solche Herde auf verschiedenen Hirnseiten sieht, dann ist der eine den Partner betreffend, der andere bekanntlich die Mutter oder ein Kind. Nun, der links-cerebrale Herd, betreffend die Oberschenkel/ Hüftmuskulatur rechts, betrifft den oder die Partner, in diesem Fall, wo es ja um eine gefährliche Rivalität um den Jungen ging, den beide begehrten, ging es möglicherweise um das Festhalten des Partners in der Umarmung des (rechten) Oberschenkels oder die Eifersucht,

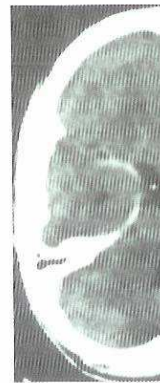
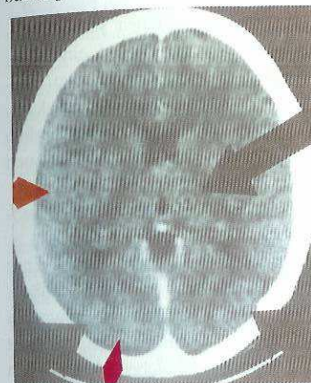
daß sich der gemeinsame Freund und die Rivalin mit ihren Oberschenkeln in der sexuellen Liebesumarmung festgehalten hatten. Aber, was ist nun mit Mutter oder Kind? Mit der Mutter des Mädchens hatte es nichts zu tun, dies scheidet also aus. Aber mit einem gewünschten Kind hatte das bei der damals 16jährigen schon wirklich zu tun! Es ging ihr damals wirklich darum, den Freund festzuhalten, gleichzeitig aber auch ein Kind von ihm zu bekommen, wie sie verriet. Das sei ja eigentlich der wahre Grund der Eifersucht gewesen. Und bei einem 16jährigen, südfranzösischen Mädchen, das über beide Ohren in den jungen Mann verliebt war, kann man sich das auch vorstellen. Der Kinderwunsch muß in diesem Moment sogar so gravierend gewesen sein, daß der Konflikt bis in den Thalamus-Bereich durchgeschlagen ist, also quasi bis in den Kern der Persönlichkeit!

Auch hier können wir die „ganze Geschichte“ wieder anhand unserer CTs psychisch bis ins Detail rekonstruieren:

Links-cerebral sehen wir einen großen HH im sexuellen Bereich, biologisch gesprochen entsprechend einem Konflikt des „Nicht-begatter-Werdens“. Dieser Konflikt ist in beginnender Lösung, was wir daran sehen, daß das linke Vorderhorn etwas imprimiert ist. Links ist ein sog. „raumfordernder Prozeß“. Rechts

fronto¹⁰⁹-basal¹¹⁰ finden wir einen ebenfalls in Lösung befindlichen Konflikt¹¹¹, die linken Nebenhöhlen betreffend. Wenn wir uns damals vergegenwärtigen, dann kämpften die Mädchen ja mit der Mutter, jedes das andere fest umschlungen ...

Rechts und links occipital schließlich haben wir die beiden Konflikte: Der rechts-cerebral betrifft die beiden linken Reaktionen der Partnerin (nach rechts) anblicken. Damit ist also eindeutig eine Sache gemeint, die mit der Partnerin zu tun hat.



Links ist die Sache etwas komplizierter: Dort haben wir (2) einen HH¹¹¹ Pfeil, der auf einen HH weist, der wiederum für die beiden zuständig ist, die nach links das Kind anschauen würden. Hier ist die Situation gleichsam doppelt gekreuzt. Der Pfeil weiter zur Mitte des rechten Glaskörpers. Dieser HH ist zwar in Lösung, aber noch in frischer Lösung, wie beispielsweise der sexuelle Konflikt oder der Konflikt fronto-basal.

Dieser Angst-im-Nacken-Konflikt hat also eine andere Bedeutung. Er bedeutet einen Angst im Nacken vor einer (Partner)-Person, die bedroht. Die Patientin hatte ja angenommen, daß das alte Messer bei sich habe und war quasi gewärtig, daß diese, wenn sie freibekäme, ihr das Messer von hinten in den Rücken stecken würde. Der Konflikt ist natürlich real schon früher gelöst worden, hat aber eine Rezidive gemacht durch die Angst-Träume. Daher die Veranlassung

¹⁰⁹ frontal = stirnwärts, stirnseitig
¹¹⁰ basal = an der Basis liegend
¹¹¹ lateral = seitlich, seitwärts

A la izquierda la cuestión es un poco más complicada: ahí tenemos (dos flechas) una flecha lateral que indica un FH que a su vez pertenece a las dos mitades de la

retina, que ven al niño hacia la izquierda. Aquí la pertenencia es, por decirlo así, doblemente cruzada. La flecha de más adelante en el medio indica sin embargo el relé del cuerpo vítreo derecho. Este FH está en solución, pero no reciente como por ejemplo el conflicto sexual o de miedo olfativo (frontal-basal).

Este conflicto de miedo en la nuca tiene por lo tanto otro significado: este FH indica un miedo en la nuca en las relaciones con una persona (partner) que amenaza por atrás. La paciente creyó que la muchacha algeriana llevaba un cuchillo y que esperaba el momento en que tuviese una mano libre para acuchillarla por la espalda. Este conflicto se resolvió antes, pero siempre ha producido recaídas a causa de los sueños angustiosos. De ahí la cicatrización.

Todos los focos de Hamer tienen edema, sólo el conflicto del tálamo está todavía activo. La “suerte” de esta muchacha ha sido encontrarse en constelación esquizofrénica, pues de otra manera no habría sobrevivido, por ejemplo, al conflicto sexual, que duraba ya dos años: infarto cardíaco con embolia pulmonar.

Las fotografías se hicieron pocos días después de la gran charla liberadora. Seguidamente la muchacha tuvo un ataque todavía más grande, después ninguno.

Es una cosa maravillosa poder restituir, de modo preciso y consciente, la despreocupación a una muchacha de diecisiete años, atormentada por los miedos de tener una “tara genética hereditaria”, una denominada “epilepsia genuina”. Entre otras cosas la muchacha ya no toma medicinas. Ahora apenas consigue identificarse con la situación precedente, cuando entraba, aunque por poco tiempo, en constelación esquizofrénica entre sueño y crisis epiléptica, es decir, en una constelación esquizofrénico-motora.

Los ignorantes del alma humana, en particular del alma de una muchacha de 16 años, dudarán: “Sí, cuesta creer que por una pelea se pueda estar afectado de una manera tan terrible”. A lo que responderé: se nos puede destruir con una única palabra. Sobre todo en el caso de una chica de 17 años. Pero prescindiendo de eso, no fue sólo una pelea, se trataba de una “guerra” a vida o muerte.

8.2.7. Ejemplo: la muerte del venerado director de orquesta

-Diagnóstico de la medicina oficial: epilepsia, asma.

-Diagnóstico de la Nueva Medicina: estado tras asma bronquial con constelación esquizofrénica, estado tras conflicto motor de no poder retener a alguien, FH de adenocarcinoma alveolar, FH de los túbulos, FH del pericardio.

Una muchacha zurda de 15 años tocaba la trompa en una orquesta que fue formada, partiendo de cero, por un viejo entusiasta músico-idealista, intérprete de trompa él mismo. Todos, en particular los muchachos y las muchachas, tenían una auténtica veneración por esta persona tan insólita como desinteresada, y también nuestra K. de quince años. En el primer y más importante concierto, con el que se esperaba hacer la inauguración, sucedió lo siguiente (7.2.75): el maestro concertista, que también era un excelente solista de trompa, sufrió años antes una gran irritación al enfrentarse a un hombre anciano que se había acercado a una

muchacha menor de edad de su orquesta. Ahora temía que quisiese aprovecharse de nuevo de alguna muchacha de la nueva orquesta y poco antes del concierto hubo un altercado violento (recaída del conflicto de territorio). El director de orquesta había alejado a este “enemigo”.

Durante el concierto “Willi”, como le llamaban cariñosamente al director sus jóvenes fans, tocó una pieza para trompa solista magistralmente. Fue el punto culminante de la tarde.

Cuando llegó el final y la tensión empezaba a bajar, de repente cayó al suelo muerto a un metro de los pies de la joven K. La muchacha K. y sus compañeros se quedaron de piedra y asustados. Tras dos horas llegó la noticia de que los intentos de reanimación no habían tenido éxito.

La muchacha K. estaba inconsolable. Pidió y le dieron la trompa del maestro. Cada día que pasaba iba a su tumba, lo que no hacía ningún otro compañero. Dice que estaba especialmente unida a él y que no conseguía dejar de pensar en la muerte tras lo sucedido.

El conflicto motor consistía en el hecho de que ella habría querido rodearlo con el brazo (izquierdo del partner), pero no pudo hacerlo.

Después de unos seis meses K. había superado el peor momento. De repente tras la muerte del maestro tenía ataques de asma cuando tenía mucho miedo. (Los ataques de asma bronquial se producían siempre en constelación esquizofrénica siempre que hubiese otro conflicto activo con FH en el hemisferio cerebral izquierdo, en este caso a causa del FH en el centro cortical motor izquierdo).

Un año después, por casualidad, estuve presente ante el féretro de la subinquilina, que había muerto. Una semana después sufrió su primer ataque epiléptico. El conflicto motor y el conflicto de miedo de la muerte en el tronco cerebral volvieron a aparecer.

Dos años después, en 1978, K. se encontró a su abuela tirada en el suelo delante del frigorífico con la puerta abierta, “como muerta”. De nuevo se asustó “de muerte”. Dice que pensó mucho en Willi en esa ocasión, y también en su muerte.

La abuela siguió viva y el conflicto se resolvió.

Pasadas algunas semanas, en diciembre de 1978, la paciente sufre cuatro ataques epilépticos del tipo “gran mal”. En enero de 1979, durante una investigación en la clínica universitaria de B. Se descubre un Foco de Hamer en una TAC con amplio edema perifocal y naturalmente se malinterpreta.

La clínica de B. escribe al médico de cabecera el 5.1.79: “En el estrato de 6,5 cm está representada a la derecha occipito-parietalmente, puesta en evidencia por los medios de contraste, una región hiperdensa circular cercana a la corteza. Sin embargo en varios estratos aparece una clara inhomogeneidad del parénquima, como se observa a menudo en las disfunciones circulatorias cerebrales de naturaleza angioespástica”. Así se ha descrito en el pasado un Foco de Hamer, zona hiperdensa con edema perifocal que se llamaba “inhomogeneidad del parénquima”.

Se ve la completa confusión de este informe puramente descriptivo, porque el investigador en la práctica no sabe que hacer. Y todavía menos sabe encontrar una explicación de porqué en una muchacha tan joven se daba una formación así.

A la muchacha le hicieron “exámenes especialistas profundos” neurológicos y psiquiátricos en la clínica universitaria de B., pero nadie le preguntó por su terrible experiencia, para ella esencial.

Eso es irrelevante “desde el punto de vista psiquiátrico”, no es interesante.

En febrero de 1979 la abuela muere. Este conflicto se ha resuelto tras una semana, porque todos opinan que eso fue “lo mejor” para la abuela.

Pasados otros 14 días K. tiene nuevamente ataques convulsivos epilépticos de gran mal, siempre de noche, durante el sueño.

Die Klinik in B. schreibt an den Hausarzt am 5.1.79: „Auf der 6,5-cm-Schicht kommt rechts occipito-parietal ganz eben angedeutet nach Kontrastmittelgabe eine rindennahe rundliche hyperdense¹¹² Region zur Darstellung. Doch fällt auf mehreren Schichten eine deutliche Parenchym-Inhomogenität auf, wie wir sie häufig bei angiospastisch¹¹³ bedingten cerebralen Durchblutungsstörungen beobachten.“ So hat man früher einen Hamerschen Herd umschrieben, hyperdense Zone mit dem perifocalen Oedem, das dann „Parenchym-Inhomogenität“ genannt wurde. Man sieht die ganze Ratlosigkeit dieses rein beschreibenden Befundes, weil der Untersucher damit praktisch nichts anzufangen weiß. Noch weniger hat er eine Erklärung dafür, wie ein so junges Mädchen an ein solches Gebilde kommen kann. Das Mädchen wurde neurologisch und psychiatrisch in der Uni-Klinik B. „gründlich fachärztlich durchuntersucht“, nach ihrem zentralen furchtbaren Ereignis aber hat sie niemand gefragt. Das war „fachpsychiatrisch nicht relevant“, bzw. uninteressant.

Im Februar '79 stirbt die Oma dann doch. Dieser Konflikt ist nach etwa einer Woche gelöst, da alle der Meinung sind, es sei so „das Beste“ gewesen. Weitere 14 Tage später bekommt K. erneute epileptische Grandmal-Krampfanfälle, immer nachts, aus dem Schlaf heraus. Dann allmähliche Besserung. Aber immer bekommt das Mädchen, wenn es große Angst hat, Asthma!



Auf dem Schnitt durch das Althirn (Stammhirn und Kleinhirn) können wir eine regelrechte Konflikt- und Konfliktverlaufs-Anamnese erheben: Der Todesangst-Konflikt (Pfeil rechts oben) ist im Wesentlichen ausgeheilt. Wenn Konfliktrezidive gekommen sind, dann nur kurzzeitig passager. Dann bilden sich ein oder ein paar kleine Lungenrundherde, nach der CL schwitzt man

nachts zwei Nächte lang und alles ist vorbei.

Untere Pfeile: Wir sehen auch eine deutliche Vernarbung im Perikard-Relais, das also lange oder häufige Konflikte gehabt haben muß, hier die Assoziation einer Attacke gegen das Herz. Die junge Musikerin hatte für den Herzinfarkt von Willi Mitgefühl gehabt, sich mit ihm identifiziert. Seinen dramatischen Herzinfarkt hat sie also auf ihren Herzbeutel assoziiert. Wir können mit Bestimmtheit

¹¹² hyperdens = Bezeichnung eines besonders dichten Bereichs

¹¹³ Angio- = Wortteil mit der Bedeutung Gefäß

sagen, daß sie
Herzbeutel-Erg

Der linke ober
HH gehabt hab
in der konflikt
häßlichen, hal
„Revier-Erzfein
handensein von
abgebaut werd
sche Bedeutun
stöcke anfertig
keinlagerungen

Diese Zusan
len können, ha
jedoch nicht n
sofort ihre Bea
etwas passiert
nert hat ...

Im Mai '83 s
wie übrigens
schrank gefu
nicht schon
viele Male ar

Vier Tage r
generalisierte
Anfälle. - Im

HH mit perij
im Top der
nahmeschicht
der Schädel
koronar, da
HH im linke
trum (Kon
festhalten-Kö

Después lentamente hay una mejoría. Pero siempre, cuando experimenta mucho miedo, le vuelve el asma.

En el estrato que atraviesa el paleoencéfalo (tronco cerebral y cerebelo) podemos intuir una anámnesis regular de conflicto y evolución de conflicto: el conflicto de miedo de la muerte (flecha de arriba a la derecha) está prácticamente curado por completo. Las recaídas conflictivas que se han producido han tenido una breve duración. Se forman uno o dos pequeños adenocarcinomas alveolares, tras la CL hay sudoración nocturna durante dos noches y después todo ha terminado.

Flecha de abajo: vemos una evidente cicatrización en el relé pericárdico que tiene que haber sufrido conflictos largos o frecuentes, aquí se asocia un ataque al corazón. La joven música había sentido compasión por el infarto cardíaco de Willi, identificándose con él y asociando a su propio pericardio aquel dramático infarto. Podemos decir con certeza que en la fase PCL ha tenido o un derrame prolongado o derrames más pequeños y repetidos del pericardio.

La flecha de arriba a la izquierda indica el relé de los túbulos que tiene que haber sufrido un FH activo, ahora cicatrizado. A nivel orgánico este hallazgo secundario en la fase de conflicto activo corresponde a un carcinoma de los túbulos causado por un conflicto de fondo semisexual repugnante (fuerte pelea semisexual de Willi con el “enemigo del territorio” antes del concierto). Un adenocarcinoma parecido de los túbulos ováricos se reduciría por necrosis caseosa en la fase PCL en presencia de las correspondientes micovacterias con pérdidas vaginales purulentas. Si tuviese alguna importancia en el diagnóstico se podría realizar una TAC de los ovarios y constatar por la presencia de tejido calcificado el estado residual de una tuberculosis de los túbulos.

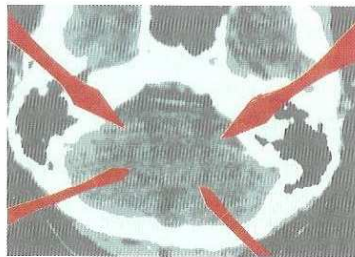
Estas correlaciones, que ahora podemos formular retrospectivamente con una TAC cerebral, en el pasado no interesaban. Sin embargo estas reflexiones no son solamente “discusiones académicas inútiles”, sino que adquieren significado si se produjese nuevamente una recaída, porque sucediese algo que indujese a la paciente a recordar intensamente el conflicto de entonces...

En mayo de 1983 murió el padre, causando a K. fuertes sentimientos de culpa, igual que ocurrió cuando se encontró a la abuela en el suelo delante del frigorífico. Se hizo muchos reproches por no haber ido a ver antes a la abuela, que la llamaba muchas veces sin conseguir hablar con ella.

Cuatro días después del funeral del padre sufre de nuevo un ataque convulsivo epiléptico generalizado. En las semanas siguientes su produjeron varias crisis; luego también ataques de asma.

Die Klinik in B. schreibt an den Hausarzt am 5.1.79: „Auf der 6,5-cm-Schicht kommt rechts occipito-parietal ganz eben angedeutet nach Kontrastmittelgabe eine rindennahe rundliche hyperdense¹¹² Region zur Darstellung. Doch fällt auf mehreren Schichten eine deutliche Parenchym-Inhomogenität auf, wie wir sie häufig bei angiospastisch¹¹³ bedingten cerebralen Durchblutungsstörungen beobachten.“ So hat man früher einen Hamerschens Herd umschrieben, hyperdense Zone mit dem perifocalen Oedem, das dann „Parenchym-Inhomogenität“ genannt wurde. Man sieht die ganze Ratlosigkeit dieses rein beschreibenden Befundes, weil der Untersucher damit praktisch nichts anzufangen weiß. Noch weniger hat er eine Erklärung dafür, wie ein so junges Mädchen an ein solches Gebilde kommen kann. Das Mädchen wurde neurologisch und psychiatrisch in der Uni-Klinik B. „gründlich fachärztlich durchuntersucht“, nach ihrem zentralen furchtbaren Ereignis aber hat sie niemand gefragt. Das war „fachpsychiatrisch nicht relevant“, bzw. uninteressant.

Im Februar '79 stirbt die Oma dann doch. Dieser Konflikt ist nach etwa einer Woche gelöst, da alle der Meinung sind, es sei so „das Beste“ gewesen. Weitere 14 Tage später bekommt K. erneute epileptische Grandmal-Krampfanfälle, immer nachts, aus dem Schlaf heraus. Dann allmähliche Besserung. Aber immer bekommt das Mädchen, wenn es große Angst hat, Asthma!



Auf dem Schnitt durch das Althirn (Stammhirn und Kleinhirn) können wir eine regelrechte Konflikt- und Konfliktverlaufs-Anamnese erheben: Der Todesangst-Konflikt (Pfeil rechts oben) ist im Wesentlichen ausgeheilt. Wenn Konfliktrezidive gekommen sind, dann nur kurzzeitig passager. Dann bilden sich ein oder ein paar kleine Lungenrundherde, nach der CL schwitzt man

nachts zwei Nächte lang und alles ist vorbei.

Untere Pfeile: Wir sehen auch eine deutliche Vernarbung im Perikard-Relais, das also lange oder häufige Konflikte gehabt haben muß, hier die Assoziation einer Attacke gegen das Herz. Die junge Musikerin hatte für den Herzinfarkt von Willi Mitgefühl gehabt, sich mit ihm identifiziert. Seinen dramatischen Herzinfarkt hat sie also auf ihren Herzbeutel assoziiert. Wir können mit Bestimmtheit

¹¹² hyperdens = Bezeichnung eines besonders dichten Bereichs

¹¹³ Angio- = Wortteil mit der Bedeutung Gefäß

sagen, daß sie in der pel-Phase entweder einen längeren Herzbeutel-Ergüsse gehabt haben muß.

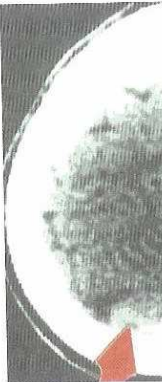
Der linke obere Pfeil weist auf das Tubenrelais, das eine HH gehabt haben muß, jetzt vernarbt. Organisch entspricht in der konflikt-aktiven Phase einem Tuben-Karzinom von häßlichen, halbgenitalen Konflikt (häßlicher, halbgenitaler „Revier-Er-feind“ vor dem Konzert). Solch ein Eileiterhandensein von entsprechenden Mykobakterien in der pel-Phase abgebaut werden mit Fluor vaginalis (Ausfluß). Wenn es in der pel-Phase eine Bedeutung hätte, was hier nicht der Fall ist, könnte man stöcke anfertigen lassen und den Restzustand einer Tubenkeinlagerungen erkennen.

Diese Zusammenhänge, die wir jetzt mit einem Hirn-CT sehen können, haben uns früher gar nicht interessiert. Solche jedoch nicht nur „brotlose akademische Erörterungen“, sondern sofort ihre Bedeutung, wenn wieder mal ein Rezidiv kommt, was passiert ist, was die Patientin sehr stark an den Tod erinnert hat ...

Im Mai '83 stirbt der Vater, für K. mit starken Selbstmordgedanken wie übrigens auch in dem Fall, als K. die Oma mit dem schrank gefunden hatte. Sie hatte sich große Vorwürfe gemacht nicht schon lange nach der Oma geschaut hatte. Die Oma hat viele Male angerufen und keine Antwort erhalten.

Vier Tage nach der Beerdigung des Vaters erfolgt wieder ein generalisierter Krampfanfall. In den nachfolgenden Tagen weitere Anfälle. - Immer auch Asthma-Anfälle.

HH mit perifocalem Oedem links im Top der Hirnrinde. Die Aufnahmeschichten sind nicht parallel der Schädelbasis, sondern fast koronar, dadurch „rutscht“ der HH im linken motorischen Zentrum (Konflikt des Nicht-festhalten-Könnens) nach hinten.



FH con edema perifocal en la corteza cerebral arriba a la izquierda. Las exploraciones no son paralelas a la base craneal, sino casi coronarias, por lo que el FH del centro motor izquierdo (conflicto de no poder retener a alguien) aparece colocado detrás en la imagen.

En enero de 1984 muere la otra abuela, con la que K. se llevaba bien, pero que por miedo no quiso ir a visitar a la clínica. Nuevamente tuvo sentimientos de culpa

y tras 14 días sufre un ataque convulsivo generalizado, a pesar de que toma fármacos antiepilépticos desde 1975 aunque no tuvo ninguna crisis epiléptica desde julio de 1983.

En el caso de la joven paciente encontramos claramente la doble vía del tema conflictivo “muerte” y “separación”, por lo tanto una vía conflictiva de miedo a la muerte relacionado con el conflicto motor (y sensorial) de no poder retener a alguien. Aquí existía el peligro de nuevas recaídas y de una nueva crisis epiléptica en la fase PCL cada vez que alguien moría en el entorno de la paciente. Dado que la muerte forma parte de la vida, la paciente, con la ayuda de los parientes, ha podido encontrar, por suerte, una “solución espiritual” a su conflicto: en el período siguiente se ocupó intensamente con el tema “muerte”, leyó muchos libros sobre el tema y tuvo numerosas charlas.

Hoy puede pensar en este tema sin ningún miedo, y hace 14 años que ya no tiene ningún ataque epiléptico.

8.2.8. Ejemplo: los cuatro espíritus malos

Seguidamente vemos la TAC cerebral de una señora de cincuenta años muy religiosa que vivía con pánico a los espíritus.

Cuando la hija de 15 años tuvo un ataque epiléptico, la mujer creyó seriamente que se le habían metido los espíritus de 4 muertos. Sufrió un DHS con pánico frontal, el correspondiente FH aparece como una gran mancha blanca a la derecha frontalmente. La paciente diestra estaba ya en la menopausia cuando sufrió el conflicto. Pero por mucho que pueda sonar extraño, la paciente de cincuenta años no tiene epilepsia a causa de este gran foco, que está en continua solución recayente. La crisis por el contrario, está causada por el pequeño foco adyacente (flecha) y vemos una cosa muy interesante:

standen hatte,
der macht sie
14 Tage spä-
Medikamenten
mehr erlitten

eutig die dop-
nungen“, also
ien (und auch
Hier bestand
uten epilepti-
irgend jemand
onnte die Pati-
Lösung“ ihres
it dem Thema
folgten unzäh-

stellen, wenn
ren keine epi-

en Frau, die in
5 Jahren einen
en in ihr 4 Gei-
ontalangst, der
its frontal. Die
ie den Konflikt
erd, der in stän-
ihre Epilepsie.
hier sehen wir

eife zum Senium

Innerhalb eines größeren HHs, der einem gelösten Revierangst-/ Revier-Konflikt entspricht, sehen wir im Inneren des HHs eine durch die Impression von frontal her nur mehr halbkreisförmig erscheinende scharfrandige Schießscheiben-Konfiguration im motorischen Bronchialmuskulatur-Zentrum und/oder im Relais der Muskulatur der linken Hand. Von hier bekommt die Patientin ihre epileptischen Anfälle.



Das ist eigentlich einer der „schönsten“ für eine Epilepsie zuständigen HHs, welche sich ja durch die Rezidive auszeichnet, so daß man auf der aktuellen Aufnahme oftmals z.B. die Lösung des letzten epileptischen Anfalls und die Aktivität des nächsten Rezidivs sehen kann!
Interessant ist aber hier auch zu sehen, daß solch ein HH auch aus 2 verschiedenen Komponenten bestehen kann:

1. Revierangst- und Revier-Konflikt in pcl-Phase. Hier ist u.a. auch die Bronchialmuskulatur betroffen.
2. Motorische Teillähmung der linken (Mutter/Kind-) Hand mit epileptischem Anfall beginnend mit der linken Hand.

Die Geister wurden dann vermeintlich von einem österreichischen Geistheil-
ler „exorziert“, d.h. ausgetrieben. Das war für die Patientin die Konfliktlö-
sung.

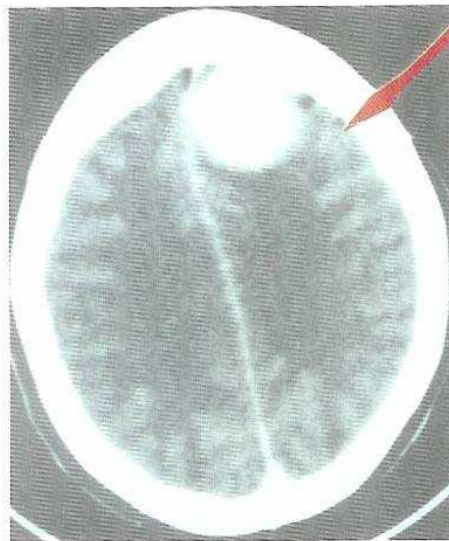
Dentro de un FH más extendido, que corresponde a un conflicto resuelto de territorio/amenaza por el territorio, vemos una configuración concéntrica con bordes marcados de un FH en el centro motor de la musculatura bronquial y/o en el relé de la musculatura de la mano izquierda, que aparece ya sólo con forma semicircular a causa de la compresión debida al foco de miedo frontal. De esto derivan los ataques epilépticos de la paciente.

Este es, efectivamente, uno de los “más bellos” Focos de Hamer relativos a una epilepsia que está caracterizada por las recaídas, de tal manera que en la fotografía a menudo, por ejemplo, se puede ver la solución del último ataque epiléptico y la actividad de la siguiente recaída.

Pero también es interesante ver aquí que un FH así puede consistir en dos componentes distintos:

1. Conflicto de amenaza por el territorio y de territorio en la fase PCL. Aquí, entre otras cosas, se ve afectada la musculatura bronquial.
2. Parálisis motora parcial de la mano izquierda (madre/niño) con ataque epiléptico que comienza en la mano izquierda.

Los espíritus fueron aparentemente “exorcizados”, es decir, cazados, por un sanador austriaco. Eso fue la solución del conflicto para la paciente.



Ein ganz gewaltiges Konflikt-DHS-Rezidiv erlitt die Patientin in praktisch gleicher Sache, als ihr Sohn mit 26 Jahren eine schizophrene Konstellation mit katatonen¹¹⁵ Starre erlitt. Als die Mutter an seinem Bett in der Klinik stand, wußte sie sofort, daß da wieder Geister am Werk waren, und zwar wieder die gleichen vier Geister von Verstorbenen, die auch schon bei der Tochter ihr Unwesen getrieben hatten. Der Hamersche Herd exazerbierte¹¹⁶, d.h. er bekam wieder Konfliktaktivität, bis auch bei dem Sohn endlich „durch

Fernwirkung“ von einem österreichischen Geistheiler die vier bösen Geister vertrieben wurden.

Diese Conflictolyse lag etwa 3 Wochen vor Anfertigung dieser Bilder. Wir sehen hier einen bereits konsolidiert gewesenen HH im rechten Frontalhirn, der nunmehr erneut aufquillt, der aber, wie gesagt, nicht zum Erscheinungsbild der Epilepsie geführt hat, sondern „nur“ zu Kiemenbogengangs-Zysten. Der eigentliche Epilepsie-Herd liegt direkt daneben rechts nach dorsal¹¹⁷ (Pfeil). Wenn man nun meint, wie in solchem Fall, man hätte den „Sündenbock“ für die epileptischen Anfälle gefunden und dieses Gebilde herausoperieren würde, würde die Patientin natürlich weitere epileptische Anfälle bekommen, da der HH für die Bronchialmuskulatur und die linke Hand natürlich weiter vorhanden ist. Man wußte eben bisher nicht, so seltsam das klingen mag, angesichts der tonisch-klonischen (motorischen) Krampfanfälle, was eigentlich die epileptischen Anfälle waren. Von jeder Stelle des motorischen Rindenzentrums kann der Anfall „generalisieren“. Wir sprechen dann von einem „großen Anfall“ oder „Grand mal“.

¹¹⁵ Katatonie = psychische Erkrankung, bei der Störungen der Willkürmotorik im Vordergrund stehen

¹¹⁶ exazerbieren = verschlimmern

¹¹⁷ dorsal = zum Rücken gehörig, nach dem Rücken hin liegend, rückseitig

Una recaída muy fuerte de DHS conflictivo la sufrió la paciente prácticamente del mismo modo cuando su hijo de 26 años entró en constelación esquizofrénica con rigidez catatónica. La madre, que estaba a su lado en la cama de la clínica, pensó

inmediatamente que los espíritus de nuevo se habían puesto manos a la obra y que se trataba de nuevo de los mismos cuatro espíritus de difuntos de la hija.

El Foco de Hamer retomó la actividad conflictiva, hasta que el hijo fue liberado de los cuatro espíritus malos por un espiritista austriaco “mediante exorcismo a distancia”.

Esta conflictolisis se produjo unas 3 semanas antes de la realización de estas imágenes. Aquí vemos un FH que ya se ha consolidado en el cerebro frontal derecho, que ya vuelve a hincharse, pero que, como hemos dicho, ha provocado que se manifieste la epilepsia, aunque “sólo” quistes de los conductos de los arcos branquiales.

El foco efectivo de la epilepsia se encuentra directamente al lado a la derecha dorsalmente (flecha). Si se pensase, en un caso así, que se ha encontrado el “chivo expiatorio” para los ataques epilépticos y que hay que extirparlo, la paciente seguiría teniendo los ataques, porque naturalmente el FH para la musculatura bronquial y la mano izquierda queda. Por muy extraño que pueda parecer no sabemos, respecto a los ataques convulsivos (motores) tónico-clónicos, que son realmente las crisis epilépticas. Partiendo de un punto cualquiera de la corteza motora, el ataque puede “generalizarse”, es decir, extenderse. Entonces hablamos del “gran mal”.

Yo jamás vi a la mujer y conocí la historia por el marido. Vemos como la hoz cerebral, que separa arriba los dos hemisferios, está muy desplazada hacia la izquierda. A estos Focos de Hamer grandes, redondos y cicatrizados normalmente se les da el nombre de “meningiomas”. Hasta ahora se creía ingenuamente que un tumor de la meninge podía crecer hacia el interior del cerebro. Si se espera tranquilamente hasta que estos FH, dramáticamente vistosos, están de nuevo deshinchados, no sucede nada.

También los ataques epilépticos cesan, si no se repiten nuevamente otras recaídas conflictivas. Pero si la masa cerebral frontal se extirpa, el paciente permanecerá alterado en el carácter durante el resto de su vida, porque en particular la extirpación de partes del cerebro frontal conlleva graves alteraciones psíquicas, por no hablar de la previsible epilepsia de cicatrización.

8.2.9. Ejemplo: los tocamientos prohibidos.

Esta paciente, que tuvo un ataque epiléptico por primera vez en 1953, a los 17 años, tiene una corteza frontal que en los dos lados está llena de Focos de Hamer. La paciente tiene una historia singular: ahora tiene 51 años y es la mujer de un comerciante de un pequeño negocio.

A los 17 años tuvo su primer amor, su novio era un muchacho tierno, más joven que ella. El muchacho quería acostarse con ella, pero ella lo rechazó porque tenía miedo de los padres y de los abuelos. Entonces los dos se contentaban sólo con los tocamientos. Al final la paciente se separó de este novio, lo que fue muy duro, pero su conflicto de miedo se resolvió temporalmente y tuvo su primer ataque epiléptico.

Con el segundo novio volvió el miedo. Este fue su gran amor. La paciente prácticamente se comportó con él como había hecho con el primer muchacho.

Pero la cogieron “en el acto” y sufrió un gran conflicto de miedo con susto. Cuando también se separó de este segundo novio, se llegó a una segunda solución y a un segundo ataque epiléptico.

A los 30 años esta paciente, muy religiosa, se casó con el siguiente novio porque con él había perdido la virginidad. Había una cosa que no sabía: su marido era exhibicionista.

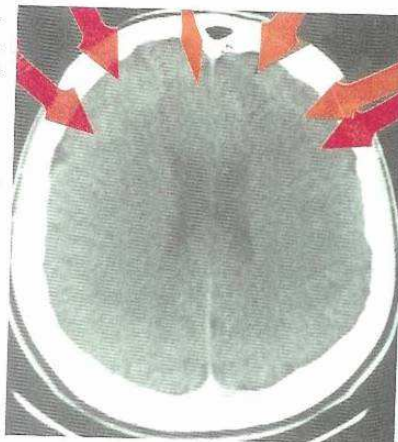
Zustand nach Rezidiven einer schizophrenen Konstellation im Frontalhirn. Linker mittlerer Pfeil: HH für Konflikt „Man müßte doch was tun“.

Unterer Pfeil links: HH Schreckangst-Konflikt.

Rechter oberer Pfeil: HH Frontalangst-Konflikt.

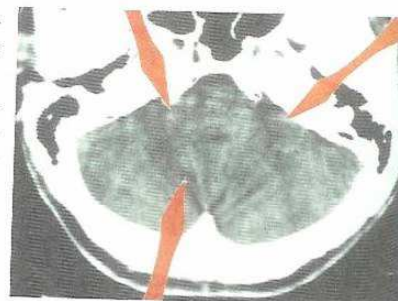
Untere Pfeile rechts: HH für Revierangst-Konflikt

Schmaler mittlerer Pfeil: Angst-Ekel- und Sträubens-Konflikt



Pfeil links oben: Häßlicher, halbgenitaler Konflikt, HH für Sigma¹²⁰-Ca und Eileiter-Ca (pcl-Phase)

Pfeil rechts oben: Verhungerungskonflikt, HH für Leber-Ca und Hör-Konflikt (Konflikt, einen Informationsbrocken nicht zu kriegen)



Als die Frau im 5. Monat schwanger war, kam eines Tages die Polizei zu ihr nach Hause, ihr Mann sei verhaftet worden, er habe exhibitioniert, er sei ein Exhibitionist, und alle Leute in der kleinen Stadt wüßten es.

Das war für sie ein DHS! Es stellte sich heraus, daß ihr Mann das schon seit vielen Jahren machte.

Aber da sie schwanger war, lag der Konflikt „auf Eis“, d.h. die Aktivität des Konfliktes war während der Schwangerschaft storniert. Als sie nach der Geburt zu Hause anrief, war der Ehemann nicht da. Er exhibitionierte wieder irgendwo. Seither bekommt sie immer dann, wenn sie ihm „verziehen“ hat und er ihr hoch und heilig Besserung gelobt hat, wieder einen epileptischen Anfall.

¹²⁰ Sigma = Colon sigmoideum, Teil des Dickdarms

Seit 2
Freund, n
fen möch

Jetzt be
bei dem I
linke Pfei
Rezidiver
während
maskulin

An dies
schwierig
phe ist in
des Ehem
sich wohl
nicht nach
zu werden

8.2.10

Der Epile
nach einer
seinen spe
vom chro
denn es fi
„vom Tis
mann): Je
Noel wied
erreichte,
nicht gleic

Ein jungen
meinsam r
bensjahr u
ich heraus
haben kön
der epilept
Frage: V
Antwort: I
Frage: C
Antwort: J

Situación tras la recaída de una constelación esquizofrénica en la corteza frontal. Flecha central a la izquierda: FH para el conflicto de impotencia (“habría que hacer urgentemente algo”).

Flecha de abajo a la izquierda: FH del conflicto de susto imprevisto.

Flecha de arriba a la derecha: FH del conflicto de miedo frontal.

Flecha de abajo a la derecha: FH del conflicto de amenaza por el territorio.

Flecha finita central: conflicto de repulsión y de miedo-asco.

Flecha a la izquierda arriba: conflicto de fondo semisexual repugnante, FH para el adenocarcinoma del sigma y adenocarcinoma de la trompa ovárica (fase PCL).

Flecha de arriba a la derecha: conflicto de miedo de morir de hambre, FH para el adenocarcinoma del hígado y conflicto del oído (conflicto de no haber podido obtener una información).

Cuando la mujer estaba en el quinto mes de embarazo, un día fue la policía a su casa para advertirla que su marido había sido arrestado por haberse exhibido obscenamente, lo que ya sabía toda la gente de la pequeña ciudad.

Esto fue para ella un DHS. Resultó que su marido hacía estas cosas desde hacía muchos años.

Pero dado que estaba embarazada el conflicto permaneció “congelado”, es decir, la actividad del conflicto se anuló temporalmente durante el embarazo.

Cuando tras el parto llamó a casa, su marido no estaba. Estaba exhibiéndose nuevamente en cualquier parte. Desde entonces cuando lo “perdona”, y él le promete solemnemente no volver a hacerlo más, tiene siempre un nuevo ataque epiléptico.

Desde hace dos años esta mujer, entonces casi en la cincuentena, tiene un amante de 20 años con el que ha tenido tocamientos y con el que le gustaría acostarse, pero siempre tiene miedo de ser descubierta.

Ahora tiene frecuentemente ataques epilépticos, a menudo en casa, después que viene de casa del amante. No puedo probarlo, pero creo que el FH indicado por la flecha izquierda es inherente al conflicto de susto imprevisto de la mujer diestra con todas las recaídas que sufre a causa del exhibicionismo del marido, mientras que la flecha derecha muestra el FH del miedo frontal que la mujer, que en este momento reacciona de modo masculino, experimenta a causa de su amante de veinte años.

En este caso podéis comprender porqué muchas epilepsias son tan difíciles de “curar”. De hecho, ¿por dónde tendríamos que empezar? La catástrofe ya está programada en ambas direcciones: el miedo del comportamiento obsceno del marido se volverá todavía peor porque es muy difícil de modificar. Tampoco su sexualidad disminuirá tan rápidamente y por lo tanto tampoco su miedo de ser descubierta con el amante o de perderlo.

8.2.10. Ejemplo: Papa Noel.

El epiléptico tiene su crisis siempre en la fase PCL, por ejemplo de noche tras una terrible incubación, y cada epiléptico tiene su incubación especial.

En los epilépticos resulta incierto el límite entre una recaída que se reproduce crónicamente y un verdadero conflicto en suspensión, porque siempre se produce una solución, pero a pesar de eso el conflicto no se elimina definitivamente. A propósito de esto es muy instructivo el caso de “Papá Noel”: cada vez el paciente llegaba a una “pequeña solución”, en cuanto que Papá Noel desaparecía, hasta que al final, con mi consejo, llegó a una “gran solución”, casi la definitiva, cuando apaleó a Papá Noel. Como se puede ver, hay diferentes tipos de solución.

Un hombre joven zurdo de 26 años de Marsella, a. Que había visitado junto con su doctora, sufría epilepsia desde los 17 años. Para mí fue un gran caso de investigación criminal.

Mientras intentaba descubrir que podría haberlo asustado tanto a los 17 años, no daba ninguna respuesta totalmente sincera. Afirmaba que solo que tenía un ataque epiléptico cada noche.

Pregunta: ¿Quién ha visto la crisis por primera vez?

Respuesta: Mi novia.

Pregunta: ¿La primera noche?

Respuesta: Sí, justo la primera noche y desde entonces a menudo.

Pregunta: (la novia estaba presente). ¿Y desde cuánto tiempo sois novios?

Respuesta: Desde hace 10 años.

Pregunta: Entonces, ¿es posible que usted ya antes tuviese un ataque epiléptico cada noche?

Respuesta: Quizás sí.

Pregunta: ¿Se ha despertado alguna vez durante un ataque?

Respuesta: Sí, pero sólo cuando duermo con mi novia y me golpea varias veces.

Pregunta: ¿Consigue recordar lo que estaba soñando cuando su novia le despierta?

Respuesta: Sí, muy bien, es siempre el mismo sueño de Papá Noel.

Pregunta: ¿Tenía variaciones sensoriales antes de la crisis o del sueño?

Respuesta: Sí, siempre la misma, sentía un sonido de campanillas.

Pregunta: Por la mañana, tras una crisis, ¿nota algo?

Respuesta: Sí, el brazo izquierdo siempre está como semiparalizado, entonces sé que he tenido una crisis. Además, casi siempre me hacía pis.

Pregunta: ¿Tenía ya los dolores en el brazo izquierdo y alguna vez se hizo pis antes de conocer a su novia?

Respuesta: Sí, desde aquella historia de Papá Noel, sufro de enuresis nocturna. Me acuerdo que a menudo ya entonces, cuando había mojado la cama, el brazo izquierdo no funcionaba bien.

Pregunta: Cuénteme, ¿qué es esa historia de Papá Noel?

Respuesta: Sí, se trata de lo siguiente: cuanto tenía tres o cuatro años había sido, como se dice normalmente, malo, nada especial, cosas de niños pequeños. Era en la época antes de navidad. De repente mi padre gritó: "Escucha". Todo se calmó y se oyó el sonido de una campanilla, justo como el que oigo cuando me sucede lo que le contaba. En esa ocasión me llevé un gran susto cuando mi padre dijo: "Es Papá Noel, ahora verás". Un miedo tremendo me invadió. Me angustié fuertemente. Duró 10 minutos, pero para mí fue como una eternidad y pensaba: ahora vendrá y me llevará. Todo mi cuerpo temblaba. Tras diez minutos el ruido desapareció, pero yo estaba como si me hubiese caído un rayo encima. Y siempre estaba soñando lo mismo cuando mi novia me despertaba. Siempre el mismo sueño de Papá Noel.

freundet?

Nacht einen

und sie mich

ten, als Ihre

el.

und wachge-
von Papa No-

dann weiß ich,
ann fast immer

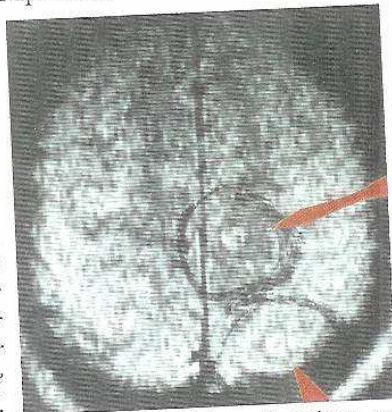
en Arm gehabt
eundin kennen-

r. Und ich kann
eingenäht hatte,

war, war ich, wie
es, so was kleine
eit. Plötzlich ruft
n Klingelzeichen,
a Albtraum habe,
damals einen hei-
a Noel, jetzt sich
die Glieder. Ich
en. Ich kriegte ei-
er es war wie eine
t kommt er gleich
ganzen Leibe wie

Espenlaub. Nach 10 Minuten hörte das Rumoren auf, aber ich war wie vom Blitz erschlagen. Und genau das gleiche habe ich immer geträumt, wenn meine Freundin mich wachgerüttelt hat. Immer der gleiche Traum mit Papa Noel.

Kernspin-Tomogramm Mai '86, Marseille, von dem Patienten mit seit 23 Jahren andauernder Epilepsie, der vollgepumpt war mit Barbituraten, ohne jeden Erfolg. Er bekam laufend weiter seine epileptischen Anfälle. Wie wir nach kriminalistischen Recherchen herausbekamen, träumte er unmittelbar vor dem Anfall immer den gleichen Traum von Papa Noel, dem Weihnachtsmann, der ihn holen und mitnehmen wollte, wie er ihn als 3jähriger Knirps in grauenvoller Weise erlebt hatte. Jedesmal bestand die Aura in dem Klingeln des Papa Noel.



Jedesmal hatte er nur eine „kleine Lösung“, wenn nämlich nach ewigen geträumten 10 Minuten der Papa Noel endlich aus dem Nebenzimmer wieder abzog. Als man später auf meinen Rat die Szene nachstellte und er dem „Double“ des Papa Noel gehörig das Fell gerbte, war der Spuk mit einem Mal verschwunden. Nie mehr hat er einen Anfall erlitten, er benötigte keine Medikament mehr.

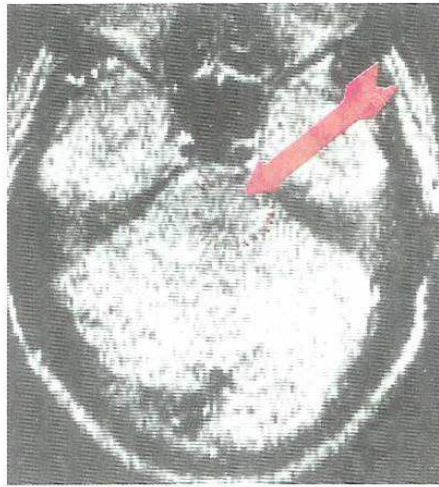
Auf dem obigen Kernspin-Tomogramm kann man deutlich die zwei eingekreisten HHe erkennen: Sie liegen unmittelbar unterhalb der Hirnrinde im motorischen und sensorischen Rindenzentrum.

Der ventrale Herd liegt im Bereich des Gyrus praecentralis rechts, deshalb nach jedem Anfall die partielle Lähmung des linken Arms und (weniger) der linken Beckenmuskulatur und Oberschenkelmuskulatur. Der Junge hatte den motorischen Angst-Konflikt des Nicht-fliehen-Könnens, der in jedem Traum wieder neu reaktiviert wurde und anschließend wieder eine Conflictolyse hatte. Der im Bild untere dorsale HH liegt rechts weiter occipital und bedeutet, daß er ständig einen sensorischen Trennungs-Konflikt hatte, weil er ja Angst hatte, von Papa Noel mitgenommen zu werden. Diese beiden hängenden Konflikte haben jeweils die epileptischen Anfälle ausgelöst. Die Lösung war immer nur eine kleine vorübergehende, bis zur nächsten Nacht anhaltende Lösung, keine endgültige. Das ist das typische Zeichen der sog. Epilepsie.

Resonancia magnética (mayo de 1986, Marsella) del paciente que sufre de epilepsia permanente desde hace 23 años, al que habían llenado de barbitúricos sin ningún resultado. Continuaba teniendo los ataques epilépticos. Como bien conseguimos descubrir gracias a las investigaciones, justo antes de la crisis tenía siempre el mismo sueño de Papá Noel, que venía para llevárselo, igual que había experimentado cuando era un niño de tres años. Siempre las campanillas de Papá Noel. Siempre se producía una “pequeña solución”, cuando 10 minutos después, que parecían eternos, Papá Noel finalmente se iba de la habitación de al lado. Cuando seguidamente, según mi consejo, representó la escena y dejó para el arrastre a la “contrafigura” de Papá Noel, el espectro desapareció de golpe. No ha vuelto a tener un ataque y no ha vuelto a necesitar medicinas.

En el tomograma de resonancia magnética de arriba se pueden reconocer claramente los dos FH buscados: se encuentran directamente bajo la corteza cerebral en el centro cortical motor y sensorial.

El foco ventral se encuentra en la zona del giro precentral a la derecha, por el tras cada ataque se produce la parálisis parcial del brazo izquierdo y (menos) de la musculatura de la cadera izquierda y de la musculatura del muslo. El joven tenía el conflicto de miedo motor de no poder escapar, que en cada sueño se reactivaba y al final tenía una nueva conflictolisis. El Foco de Hamer dorsal inferior en la figura se encuentra a la derecha más occipitalmente y significa que tenía continuamente un conflicto de separación sensorial, porque tenía miedo de que se lo llevara Papá Noel. Estos dos conflictos en suspenso han causado ataques epilépticos de vez en cuando. La solución siempre era pequeña y temporal, duraba hasta la noche siguiente, jamás definitivamente. Este es el signo típico de la denominada epilepsia.



Im Kernspin-Tomogramm HH im Stammhirns etwas schwieriger aber doch deutlich zu sehen. Wahrscheinlich ist es auch an dieser Stelle ein alter hängend-rezidivierender Flüchtling-Konflikt im Stammhirn (Pons¹²¹), betreffend die rechte Niere, daher das nächtliche Einnässen).

Therapie:

Die Therapie ist rasch erzählt und ergibt sich logisch aus der Diagnose: Ich riet ihm, einen seiner Freunde zu engagieren für 300 Francs. Der sollte damit einverstanden sein, sich von ihm verprügeln zu lassen.

Er meinte, das sei kein Problem, vor allem, wenn es einen Sinn habe, würde schon ein Freund mitmachen. Also gut, solle man eines Abends die ganze Szene nachstellen, aber so, daß er vorher nicht wisse, wann. Der Freund solle also mit Klingelzeichen kommen, wie damals, verkleidet sein als Papa Noel, wie dieser im Nebenzimmer herumrumoren. Aber entgegen der Wirklichkeit vor 23 Jahren solle er sich jetzt augenblicklich auf den Papa Noel stürzen und ihm das Fell gehörig gerben. Dann sei der Spuk zu Ende.

Der Patient dankte sehr höflich, die Ärztin war auch sehr angetan und ließ das Kernspin-Tomogramm anfertigen. Da stutzte sie allerdings. Woher konnte der Hamer wissen, daß der Patient in der Hirnrinde einen oder sogar zwei Hamersche Herde haben würde. Und sie sagte dem Patienten, vielleicht habe der Dr. Hamer dann auch mit dem anderen recht. Also schritt man zur Tat, setzte die Menge an Barbituraten ab, stellte die Szene nach, wie ich geraten hatte, der Freund bekam das Fell gegerbt und anschließend die etwa 100 Mark, und - der Patient hat nie wieder einen epileptischen Anfall gehabt und nie mehr eingenäßt, ohne alle Medikamente. Er sagte, er fühle sich „wie erlöst, nicht nur, weil er keine Anfälle mehr habe, sondern er sei auch sonst wie aus einem Albtraum endgültig erwacht“.

¹²¹ Pons = Stammhirn

8.3 Die toiden K

Ihren Namen der epileptis nicht zu übe eines Beins lisieren, d.h. Schaum vor lepsie hieß i im Zusamm Das kann si toprovokati

Die Anfä zerstören n Gehirn zelle Konflikt-Se die entspre torischen K lösen kann, Krise verm

Wir habe gramm seir

Die Patie

In diesen ähnlichen d der konflik marm ode epileptisch üblichen ep

Anders is ben, z.B. die epilept Schmerz l bzw. Mor müsse we terweise e meist um. Ulcus, da

El FH en el tomograma de RM del tronco cerebral se ve claramente aunque con un poco más de dificultad. Probablemente también en este punto hay un viejo conflicto del prófugo en suspenso y con recaídas en el tronco cerebral (puente), que tiene que ver con el riñón derecho.

Terapia:

La terapia se cuenta pronto y es una lógica derivación del diagnóstico: le aconsejé que se pusiese de acuerdo con uno de sus amigos por 100.000 liras, para que se dejase pegar. Dijo que no sería difícil convencer a un amigo si la cosa tenía sentido. Se trataba de representar la escena, de tal manera que no supiese cuándo iba a ocurrir. El amigo tenía que ir con una campanilla, como entonces, vestido de Papá Noel y hacer ruido en la sala de al lado. Pero a diferencia de cuando sucedió realmente hace 23 años, ahora tenía que echársele encima y hacerlo polvo. En ese momento se habría librado del espectro.

El paciente me dio las gracias, y también la doctora estaba llena de curiosidad y le hizo una RM. En este momento se maravilló. ¿Cómo podía saber Hamer que el paciente tenía en la corteza cerebral uno o incluso dos Focos de Hamer? Por lo tanto dijo al paciente que era posible que el Dr. Hamer tuviese razón también en el resto. Por lo tanto se pasó a los hechos, se redujo la dosis de barbitúricos, se preparó la escena tal cual yo aconsejé, el amigo se dejaría pegar por 100.000 liras y el paciente ya no tendría ningún ataque epiléptico y ya no se meó en la cama, y todo sin medicinas. Dijo que se sentía “como liberado, no sólo porque ya no tenía crisis, sino porque era como si se hubiese despertado de una pesadilla”.

8.3. Las crisis epilépticas y epileptoides más importantes

El nombre de “epilepsia” o “mal caduco” deriva del síntoma típico de los conflictos motores de la crisis epiléptica. Una crisis así es claramente visible, puede afectar sólo a grupos de músculos individuales, por ejemplo un brazo, una pierna o la cara (denominadas “crisis locales”) o ser una denominada crisis generalizada, convulsiva, con mordedura de la lengua y baba en la boca. También son posibles los estadios intermedios. La epilepsia antiguamente se llamaba “morbus sacer”, “enfermedad sacra”, porque formaba parte del éxtasis en las fiestas religiosas. Esto puede suceder frecuentemente, incluso por autoprovocación, pero en principio la epilepsia no es un suceso uniforme.

Las crisis o convulsiones tónico-clónicas (=contracciones) no destruyen, como se creía en el pasado, el cerebro o las células cerebrales; por otra parte es como en cualquier otro conflicto o vía conflictiva: cuanto más a menudo hay una recaída de conflicto, más se cicatriza el área cerebral correspondiente, y dado que se puede descubrir de un modo relativamente fácil la mayor parte de estos conflictos motores y resolverlos definitivamente (es decir, se pueden impedir otras recaídas seguidas de fase de reparación con crisis epiléptica, se hace posible “curar” muchísimas epilepsias.

Los pacientes la llaman la mayoría “los días fríos”.

En estos “días fríos” (u horas) los pacientes tienen nuevamente síntomas iguales o análogos, a menudo más concentrados, como en la fase de conflicto activo. Y dado para la mayor parte las fases de conflicto activo se producen sin síntomas o en cualquier caso no se notan, normalmente las crisis epilépticas se perciben como “días fríos” u “horas frías”, en las crisis epilépticas habituales duran sólo unos pocos minutos.

La cosa es diferente para aquellos programas EBS que provocan fuertes dolores en la fase CA, por ejemplo la angina de pecho o la úlcera del estómago. En el primer caso la crisis epileptoide se llama infarto cardíaco y puede estar acompañada por dolores muy fuertes que en el pasado intentábamos tratar con potentes analgésicos como la morfina, con la ilusión de que el dolor “se eliminase”. El dolor se iba, pero provocando, por ignorancia, la desregularización de todos los circuitos y a menudo se mataba al paciente. Lo mismo sucedía con la fase PCL de la úlcera sangrante del estómago, a menudo acompañada también por fuertes dolores.

Casi siempre se supone que hay una “perforación del estómago” y se opera. Con esta intervención totalmente insensata que realizamos los aprendices de brujo en la fase crítica del programa EBS provocamos la muerte a la mayor parte de los pacientes, porque también aquí se destruyen los circuitos naturales no sólo a causa de la operación, sino también de la morfina, que se vuelve necesaria.

Desde que conocemos las distintas variaciones explicadas por la Nueva Medicina podemos hacer que nuestros pacientes consideren esos dolores como algo normal, incluso positivo, necesario para el regreso a la normalidad. Porque si el paciente sabe que cuando toma morfina sus posibilidades de curación disminuyen, ya no querrá tomarla. El médico, si estuviese en su lugar desde luego que no la tomaría.

Dado que las epilepsias de la corteza cerebral son las más impresionantes y también las más peligrosas, seguidamente trataremos en particular las más importantes.

Distinguiamos más o menos cuatro grandes grupos:

1. Crisis epilépticas corticales frontales: ataques de hemicrania.
2. Crisis epilépticas del centro cortical motor:
Todos los denominados ataques epilépticos, incluidos el movimiento facial, crisis de asma bronquial, crisis de asma laríngea, crisis de estado asmático, infarto de miocardio de la parte de la musculatura estriada cardíaca.
3. Crisis epileptoides del centro cortical sensorial (epitelio principal) y postsensorial (periostio):
 - a) Ausencias con neurodermatitis
 - b) Ausencias afectando al periostio
 - c) Infarto cardíaco con ausencia en la úlcera de las arterias coronarias (infarto cardíaco izquierdo).
 - d) Epilepsia con úlcera del íntima de las venas coronarias y al mismo tiempo embolia pulmonar y úlcera del cuello del útero (infarto cardíaco derecho).
 - e) Epilepsia con úlcera de los conductos hepático-biliares con ausencia en la hepatitis (coma hepático).
4. Crisis epiléptica del glaucoma:
Ataque de glaucoma que en realidad es una fuerte variación de la presión ocular dentro del globo ocular en la fase PCL con ofuscamiento del cuerpo vítreo (glaucoma).

8.3.1. Ataques de hemicránea

La hemicránea en el pasado se llamaba “pequeña epilepsia”, porque cualquier buen médico sabía que aparecía sólo en la fase de reposo o relajación. Por eso ninguno sabía como “tratarla”. ¿Se deberían dar simpaticotónicos para atenuar la fase de reposo o se deberían dar vagotónicos porque de hecho la hemicrania es un proceso simpaticotónico? Toda persona “afectada de hemicrania” tenía sus remedios o prescripciones. Uno se metía en una bañera de agua caliente, otro lo intentaba con una ducha fría. Nadie conocía el contexto global.

Con la Nueva Medicina sabemos que son los dos procesos frontal-corticalmente o los programas EBS los que dan hemicranias agudas (ataque de hemicrania) en la fase PCL como crisis epileptoide. Dado que existían ciertas analogías con los ataques epilépticos (motores o tónico-clónicos) las hemicráneas se llamaron “pequeña epilepsia”.

En los ataques agudos de hemicránea, que ahora sabemos que es un proceso positivo y necesario, no desaconsejaremos al paciente sus “metodillos sintomáticos”, Sin embargo aquí es donde empieza nuestro verdadero trabajo.

El último ataque de hemicránea se produce en efecto, sólo porque una recaída conflictiva había metido al paciente en la correspondiente vía.

Sin embargo en principio esto no tiene porqué repetirse necesariamente si hablando con el paciente conseguimos entender y resolver definitivamente el conflicto que está en la base y su relativa vía. No se trata de brujería.

Viene bien citar también la “constelación esquizofrénica frontal-cortical” que a veces puede tener su ataque de hemicránea (=crisis epileptoide) al mismo tiempo en los dos hemisferios.

Los pacientes cuentan que no hay nada peor. Es sencillamente terrible.

Y cierto es que se puede producir en un hemisferio un ataque de hemicránea con una crisis epiléptica o epileptoide motora u otro con una crisis no frontal, cortical. Entonces no sólo los síntomas pueden ser tremendos, sino que los pacientes, que durante la crisis epiléptica son simpaticotónicos en los dos lados (i), se encuentran en constelación esquizofrénica.

8.3.2. Las crisis epilépticas (ataques epilépticos) del centro cortical motor.

Entre estas crisis epilépticas, que antes llamábamos “ataques epilépticos”, se cuentan los ataques tónico-clónicos que de vez en cuando puede ser sólo tónicos (calambres musculares), pero que en general son tónico-clónicos, es decir, se manifiestan con calambres convulsivos rítmicos de la musculatura.

Estos pueden estar combinados a su vez con las ausencias típicas del conflicto sensorial (conflicto de separación) (= pérdida de consciencia).

En todos los denominados ataques epilépticos motores siempre está activo al mismo tiempo en la médula cerebral y también el correspondiente FH perteneciente a la musculatura, así que incluso en el caso más simple

encontramos siempre un suceso combinado. Se puede comparar la actividad motora excesiva (epilepsia) de la fase PCL, tras la parálisis anterior de la fase CA, con la ondata de leucocitos (leucemia) en la fase PCL tras la leucopenia precedente de la fase CA. Los dos procesos entran en el mismo “grupo de lujo” de la médula cerebral.

La musculatura bronquial en parte es antigua musculatura peristáltica, porque los alvéolos pulmonares (en el caso del adenocarcinoma) bajo el perfil filogenético son una extroflexión de la mucosa intestinal.

Y la otra parte de la musculatura bronquial es musculatura estriada migrada junto con la mucosa bronquial del epitelio pavimentoso y está inervada desde la corteza motora del hemisferio derecho.

Un ataque epiléptico de la musculatura bronquial conlleva por lo tanto convulsiones tónicas (espasmo bronquial o tónico-clónico de la musculatura bronquial y justo en dirección de la boca, es lo que llamamos tos muy fuerte =denominada “tos” bronquial). Típicamente la espiración es prolongada.

Lo mismo sucede en la musculatura de la laringe que va directa desde el centro cortical motor del hemisferio izquierdo (=denominada “tos laríngea”). Aquí la direcciones de las convulsiones son hacia el interior.

Por eso aquí es típica la inspiración prolongada durante el ataque epiléptico.

8.3.2.1. Asma bronquial

Si la motricidad de la parte muscular bronquial estriada está afectada por un programa EBS, y justo se encuentra en la fase de conflicto activo, vemos una parálisis muscular parcial de la musculatura bronquial. Si en ese punto en el hemisferio izquierdo hay todavía un FH cortical en actividad, incluso verificándose una constelación esquizofrénica no se nota casi nada.

La cosa es totalmente diferente en el caso de la crisis epiléptica, si en el lado contrario hay todavía o nuevamente actividad conflictiva en la zona cortical.

Precisamente llamamos asma bronquial con expiración prolongada a la siguiente constelación:

actividad conflictiva en la
corteza izquierda

crisis epiléptica en la corteza motora derecha
con calambres tónico-clónicos de la musculatura
bronquial

Mientras que llamamos asma laríngeo con inspiración prolongada a la constelación:

FH de la laringe activo
En la corteza motora
Izquierda

actividad conflictiva de la corteza derecha

Por el contrario si el FH bronquial motor y el FH laríngeo motor se encuentran los dos al mismo tiempo en crisis epiléptica hablamos de

estado asmático = expiración prolongada e inspiración prolongada.

8.3.2.2. El infarto de miocardio

El infarto de miocardio (= necrosis de la musculatura cardiaca estriada) se distingue del infarto coronario. El infarto coronario es la crisis epiléptica del programa EBS con úlcera coronaria en el conflicto de territorio (sección roja de la tabla, ectodérmico, o cortical periinsular a la derecha). Sin embargo podemos considerar el infarto cardíaco como “epilepsia del músculo cardíaco” de la parte estriada del músculo cardíaco.

El FH se encuentra tanto en el centro cortical motor como en la médula del cerebro, donde se encuentran los relés de toda la musculatura estriada. El denominado infarto de miocardio es por lo tanto el ataque convulsivo epiléptico en la fase de reparación después de la parálisis parcial de una parte del músculo cardíaco con necrosis (necrosis de miocardio) de esta zona muscular.

La medicina clásica ha construido muchas hipótesis del tipo:

El infarto cardíaco con necrosis del miocardio se produciría a causa de que un vaso coronario se obtura, por lo tanto una cierta zona muscular no puede ser alimentada con oxígeno y por lo tanto necrotiza.

Como bien sabemos hoy en día esta era una construcción hipotética arriesgada, porque no sabíamos explicar muchas cosas:

1. Si en los experimentos con animales, al operar se comprimen los vasos coronarios en puntos sucesivos a una cierta distancia, al animal no le sucede nada, porque los denominados vasos colaterales proveen de alimento al músculo cardíaco sin problemas.
2. Ninguno conseguía explicar por qué el infarto cardíaco en este cuadro era un suceso dramático agudo.
3. Gracias a la angiografía coronaria se sabe ya desde hace tiempo que la hipótesis de “la oclusión coronaria” en el momento del infarto cardíaco era errónea.

De hecho desde el momento de la conflictolisis del conflicto de territorio comienza la hinchazón del íntima en el vaso coronario, pero en la mayor parte de los casos no provoca una oclusión total del vaso coronario en el momento del infarto, si no se añaden viejos callos de cicatrización (estenosis). Y eso no tiene importancia ni en los casos en los que se llega a una oclusión, como ya hemos visto en los experimentos con animales, porque, al contrario de lo que se afirma, por esto no se produce necrosis del músculo cardíaco.

Toda esta hipótesis era errónea porque no se tenían en cuenta las correlaciones que ha indicado la Nueva Medicina.

8.3.3. Las crisis epilépticas del centro cortical sensorial (epitelio pavimentoso de la mucosa y de la piel) y postsensorial (periostio).

8.3.3.1. Desmayos en caso de neurodermatitis y soriasis.

El centro cortical sensorial para el epitelio pavimentoso de la piel y de la mucosa y el centro cortical postsensorial para el periostio (piel del hueso), que estaba recubierto de epitelio pavimentoso en el primer estadio embrional del hombre, en cuanto a la dimensión, ocupan en la corteza cerebral un área mucho más grande respecto al centro cortical motor.

De aquí podemos comprender la extrema importancia biológica de los conflictos sensoriales.

No se trata sólo de “un poco de piel o de periostio” (en el periostio no se puede ver nada), sino que estos conflictos tienen un gran significado desde el punto de vista biológico.

Los efectos orgánicos son visibles en la piel externa como neurodermatitis o soriasis.

La crisis epileptoide del programa EBS del conflicto de separación siempre es el desmayo, en correspondencia con una evolución conflictiva larga puede alargarse durante horas o días.

Naturalmente todos se alteran mucho y piensan que hay que despertar al paciente inmediatamente.

Ahí está el error, porque durante la crisis epileptoide, de una manera notoria, nos llenamos del carburante necesario para superar la segunda parte de la fase de reparación hacia la normalidad.

Obviamente eso no significa que los médicos de la Nueva Medicina sean descerebrados y consideren el desmayo con ligereza.

Por el contrario, tienen que garantizar las funciones vegetativas (respiración, circulación, tasa de azúcar en sangre, etc.).

El buen terapeuta, con el conocimiento de las leyes biológicas, puede en cierta medida valorar con anticipación cuánto durará el desmayo. Y por eso no sirve de nada caer en el pánico.

Si se lleva a estos pacientes a la clínica, se piensa que el paciente está en “estado de shock” del que hay que sacarlo lo más rápidamente posible. Esto es un error. A menudo la consecuencia de ese error es la muerte del paciente, que se habría podido evitar si el médico hubiese conocido la Nueva Medicina.

8.3.3.2. Desmayo cuando está afectado el periostio

El desmayo en la crisis epileptoide del programa EBS con conflicto de separación dolorosa (periostio) no se distingue casi del desmayo de un conflicto normal de separación con úlcera del epitelio pavimentoso de la piel o de la mucosa.

La cosa respecto a esto es que en el exterior no se nota nada. De hecho las partes alrededor del periostio afectado están frías en la sensación subjetiva del paciente y también la piel externa puede estar un poco más fría, ¿pero qué investigador nos hace caso?

El mismo paciente podría ayudarnos diciéndonos, por ejemplo: “La pierna derecha y el brazo derecho siempre están fríos. De noche me pongo ropa y meto la mano en la tripa para calentarla”.

8.3.3.3. El desmayo en el infarto cardíaco izquierdo con úlcera del íntima coronario, bradicardia ventricular y arritmia.

Una ojeada a nuestro hombrecillo nos muestra que también el íntima coronario pertenece al centro cortical sensorial, y por lo tanto en fase conflictiva activa produce dolores (angina de pecho) y úlcera. Además del hinchamiento progresivo de la mucosa del epitelio pavimentoso, que conducirá a la oclusión de las coronarias (= derivado del arco branquial!), en fase de reparación, durante la crisis epileptoide, tenemos

- a) un fuerte dolor (“super angina de pecho”) y
- b) un desmayo, cuya duración depende de la duración del conflicto precedente.

Para muchos, muchísimos pacientes, este desmayo se considera igual a la muerte. Así, creo entender, se forma el gran número de los denominados “muertos aparentes”.

Por desgracia muchos de estos pacientes, en nuestras clínicas sin alma, no tiene ninguna posibilidad de despertarse del normal desmayo biológico, porque durante este desmayo les quitan rápidamente los órganos para las donaciones.

8.3.3.4. Epilepsia por la úlcera del íntima de las venas coronarias con embolia pulmonar (infarto cardíaco derecho) con úlcera del cuello del útero al mismo tiempo.

Así como el íntima de las arterias coronarias, en cuanto que deriva de los arcos branquiales (un descubrimiento originario de la Nueva Medicina), está recubierto de epitelio pavimentoso provisto de una elevada sensibilidad, lo mismo sucede para las venas coronarias, que vierten su sangre en el corazón derecho. Desde el corazón derecho, como sabemos, llega al pulmón. Las costras de reparación de la úlcera de las venas coronarias en la crisis epileptoide terminan en el pulmón, donde causan la denominada embolia pulmonar.

Este proceso de obstrucción de las pequeñas arterias pulmonares que transportan sangre corporal venosa, la denominada embolia pulmonar, se produce por el hecho que en la crisis epileptoide el proceso de reparación se interrumpe durante la duración de la crisis epileptoide. Las úlceras de las venas coronarias que estaban cicatrizando (con costras de reparación) de repente comienzan a ulcerarse. De este modo las costras de reparación se arrancan y son transportadas al corazón derecho por las arterias pulmonares. En este infarto cardíaco derecho con taquicardia el paciente tiene dolores cardíacos, pero normalmente menos que en el caso del infarto cardíaco izquierdo.

Y también aquí se produce un desmayo que a menudo se interpreta erróneamente como muerte.

Nuestras pacientes mueren, no por la úlcera del cuello del útero, sino por la embolia pulmonar que casi siempre aparece en la crisis epileptoide.

Sin embargo creo que esto sólo es válido en los casos de pacientes diestras que han tenido una larga evolución conflictiva y ninguna constelación esquizofrénica.

A menudo, en caso de evolución conflictiva breve (por ej. 3 meses) o de constelación esquizofrénica cortical durante la fase de conflicto activo la “pequeña embolia pulmonar” normalmente se descuida (único síntoma: “un poco de dificultad al respirar”). También aquí la duración del desmayo está ligada a la fase de conflicto activo y seguidamente a la eventual presencia de constelación esquizofrénica.

Lo mismo se puede decir en líneas generales también para el infarto cardíaco derecho.

8.3.3.5. La crisis epileptoide de la úlcera de las vías biliares con desmayo durante la hepatitis, lo que hasta ahora se había denominado “coma hepático”.

También aquí, por analogía, vale lo dicho anteriormente.

Durante la denominada “hepatitis” se interrumpe la reparación de la úlcera a través de la crisis epileptoide, que es simpaticotónica, por lo tanto en la práctica conflictualmente activa.

Solo que las costras o placas de las pequeñas úlceras en fase de cicatrización que ahora vuelven a ulcerarse durante breve tiempo en las vías biliares pequeñas o grandes, puede ser arrancadas y transportadas sin peligro con la bilis en la colequiste (cálculos biliares) o en el intestino.

Y dado que las vías biliares por el interior están revestidas de epitelio pavimentoso y este último viene directo del centro cortical sensorial, se produce también aquí el desmayo habitual. A menudo no lo notamos, si se produce en el sueño. Hasta ahora, se le llamaba “coma hepático”.

Si los familiares, los médicos y el personal sanitario lo saben y se comportan adecuadamente, intentando comprender en lugar de asustándose, se puede reducir el pánico que siempre se difunde por el hecho de que los médicos y el resto del personal anuncian: “Esto ya es el coma hepático, el comienzo del fin”.

Un desmayo en la crisis epiléptica en el curso de la hepatitis (=fase de reparación del programa EBS de rencor en el territorio) es de hecho del todo normal.

8.3.3.6. La crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial con desmayo en “bronquitis”, atelectasia bronquial o pulmonía.

Para poder comprender completamente hace falta citar aquí la crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial. También en este programa EBS con úlcera

del epitelio pavimentoso relativo al centro cortical sensorial encontramos un desmayo que, sin embargo, no se nota, sobretodo si se produce durante el sueño.

8.3.3.7. La crisis epileptode del denominado “glaucoma” (ofuscamiento del cuerpo vítreo del ojo)

Hasta ahora se ha mantenido que hace falta una terapia para el denominado glaucoma, es decir, para el aumento de la presión del ojo en la cavidad ocular posterior, incluido el cuerpo vítreo, porque se creía que destruía el ojo. Justo es lo contrario. En la crisis epileptoide, como efecto de la breve actividad conflictiva, se produce una disminución de la elevada presión ocular.

El glaucoma con su típica crisis (epileptoide) es la presión elevada de la cavidad ocular interna necesaria para que el ojo permanezca firme con el nuevo llenado de las partes vaciadas.

Si no hubiese glaucoma, el globo ocular se arrugaría y la capacidad visual se peligraría.

8.4. El orgasmo

8.4.1. El orgasmo unilateral

Un tipo de crisis epiléptica o epileptoide.

8.4.2. El orgasmo bilateral

Un tipo de breve psicosis o de constelación esquizofrénica con dos crisis epileptoides en FH que se encuentran en posición opuesta en los hemisferios.

8.4.3. La denominada “borrachera amorosa”

A propósito meto en discusión este capítulo.

Los que han leído este capítulo ya han protestado diciendo que no es posible afirmar todas estas cosas.

Nadie sabe lo que lo que sucedía en realidad, por lo que respecta a la esfera del amor, en los pueblos primitivos. Además todos intentamos reconocernos aquí como “casos normales”.

En el pasado he enseñado durante años en el campo de las ciencias sexuales humanas, pero este capítulo sigue un desarrollo completamente nuevo: toma en cuenta las relaciones existentes en el cerebro. Sin embargo quedan muchos puntos interrogantes.

Me han advertido que no cargue la exposición de la Nueva Medicina con argumentaciones que probablemente en gran parte todavía no conozco. Pero jamás me he apartado de un desafío.

No considero una vergüenza poner interrogantes. Además este capítulo se refiere sólo a las estructuras fundamentales que encontramos también en los programas especiales, biológicos y sensatos, pero que puede ser usados de un modo totalmente diferente por madre naturaleza. Como ya se ha dicho, en este capítulo no hay hipótesis, sino interrogantes, lo cual es legítimo.

8.4.4. El orgasmo unilateral (a nivel cerebral)

La madre naturaleza utiliza sus estructuras fundamentales del modo que le parece útil y sensato. Esas estructuras fundamentales arcaicas las ha usado en el fenómeno del orgasmo en el amor tanto en el hombre como en el animal.

Cuando se celebra con el propio (la propia) partner el acto sacro del amor en una blanda cama caliente, eso tiene que ver con un sentido de bienestar (vagotónico); el achucharse, acariciarse, todo eso tiene que ver con la vagotonía.

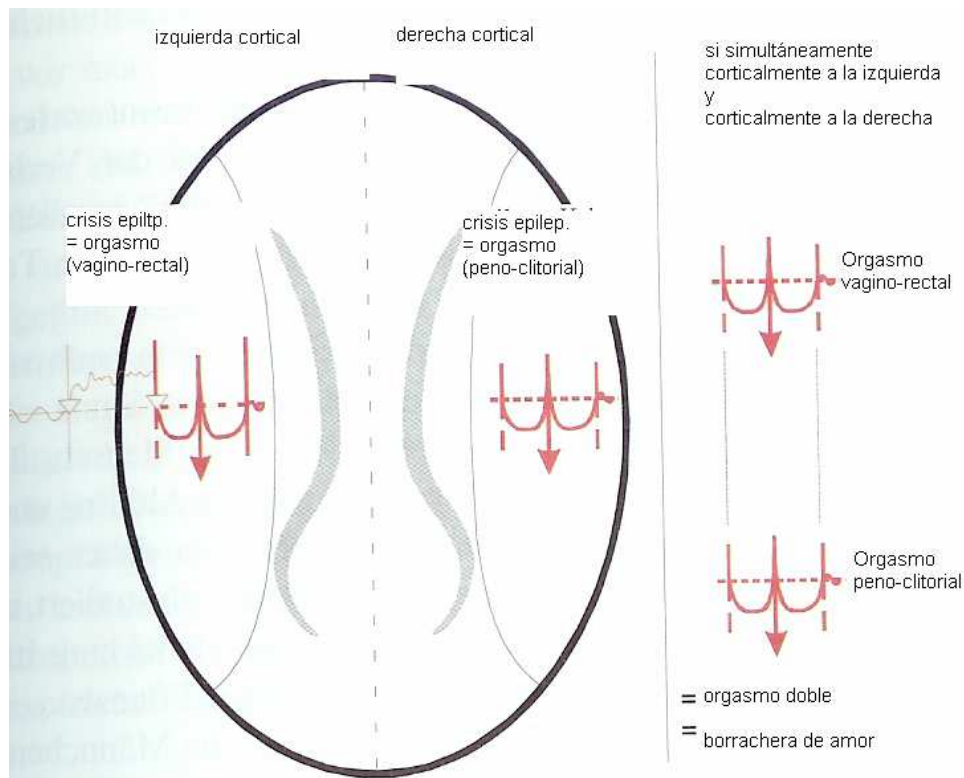
De ahí se pasa naturalmente al verdadero y propio juego del amor, bien visible en el hombre con la erección del pene.

Desde ese momento se procede hacia el ápice de la crisis epileptoide y de la crisis epiléptica, que encuentra su punto culminante con la eyaculación en el hombre o con el orgasmo (clitoriano o vaginal) en la mujer.

Todo este proceso es simpaticotónico. Sabemos que también en los programas especiales, biológicos y sensatos existe este fenómeno de la crisis epiléptica o epileptoide.

Después del orgasmo vuelve nuevamente la vagotonía: post coitum Manis animal triste = vagotonía. La erección desaparece inevitablemente. Se pasa normalmente al sueño.

Esquema del orgasmo



¿Y qué decir de la fase de conflicto activo, CA?

Cuando dos amantes se encuentran juntos en la cama, eso constituye siempre la fase de solución, la realización de todos los sueños.

La fase de conflicto activo forzosamente tiene que preceder a este momento y de hecho es lo que sucede. Se trata de hecho de una recaída que sigue representándose ("estímulo desencadenante").

Sustancialmente no es nada diferente, por ejemplo, de una denominada epilepsia: el paciente sueña con su vieja vía y gracias a algo se acuerda de un viejo conflicto, o se mete en una vieja vía. Poco tiempo después, siempre en la fase de relajación, tiene su ataque epiléptico.

Sabemos que en la epilepsia está el conflicto biológico motor. Pero la fase de conflicto activo ¿sólo tiene "estímulos desencadenantes parecidos a recaídas" y ningún DHS?

Ahora se entiende mucho mejor que en este caso, cuando hablamos de "estructuras fundamentales" que son usadas por la madre naturaleza, el concepto de "conflicto" no se entiende del mismo modo, porque lo afrontamos con la acepción "psíquico".

Sin embargo si hablamos de un conflicto biológico y de programas especiales, biológicos y sensatos, ya no hay problemas de comprensión.

Igual que se puede resolver un conflicto biológico sexual con el proceso biológico de una inundación de estrógenos, por ejemplo en el blastoma del ovario (quiste ovarial indurito), también se puede poner en marcha, con el transcurrir natural de los estrógenos (en una muchacha en la pubertad) y de la testosterona del joven en

pubertad, una especie de programa especial biológico y con sentido que tiene una evolución análoga sin ser un programa EBS típico, desencadenado por un conflicto biológico.

No veo ninguna contradicción y no hay motivo para ser más papista que el papá si la madre naturaleza aprovecha las estructuras fundamentales que ella misma ha desarrollado para esos importantes procesos biológicos, con gran éxito, como se puede ver.

La pregunta que se nos presenta es la siguiente: ¿el “primer gran amor” es la DHS o se trata casi de un “programa especial, biológico, sensato y natural”?

No puedo y no quiero responder a esta pregunta de un modo definitivo. Fundamentalmente tengo por posibles las dos hipótesis. El hecho de que el desarrollo corresponda a la recaída de un “programa EBS” en todas las fases, no deja, en mi opinión, ninguna duda al respecto. Los hechos son simplemente demasiado evidentes.

Como veremos en el capítulo sobre las reglas biogenéticas fundamentales, el hermafroditismo y la sexualidad en sentido literal, mezclado con el criterio ontogenético de la evolución, en el hombre, en el animal y en las plantas son un proceso antiquísimo, que ha sido programado en el período evolutivo de pasaje del peleocéfalo al neocéfalo, por el que ya desde hace muchos millones de años se ha perfeccionado y utilizado por la madre naturaleza. Es el motor del 98% de toda la evolución o del desarrollo de las especies en el hombre, los animales y las plantas.

Sabemos que en el reino animal los machos de muchas especies mueren repentinamente después de que se ha producido la fecundación y que son incluso asesinados o devorados por las hembras (por ejemplo las arañas). El acto de apareamiento es biológicamente por lo tanto un acto elemental, que está preestablecido con un programa sexual especial propio para cada especie animal o vegetal.

El funcionamiento de estos programas especiales en el curso de millones de años ha decidido si una especie podía sobrevivir, se podía seguir evolucionando; estaba integrado además en un programa social para cada especie particular, es decir, con el reparto de las diferentes funciones entre los miembros de una manada, de una grey, de una familia o, en el caso de las plantas, de una “colonia” o una especie vegetal o de más colonias, etc. (por ej. las plantas masculinas y femeninas de kiwi).

8.4.5. La frecuencia del orgasmo

Se comparamos los modos de comportamiento de la especie de mamíferos más cercana a nosotros con los del hombre, podemos llegar a entender por qué los seres humanos, a causa de la civilización, nos hemos alejado ya muchísimo del comportamiento natural inmediato y falto de ideología. Hacemos esta comparación con todas las reservas y selectivamente, teniendo en cuenta la diversidad de las razas. De hecho no tendríamos necesidad de esta comparación si mirásemos a los denominados pueblos primitivos, que viven todavía de acuerdo a su código natural. Los hombres civilizados nos hemos alejado muchísimo de ellos, aunque

sean ellos los que viven adaptándose de la mejor manera al programa natural que llevamos dentro.

Cuando vamos dar un paseo en el parque con nuestro perro domesticado (=macho), es fácil que encuentre 3 o 4 perras en celo listas para ser fecundadas por el macho que desea montarlas. Un lobo “jefe”, que vive libre en la naturaleza en su manada lo hace muy raramente, y justo cuando en la manada se han producido pérdidas que hay que reemplazar. Y también en los animales presa, que intentan conservar su especie por medio de una reproducción abundante (conejos, ovejas, etc.), el acto del apareamiento se produce de un modo sensato y planificado.

El proyecto natural para los humanos prevé que una mujer, tras el embarazo y una lactancia de tres años, esté de nuevo lista para la fecundación sólo cada cuatro años, tenga de nuevo ovulación y posiblemente sólo entonces lleve hasta el final el acto del amor. Por el contrario en nuestra realidad civilizada el acto del amor biológicamente “sacro” se ha reducido progresivamente a una diversión cotidiana que cuenta poco, para el que la mujer, en especial, tiene que estar siempre lista.

Nada mas lejos de mi intención que ofrecer con mis consideraciones humano-biológicas otro capítulo de literatura sexual más o menos inestable, sino que junto a ti, querido lector, hacer reflexiones biológicas serias sobre el acto biológicamente sacro de la unión amorosa entre el hombre y la mujer con el fin de producir una nueva persona.

8.4.6. ¿Qué relés del cerebro reaccionan como Focos de Hamer con el orgasmo unilateral o simple?

Entonces, siempre que precedentemente no haya ningún conflicto en suspensión corticalmente, cuando se produce el orgasmo en el hombre diestro y en la mujer zurda, reacciona el lado derecho cerebral.

¿Cómo se puede ver?

Es muy fácil: ya se ha escrito mucho sobre el amor y mucho sobre el orgasmo.

Pero jamás nadie ha hecho las observaciones de un modo coherente. Siempre se ha intentado entender el fenómeno bajo el perfil psicológico, pensando que los diferentes orgasmos tuviesen que ser relacionados con la intensidad. Esto no era del todo correcto.

El hombre diestro y la mujer zurda, si tienen sólo un orgasmo simple, y clitoral, pueden reaccionar a la derecha con toda la zona de territorio incluida las zonas del olfato (fronto-basalmente a la derecha) y del oído (temporo-basalmente a la derecha).

Sin embargo también puede ser que sólo reaccionen uno o dos relés como Focos de Hamer, según de cómo estén las vías. Seguidamente explicaré este mecanismo todavía más claramente.

Entonces si, por ejemplo, reacciona el relé bronquial motor, que es lo que sucede a menudo, los dos grupos tienen una denominada “expiración prolongada” (fase larga de emisión del aire con cada respiración), al mismo tiempo que un asma bronquial.

Sin embargo no se trata de asma bronquial, esto existe sólo en el denominado "orgasmo doble", sino de ahogo bronquial con expiración prolongada.

Los conceptos de eyaculación en el hombre diestro y de orgasmo clitoral en la mujer zurda, que pertenecen los dos al área cerebral a la derecha inherente al territorio, corresponden al denominado "orgasmo simple".

Hablamos de orgasmo "simple" o "unilateral" independientemente cuantos relés reaccionan juntos como Focos de Hamer en este lado cerebral derecho. El número de relés que reaccionan depende de la o las "vías", que pueden ser establecidas en el momento del primer amor, pero también derivar de las sucesivas "recaídas".

Naturalmente la situación es al contrario en la mujer diestra y el hombre zurdo. Mientras que la mujer diestra sólo puede reaccionar unilateralmente, es decir, con orgasmo "simple" (vagino-rectal), en el hombre zurdo un orgasmo unilateral o simple recto-anal se produce prácticamente sólo en los homosexuales (con relación anal sin eyaculación).

Normalmente el hombre zurdo no impotente reacciona "en los dos lados cerebrales" o con "orgasmo doble", lo cual trataremos en el tercer apartado y prácticamente representa siempre una breve constelación esquizofrénica. En el segundo apartado debatiremos la cuestión de si tales fases PCL dobles con orgasmo en los dos lados o bilateral no tiene que ser precedida también por dos procesos controlaterales (es decir, en los dos hemisferios) parecidos a los conflictos activos.

La sintomática de la mujer diestra con orgasmo simple (vagino-rectal) puede, entre otras cosas, ser un lamento laringal con inspiración profunda (fase de aspiración del aire en la respiración), ("se ha quedado sin aire"). Naturalmente también aquí todos los relés pueden reaccionar en la sucesión habitual de la corteza cerebral izquierda, en particular las regiones corticales izquierdas inherentes a los conflictos de territorio, naturalmente siempre a condición de que no exista precedentemente ningún conflicto cortical activo/en suspensión.

En la mujer diestra, con orgasmo simple, vemos a menudo una inspiración prolongada, "intenta aferrar el aire".

Respecto a todo este tema hay que subrayar en particular una cosa: en la naturaleza el orgasmo y todo el acto del apareamiento son una cosa muy seria. Es lo que muchas personas hoy día no consiguen entender, para ellos un "polvo" no tiene mayor significado que el placer de un cigarro. Para nuestro cerebro/ordenador este momento biológico fundamental, sin píldora, aborto ni preservativo, ha permanecido como siempre un suceso biológico de la máxima seriedad. Una nueva mirada al reino animal muestra lo seriamente que se produce el acto de apareamiento. Consecuentemente debe ser también importante a nivel biológico, pero sólo "a su debido tiempo".

Dado que este acto está integrado en el programa vital de una especie, pone en marcha nuevos programas (embarazo) y eventualmente programas especiales, por ejemplo, cuando hay disfunciones en la cría de los pequeños (adenocarcinoma mamario).

8.4.7. El denominado “saltar” de un conflicto y también del tipo de orgasmo de un hemisferio al hemisferio opuesto, en el caso de un conflicto activo en suspensión precedente o modificación de la situación hormonal. La impotencia.

Nuestra visión biológica del acto del amor, que tiene la ventaja de ser reproducible y por lo tanto demostrable en sentido científico, nos explica casi todos los fenómenos que hemos visto hasta ahora parcialmente sin conseguir encuadrarlos, de un modo totalmente simple y comprensible.

Seguramente no se puede dar explicaciones psicológicas de estos fenómenos del acto del amor, lo que siempre, en vano, hemos querido hacer.

Estas cuestiones arcaicas se desarrollan a nivel biológico y tienen también su sentido biológico. El hecho de que hasta ahora no lo hayamos entendido no cambia la realidad.

Una mujer diestra reacciona en el lado cerebral derecho y la ovulación se bloquea cuando se modifica su situación hormonal, esto puede suceder por un conflicto en la región de territorio femenino a la izquierda con programa EBS o por el embarazo, por un conflicto de pérdida con necrosis de los ovarios, por la menopausia o la toma de la píldora anticonceptiva. Con un conflicto sexual, por ejemplo con úlcera del cuello/orificio del útero y úlcera del íntima de las venas coronarias, se modifica también el modo de sentirse de la mujer, con desaparición de la ovulación y cambio del lado cerebral tras la fase aguda del conflicto, es decir, la mujer se siente “masculina”. Entonces se vuelve o masculina lesbiana o prefiere un hombre femenino, por lo cual ella haría “el hombre”.

Pero con este cambio al lado cerebral derecho cambia también el tipo de orgasmo: una mujer así ahora tiene los orgasmos clitorial, masculino. Asumiría así dentro de la estirpe natural una posición del todo diferente, que “ella” mantendría también con un conflicto duradero, porque desencadenaría los mecanismos naturales para no resolver este conflicto hasta el final de su vida (para evitar un infarto cardíaco derecho letal con embolia pulmonar). Respecto a su marido una mujer así, que reacciona masculinamente, ahora es “frígida”.

La denominada frigidez en nuestro tiempo se considera como una enfermedad o una anomalía. La frigidez para la mujer del “homo sapiens” sería, como muestra una mirada al comportamiento de los pueblos primitivos, la normalidad durante el 95% del tiempo de la edad fecunda. De hecho durante el embarazo y los sucesivos tres años de lactancia una mujer, normalmente, no está preparada para el acto sexual.

Nuestra denominada civilización “parabiológica” quiere convencernos de que las mujeres tendrían que estar disponibles cada noche para el sexo, al denominado “deber conyugal”, y por añadidura con la píldora, el medio anticonceptivo que vuelve (temporalmente) masculinas a las mujeres. Si no están disponibles tienen que someterse a psicoterapia.

Ahora que podemos entender las causas de estas situaciones sabemos lo insensato que era. En realidad hemos actuado del modo incorrecto todo lo que era posible hacer mal. En este caos biológico, que cada vez se vuelve peor, las religiones y las confesiones han añadido su moral sexual arbitraria con la que han

provocado infinitas penas y peligros a las pobres mujeres; piénsese sólo en los abortos impuestos por motivos religiosos.

Dado que la moral sexual de la iglesia, especialmente de la católica, ha sido ratificada casi exclusivamente por hombres no casado (en su mayoría homosexuales), a la mujer sólo se le ha concedido la sexualidad de un modo inevitable, la que pasa “sin notarse” como en la concepción de Jesús por el “Espíritu Santo”, en el que María fue fecundada sin sexo y a escondidas.

Una “sexualidad minimalista” de la mujer, es decir, una sexualidad con el único fin de concebir estaría en cierta medida casi cerca de la biología, si no se hubiese introducido en el s. XIII la denominada “monogamia” para el pueblo.

Por el contrario los nobles: los condes (entonces oficiales de justicia), caballeros, príncipes, abades y obispos príncipes tenían el denominado “ius primae noctis”, es decir, el “derecho” a la primera noche.

Por lo tanto podían violentar a placer y siempre que querían a cualquier muchacha virgen de sus subditos. A partir de esta esclavitud sexual de la mujer se ha desarrollado nuestra moral sexual.

Comencemos sistemáticamente con el saltar de los conflictos de un lado cerebral al otro:

1. La mujer diestra tiene normalmente el orgasmo vagino anal (o vagino-rectal). Sin embargo con una estimulación adecuada puede llegar también a un orgasmo clitoral. El orgasmo vaginal se produce por el lado cerebral izquierdo, el clitoral por el lado cerebral derecho.
2. La mujer zurda tiene normalmente el orgasmo clitoral, producido por el lado cerebral derecho. Sin embargo con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo vagino-recto-anal producido por el lado cerebral izquierdo.
3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo pene-clitoral (de pene y clitoris) producido por el lado cerebral derecho. Sin embargo con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo recto-anal producido por el lado cerebral izquierdo.
4. El hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo recto anal, pero además a menudo el orgasmo pene-clitoral, con el que solamente puede producirse la eyaculación, es decir, el “doble orgasmo”. Entonces el hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo más fuerte, porque es doble.

Si a causa de un conflicto biológico o de modificaciones de la situación hormonal se cambia el lado cerebral (el denominado saltar a otro hemisferio) se pueden presentar las siguientes situaciones:

1. la mujer diestra normalmente es vaginalmente impotente, por lo que ahora puede experimentar el orgasmo clitoral. Ahora prefiere, siempre que lo quiera, hacer sexo con hombres femeninos y el acto sexual de un modo masculino con el orgasmo clitoral. Dado que los hombres en general no entienden mucho de esto, se considera “frígida”, lo que efectivamente sólo es verdad en el caso de un conflicto sexual biológico.
2. La mujer zurda biológicamente tiene, y se ve muy bien, una función totalmente diferente de la diestra. También ella, por mucho que pueda parecer

contradictorio, está bloqueada sexualmente de un modo pasajero, ahora que ha cerrado la mitad cerebral derecha, masculina, siente por primera vez el orgasmo vaginal y puede, de hecho, quedar embarazada mejor que antes, cuando experimentaba el orgasmo clitoral con el lado cerebral derecho. A pesar de eso o a causa del conflicto sexual se ve incluso obligada al embarazo, en sentido biológico bien entendido.

3. El hombre diestro, dado que su lado cerebral derecho está cerrado por no haber resuelto su conflicto, normalmente tiene todavía el orgasmo recto-anal. Es decir, es homosexual o más o menos impotente (impotentia coeundi) respecto al pene.
4. El hombre zurdo está psicológicamente bloqueado de modo pasajero pero siente ahora por primera vez el orgasmo pene-clítoris producido en el lado cerebral derecho, de tal forma que un zurdo así con conflicto de territorio al menos por un cierto tiempo puede hacer de jefe sustituto de territorio, por lo que se refiere al apareamiento, aunque se vuelve "homosexual macho" si el conflicto de territorio dura mucho.

No sé si he conseguido clasificar ya todo de un modo correcto, quiero decir bajo el perfil biológico. Para los médicos, estando acostumbrados durante siglos a considerar estos programas especiales, biológicos y sensatos como cosas negativas, como "disfunciones patológicas", insuficiencias, errores y cosas parecidas, ahora es demasiado difícil comprender de repente que estos programas EBS están previstos por la madre naturaleza con el fin de crear relaciones y uniones sociales, familias, manadas, estirpes, etc., para los que estas supuestas "disfunciones", estas modificaciones de la función e "impotencia" son procesos particularmente sensatos y necesarios para la supervivencia, justo de los programas especiales, biológicos y sensatos (EBS) de la naturaleza.

Espero, queridos lectores, que no os habréis desilusionado leyendo ahora las descripciones del acto sexual, que siempre se ha descrito como irracional e incluso "indescriptible", descubriréis y entenderéis cosas totalmente diferentes al respecto. Será todavía más fantástico que antes, en cualquier caso menos irracional.

El orgasmo bilateral u "orgasmo doble" de la borrachera de amor, del que a los escritores que querían narrar la alegría del acto sexual no les salían las palabras, ese orgasmo doble ahora puede ser descrito con palabras científicas sin que pierda nada de su fascinación.

Definición:

El orgasmo "doble" es la crisis epileptoide del programa EBS del apareamiento desencadenada al mismo tiempo en los dos ámbitos de territorio de los dos hemisferios, es decir,

- a) La crisis epileptoide vagino-recto-anal directa del lado cerebral izquierdo
- b) La pene-clitoral directa del lado cerebral derecho.

En el momento de la crisis epileptoide cortical, que se produce al mismo tiempo en los lados cerebrales, el amante se encuentra en constelación esquizofrénica. Este

sentimiento de “locura” pasajera ha representado hasta ahora la gran parte de la fascinación del acto de amor. Lo hemos llamado “borrachera de amor”. En los animales, relativo a las hembras, que cumplen este acto de amor sólo en el momento de la ovulación y con el único fin de la reproducción, encontramos este “orgasmo doble” más frecuentemente que en la mujer, que precisamente quiere evitar la reproducción y conseguir sólo placer.

En situación normal, es decir, sin conflicto y sin alteración hormonal, el hombre zurdo y la mujer diestra tienen una cierta ventaja en el vivir “la borrachera de amor”: el hombre zurdo la experimenta casi regularmente porque experimenta el orgasmo recto-anal a causa de su zurdismo y el orgasmo clitoral forzosamente por la eyaculación. La mujer diestra experimenta el orgasmo vagino-recto-anal normalmente y además puede experimentar fácilmente al mismo tiempo el orgasmo clitoral con una técnica amatoria adecuada.

También aquí es como para muchas otras cosas de la Nueva Medicina: incluso siendo tan fácil entender la cuestión bajo el aspecto teórico, cuando se entra en detalles comienzan también los problemas de comprensión.

Tenemos que pensar siempre que los diferentes orgasmos de la persona son de tipo artificial o no biológico. A causa de las normas no biológicas que han creado los fundadores religiosos se vuelve todo mucho más complicado e incomprensible.

8.4.8. Sexualidad en la denominada “constelación esquizofrénica”

Tomemos nuevamente nuestros cuatro grupos:

1. La mujer diestra, que probablemente experimentaría un orgasmo biológicamente sólo cada 3-4 años (tras el embarazo y el correspondiente tiempo de lactancia), y por la precisión antes de una ovulación, con constelación esquizofrénica de las dos regiones de territorio, que aquí vamos a indagar, se podría comportar de un modo totalmente diferente. Sustancialmente llamaremos un estado así “constelación post-mortal”, a veces con acentuación del conflicto del lado cerebral izquierdo “constelación suicida” o, cuando las dos vías tienen carácter sexual, “constelación ninfómana”. De hecho un conflicto en la región de territorio no tiene que ser necesariamente un conflicto sexual en sentido específico. Aquí el concepto de la denominada vía tiene mucha importancia, porque hay dos posibilidades:
 - a) si la vía, por lo que respecta a un hemisferio o a los dos, no es inherente a la sexualidad en sentido propio, puede resultar, a pesar de ello, una impotencia uni o bilateral (impotencia coeundi aut/et generandi) con crisis epileptoide en la fase PCL.
 - b) Si la vía tiene que ver con la sexualidad real y propia en uno o los dos hemisferios, entonces con cada recaída uni o bilateral tiene lugar

también una sucesiva crisis epileptoide, sin embargo muy atenuada, como normalmente se produce en la constelación esquizofrénica.

Vemos aquí también como la impotencia y el orgasmo atenuado, incluso bilateral o simplemente “doble” (indebido) son muy afines. Obviamente procesos parecidos en la naturaleza o en los pueblos primitivos serían muy raros.

En nuestra civilización los hombres han estado convencidos de que la sexualidad forme parte de las necesidades cotidianas como comer, beber o dormir. Esto biológicamente está casi “falto de sentido” y está manipulado a conciencia. Y aun cuando sucede algo completamente insensato bajo el aspecto biológico, aún así tiene que seguir las cinco leyes naturales biológicas arcaicas. Resumiendo: la mujer diestra, que está en constelación esquizofrénica en las dos regiones de territorio, que no ha tenido ninguna ovulación y tras un cierto tiempo seguido al primer DHS (lado cerebral izquierdo), ha reaccionado de modo masculino, no podía seguir teniendo un orgasmo vagino-recto-anal, a excepción de una vía: en efecto, tras el segundo DHS, esta vez en el lado cerebral derecho, la mujer no reacciona ya de modo totalmente masculino, es decir, ya no tiene ningún orgasmo clitoral (excepto en la vía), se encuentra en constelación ninfómana, postmortal, maníaco-depresiva (esta última cosa sólo si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo). Y a esto lo llamamos ninfomanía.

Mujeres así, por ejemplo, buscan a menudo hombres de manera platónica o quieren, si había vía, estar continuamente estimuladas a nivel del clitoris o recurren a la masturbación. No tenemos que olvidar aquí que tales mujeres en la constelación esquizofrénica, por la que gracias al segundo conflicto (en el lado cerebral derecho) tienen nuevamente su ovulación y el ciclo menstrual, pueden quedar embarazadas, lo que es la solución biológica de este estado.

2. La mujer zurda en constelación, que biológicamente tiene un orgasmo vaginal sólo cada 3-4 años (tras el embarazo y lactancia) en el periodo antes de la ovulación y tras un orgasmo clitoral, tiene un perfil hormonal totalmente diferente tras el primer conflicto biológico en la región de territorio en el lado cerebral derecho respecto al de la diestra tras el primer conflicto (en el lado cerebral izquierdo). De hecho la zurda sigue teniendo ovulación y nada impide un embarazo inmediato, a pesar de un probable conflicto sexual en la región de territorio a la derecha. También a veces esta mujer zurda sufre un segundo conflicto, esta vez en el lado izquierdo, siempre en la región de territorio (femenino), no pierde por eso la ovulación siempre que no se encuentre en una edad crítica.

Entonces tiene constelación maníaco-depresiva, post-mortal y a la fuerza ninfomano-depresiva, porque ha sufrido ya dos veces un conflicto sexual, uno tras otro, antes en el lado derecho y después en el izquierdo. En principio el estado puede ser “ninfo-depresivo” y ninfómano, si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo. En la constelación esquizofrénica la mujer zurda y diestra son comparables nuevamente.

Aquí, respecto a la frigidez (impotencia), vale el mismo discurso que para la diestra. También aquí depende de si el conflicto sexual era la vía efectiva, correspondientemente también el orgasmo será diferente. Sin embargo se añade el hecho de que con la costumbre de la masturbación se establece una

especie de “canalización”, como se decía antes correctamente. Y, como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que estas cosas se pueden resolver o mantener más o menos artificialmente, porque la solución biológica es simplísima: embarazo.

Y tras 3-4- años “todo vuelve a entrar en juego”.

3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo pene-clitoral, que se origina en el lado cerebral derecho. Si no puede resolver durante mucho tiempo su primer conflicto de territorio, que sufre en el lado cerebral derecho, no se le ofrece biológicamente la posibilidad de resolverlo, porque de otro modo sufriría inmediatamente un infarto cardíaco izquierdo. Se vuelve homosexual y puede sentir el orgasmo recto anal. Sin embargo el partner o la “partner masculina” puede provocar todavía, con dificultades, el orgasmo del pene, si este era la vía, manualmente y oralmente, de modo que pueda experimentar un orgasmo doble aunque el pene-clitoral sea de intensidad reducida. De aquí viene la opinión largamente difundida entre los heterosexuales de que los “heteros” no pueden experimentar el orgasmo tan intensamente como ellos. Entendemos siempre el doble orgasmo.
4. El hombre zurdo sufre el primer conflicto de territorio a la izquierda cerebralmente, volviéndose maníaco e incapaz del orgasmo anal. Entonces es un macho “psicológicamente casi castrado”. En este estado, sin embargo, está en condiciones todavía de aparearse y también está muy dispuesto a hacerlo. Por lo tanto en la naturaleza un lobo zurdo así será atacado por el jefe de manada y maltratado en cualquier ocasión posible hasta que sufre el segundo conflicto de territorio, esta vez en el lado cerebral derecho, entrando así en constelación esquizofrénica. En este punto el hombre zurdo todavía es capaz de tener erección y de llegar a la eyaculación con la manipulación, pero la libido es casi nula. También puede “dejarlo pasar” completamente y como tal, por ejemplo en el caso de los lobos, vuelve a ser tolerado por el jefe de manada. En el capítulo sobre las psicosis veremos que estas constelaciones no son defectos de la naturaleza, sino que tienen su sentido biológico. De hecho estos lobos zurdos en constelación esquizofrénica, en caso de muerte del jefe de manada y en el caso en el que la loba alfa, por cualquier motivo no pueda tomar temporalmente el mando de la manada, son los únicos que podrían suceder al jefe de manada, resolviendo así los dos conflictos. Todos los otros lobos de segundo rango con un único conflicto de territorio no deben e instintivamente no pueden resolver su conflicto, porque de otro modo morirían de infarto cardíaco izquierdo o derecho.

Lo que es cierto para los hombres homosexuales vale análogamente para las mujeres lesbianas, que obtienen estos efectos con el uso de vibradores. En la constelación esquizofrénica, en la constelación maníaco-depresiva, portmortal, casanova-maníaca de los hombres, es nuevamente todo posible según que lado esté acentuado, que vía exista y que estimulación se produzca normalmente. Por desgracia hasta ahora no existe ningún parámetro hormonal sistemático con este

propósito, de tal manera que sólo podemos hacer suposiciones, pero no tenemos ninguna prueba. Esto podría cambiar dentro de poco tiempo si tuviese a mi disposición una clínica.

Obviamente también los posibles conflictos de pérdida y los valores de testosterona aumentados al final de la fase PCL juegan aquí un papel importante. De estos numerosos particulares se puede calcular más o menos el tipo de orgasmo (simple o doble) (vías!!) o de impotencia, siempre sabiendo que esto tiene en común con la biología, normalmente, sólo los mecanismos arcaicos fundamentales de las 5 leyes biológicas naturales.

9. Ritmo vegetativo: simpaticotonía – vagotonía

Si cualquier médico de este mundo se hubiese interesado por el ritmo fundamental de la biología, el ritmo día/noche o el ritmo de simpaticotonía y vagotonía y hubiese visitado científicamente, aunque sólo hubieran sido tres pacientes de cáncer, habría visto la correlaciones del cáncer. Y yo mismo, durante mis primeros veinte años de actividad médica, me incluyo en el grupo de los que pasaban por alto estos hechos.

Por desgracia nuestra medicina no tiene en gran consideración el ocuparse de estas cuestiones del biorritmo, incluso se puede decir que en este campo se sigue en el oscurantismo. En los libros de psicosomática de grandes dimensiones sólo se dedican unas pocas líneas al biorritmo, y estas pocas líneas son muy pobres. Según el axioma, donde hay una molestia, se habla de “distonía vegetativa” y con eso basta.

En el campo de la génesis del cáncer, de su evolución y curación, el ritmo vegetativo juega un papel de importancia fundamental.

Nótese:

La modificación del ritmo vegetativo (biorritmo) es el criterio de diagnóstico más importante de la enfermedad del cáncer, y precisamente tanto la génesis del cáncer como su curación (DHS y CL).

La génesis de la enfermedad cancerosa, es decir, la entrada de un programa especial, biológico y sensato, consiste, por lo que respecta al biorritmo, en una simpaticotonía permanente desencadenada por un DHS, la evolución de la curación post-conflictiva, en una vagotonía permanente.

La curación final consiste en una vuelta a la normotonía.

El estado vegetativo de un paciente es el más accesible para el diagnóstico. Basta dar la mano al paciente para saber si tiene las manos frías o calientes, es decir, si se encuentra en simpaticotonía o en vagotonía.

Las alteraciones del ritmo vegetativo se consideran disfunciones circulatorias que hay que regresar al “valor normal”.

Muchas personas resisten estas alteraciones durante una semana o 14 días, si después en casa pueden sacar el estrés del hospital. Pero más allá de las 4 semanas se vuelve más difícil. Y para agravar la situación se añade el escaso conocimiento de la Nueva Medicina por parte de los médicos.

Éstos, en el hospital, ordenaban a cualquier paciente con una complicación (por ej. un drenaje pleurico o una transfusión de sangre), que ya estaba en la fase de reparación (fase PCL), y se decía siempre lo mismo: “No podemos hacer nada más, la circulación ya está afectada totalmente por el cáncer. Nuestro médico jefe ha prescrito la morfina”. A los parientes después se les contaba que el paciente ya no tenía esperanza, que el sistema circulatorio estaba totalmente destruido y que se le debía dejar morir en paz. Tras algunos días, efectivamente, moría por el efecto de la morfina.

Conozco muchísimos pacientes que han permanecido en una profunda vagotonía durante meses, con esa supuesta “disfunción circulatoria permanente”, y que hoy en día están alegremente sanos. De hecho la fase de vagotonía, la fase de reparación tras la conflictolisis, es solamente una fase que termina de un modo natural, cuando el organismo se encuentra de nuevo en normotonía. Pero sólo depende de la naturaleza, cuando el organismo ha reparado el cerebro y también el órgano, de tal manera que el individuo puede retomar la lucha de la vida. Si un hombre o un animal se levanta antes de que la reparación haya concluido y se encuentra de nuevo en la lucha por la existencia, eso sería un verdadero suicidio. Justo como en la fase de conflicto activo el organismo moviliza todas las fuerzas para superar el conflicto a su favor, así en la fase de reparación busca tener la máxima tranquilidad, de modo que el Foco de Hamer en el cerebro y el tumor en el órgano puedan cicatrizar.

Así como es posible dividir el día en 24 horas en una fase diurna y nocturna, también en la enfermedad del cáncer se puede distinguir una fase diurna de simpaticotonía permanente o fase de conflicto y una fase nocturna de vagotonía permanente o fase de reparación. Y al igual que la persona de noche no está enferma porque duerme y de día no está mala porque no duerme, en principio la fase de conflicto activo, igual que la fase de reparación, son normales.

Sustancialmente por eso la enfermedad del cáncer es algo normal. Es cualquier cosa menos una célula enloquecida, que supuestamente se comporta de un modo loco destruyendo todo, que crece de manera incontrolada y se multiplica y lucha contra su supuesto “organismo huésped”. El tumor, contra el que se vuelve la ira de los médicos, es sólo un indicio relativamente inocuo de la “enfermedad” verdadera en la psique y en el cerebro. Básicamente podemos considerar un conflicto, que sufrimos en el instante del DHS, también como un test de la naturaleza para controlar si nuestro organismo está todavía en posición de superarla con el programa especial que sigue. Si no superamos el test, tenemos que dejar libre el puesto que ocupamos en el mundo para otra persona que consiga superar esa prueba.

El tumor en el órgano muestra solamente que ya desde hace tiempo no hemos superado este test y que es urgente superarlo. Quien extirpa este tumor con la esperanza de sanar del todo de la enfermedad es como la persona que al mediodía cierra los ojos y piensa que está amaneciendo.

Hasta que no aferremos el ritmo vegetativo como pulsación de la naturaleza, no podemos comprender en absoluto la Nueva Medicina.

Todos los principios y leyes de la naturaleza están en relación, de hecho al final son pocos a los que se puede reconducir todo. Un principio parecido es el ritmo de la naturaleza, que llamamos, en referencia a nuestro organismo, ritmo vegetativo. Mis pacientes se saludaban por la mañana con un apretón de manos: "Ah, tiene las manos bien calientes, parece que sus circuitos funcionen perfectamente". Ciertamente, ahora que se sabe es fácil decir que se habría podido descubrir con facilidad, porque todo cáncer en conflicto activo tiene una simpaticotonía permanente y todo cáncer en la fase de reparación tras la solución del conflicto tiene una vagotonía permanente. (Lo mismo vale naturalmente para las enfermedades oncoequivalentes).

¿Qué relación hay entre este fenómeno y nuestro biorritmo? ¿Dónde se sitúa la disfunción? ¿Se trata realmente de una disfunción? Las preguntas tienen que ver sobre todo con una comprensión radical del cáncer.

Comencemos desde el principio: en nuestro ritmo diario existen dos fases:

1. la fase diurna:

en esta fase trabajamos y luchamos, tenemos que estar bien despiertos. Dura más o menos desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde en verano y de las 6 hasta las 6 de la tarde en invierno. Están inervados los órganos denominados "ergotrópicos", es decir, los "órganos del trabajo, músculos, corazón, cerebro.

2. la fase nocturna:

en esta fase dormimos. Psique, cerebro y órganos descansan del trabajo. En esta fase están inervados y muy irrigados de sangre los denominados órganos "trofotrópicos": estómago, intestino, hígado, páncreas. La nutrición se produce tranquilamente. Psique, cerebro y órganos, todo el organismo recupera las fuerzas para el día siguiente.

La medicina denominada moderna, sin embargo, ha intentado ignorar este ritmo día/noche.

En las secciones de reanimación ya no existe ningún ritmo día/noche. Siempre están las luces encendidas, la presión sanguínea, señal segura de la diferencia del ritmo entre el día y la noche, se mantiene "estable", como se dice eufemísticamente, durante las 24 horas.

Esta es la primera cosa sin sentido. Para mantener artificialmente alta la presión sanguínea, que en cada persona sana que duerme desciende sistólicamente por debajo de 100 mm Hg, se suministra al paciente continuamente "fármacos para la circulación", que no son otra cosa que simpaticotónicos. En la práctica al paciente no puede dormir profundamente.

Recordemos el esquema del desarrollo bifásico de todos los programas especiales, biológicos y sensatos del capítulo 7 sobre las dos fases de todas las enfermedades si se produce la solución del conflicto: el ritmo normal día/noche es la normotonía, en la primera fase de estrés de conflicto activo domina la simpaticotonía, en la segunda fase de reparación con conflicto resuelto, la vagotonía, tras la conclusión de la fase PCL, de nuevo la normotonía. Entre DHS,

CL y el regreso a la normalidad hacia la eutonía, se sitúa, por ejemplo, una enfermedad cancerosa.

Para poder comprender el sentido y la sustancia de la modificación del biorritmo, queremos presentar una vez más un típico conflicto de territorio mediante el ejemplo del ciervo: un ciervo joven irrumpe en el territorio de un viejo y, aprovechándose del efecto sorpresa, saca al viejo ciervo de su territorio. Este último sufre un DHS con conflicto de territorio permanente. Este DHS con correspondiente conflicto de territorio prevé al mismo tiempo entrar en un programa especial o de emergencia. Esto puede causar la muerte del ciervo viejo, pero también puede ser su suerte. Porque si no se hubiese sufrido ningún DHS, su organismo no tendría ningún estímulo para movilizar todas sus fuerzas. Por el contrario así moviliza todas sus fuerzas y actúa a pleno ritmo. Se prepara a fondo, lleva a cabo un ataque, saca toda su experiencia de lucha acumulada durante años. El ciervo joven no está preparado y tiene que abandonar el campo. El ciervo viejo aprovecha su ocasión, quizás para un año, o dos, incluso tres, quién lo sabe.

Una o otra vez se repetirá la ley de la lucha por el territorio. Entonces el ciervo viejo, vencido en el campo de batalla, se irá dejando el territorio al joven sucesor. El ciervo viejo perderá las fuerzas, adelgazará y al final morirá de debilidad como una persona que está enferma de cáncer y no ha sido capaz de resolver su conflicto.

Decidme vosotros, un DHS con su simpaticotonía y la entrada de un programa especial, ¿es sólo una disfunción o es un proceso necesario para la supervivencia en la naturaleza? A la naturaleza le han hecho falta muchos millones de años para crear este fantástico sistema con cientos de variantes, como ha sido confirmado. Por lo tanto no puedo creer que no tenga ningún sentido, incluso aunque nosotros, hombres miopes, sólo seamos capaces de considerar todo como “disfunción, enfermedad, etc”.

Cierto que no se puede consolar al enfermo diciéndole que su muerte también sería algo normal. Estamos acostumbrados a “combatir” todas las enfermedades, tumores, bacterias, incluso los síntomas individuales como fiebre, conato de vómito, edemas, etc. Son algo “malo, maligno” que destruye al hombre. Creo que tenemos que aprender urgentemente un nuevo modo de entender la realidad de la enfermedad.

La fase de surgimiento del cáncer, de conflicto activo es igual que una fase diurna permanente. Así se nos describe en la Iliada que el “furioso Aquiles” estuvo enfadado durante mucho tiempo hasta que mató a Héctor, que había asesinado a su amigo Patroclo. Justo después Aquiles murió de un infarto cardíaco.

El paciente que está en ritmo diurno permanente, no puede dormir, tiene una producción elevada de adrenalina, pierde peso hasta que resuelve finalmente su conflicto o no puede resolverlo ya nunca.

Normalmente a la fase diurna permanente de conflicto activo le sigue la fase postconflictiva, la fase nocturna permanente o de reparación.

Toda enfermedad cancerosa u oncoequivalente es por lo tanto un proceso rítmico día/noche postergado durante mucho tiempo. No se puede creer que un proceso así pueda ser “casual”. También hay que excluir la hipótesis de los aprendices de

brujo de que un proceso regulado así es la obra “casual” de una célula enloquecida.

Todo nuestro organismo funciona guiado por sus dos inervaciones simpática y parasimpática, con el ritmo día y noche de tensión y relajación, fase de estrés y fase de reparación, con fase de conflicto activo y de solución del conflicto, con surgimiento del cáncer y curación del cáncer.

Este sistema nervioso vegetativo es el segundo sistema más antiguo de nuestro cuerpo. Deriva del tiempo en el que el denominado puente o pons de nuestro actual tronco cerebral era casi “el cerebro” en nuestros antepasados más primitivos. Debe haber sucedido hace 80-100 millones de años; antes de que existieran los mamíferos, cuando por primera vez se delineó la diferencia entre día y noche, la temperatura corporal se volvió regulable y el organismo mostró una especie de reloj que indicaba el ritmo noche/día.

9.1. El sistema nervioso vegetativo: la central computerizada de los sucesos rítmicos biológicos de nuestro cuerpo.

Cuando nuestro organismo está sano oscila en los denominados ritmos y al mismo tiempo en ciclos más grandes. Llamamos el ritmo de varias maneras: ritmo día/noche o también ritmo despierto/sueño o ritmo tensión/relajación o ritmo simpaticotónico/parasimpaticotónico (=vagotónico).

Este ritmo día/noche en el hombre y en el animal oscila como un péndulo, donde algunas especies animales (“cazadores nocturnos”) de noche tienen la fase de tensión y de día la fase de reposo.

Este ritmo, que llamamos también ritmo vegetativo, es un componente esencial de todo nuestro organismo, de hecho de toda nuestra vida. La funcionalidad de todos nuestros órganos se coordina por este ritmo vegetativo. El sistema nervioso central, que provoca tal coordinación, se llama sistema nervioso vegetativo o autónomo. A menudo se compara también con las riendas de un caballo, entre las que nuestro organismo se movería justo como un caballo. Una rienda, la simpática, tira en la dirección de la tensión, la otra, la parasimpática, en la dirección de la relajación y del reposo.

Dado que el nervio principal de todo el grupo del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago, la inervación de reposo también se llama vagotonía. La inervación simpática y la parasimpática tienen cada una su propia “red telegráfica”, como podremos ver en los esquemas de la inervación a continuación.

En el ámbito de este libro es importante comprender esta “rienda nerviosa” de nuestro organismo, dado que cada célula de nuestro cuerpo está guiada por estas riendas. Lo vemos en la simpaticotonía permanente durante la fase de reparación PCL. Parece que sea suficiente una única “línea” telegráfica parasimpática.

La correspondiente “estación de clasificación”, los denominados ganglios, se distribuyen desde la garganta hasta la pelvis. Parece que esta “red telegráfica” tiene dos líneas de las que, dicho de un modo aproximado, una corre

paralelamente a la “línea telegráfica” parasimpática, es decir, de la médula espinal; la otra línea telegráfica es la hormonal-nerviosa:

Tálamo – hipófisis – tiroides

Tálamo – hipófisis – células insulares (alfa y beta)

Tálamo – hipófisis – corteza subrenal

9.2. Parasimpaticotonía o vagotonía y simpaticotonía

En la vieja medicina clásica no sabíamos bien como encuadrar los conceptos de parasimpaticotonía o vagotonía y simpaticotonía. Todo lo llamábamos sistema nervioso vegetativo.

Si alguien no conseguía dormir, tenía los nervios alterados o si siempre estaba cansado hablábamos de “distonía vegetativa”.

Durante este tiempo con la Nueva Medicina, la simpaticotonía y la vagotona se han convertido en conceptos fundamentales, dado que sabemos que todos los programas especiales, biológicos y sensatos, si les sigue una solución del conflicto biológico, se producen con este ritmo de dos fases.

Con este propósito, queridos lectores, tendréis suficiente información en el capítulo sobre la segunda ley biológica natural.

Pero el ritmo vegetativo diferente, que en el pasado fue definido como las riendas con las que Madre Naturaleza guía a cada individuo, no existe sólo en los programas EBS, sino que también la normotonía tiene dos fases.

Excluyendo a unas pocas especies animales, los denominados “cazadores nocturnos”, la fase diurna es la fase de estrés simpaticotónica (que en verano empieza hacia las 3 y en invierno alrededor de las 5), la fase nocturna es la fase de relajación o reposo = fase vagotónica.

Los chinos las llaman yin y yang, donde el yin representa el principio femenino pasivo y el yang el masculino activo. En un sentido más amplio se podría considerar el principio femenino como la vagotonía y el principio masculino yang como la simpaticotonía.

En la mayor parte de las culturas y de las religiones se conocen dualismos parecidos. Sin embargo estos jamás se entendieron como científicamente biológicos.

De hecho cualquier comparación cojearía: en casi todas las culturas la noche representa la oscuridad, el frío y la muerte, mientras que el día representa la vida, la luz y el calor. En la naturaleza sin embargo en la noche hay reposo, calma, vagotonía; de día estrés y conflictos, a excepción, como hemos dicho, de los “cazadores nocturnos”, que tienen el ritmo cambiado, al igual que los animales que cazan.

La naturaleza misma tiene en cuenta el hecho de que los animales de presa que se encuentran en la fase PCL (con un DHS) pueden dormir sólo hacia las 3 o 4 de la mañana, cuando clarea, de modo que no sean sorprendidos y matados por los cazadores nocturnos en la oscuridad, mientras duermen.

Vamos a crear una nueva expresión para este encenderse y apagarse biológico:

el ritmo biológico ondulatorio.

Tanto la normotonía como la bifasicidad del programa especial, biológico, sensato son variaciones de este ritmo biológico ondulatorio, que en mi opinión es el motor originario de la vida.

Si saltamos la primera parte de la creación de Madre Naturaleza hasta las primeras células haploides, entonces podemos decir: a las primeras células haploides les sucede la simpaticotonía según el esquema del paleoencéfalo para “redoblar” internamente y volverse células diploides, que erróneamente en biología consideramos siempre como las primeras células (ver el capítulo sobre las reglas biogenéticas fundamentales). Con esta primerísima célula haploide no se entiende el óvulo o el espermatozoide, que se unen en la célula diploide fecundada.

Dentro del gran ritmo biológico ondulatorio de la multiplicación celular según el esquema del paleoencéfalo con simpaticotonía transcurren las “pequeñas ondas biológicas”, porque toda “multiplicación celular interna” en el orden cromosómico cuádruple como fase simpaticotónica está seguida de una división celular o separación de los grupos de cromosomas dobles como fase vagotónica.

La “gran onda biológica” está presente, como en el caso de una solución de conflicto, en el embarazo, por ejemplo en una madre y en su niño al final del tercer mes de embarazo con la división en vagotonía de las células embrionales, siempre según el esquema del paleoencéfalo y de la siguiente segunda parte (vagotónica) de la “onda biológica” con multiplicación celular según el esquema del neoencéfalo.

El lector que esté interesado puede encontrar estos argumentos en el capítulo de las reglas biogenéticas fundamentales contenido en este libro.

Aquí es obligado indicar que en la naturaleza prácticamente todo sucede en esta forma de ondas, según este “ritmo biológico ondulatorio”, motor originario de la vida.

Por medio del ritmo biológico ondulatorio toda la vida sobre la tierra está conectada con:

Onda del ritmo de una vida, onda del ritmo anual, onda del ritmo mensual y onda del ritmo de día.

Se añaden los pequeños ritmos a ondas inmanentes, que se entrecruzan entre ellos en toda la naturaleza.

Los hombres nos consideramos ya muy buenos por ser capaces de hablar por teléfono sin hilos, mediante las ondas de radio en el globo terrestre.

Pero sabemos desde hace mucho tiempo que dos cerebros pueden comunicarse entre ellos incluso sin ayuda de medios técnicos (la denominada telepatía) y sabemos incluso que el hombre y el animal pueden no sólo cambiar entre ellos ondas pertenecientes a la propia especie, sino también con otras razas y

especies. Sustancialmente toda la naturaleza, incluidas las plantas, es un único, enorme bosque de antenas de envío y recepción. Todos los individuos envían y reciben.

Ritmo biológico ondulatorio

lturen steht Nacht für Wärme. In der Natur Tag Streß und Kon- ern“ absieht, die einen Dem trägt die Natur se befindlichen Beute- hr, wenn es hell wird, unkelheit im Tiefschlaf

nen neuen Begriff prä-

us

des Sinnvollen Biologi- s Biologischen Wellen- st meiner Meinung der

Schöpfung von Mutter e, dann können wir sa- icotomie nach Althirn- zur diploiden¹⁴⁴ Zelle zu ogie als die erste Zelle rundregeln). Mit dieser Samen- zelle gemeint, die

aus der Zellvermehrung en die „kleinen Biologi- g“ auf den vierfachen erfolgt von einer Zelltei- zes als vagotone Phase. t einer Konfliktlösung in l mit dem Ende des 3 ung der Keimbahnzellen nde 2. (vagotonen) Teils Großhirn-Schema.

ze im Zellkern von Orga-

Diese Dinge kann der daran interessierte Leser im Kapitel über die Bioge- netischen Grundregeln in diesem Buch nachlesen. Hier geht es mir haupt- sächlich darum zu zeigen, daß in der Natur praktisch alles in dieser Wellen- form, diesem „Biologischen Wellen-Rhythmus“, verläuft, dem Urmotor des Lebens.

Über den Biologischen Wellen-Rhythmus ist alles Leben dieser Welt mit- einander vernetzt: zum

Lebenswellen-Rhythmus, Jahreswellen-Rhythmus, Monatswellen- Rhythmus und Tageswellen-Rhythmus

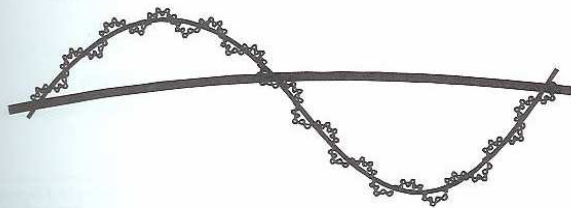
kommen die immanenten kleinen Wellen-Rhythmen hinzu, die die gesamte Natur miteinander vernetzen.

Wir Menschen kommen uns schon sehr klug vor, wenn wir drahtlos über Radiowellen miteinander um den Erdball herum telefonieren können.

Aber wir wissen ja längst, daß auch zwei Gehirne (sog. Telepathie!) ohne technische Hilfsmittel miteinander kommunizieren können. Und wir wissen auch, daß Mensch und Tier nicht nur die Wellen der Angehörigen ihrer eigenen Art miteinander austauschen können, sondern auch die anderer Ras- sen und Arten. Ja, im Grunde ist die ganze Natur, einschließlich der Pflan- zen, ein einziger riesiger Wald von Sender- und Empfängermasten.

Alle Individuen senden und alle empfangen.

Der Biologische Wellen-Rhythmus



Betrachten wir jetzt die sog. vegetative Innervation des Menschen, so sehen wir, daß die sympathicotone Innervation durch den Grenzstrang des Sympathicus verläuft, dagegen die parasympathische (= gegen-sympathische) oder vagotone Innervation durch den Nervus Vagus, den 10. Kopfnerv.

Observemos ahora la denominada inervación vegetativa del hombre y veremos que

la inervación simpaticotónica transcurre a través del tronco del nervio simpático,
por el contrario
la inervación parasimpática o vagotónica pasa a través del nervio vago, el décimo nervio craneal.

Las dos inervaciones ya habían encontrado su colocación bajo el aspecto evolutivo, y precisamente en el exterior de la médula espinal, cuando se llegó a la rotura tan significativa de la estructura de anillo de nuestros “antepasados”.

Durante el proceso evolutivo la musculatura estriada migrada, el epitelio pavimentoso y la mucosa epitelial han migrado en la porción intestinal expelente (recto). Tras la ruptura de la estructura a anillo no teníamos ninguna inervación, dado que la inervación originaria de las partes de músculos y piel migrada con estos fue interrumpida.

A partir del quinto segmento lumbar toda la inervación de las “partes migradas” tenía que ser inervada de nuevo a través de la médula espinal. Por eso con una parálisis de fractura espinal estas partes (esfínter anal y vejiga, musculatura del cuello del útero y musculatura vaginal, así como la musculatura de las ampollas rectales y de la vejiga y las correspondientes mucosas de epitelio pavimentoso sensible) se paralizan, mientras que todo el tracto gastro-intestinal permanece inervado simpáticamente y parasimpáticamente a través del tronco del simpático y el vago, porque su inervación no se produce a través de la médula espinal. (Ejemplo: la anestesia epidural afecta sólo a la sensibilidad del cuello del útero y vagina sin afectar a la peristalsis uterina).

En la simpaticotonía y la parasimpaticotonía (=vagotonía) hay que hacer una distinción:

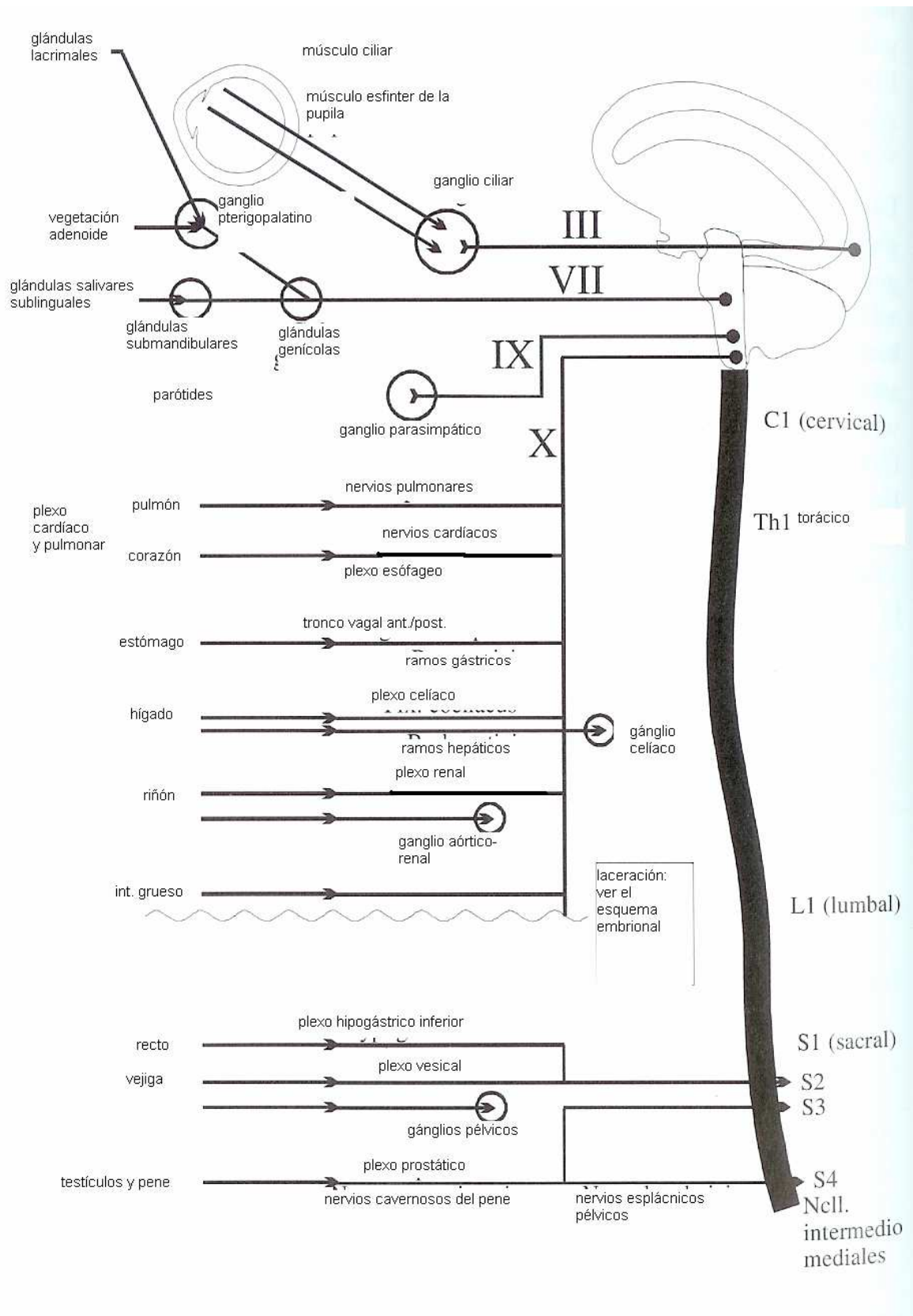
simpaticotonía	vagotonía
órganos directos del paleoencéfalo	
reposo, actividad reducida del tracto gastro-intestinal y de sus órganos correspondientes	actividad aumentada, por ej.: mayor peristalsis mayor secreción mayor absorción mayor asunción de alimentos y digestión sueño
órganos directos del neoencéfalo	
aumento del estrés, lucha por la existencia, el organismo está despierto. Todos los órganos directos del neoencéfalo tienen un mayor metabolismo, siempre están en alerta. El organismo, respecto al ambiente que lo rodea, está listo para las máximas prestaciones.	Reposo de las prestaciones máximas. Relajación y regeneración de todos los órganos directos del neoencéfalo en el sueño y en el reposo. Sólo las funciones de control más importantes (oído, olfato...) están todavía activas para anunciar que el enemigo se acerca.

Aunque desde los primerísimos grados evolutivos hasta los estadios de desarrollo actuales la simpaticotonía y la parasimpaticotonía han permanecido siempre iguales, sus funciones se han hecho del todo diferentes con la evolución de las funciones cerebrales en el curso del tiempo mediante el desarrollo del neoencéfalo, para el paleoencéfalo y los órganos directos de éste: proliferación celular en fase activa, mientras que para el neoencéfalo y los órganos directos de él: proliferación celular en fase de reparación.

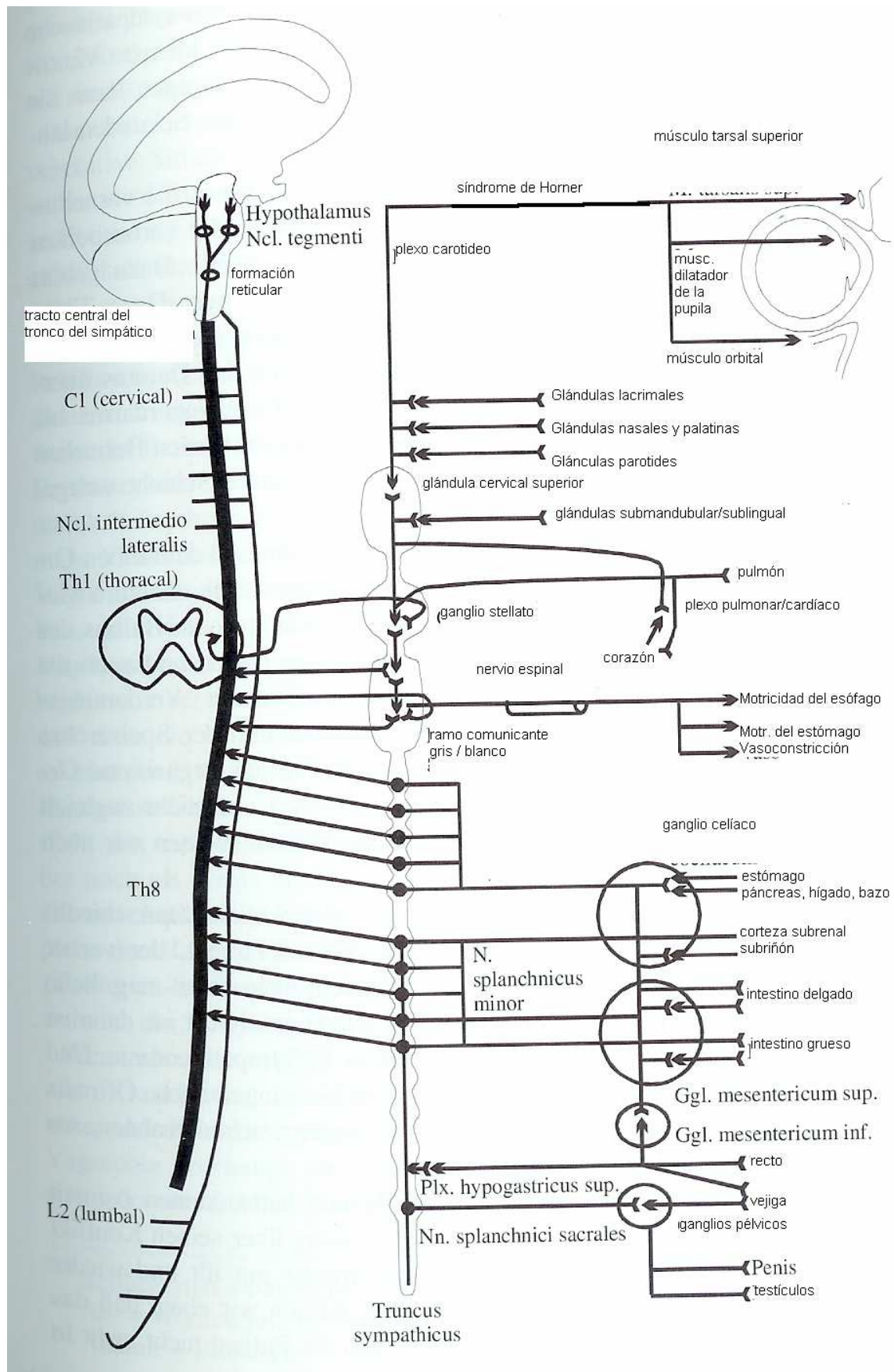
Estas importantes correlaciones son difíciles de entender para muchos, mucho más porque han rechazado la llave de los conocimientos de la Nueva Medicina. Estos conocimientos deberían realmente poner fin a las insensatas prácticas farmacológicas polipragmáticas de la actual medicina oficial o de estado, donde en caso de emergencia no se debe renunciar a los remedios realmente importantes según el experto, por lo que si un médico demasiado celoso quiere “hacer un intento de curación con las medicinas”, preguntémosle: ¿Dónde tiene que funcionar su fármaco, en la simpaticotonía o en la parasimpaticotonía (= vagotonía)? ¿Y sobre que parte cerebral?.

Normalmente no sabe que responder, ya que él mismo no toma nunca medicinas, como se a comprobado en innumerables investigaciones.

9.3. El sistema nervioso parasimpático



9.4. El sistema nervioso simpático



La "red telegráfica" del simpático en el hombre y en los animales superiores, está construida a la perfección, porque en caso de necesidad de fuga, por motivos de defensa o por un ataque, la transmisión de la información nerviosa a nivel del simpático tiene que funcionar instantáneamente. Cualquier retraso conllevaría como consecuencia la muerte del individuo. Por el contrario la relajación o el reposo tras la lucha se puede retrasar un par de segundos.

En nuestro organismo hay órganos y sistemas de órganos que sirven sobretodo para recuperar las fuerzas, para reconstruir las energías consumidas, mediante la organización de refuerzos "al frente". A estos pertenece por ejemplo el tracto gastro-intestinal.

Aunque originariamente este tracto gastrointestinal se extendiese desde la boca hasta el ano, en el proceso evolutivo ha sido recubierto parcialmente por la mucosa ectodérmica de la cavidad oral y del perineo, y hoy se extiende sólo desde la extremidad del duodeno hasta 12 cm por encima del ano. Sin embargo en estas regiones crecidas sobre el viejo epitelio adenointestinal se ha conservado todavía en profundidad como estrato de subucosa.

También las inervaciones opuestas pueden estimular el mismo órgano, por ejemplo el estómago: la inervación simpática, que puede causar la úlcera de la mucosa gástrica del epitelio pavimentoso, en la pequeña curvatura y en el bulbo del duodeno y al mismo tiempo la inervación (principal) parasimpática, que permite una peristalsis regular de digestión. La situación es análoga en el hígado y en el esófago y en la mayor parte de los otros órganos. No sabemos todavía con precisión si hay órganos individuales o grupos de órganos que son activados sólo por una rinda, y no frenados al mismo tiempo por la otra rinda.

Sin embargo para nuestro análisis es muy importante conocer las diferentes funciones de estas riendas. Por ejemplo, si un paciente, que antes tenía buen apetito, estaba en vagotonía, de repente ya no quiere comer, y si come vomita, esto significa que su esófago está como estrangulado, es decir, ya no está en vagotonía, sino de nuevo en simpaticotonía. Y en 9 de cada 10 casos es víctima de un conflicto de pánico. A menudo se puede intuir donde ha afectado el conflicto de pánico cuando conocemos el órgano que ha reaccionado principalmente.

O si un paciente, que antes tenía las manos heladas, no tenía apetito y por la noche no conseguía dormir, sino que pensaba continuamente en su conflicto, de repente tiene las manos calientes, come de nuevo y duerme bien, y está cansado y abatido, entonces sabemos que el sistema nervioso vegetativo ha invertido la marcha y que el paciente ya no está en simpaticotonía, sino que se encuentra de nuevo en parasimpaticotonía o vagotonía.

Para el buen médico las dos situaciones tienen consecuencias terapéuticas inmediatas. En el primer caso sabe que tiene que intentar resolver el conflicto del paciente lo antes posible, si es posible, en el segundo sin embargo, tiene que ocuparse de las complicaciones del proceso de curación.

Siempre es de importancia decisiva la condición de inervación del sistema nervioso vegetativo o la situación vegetativa que hoy en día no se considera jamás en el historial clínico. Y dado que hasta ahora no se le ha dado jamás ninguna importancia, tampoco se han desarrollado los métodos para valorar la diferente condición de inervación.

En la discusión sobre la leucemia veremos que se puede establecer la relación del volumen de eritrocitos respecto al plasma sanguíneo mediante el número de eritrocitos por milímetro cúbico y con el hematocrito, pero con este método no se puede determinar la cantidad total de eritrocitos. Sería grave si el paciente, en normotonía, durante la fase leucémica (vagotónica) tuviese “sólo” un valor de eritrocitos de dos millones por milímetro cúbico y un hematocrito con plasma/volumen de los eritrocitos del 17%. Sin embargo si se calcula que el paciente en la vagotonía ha aumentado dos o tres veces su volumen sanguíneo, entonces el valor de la cantidad total resulta efectivamente normal. Obviamente todos los pacientes en vagotonía están cansados y abatidos. Si se siente así también el paciente “leucémico”, entonces se dirá que está cansado y abatido a causa de la anemia.

Se ha llegado a resultados faltos de sentido propio por el hecho de que la vagotonía no se reconoce en su diversidad como fase de reparación, sino que se considera como una enfermedad.

Sucede lo mismo para la mayor parte de los síntomas vegetativos: en el pasado la fiebre era algo normal en muchas enfermedades infecciosas. Hoy, por el contrario, se tiene que combatir con antibióticos. En realidad es un síntoma cerebral del proceso de curación, signo de un edema cerebral, muy lejos de derivar de “productos del metabolismo bacterial”, cualquiera puede, por lo tanto, imaginarse a que nivel ha trabajado la “medicina sintomática” hasta ahora.

El ritmo vegetativo entre tensión y reposo, día y noche, actividad conflictiva y fase PCL de la reparación, tiene dimensiones todavía mayores: se inserta en ciclos rítmicos más grandes, como el ciclo lunar, ciclo anual de las estaciones y ciclo de la vida. Además los grandes ritmos se modifican de vez en cuando por la influencia de los planetas y de los grandes astros, sobretudo del sol.

Los hombres siempre han comparado la mañana con un niño apenas nacido, y lo mismo se dice de la primavera. Correspondientemente se han imaginado la tarde y la noche, el otoño y el invierno, como el final de la vida. En medio se encuentra el punto culminante de la vida, la fuerza creativa, la procreación, todo el denominado suceso del hombre. Si transferimos la imagen de estos ritmos vegetativos en su sustancia a las relaciones de intervención de la “enfermedad cancerosa”, entonces la fase simpaticotónica, de conflicto activo, es efectivamente una fase de fuerza potenciada y concentrada con la que se afronta un problema de un modo intensificado. El organismo abarca todos los registros y hace proceder todo a pleno ritmo para superar el conflicto reuniendo fuerzas.

Cuando del mismo modo un general guía su ejército reuniendo las fuerzas contra el ejército enemigo, esto se considera inteligente. Si nuestro organismo hace lo mismo, nosotros, aprendices de brujo, consideramos que esto es una enfermedad. El hecho de que de noche podemos descansar del trabajo y del estrés del día, el hecho de que los animales en invierno estén aletargados hasta la primavera, todo eso se considera normal. Pero ninguno entiende el hecho de que nuestro organismo, cuando ha luchado durante meses a causa de un conflicto, con todas sus fuerzas, hasta las de reserva, tras la solución de ese difícil conflicto, necesita incluso varios meses de reposo y de tranquilidad, y también esto se considera una enfermedad.

En sustancia nuestra “enfermedad cancerosa” es “sólo” un ritmo vegetativo, durante mucho tiempo, muy sensato y necesario, del cual la naturaleza nos muestra el modelos.

El modelo del ritmo vegetativo es un principio natural.

10. El descubrimiento de los FOCOS DE HAMER – un compendio histórico

Desde que existe la tomografía cerebral computerizada se consigue individuar en el cerebro los aglomerantes de tejido glial que también se pueden colorear bien con los medios de contraste; en este caso normalmente el diagnóstico ya está declarado: tumor cerebral.

En 1982, es decir, un año después del descubrimiento de la Nueva Medicina, conseguí encontrar ya preventivamente un Foco de Hamer (FH) de enormes dimensiones en un paciente con un conflicto de territorio en la fase de reparación y un infarto cardíaco durante la crisis epileptoide. Desde entonces supe que no existen tumores cerebrales, sino que estos fenómenos tienen que ser todos correlatos de la fase de reparación de un suceso conflictivo biológico.

Tras haber observado con mucha precisión los Focos de Hamer (la expresión la fijaron mis opositores, que con desprecio han llamado estas formaciones que yo encontré en el cerebro “estos extraños Focos de Hamer”), estuve pronto en posición de reconocer aquellos de los que podía seguir la supuesta formación desde el inicio de la fase de reparación. Y dado que ya había descubierto la ley de las dos fases de la enfermedad, sabía naturalmente que todo proceso de la fase de reparación conlleva también un proceso de conflicto activo.

La desgracia ha hecho que en muchos pacientes los Focos de Hamer en la fase de reparación se reparasen mediante la acumulación de células gliales (tejido conectivo). Esto va acompañada por una mayor rigidez del tejido, pero no provoca molestias hasta que el organismo no enferma de nuevo con un conflicto en el mismo punto.

Se me presentaban dificultades enormes:

1. En el caso del cáncer (entonces me concentré en esta enfermedad porque creía que había descubierto solamente los mecanismos del origen del cáncer) no era la costumbre hacer una tomografía computerizada del cerebro, excepto si existían los motivos justificados para suponer “metástasis cerebral”. En este caso particular fue mucho más difícil hacer que aceptaran hacer una TAC del cerebro. Dado que la tomografía computerizada entonces era extremadamente costosa, eran afortunados los que conseguían tener una serie de TAC.
2. Al inicio intenté recomponer la topografía de los Focos de Hamer en el cerebro, lo que resultó muy difícil porque cuando se nota algo en el cerebro eso puede ser también un viejo proceso ya terminado que no tiene nada que ver con el suceso conflictivo actual del paciente. Además no sabía si el paciente tenía otros carcinomas que hasta ahora no habían sido

diagnosticados, lo que era posible por los procesos nuevos o por conflictos biológicos totalmente actuales.

3. Encontré amplios conflictos con contenido análogo, de los que hoy sé que habían invadido varios relés con un único Foco de Hamer, es decir, el paciente había sufrido uno o más conflictos que tenían aspecto conflictivo diferente y todos habían golpeado al paciente en el mismo instante del DHS y se habían recogido en un gran Foco de Hamer.

Además había también pacientes que habían activado al mismo tiempo varios Focos de Hamer en puntos completamente diferentes del cerebro. Todos estos focos, sin embargo, tenían una cosa en común, tenían que encontrarse en fase de reparación cuando el paciente mostraba, correspondientemente, todos los síntomas de la fase PCL de conflicto resuelto.

4. Para todos estos Focos de Hamer en la fase de reparación tenía que haber ahora en el cerebro alguna formación que se pudiese ver con aparatos y que fuese correspondiente a tal conflicto en la fase activa. Algunas veces vi esos cercos con forma de anillos concéntricos que, sin embargo los radiólogos a los que se preguntó solucionaron diciendo con una sonrisilla que eran artefactos circulares del aparato. Había estructuras semicirculares, tanto algunas que estaban delimitadas por la hoz como otras que parecían delimitadas desde el borde lateral de la TAC.
5. La colaboración de los radiólogos no sirvió prácticamente para nada. Muchos de ellos tenían un irradiador y aplicaban la denominada "radioterapia". Los que un día fueron mis colegas no podían permitirse tomar, ni siquiera de lejos, en consideración la posibilidad de que mis resultados fuesen correctos. Los otros (entonces no había muchos radiólogos que tenían un aparato para TAC) me decían sin medios términos que en el momento en el que declarasen correctas las teorías de Hamer ya no habrían recibido ningún encargo de las clínicas. Cuando se les encargaba una TAC cerebral, normalmente era para encontrar un "tumor cerebral" o "metástasis cerebral".
6. Dado que no poseía mi propio aparato de TAC, no tenía ni siquiera la posibilidad de realizar las indagaciones sistemáticas o de repetir los exámenes en un ángulo diferente. Solamente nos llegaba lo que "caía de la mesa de los señores", y no era mucho. A menudo sucedía que las tomografías computerizadas no se daban a los pacientes. Y el informe escrito, por sí solo, no servía para mucho.
7. Conocía los Focos de Hamer, y los que consideraba como tales, y sabía sin embargo que pertenecían a la fase de reparación. Postulé que estos FH tenían que estar presentes ya en la fase de conflicto activo, lo cual fue refutado por los radiólogos: "Señor Hamer, aquí no vemos nada".
8. Veía muchos Focos de Hamer, pero no podía individuar ningún cáncer, si se trataba por ejemplo de relés motores, sensoriales y periostio-sensoriales en el cerebro, que no producen ningún cáncer a nivel orgánico, pero que pueden representar una enfermedad oncoequivalente. Sin embargo yo todavía no había pensado en estas enfermedades, sino sólo en el cáncer. Y entonces me sucedió a menudo que tenía muchos más Focos de Hamer de los que buscaba y en los casos en los que el paciente tenía sólo una actividad conflictiva y todavía ninguna solución de su conflicto, no se encontraba nada.

A menudo sucedía que el paciente tenía un enorme tumor y en la tomografía del cerebro no se encontraba “nada”. Otros tenían un pequeño tumor, que estaba en fase de reparación y en el cerebro había un gran Foco de Hamer.

No me quedaba otra que seguir el desarrollo de cada científico y, como cualquier buen artesano, con 99% de “sudores” y un 1% de inspiración, comparar todas las tomografías cerebrales que pudiera obtener de cualquier modo, junto con los informes orgánicos correspondientes, con otras TAC cerebrales que tenían a su vez otros referentes orgánicos.

Al inicio se añadió otra dificultad por el hecho de que no conocía la diferencia entre diestros y zurdos, así que, como supe seguidamente, habría caído en el error todavía más a menudo si no hubiese partido del órgano. La correlación del órgano al cerebro o del cerebro al órgano siempre es unívoca.

Solamente en la correlación entre psique y cerebro o cerebro y psique es importante el ser zurdo o diestro.

Un ejemplo: las hemorroides las puede tener tanto una mujer diestra con un conflicto de identidad en la fase de reparación como un hombre zurdo con un conflicto de rencor en el territorio en fase de reparación. Sin embargo si veo en el lado izquierdo del cerebro, en un punto preciso en el lóbulo temporal izquierdo un Foco de Hamer con edema, entonces el paciente tendrá hemorroides o la reparación de la úlcera del epitelio pavimentoso rectal. Viceversa, si el paciente tiene una úlcera de la mucosa rectal en la fase de reparación, es decir, hemorroides, entonces en el cerebro en el punto del lóbulo temporal izquierdo tendrá siempre un FH con edema en fase de reparación.

Conseguí aprender a distinguir finalmente entre cáncer y enfermedades oncoequivalentes tras muchos miles de TAC del cerebro, después de establecer la correcta ubicación o la topografía correcta respecto al órgano. Subrayo también que para muchas funciones corporales, como por ejemplo la sensibilidad del periostio, que se extiende a todo nuestro sistema esquelético, había solamente una enorme laguna en el mapa cerebral y en el mapa de los órganos, porque no se podía examinar bien. En ningún tratado médico se habla de sensibilidad del periostio.

10.1. Los presuntos artefactos en forma de anillo en la tomografía cerebral computerizada erróneamente interpretados por los radiólogos durante casi 20 años.

Todavía persiste la discusión sobre los denominados artefactos en forma de anillo, que existen realmente pero que entonces había visto sólo una vez cada cien pacientes, y a los que consideré Focos de Hamer con configuración de anillos concéntricos, es decir, en fase de conflicto activo. Los supuestos artefactos en anillo, a los que di una respuesta falsa, salvo unas pocas excepciones bien evidentes, y que considero FH con configuración concéntrica, han sido negados

siempre como realidad efectiva por parte de los radiólogos, siendo considerados por el contrario artefactos, es decir, productos artificiales de los aparatos.

Durante años se intentó un acercamiento a estos fenómenos. Al final me vino una buena idea por la que se volvió útil el estudio de física que realicé durante 12 semestres.

Me presenté para pedir un favor al jefe del departamento de tomografía computerizada de la empresa Siemens, el señor Feindor. Tuvimos una agradable conversación, en el curso de la cual le pedí si podíamos establecer juntos los criterios que se debían satisfacer para poder determinar con precisión un artefacto en anillo y cuando con seguridad se tenía que excluir. El señor Feindor es ingeniero y no tuvimos ningún problema para establecer las condiciones que se tienen que satisfacer en este o aquel caso. Esto sucedió el 18.5.90. El 22.5.90 se firmó el informe definitivo. Desde entonces ha estallado un verdadero pánico entre los neuroradiólogos. Sacamos conclusiones del tema cuando preparamos una serie de test en la Siemens en la segunda mitad del año.

Documento de la firma Siemens.

Erlangen, 22.12.1989

Estructuras dudosamente denominadas en anillo/artefactos en la TAC cerebral.

Los abajo firmantes han elaborado los siete criterios siguientes que excluyen la presencia de los denominados artefactos en anillo.

Por lo tanto, un artefacto en anillo no existe jamás

1. cuando en la imagen de resonancia magnética correspondiente es visible una formación en anillo evidentemente parecida.
2. cuando los anillos no son circulares, sino "magullados", es decir, aparecen visiblemente compresiones del tejido que está alrededor.
3. cuando una formación circular tiene evidentes acumulaciones de glia.
4. cuando el anillo o los anillos no son perfectamente concéntricos, respecto al aparato ("configuración concéntrica paracentral").
5. cuando aparecen varios círculos juntos, como mucho una formación en anillo puede ser un artefacto.
6. cuando las formaciones en anillo tienen un transcurso "clínico-radiológico", eso significa que en las sucesivas TAC de control son visibles siempre en el mismo punto, pero modificadas.

7. los artefactos que dependen del aparato son estructuras en forma circular o en forma de segmento circular concéntrico al aparato. Si tales estructuras corresponden a una verdadera realidad anatómica, recomendamos repetir el escáner con el paciente en posición lateral o más levantado. Si la estructura no aparece en el nuevo tomograma, por lo que respecta a las estructuras características, propias del paciente, no nos encontramos frente a ningún artefacto.

Siemens S.A.

Borrador para otro documento común relativo a un estudio proyectado sobre una serie de TAC en pacientes voluntarios, que presentaban estructuras circulares en la TAC cerebral, cuya actuación, sin embargo, fue impedida (ver texto).

Erlangen, 18.05.90

Asunto: estructuras en anillo, formaciones circulares, configuraciones concéntricas o Focos de Hamer en la TAC cerebral.

La firma Siemens y el Dr. Hamer constatan las siguientes correlaciones físicotécnicas:

Los firmantes han elaborado ya los siguientes 9 criterios el 22.12.89, que excluyen la presencia de los denominados artefactos en anillo.

Por lo tanto un artefacto en anillo no existe jamás:

1. cuando en la imagen de resonancia magnética correspondiente es visible una formación en anillo evidentemente parecida.
2. cuando los anillos no son circulares, sino "magullados", es decir, aparecen visiblemente compresiones del tejido que está alrededor.
3. cuando un cerco tiene fenómenos secundarios anulares visiblemente edematizados ("anillos edematizados").
4. cuando el anillo o los anillos no son perfectamente concéntricos, respecto al aparato ("configuración concéntrica paracentral").
5. cuando una formación circular tiene evidentes acumulaciones de glia.
6. cuando aparecen varios círculos juntos, como mucho una sola formación en anillo puede ser un artefacto.
7. cuando las formaciones en anillo tienen un transcurso "clínico-radiológico", eso significa que en las sucesivas TAC de control son visibles siempre en el mismo punto, pero modificadas.
8. tampoco estamos frente a un artefacto si las formaciones circulares son visibles sólo sobre una parte de los estratos de la TAC, pero faltan en los otros estratos.

9. los artefactos que dependen del aparato son estructuras en forma circular o en forma de segmento circular concéntrico al aparato. Si tales estructuras corresponden a una verdadera realidad anatómica, recomendamos repetir el escaner con el paciente en posición lateral o más levantado. Si la estructura no aparece en el nuevo tomograma, por lo que respecta a las estructuras características, propias del paciente, no nos encontramos frente a ningún artefacto.

Le pedí al director Feindor que me diese la posibilidad de realizar, con el aparato de la Siemens en Erlangen, una serie de test que se prolongarían durante cuatro semanas más o menos. Seguidamente habría invitado a un cierto número de neuroradiólogos que, junto con la Siemens, habrían tenido que confirmar que los casos presentados no podían ser artefactos, sino hechos reales.

La fecha prevista para esta conferencia se postergaba continuamente, hasta que un día un responsable de la firma Siemens me dijo en confidencia: "Señor Hamer, hemos encontrado las peores dificultades con los radiólogos". Ya habían declarado su desaprobación.

Para la preparación de esta conferencia habíamos hecho todas las investigaciones posibles, acordadas previamente con la Siemens, como por ejemplo desplazar al paciente e el examen de TAC desde la posición central de dos cm hacia la izquierda o desplazarlo nuevamente 2 cm hacia la derecha para ver si la configuración concéntrica siempre permanecía en la misma posición en el cerebro, lo que sucedía de hecho. O intentamos hacer con el mismo paciente controles progresivos a intervalos lo más regulares posibles, según las posibilidades con aparatos diferentes para verificar que desarrollo tomaba la configuración concéntrica.

Constituía un criterio seguro para un informe auténtico el hecho de que la configuración concéntrica apareciese sólo en un cierto número de estratos y en otros nunca.

En todos estos exámenes, que requirieron mucho tiempo y fatigas y muchos buenos consejos por parte de los radiólogos, encontramos una cosa totalmente sorprendente: un radiólogo dijo una vez que había visto estos anillos concéntricos también en los órganos y que realmente se tenía que tratar de artefactos.

Desde aquel momento en adelante se despertó mi interés por esas configuraciones concéntricas, que sin embargo normalmente eran visibles sólo al inicio del desarrollo patológico, y eventualmente eran visibles después en el hueso, cuando se recalcificaba. Se evidenció el hecho sorprendente de que el cerebro y el órgano se correspondían entre ellos en la configuración concéntrica y que esta tenía un determinado curso también en el órgano. Casi vemos por ejemplo en el hígado la clásica configuración concéntrica sólo en la fase inicial del adenocarcinoma hepático solitario.

Seguidamente el adenocarcinoma hepático solitario se vuelve oscuro en la tomografía, sin que se pueda reconocer ninguna configuración concéntrica.

En la reparación natural por medio de la TBC vemos indicios de anillos calcáreos, particularmente si no se había llegado a la caseificación total, es decir, una caverna o agujero en el hígado, sino si el adenocarcinoma hepático había

permanecido a medio camino y el carcinoma solitario sólo había sido eliminado parcialmente por la necrosis caseosa por la TBC ("cavidad esponjosa").

10.2. El cerebro central y el cerebro del órgano

Si se observa bien toda la cuestión, vemos que por una parte hay un cerebro central, conocido por todos, y por otra parte están las células de los órganos que tienen cada una su propio núcleo. Todas las células de los órganos están comunicadas entre sí e igualmente cada núcleo de las células, podríamos decir que su minicerebro está conectado con todos los otros minicerebros del cuerpo.

Podemos considerar la suma de estos pequeños cerebros como un segundo cerebro. Eso significaría entonces que en el caso de un conflicto biológico una región del cerebro central, que llamamos Foco de Hamer, se encuentra en correspondencia con otra región del cerebro del órgano, que hasta ahora hemos llamado cáncer o enfermedad oncoequivalente o alteración del órgano.

En el caso de un estímulo sensorial, por ejemplo, el cerebro del órgano envía informaciones al cerebro central y, al revés, con una respuesta motora el cerebro central envía informaciones y órdenes al cerebro del órgano.

Todavía no sabemos que sucede con precisión bajo el aspecto electrofisiológico en cada célula del cerebro y de los órganos o en las regiones o relés afectados, pero esta indagación no constituye una premisa para nuestro trabajo clínico en presencia de estos hallazgos.

10.3. El Foco de Hamer en la fase CA y en la fase PCL

Con el DHS se señala en el cerebro el centro del relé pertinente y precisamente con una denominada configuración concéntrica. Entorno al centro de este relé se forman cercos bien visibles, que llamamos cercos concéntricos y parecen una diana; estos indican que el Foco de Hamer se encuentra en la fase de conflicto activo.

El área activada no es casual, sino que se trata del relé del ordenador-cerebro que es correlativo al correspondiente contenido conflictivo en el instante del DHS; este Foco de Hamer a partir del mismo instante del DHS producirá el cáncer o la enfermedad oncoequivalente en el órgano correlativo. Con el progreso del conflicto también el Foco de Hamer avanza en el cerebro, es decir, viene afectada un área cada vez más grande o la ya afectada se modifica, es decir, el tumor se vuelve más voluminoso a causa de una auténtica mitosis celular (tanto en la hoja embrional interna como por la parte directa del cerebelo de la hoja embrional media), "más grande" por la necrosis (en la parte directa de la médula cerebral de la hoja embrional media), más grande por la úlcera, más alargado a causa de muchas pequeñas úlceras (por la hoja embrional externa).

En mi primer obra de 1984 "Cáncer- Enfermedad del alma, cortocircuito en el cerebro...", consideré este Foco de Hamer en la fase de conflicto activo todavía

como un cortocircuito, porque no conocíamos los procesos bioeléctricos. Hoy en día ya no lo llamo así, porque por cortocircuito entendemos en general una alteración del programa. Pero en el caso del Foco de Hamer esto es verdad sólo en parte. Podemos decir que es una alteración del programa normal que, sin embargo, el organismo ya sabe que tiene que afrontar.

Pero la palabra alteración no es en cualquier caso la más adecuada, porque se trata de una especie de programa especial o de emergencia. Es decir, cuando el individuo es cogido a "contrapié", inesperadamente, en una situación que no había previsto, empieza el programa de emergencia de llamamos conflicto biológico y que tiene por misión llevar al individuo al ritmo normal.

Este programa de emergencia no se refiere sólo al individuo, sino que comprende de vez en cuando varios, por cuanto puede referirse a una familia o una estirpe.

Un ejemplo: una madre asiste al accidente de su hijo de tres años, que se queda inconsciente ante sus ojos. Eso para la madre es un DHS que desencadena un conflicto biológico muy preciso, es decir, de preocupación madre/niño. Este conflicto biológico tiene un significado sensato y particular en los tres niveles: a nivel psicológico el pensamiento y la acción se concentran en el hecho de que el niño vuelva a estar sano. A nivel cerebral, si la mujer es diestra, en el cerebelo lateral derecho vemos un Foco de Hamer en forma de diana que nos muestra que está activo el conflicto madre/niño. A nivel orgánico vemos crecer el tejido de las glándulas mamarias de la mujer y madre.

El pecho izquierdo aumenta con una cierta cantidad de tejido mamario, que se utiliza en la producción de leche. Si están presente, se multiplican sincrónicamente las micobacterias de la TBC.

En la naturaleza o en los pueblos primitivos, una mujer edad en edad fértil está prácticamente siempre en condiciones de amamantar, excepto durante el último período del embarazo. Casi la madre produce en el pecho relativo al niño más leche que antes. Con esto se consigue que el niño reciba más leche y por lo tanto tiene la posibilidad de curarse más rápidamente. Cuando el niño está de nuevo sano, comienza la solución del conflicto, es decir, las células de las glándulas mamarias excedentes ya no son necesarias porque ahora al niño le basta con la cantidad normal de leche. La consecuencia es que durante al amamantamiento se origina una tuberculosis de tal manera que el niño prácticamente recibe leche tuberculosa que sin embargo no lo daña. La tuberculosis caseifica las células mamarias de nueva producción y las elimina. Queda una caverna. Justo todo este proceso es lo que llamamos ahora un programa especial, biológico, sensato y previsto y deseado por la naturaleza.

Pero ¿qué son estos Focos de Hamer en el cerebro?

Cuando son bien visibles, es decir, ya en la fase de reparación, los neuroradiólogos los llaman tumores cerebrales o metástasis cerebral; cuando se ven menos claramente, levanta perplejidad; cuando muestran un edema perifocal muy fuerte y el Foco de Hamer se puede colorear, se consideran como tumores cerebrales de crecimiento rápido; cuando forman un gran edema, incluso aunque no sea visible el Foco de Hamer, como sucede normalmente con los FH de la médula, de nuevo causan un gran revuelo; cuando se encuentran a lo largo de la

corteza cerebral, se malinterpretan como tumores de la meninge. Sustancialmente siempre son la misma cosa: sólo son estadios diferentes de la evolución de un Foco de Hamer.

Los Focos de Hamer en la fase de conflicto activo, es decir en las configuraciones concéntricas, sono estados hasta ahora malinterpretados como artefactos de los aparatos. Cuando seguidamente se vuelven edematosos y por lo tanto clasificados como tumores cerebrales, el radiólogo normalmente no se toma la molestia de constatar que estos presuntos tumores cerebrales ya eran visibles antes bajo la forma de configuración concéntrica, es decir, como Foco de Hamer en la fase de conflicto activo.

Desde que la firma Siemens y yo hemos firmado el documento incluido en este capítulo, la discusión sobre supuestos artefactos debería estar definitivamente concluida. Se trata de hechos verdaderos: las formas de diana indican la fase de conflicto activo en un determinado relé o en un grupo de relés del cerebro.

Por definición no existen tumores cerebrales: las células cerebrales tras el nacimiento ya no pueden multiplicarse más, por ninguna razón, y menos en las condiciones que hasta ahora se han interpretado erróneamente como tumores cerebrales. Lo que puede multiplicarse es el inocuo tejido conector glial del cerebro que tiene justo la misma función del tejido conector del cuerpo.

Nadie puede colocar con precisión la formación histológica en la historia evolutiva de las células de tejido glial. El modo en el que se comportan en el cerebro hace sospechar que sean de origen mesodérmico. Esto se evidencia por el hecho de que la acumulación de tejido glial se produce siempre durante la fase de reparación en los relés cerebrales. Por otra parte sabemos que los neurofibromas se originan en la fase de conflicto activo, es decir, que causan proliferación celular. Pero esta no es una contradicción, porque de hecho sabemos que entre los órganos mesodérmicos están tanto los órganos directos del cerebelo como los directos de la médula cerebral. Los primeros tienen la proliferación celular en la fase de conflicto activo y el segundo grupo en la fase de reparación. Tenemos que suponer, por lo tanto, que los gliomas poseen las dos capacidades del mesodermo.

Estos focos de Hamer hiperdensos, con acumulación de tejido glial con reparaciones del organismo sobre el mismo foco, motivo de alegría en lugar de miedo o incluso de una intervención quirúrgica cerebral.

Recorramos de nuevo toda la serie: con un DHS en el cerebro se señala el "centro de relé relativo" y entonces se tiene el Foco de Hamer en formación concéntrica. Apenas vemos en la TAC esta configuración concéntrica en un determinado relé sabemos que en este relé está en curso un programa especial, es decir, el organismo ha sido "cogido a contrapié" en esa esfera conflictiva de cerebro y órgano y ha activado un programa especial.

Este programa especial hace que el organismo pueda afrontar la situación imprevista que puede afectar no sólo al paciente como individuo, sino eventualmente también a su grupo biológico (estirpe, familia, etc.). La actividad conflictiva, es decir, la configuración concéntrica en el cerebro dura hasta que se resuelve la situación conflictiva y el organismo puede regresar a la normalidad. Antes de poderlo hacer, sin embargo, el organismo tiene que pagar por el hecho de que el programa especial se ha producido con una especie de cortocircuito,

que representa un tipo de programa de emergencia. El precio es la fase de reparación, el proceso de curación en los niveles psíquico, cerebral y orgánico para volver cuanto antes posible a la condición óptima precedente. Sólo cuando esta ha sido añadida con la fase de reparación en los tres niveles, el organismo puede realmente volver a la normalidad.

Podemos suponer que el relé cerebral esté involucrado hasta que en el Foco de Hamer subsiste el programa especial en forma de configuración concéntrica, de fase de conflicto activo, llamada también simpaticotonía permanente.

Podemos imaginarnos que es como si una cantidad de corriente demasiado grande con una tensión demasiado alta se metiese en una línea de baja tensión. La línea, naturalmente se recalienta, sobretodo a causa del aislamiento.

En la bioelectricidad las cosas son ligeramente diferentes y tenemos que imaginar las células del cerebro dispuestas como en una red infinitamente complicada. A través de la simpaticotonía permanente, que en principio está prevista, las líneas de comunicación de los nervios cerebrales sufren un daño creciente (por sobrecarga), así como el órgano en el cuerpo a causa del cáncer se agranda o en cualquier caso se modifica para poder hacer frente a la nueva situación imprevista.

Hasta el final de la fase de conflicto activo en el Foco de Hamer, al menos por lo que respecta a la TAC, no sucede nada visiblemente inquietante, excepto el hecho de que permanece constantemente presente la configuración concéntrica. En la resonancia magnética, por ejemplo, podemos ver que hay una diferencia mínima respecto al tejido de alrededor.

La realidad es, por el contrario, muy diferente y podemos calcular los daños sólo cuando se verifica la conflictolisis. Ahora en la fase PCL es posible valorar todo el daño, porque justo con el comienzo de la fase PCL el organismo comienza a reparar los daños de este programa especial, tanto con multiplicación celular como con reducción celular a nivel orgánico y también con la reparación del relé cerebral afectado.

Resumiendo sistemáticamente, tras un DHS sucede lo siguiente en los tres niveles de nuestro organismo:

A nivel psíquico:

a) fase de conflicto activo (fase CA):

simpaticotonía permanente, es decir, máximo estrés. El paciente piensa día y noche en su conflicto e intenta resolverlo. No duerme y si lo hace es sólo durante la primera mitad de la noche, a períodos de media hora, adelgaza, no tiene apetito.

b) Fase de conflicto resuelto (fase PCL):

Se tranquiliza. La psique tiene que descansar. El paciente se siente cansado, pero tiene buen apetito, el cuerpo está caliente, a menudo con fiebre, a menudo con dolores de cabeza. Los pacientes duermen bien, pero en general

a partir de las tres de la mañana. Este mecanismo lo produce la naturaleza de modo que el individuo en vagotonía duerma sólo cuando comienza el día, para no ser sorprendido durante el sueño por un peligro potencial (por ejemplo un depredador). Los pacientes duermen mucho y gustosamente de día.

A nivel cerebral:

a) Fase de conflicto activo (fase CA):

Configuración concéntrica en el correspondiente Foco de Hamer (ver tabla), lo que significa que aquí está en curso un programa especial.

b) Fase de conflicto resuelto (fase PCL):

El Foco de Hamer se repara con la formación de edema y se acumula tejido glial en la región del relé afectado. De este modo se retoma la situación precedente, cosa importante para los sucesivos conflictos, pero el precio es que el tejido es menos elástico que antes. (Eventuales complicaciones causadas por el edema cerebral se tratan en el capítulo de la terapia).

A nivel orgánico:

a) Fase de conflicto activo (fase CA):

Correspondientemente a la tabla y al esquema del sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes en la fase de conflicto activo se produce o una proliferación celular, que biológicamente tiene un sentido totalmente particular, o una necrosis celular, es decir, una reducción celular o un agujero, que tiene un sentido especial bajo el perfil biológico. El sentido está en el hecho de que esta situación empredista, que llamamos conflicto biológico, puede ser resuelta con la ayuda de la modificación orgánica que se produce. Por ejemplo, el sentido biológico de una úlcera del íntima de las coronarias consiste en el hecho de que en la fase de conflicto activo las arterias coronarias se dilatan de modo que pueda correr la mayor cantidad de sangre aumentando así la fuerza y la resistencia del individuo. Una multiplicación de las células de la glándula mamaria, por ejemplo, tiene como fin ofrecer más leche al niño que ha sufrido un accidente de modo que pueda sanar en breve tiempo. Al mismo tiempo en las enfermedades directas del paleoencéfalo (hoy llamadas programas especiales, biológicos y sensatos) se multiplican las micobacterias).

b) Fase de conflicto resuelto (fase PCL):

Se produce la reparación por medio de necrosis caseosa del tumor por acción microbica o con reparación de las úlceras gracias a la proliferación microbica (ver tabla y esquema del sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes). Tanto en el cerebro como en el órgano encontramos siempre edema como signo del proceso de reparación en curso. En los órganos directos del paleoencéfalo, al final de la fase de reparación, el parenquima empequeñecido a causa de las cavernas se multiplica alrededor de esta masa de tejido produciendo células que permanecen. Es decir: al final de una tuberculosis del hígado o del adenocarcinoma hepático precedente, el

hígado es nuevamente tan grande como antes, tiene tantas células como antes (fenómeno de Prometeo).

Seguidamente mostraremos una serie de esquemas y una serie de típicos Focos de Hamer en diferentes fases para aclarar mi exposición a la luz de estos ejemplos.

10.4. Esquema del cerebro

ismus ist von
erst schlafen,
Raubtier) sie
Tage sehr viel

en Herd (siehe

und im betrof-
vorhergehende
st für spätere
r elastisch ist,
em werden in

schen Systems
-aktiven Phase
z bestimmten
ein Loch, das
besteht darin,
ir den biologi-
erung, die vor-
inn nach sorgt
Phase die Ko-
urch die Koro-
s Individuums
llen z.B. dient
gesundheit des
ig werden bei
che Sonderpro-

biellen Abbau
riff genommen,
s der Tumoren
rn als auch am

Organ das Oedem als Zeichen der Heilung. Bei den althirn-gesteuerten Organen vermehrt sich am Ende der Heilungsphase das durch die Kavernen verkleinerte Parenchym um eben diese Gewebemasse mit bleibenden Zellen. D.h.: am Ende einer Leber-Tuberkulose bzw. vorangegangenen Leberkrebs, ist die Leber wieder genauso groß, hat gleich viele Zellen als sie vorher hatte (Prometheus-Phänomen).

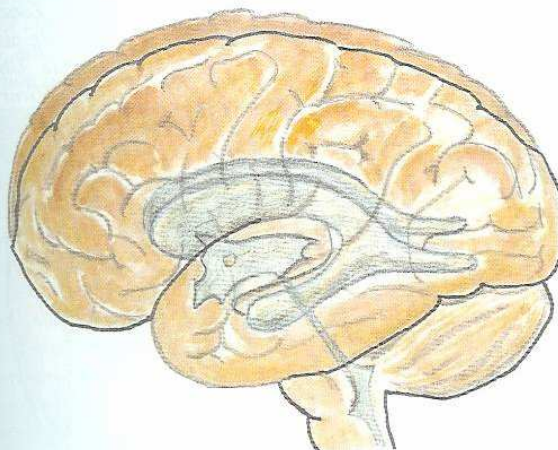
Im nachfolgenden sollen eine Reihe von Schemata und eine Reihe typischer Hamerscher Herde in verschiedenen Phasen gezeigt werden, um meine Ausführungen anhand von Beispielen zu belegen.

10.4 Gehirn-Schemata

Das Hirn von der linken Seite aus gesehen, und zwar so, als wenn die Hirnsubstanz quasi durchsichtig wäre und man durch die Hirnsubstanz die Hirnventrikel oder Hirnkammern sehen könnte. Wir sehen im Zentrum die beiden Seitenventrikel, die miteinander in Kommunikation stehen durch den 3.

Ventrikel, den wir darunter sehen. Vom 3. Ventrikel kann der Liquor cerebrospinalis¹⁵⁴ abfließen durch den Aquädukt¹⁵⁵ in den 4. Ventrikel, den wir unten in Höhe des unteren Pons¹⁵⁶ und der oberen Medulla oblongata¹⁵⁷ sehen.

Die Seitenventrikel bestehen aus den Vorderhörnern (frontal), den Hinterhörnern (occipital) und den Unter- oder Temporalhörnern, die rechts und links außen in die Temporallappen verlaufen. Das ganze Ventrikelsystem ist in Kommu-



¹⁵⁴ Liquor cerebrospinalis = Flüssigkeit von Hirn und Rückenmark

¹⁵⁵ Aquädukt = „Wasserführer“, also eine Art Wasserleitung

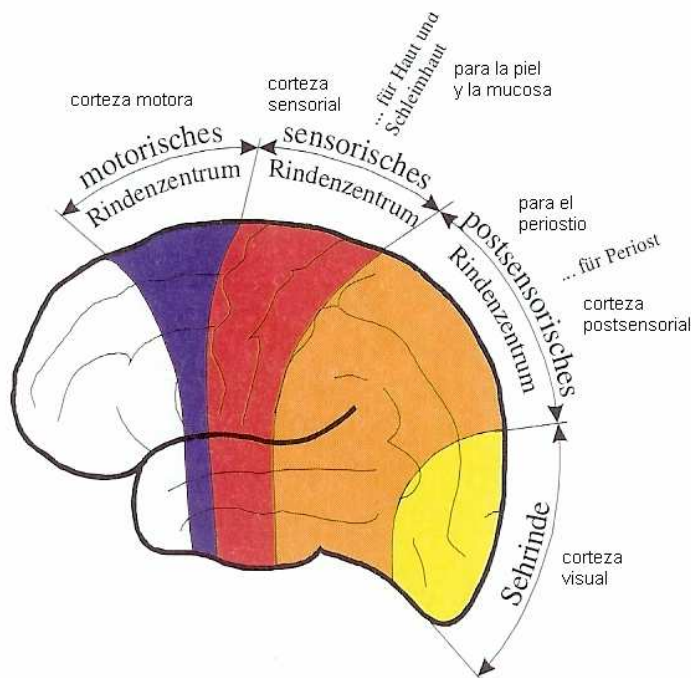
¹⁵⁶ Pons = Hirnteil (deutsch: Brücke), dessen Namen sich der Laie nicht merken muß

¹⁵⁷ Medulla oblongata = das 'verlängerte Mark'

El cerebro visto desde el lado izquierdo y justo como si la materia cerebral fuese casi transparente y se pudiese ver el ventrículo cerebral o la cavidad cerebral a través de esta materia. En el centro vemos los dos ventrículos laterales que están en comunicación entre ellos mediante el tercer ventrículo, que se ve abajo. El líquido puede correr desde el tercer ventrículo a través del acueducto al cuarto ventrículo que vemos abajo, a la altura del puente (tronco cerebral) inferior y de la médula superior.

Los ventrículos laterales consisten en cuernos anteriores (frontales), cuernos posteriores (occipitales) y cuernos inferiores (temporales), que van hacia el exterior a la derecha y a la izquierda en los lóbulos temporales. Todo el sistema de ventrículos está comunicado. Si el acueducto se comprime por un proceso expansivo en el mesencéfalo o en el puente, el líquido se estanca en el sistema ventricular desde el primer al tercer ventrículo causando una denominada hidrocefalia interna. Si un Foco de Hamer durante la fase de reparación tiene un proceso expansivo en el neocórfalo, normalmente comprime sólo el ventrículo lateral adyacente. En la leucemia infantil a menudo todo el sistema ventricular de los primeros tres ventrículos está comprimido (a causa del edema de la médula generalizado) de tal manera que sólo con grandes dificultades podemos reconocer los ventrículos en la TAC cerebral.

ZONAS DE LA CORTEZA CEREBRAL



La imagen de la izquierda presenta las denominadas circunvoluciones cerebrales actualmente usadas a nivel internacional, que en cuanto a lóbulos cerebrales tienen transiciones graduales. Aquí vemos la corteza cerebral del lado izquierdo. El lado izquierdo contiene siempre, en los zurdos y en los diestros, el relé para: dotes excretores tiroideos, laringe, orificio y cuello del útero, vagina, recto, vejiga femenina, así como los relés motores y sensoriales del lado derecho del cuerpo. El lado derecho contiene siempre, en los zurdos y en los diestros, los relés de los arcos branquiales, los bronquios, las arterias coronarias, la mucosa epitelial de la pequeña curvatura del estómago y del bulbo del duodeno, de los conductos biliares y pancreáticos y los relés de la vejiga masculina, además de los relés motores y sensoriales del lado izquierdo del cuerpo.

or cerebrospina-
Rückenmarkska-

ke (Stammhirn)
kelsystem des 1.
rnus. Macht ein
Raumforderung,
ntrikel. Bei der
der ersten drei
er-Oedem), daß
können.

gibt die derzeit
gebräuchlichen
Hirnwindungen
Hirnlappen flie-
ge haben. Hier
von der linken
n.

ite enthält bei
ntshändern stets

ge, Kehlkopf,
d und -hals,
, weibliche Bla-
motorischen und
lais für die ge-
Körperseite.

ite enthält bei
ntshändern stets
terien, Magen-
llengänge, Pan-
sorischen Relais

Photographie eines Hirnmo-
dels, an dem man sehr schön
die Verhältnisse erkennen
kann. Balken, Zwischenhirn,
Pons (Stammhirn) und Klein-
hirn sind in der Mitte durch-
geschnitten.

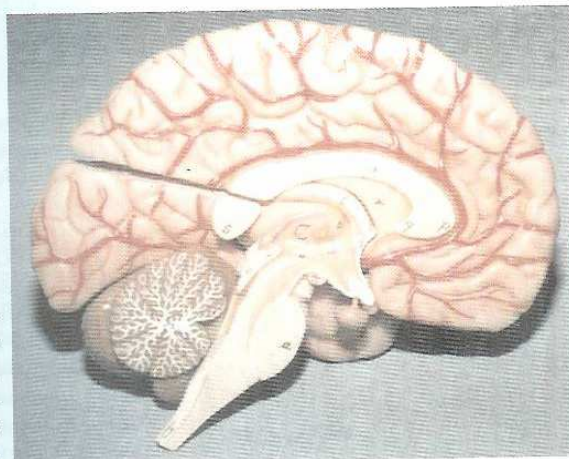
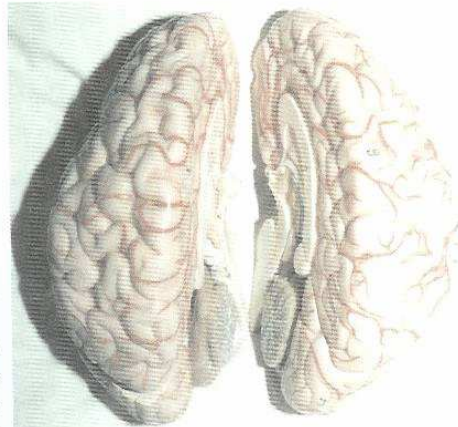
Aber man erkennt grob, daß
der Cortex (Hirnrinde) auch
zwischen den Großhirn-
Hemisphären (interhemisphä-
risch) bis zum Balken besteht.
Dort ist z.B. die motorische
und sensorische Innervation
für die Beine. Man sieht auch
gut, daß die Sehrinde hinter
dem Kleinhirn fast bis zum Boden des Kleinhirns reicht.

Das Gehirnmodell
von der Mitte ge-
sehen.

Das nach unten
offene, von oben
und vorne unten
eingefasste weiße
Gebilde ist der sog.
„Balken“.

Von hier ab nach
unten sind die
rechte und linke
Gehirnhälfte mit-
einander verbun-
den. Wir sehen also
quasi einen Mittel-
schnitt durch das Gehirn des Menschen.

Der klaffende Spalt occipital (hinten) auf dem unteren Bild links, zeigt etwa die
Grenze der Sehrinde (nach unten). Der gesamte Bereich zwischen motorischen
Rindenzentrum und Sehrinde ist sensorischer und postsensorischer (Periost-
Sensibilität) Bereich, bzw. seitlicher Revierbereich. Man sieht daraus, welche
biologische Bedeutung die Trennungs-Konflikte haben!



Fotografía de un modelo cerebral en el que se puede reconocer muy bien la situación global.

El cuerpo calloso, el diencéfalo, el puente (tronco cerebral y el cerebelo aparecen en sección transversal.

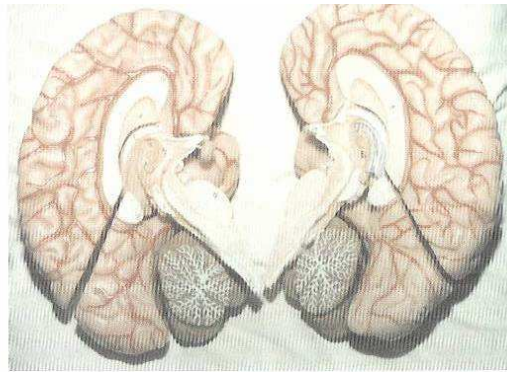
Se puede distinguir a grandes rasgos que la corteza cerebral se extiende también entre los hemisferios cerebrales (intrahemisféricamente) hasta el cuerpo calloso.

Allí hay, por ejemplo, inervación motora y sensorial para las piernas. Se ve muy bien que el relé de la retina llega hasta casi el cerebelo.

El modelo cerebral visto en la parte mediana. La estructura blanca abierta hacia abajo, curvada hacia delante hacia abajo es el denominado "cuerpo calloso". A partir de aquí hacia abajo la mitad cerebral derecha e izquierda están conectadas entre sí. Vemos una especie de sección mediana a través del cerebro humano.

La fisura abierta occipitalmente (posteriormente) a la izquierda en la imagen, muestra el límite del área visual (abajo).

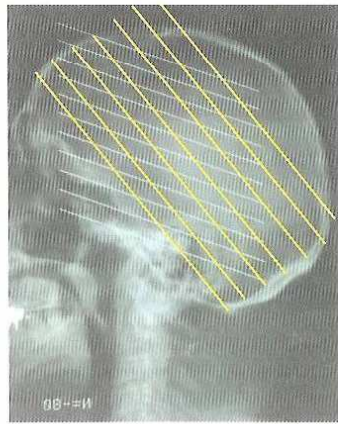
Todo el área entre el centro cortical motor y el relé de la retina es el área sensorial y postsensorial (sensibilidad del periostio), o el área lateral de los conflictos de territorio. Por la extensión de esta área podemos entender la importancia biológica que tienen los conflictos de separación.



frontal das Zuckerzentrum und noch weiter frontal das (Zahnschmelz-) Beiß-Zentrum und die frontalen Ängste.

... sind beide Hirnhälften auseinandergeklappt, in der Mitte quasi die weiß erscheinenden Anteil durchgeschnitten. Besonders gut zu sehen die interhemisphärische Großhirnrinde, in der die Relais für Motorik und Sensorik der Beine gelegen sind.

10.4.1 Unsere Gehirn-CT-Schnitte



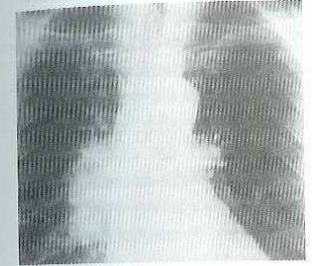
Mit den modernen Untersuchungsmethoden, z.B. des Computertomogramms, können wir quasi in das menschliche Gehirn hineinschauen, indem wir das Gehirn schichtweise untersuchen. Man kann beliebige Schichten einstellen und fotografieren, meist waagerechte und senkrechte. Das Bild nebenan zeigt die Standard-Schichten, die nahezu parallel zur Schädelbasis verlaufen (weiße Linien sind falsch, gelbe richtig).

Aus diesen verschiedenen Schichten erhält man eine Serie von Fotos, die die verschiedenen Hirnteile und etwaigen Hamerschen Herde zeigen.

10.5 Der erste Hamersche Herd

Rechts fronto temporal, im Revierangst-, Revier- und Revierärger-Relais in der erneuten Heilungsphase nach Rezidiv.

Oberer Pfeil links: in Lösung gehende Schießscheibe im Unterzuckerungs- und Überzuckerungs-Relais (Diabetes bis 500 mg % Blutzucker).



Bronchial-C

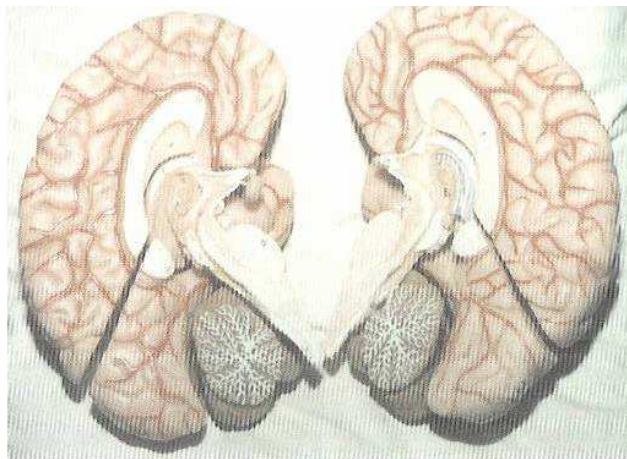
Der Patient, zu dem diese Bilder gehören, war spektiv einen später sog. „HAMERSchen HE am 6.4.83. Er hatte eigentlich ein Melanom an

Der Patient betrieb einen kleinen Supermarktfleischabteilung. Für die ortsansässigen Auge. Ein Konkurrent war darunter, der sich nährungsarzt verstand der im Ort die Kontrolle wurde nun laufend von diesem Veterinär schließlich soweit, daß er ihm ein Verfahren nach langem hin und her nicht klappte, wurde ein anderer übernahm diesen Bezirk für mehr keinen Ärger mehr.

Doch eines Tages, kurz vor Mittag, stand p rinärarzt in der Tür, und ohne sich umz Fleischabteilung. Als er den Patienten sah, sa ja immer noch da!“ Im Verlauf der Kontrolle draußen zum Kühlraum, dabei ließ er jedoch fen stehen. Als beide zurückkamen hatte sich eingeschlichen. Der Patient erstarrte vor Sch nur wortlos auf die Katze und sagte: „Die Fle Da geriet der Patient außer sich. Er rannte

En esta imagen las dos mitades cerebrales están una enfrente de la otra, con la parte central que parece casi blanca cortada por la mitad. Se ve particularmente bien la corteza cerebral intrahemisférica, en la que se encuentran los relés de la motricidad y la sensibilidad de las piernas, frontalmente el centro del azúcar y más adelante el centro del morder (esmalte dental) y los miedos frontales.

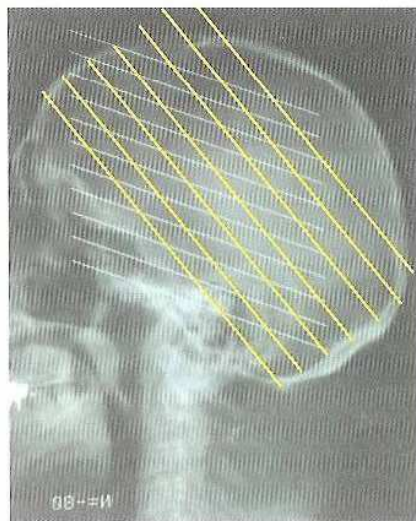
10.4.1 Nuestras tomografías cerebrales



frontal das Zuckerzentrum und noch weiter frontal das (Zahnschmelz-) Beiß-Zentrum und die frontalen Ängste.

... sind beide Hirnhälften auseinandergeklappt, in der Mitte quasi die weiß erscheinenden Anteil durchgeschnitten. Besonders gut zu sehen die interhemisphärische Großhirnrinde, in der die Relais für Motorik und Sensorik der Beine gelegen sind,

10.4.1 Unsere Gehirn-CT-Schnitte



Mit den modernen Untersuchungsmethoden, z.B. des Computertomogramms, können wir quasi in das menschliche Gehirn hineinschauen, indem wir das Gehirn schichtweise untersuchen. Man kann beliebige Schichten einstellen und fotografieren, meist waagerechte und senkrechte. Das Bild nebenan zeigt die Standard-Schichten, die nahezu parallel zur Schädelbasis verlaufen (weiße Linien sind falsch, gelbe richtig).

Aus diesen verschiedenen Schichten erhält man eine Serie von Fotos, die die verschiedenen Hirnteile und etwaigen Hamerschen Herde zeigen.

10.5 Der e

Rechts fronto temp
Revier- und Revi
erneuten Heilungs
Oberer Pfeil lin
Schießscheibe im
Überzuckerungs-K
500 mg % Blutzuc



Der Patient, zu
spektiv einen sp
am 6.4.83. Er ha

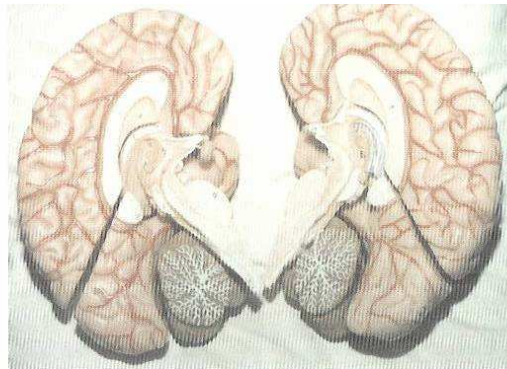
Der Patient b
Frischfleischabte
Auge. Ein Konk
närarnsarzt ver
wurde nun lau
schließlich sow
nach langem hin
ein anderer über
keinen Ärger me

Doch eines Ta
rinärarzt in de
Fleischabteilung
ja immer noch d
draußen zum K
fen stehen. Als
eingeschlichen.
nur wortlos auf
Da geriet der P

Con los modernos métodos de investigación, por ejemplo la tomografía computerizada, podemos prácticamente mirar en el cerebro humano explorándolo por estratos. Se puede fotografiar a placer los estratos, normalmente horizontalmente y verticalmente. La imagen de al lado muestra los estratos estándar que van casi paralelos a la base del cráneo (las líneas blancas son errores, las amarillas correctas).

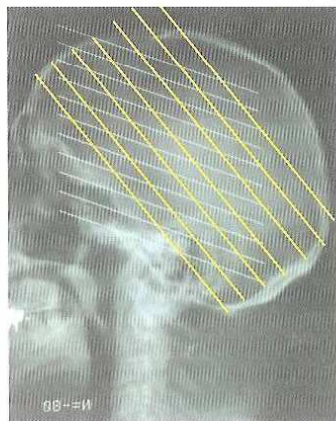
De estos diferentes estratos se obtiene una serie de fotografías que muestran las diferentes porciones cerebrales y los eventuales Focos de Hamer.

10.5. El descubrimiento del primer Foco de Hamer



frontal das Zuckerzentrum und noch weiter frontal das (Zahnschmelz-) Beiß-Zentrum und die frontalen Ängste.

10.4.1 Unsere Gehirn-CT-Schnitte



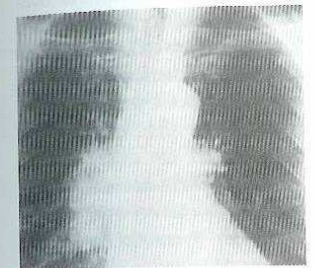
Mit den modernen Untersuchungsmethoden, z.B. des Computertomogramms, können wir quasi in das menschliche Gehirn hineinschauen, indem wir das Gehirn schichtweise untersuchen. Man kann beliebige Schichten einstellen und fotografieren, meist waagerechte und senkrechte. Das Bild nebenan zeigt die Standard-Schichten, die nahezu parallel zur Schädelbasis verlaufen (weiße Linien sind falsch, gelbe richtig).

Aus diesen verschiedenen Schichten erhält man eine Serie von Fotos, die die verschiedenen Hirnteile und etwaigen Hamerschen Herde zeigen.

10.5 Der erste entzündete Hirn

Rechts fronto temporal, im Revierangst-, Revier- und Revierärger-Relais in der erneuten Heilungsphase nach Rezidiv.

Oberer Pfeil links: in Lösung gehende Schießscheibe im Unterzuckerungs- und Überzuckerungs-Relais (Diabetes bis 500 mg % Blutzucker).



Bronchial-Ca

Der Patient, zu dem diese Bilder gehören, war spektiv einen später sog. „HAMERSchen HE am 6.4.83. Er hatte eigentlich ein Melanom an

Der Patient betrieb einen kleinen Supern Frischfleischabteilung. Für die ortsansässigen Auge. Ein Konkurrent war darunter, der sich nährungsarzt verstand der im Ort die Kontro wurde nun laufend von diesem Veterinär schließlich soweit, daß er ihm ein Verfahren a nach langem hin und her nicht klappte, wurde ein anderer übernahm diesen Bezirk für mehr keinen Ärger mehr.

Doch eines Tages, kurz vor Mittag, stand p rinärarzt in der Tür, und ohne sich umz Fleischabteilung. Als er den Patienten sah, sa ja immer noch da!“ Im Verlauf der Kontrolle draußen zum Kühlraum, dabei ließ er jedoch fen stehen. Als beide zurückkamen hatte sich eingeschlichen. Der Patient erstarrte vor Sch nur wortlos auf die Katze und sagte: „Die Fle Da geriet der Patient außer sich. Er rannte

A la derecha frontal-temporalmente en los relés de amenaza del territorio, lucha por el territorio y rencor en el territorio, vemos un Foco de Hamer en fase de reparación tras una recaída.

Flecha de arriba a la izquierda, forma concéntrica al comienzo de la fase de solución en el relé de la hipoglucemia y de la hiperglucemia (diabetes hasta 500 mg% de glucemia).

Adenocarcinoma bronquial en el lóbulo pulmonar derecho.

El paciente al que pertenecen estas imágenes fue la primera persona en la que busqué prospectivamente un “Foco de Hamer”, como se llamó a continuación, consiguiendo encontrarlo el 6/4/83. De hecho tenía un melanoma en el brazo izquierdo.

El paciente gestionaba un pequeño supermercado con un departamento de carne fresca que funcionaba bien. Para los carniceros de la zona eso era una espinita. Entre ellos había un carnicero que se llevaba muy bien con el veterinario encargado de realizar los controles de la zona. Por el contrario el paciente siempre tenía problemas con este veterinario. Al final la cosa empeoró hasta el punto de que el veterinario intentó que lo procesaran. Tras intentarlo sin éxito, este veterinario fue trasladado “por órdenes superiores” y otro ocupó aquella zona durante varios años. Desde entonces ya no hubo rencores.

Sin embargo un día, poco antes del mediodía, de repente, el primer veterinario se presentó en la puerta de casa y sin mirar atrás fue directamente al departamento de carne fresca. Cuando vio al paciente dijo literalmente “¿Cómo, todavía está usted aquí?”. Durante el control fue con el paciente a la cámara frigorífica, pero cuando salía dejó la puerta entreabierta. Cuando volvieron el gato del paciente se había metido. El paciente se quedó helado por el susto, el veterinario sólo señaló al gato y dijo: “El departamento de la carne está cerrado”. El paciente estaba fuera de sí. Corrió arriba a su apartamento, cogió una cámara (que no tenía película) y “disparó” el flash sobre el veterinario. El paciente había sufrido un conflicto de territorio, de rencor en el territorio y de amenaza en el territorio. Desde entonces de vez en cuando tiene molestias en el brazo izquierdo, que hay que masajear.

Descubrió una verruga que friccionó con aceite de ricino porque había leído en alguna parte que así se quitaban. Pero dado que la verruga se inflamó fue al dermatólogo, quien lo mandó a la clínica universitaria de dermatología. Diagnóstico: supuesto melanoma. Se le operó inmediatamente y también se le quitó un linfonodo por “prevención”. Ahí empezó su Odisea. Desde ese momento el paciente tenía una fijación con los “melanomas” y los producía continuamente, porque con cada nuevo melanoma y con cada operación se sentía nuevamente ensuciado y desfigurado, de tal manera que al final entró en un círculo vicioso.

Antes de venir a mí (a finales de enero del 83), tenían que amputarle el brazo. Sin embargo en el último control antes de la amputación le diagnosticaron un adenocarcinoma bronquial, que todavía no había sido descubierto en el control anterior en agosto. La amputación se suspendió.

Entonces ya sabía que el denominado adenocarcinoma bronquial es la fase de reparación de un conflicto de rencor en el territorio. En septiembre el paciente pudo finalmente alquilar su negocio a buen precio, después de que el inquilino que estaba entonces se fuera dejando mucho dinero pendiente.

Tras mi conferencia de marzo en el congreso de terapeutas en la sala Rheingold de Maguncia, en la que el paciente había participado, me preguntó si corría el

riesgo de un ataque apopléjico. Le dije que no se podía excluir. Catorce días después le ocurrió, tuvo un colapso en el baño de su casa, donde lo encontraron. Le llevaron al hospital, y allí sufrió otro conflicto porque fue lavado y atendido por un enfermero del que él paciente pensaba que era un guarro. Se disgustó y opuso resistencia. Los valores glucémicos subieron a 500 mg% y se normalizaron del todo sólo cuando el paciente regresó a casa a comienzos de mayo.

Conseguimos que le hicieran una TAC cerebral el 6-4-83. Cuando me enseñaron las imágenes, por un lado estaba orgulloso por haber predicho un suceso así con anterioridad. De hecho yo esperaba que se produjesen pequeñas modificaciones que fuesen responsables del melanoma, y algunas más grandes que podrían ser responsables del carcinoma bronquial. Pero con este enorme edema a la derecha temporalmente y a la izquierda paramedial-frontalmente no podía hacer mucho en realidad. Estaba perplejo.

En casos parecidos hay que trabajar como los buenos artesanos, hay que considerar todos los detalles que pudiesen ser pertinentes. Con este propósito la familia del paciente fue de gran ayuda. Por lo menos las secuencias cronológicas se habían producido como yo más o menos me imaginaba. Eso fue para mí la primera base.

Las configuraciones concéntricas en solución en el centro del azúcar a la derecha (diabetes) y a la izquierda (hipoglucemia) probablemente eran correlativas al hecho de que habían sustituido al enfermero. Todavía no sabía estas cosas y mucho menos que estuviese involucrado también el relé del dolor de dientes del “no poder morder”. Me concentré sobre el foco temporal derecho que me parecía reciente (la denominada “hemorragia cerebral”) con hemiparesis izquierda. Aquel foco pertenecía visiblemente a la historia precedente que tendría que ver todavía con los locales del negocio alquilado hacía poco. En este caso, nuevamente, sólo había intuido cual era la situación. Pero desde aquel momento supe cómo y dónde tenía que buscar. Y comenzó la búsqueda de las “agujas en el pajar”.

10.6. Ejemplo

d „beschoß“ regel-
 mitte wahrscheinlich
 evierangst-Konflikt
 linken oberen Arm,

einrieb, weil er ir-
 schwinden bringen
 mit zum Hautarzt,
 Verdacht auf Me-
 lärer Lymphknoten
 eine Odyssee. Denn
 laufend Melanome
 er Operation fühlte
 sich schließlich in

rm noch amputiert
 or der Amputation
 ontrolle im August
 itation abgeblasen.
 : Heilungsphase ei-
 it hatte im Septem-
 dem ein Vormieter

kerkongreß in der
 agte er mich, ob er
 ch sagte ihm, aus-
 m er wirklich einen
 ung, wo man ihn
 ort einen weiteren
 legt wurde, den er
 dagegen. Die Blut-
 h erst gänzlich, als

m 6.4.83. Als man
 ;, daß ich so etwas
 hatte winzig kleine
 wortlich sein, und
 sein könnten. Aber
 und links parame-

dian frontal konnte ich eigentlich nicht viel anfangen. Ich war ziemlich rat-
 los.

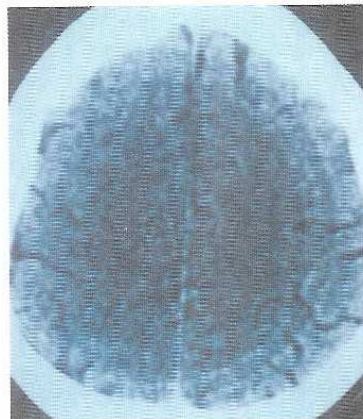
In solchen Fällen muß man als braver Handwerker arbeiten, muß alles zu-
 sammentragen, was dazugehören könnte. Dabei war die Familie des Patien-
 ten maximal kooperativ. Mindestens waren die zeitlichen Abfolgen ja unge-
 fähr so gewesen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das war für mich zu-
 nächst die Basis.

Die gerade in Lösung gehenden Schießscheiben im rechten (Diabetes) und
 linken (Unterzuckerung) Zuckerzentrum hingen wohl damit zusammen, daß
 der Pfleger ausgetauscht worden war. Solche Dinge wußte ich aber damals
 noch nicht, noch weniger, daß da auch das Zahnschmelz-Relais des Nicht-
 zubeißen-Dürfens mitbetroffen war. Ich konzentrierte mich auf den rechts-
 temporalen Herd, der mir frisch aussah (sog. „roter Schlaganfall“) mit
 Lähmung der linken Seite. Und der gehörte offenbar zu der Vorgeschichte,
 die wiederum mit den kürzlich vermieteten Ladenräumen zu tun haben
 könnte. Auch das habe ich damals mehr geahnt als gewußt. Aber von da ab
 wußte ich, wie und wo ich suchen mußte. Die Suche nach den vielen Steck-
 nadeln im Heuhaufen begann.

10.6 Fallbeispiele

*Typische Schießscheiben-
 Konfiguration eines HHs, d.h. ca-
 Phase im sensorischen Rindenzentrum
 mit dem Zentrum links paramedian
 liegend. Es betrifft eine sensorische
 Lähmung des rechten Beins und (etwas
 weniger) auch des rechten Arms.*

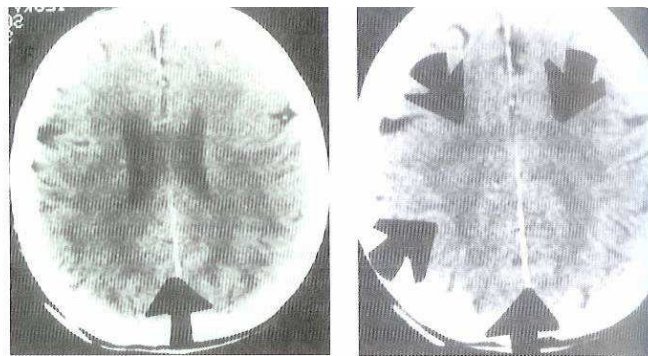
*Die Tatsache, daß die Schießschei-
 benringe auch auf die rechte Hirnseite
 hinüberreichen, sowie ins motorische
 Rindenzentrum und ins postsensorische
 (Periost betreffend) zeigt uns, daß auch
 die Sensibilität der linken Körperhäl-
 fe, sowie Motorik und Periost-
 Sensibilität beiderseits mitbetroffen
 sind.*



Típica configuración concéntrica de un FH, es decir, en fase CA en la corteza sensorial con el centro que se encuentra ala izquierda en posición paramediana provocando una parálisis de la sensibilidad de la pierna derecha y (un poco menos) también del brazo derecho.

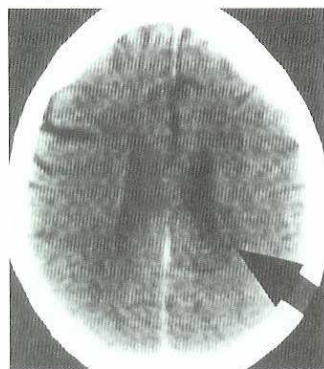
El hecho de que los anillos concéntricos se extiendan también por el lado cerebral derecho, así como en el centro cortical motor y en el postsensorial (afectando el periostio) nos muestra que también están afectadas la sensibilidad de la mitad

izquierda del cuerpo así como la motricidad y la sensibilidad del periostio de los dos lados del cuerpo.



Zwei HHle zentral im postsensorischen (für das Periost zuständigen) Rindenzentrum in der pcl-Phase. Die Schießscheibenringe sind oedematisiert, zeigen allmählich verlaufende Lösungsringe; der Beweis, daß es sich nicht um Artefakte gehandelt hat.

10.6.1 Fallbeispiel: Italienischer Gastarbeiter



Verschiedene Schichten einer CCT-Serie desselben Patienten. Der nebenstehende HH ist noch weitgehend in aktiver Phase, projiziert sich z.T. ins Marklager, gehört aber zum postsensorischen Rindenzentrum, (schmerzhafter Trennungs-Konflikt das Periost des linken Beins betreffend). Wir sehen schon einen Ring in Lösung gehen, d.h. der Konflikt ist also offenbar gerade ganz kurz vorher gelöst worden.

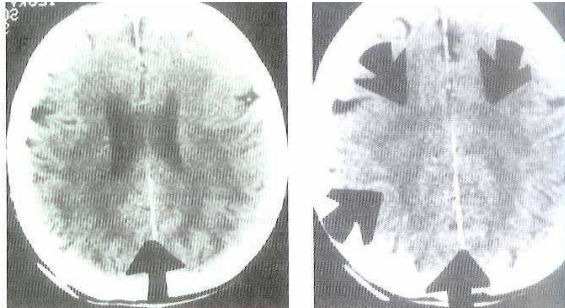
Man ist zunächst geneigt, an ein Artefakt (Kunstprodukt) des Apparates zu denken, jedoch kann ein Artefakt unmöglich oedematieren.

Es handelt sich um die Bilder eines italienischen Patienten aus Rom, der als Gastarbeiter in Südfrankreich arbeitete. Dieser hatte, wie das dort so üblich ist, in Rom nahe dem Flughafen Leonardo da Vinci angefangen ein Haus zu bauen. Ein Jahr später, als der Rohbau fast fertig war, kam die Baupolizei und ordnete die Stilllegung des Baus an. Der Patient erlitt einen Revierärger-Konflikt und Leber-Gallengangs-Ca. Doch nach einigen Tagen begann er nachts weiterzubauen. Da er jeweils nur im

Urlaub weiterbauen konnte, begann ein Katz-und-polizei. Viermal legte man ihm den Bau still, jedes Rezidiv. Aber er steckte das alles weg in Vorfreude Altersruhesitz. Und wirklich erreichte er vier Jahre Bußgeld sein Haus fertigstellen durfte, wie das. Durch die nun eintretende definitive Lösung bekam Schwellung, die Ärzte vermuteten eine Leber-Ca. diagnose erlitt der Mann ein Krebsangst (Frontal- bogengangs-Ulcera. Als er sich wieder einigermaßen im Februar des darauffolgenden Jahres zu einer Sitzung, was die Schulmediziner als Lymphknoten fe wurde ihm die Diagnose „metastasierendes Lebergeschleudert. Hierdurch erlitt der Patient einen ge nungs-Konflikt, den wir auf der hier vorliegenden können. Er zitterte am ganzen Leibe, hatte einen Konflikt und nahm rasch an Gewicht ab. Der Patient allem eine innerliche Lösung erreichen - die Lungen angst-Konfliktes gingen sogar leicht zurück. Aber stehen. Der alte Revierärger kehrte in Form eines Wegen seiner Erkrankung konnte er ja nun nicht Kinder „spurten nicht“, hatten keinerlei Interesse stellen und die Geldbuße zu zahlen. Es gab eine dr einandersetzung. Auch darüber kam der Patient noch kam es in der Heilungsphase zu einer Potenzierung noedeme, wodurch der Patient ins Koma fiel und i starb.

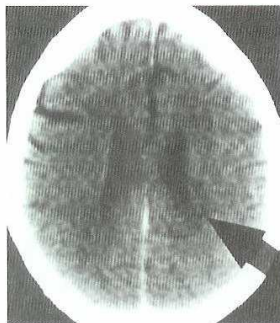
Dos FH centralmente en la corteza postsensorial (pertenecientes al periostio) en la fase PCL. Los anillos concéntricos están edematizados, muestras anillos en lenta solución, esto es la prueba de que no se trata de artefactos.

10.6.1. Ejemplo: un trabajador italiano emigrante.



Zwei HHs zentral im postsensorischen (für das Periost zuständigen) Rindenzentrum in der pcl-Phase. Die Schießscheibenringe sind oedematisiert, zeigen allmählich verlaufende Lösungsringe; der Beweis, daß es sich nicht um Artefakte gehandelt hat.

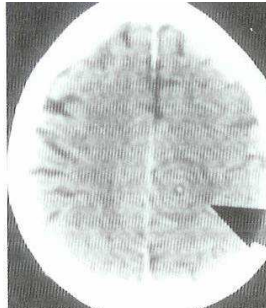
10.6.1 Fallbeispiel: Italienischer Gastarbeiter



Verschiedene Schichten einer CCT-Serie desselben Patienten. Der nebenstehende HH ist noch weitgehend in aktiver Phase, projiziert sich z.T. ins Marklager, gehört aber zum postsensorischen Rindenzentrum, (schmerzhafter Trennungskonflikt das Periost des linken Beins betreffend). Wir sehen schon einen Ring in Lösung gehen, d.h. der Konflikt ist also offenbar gerade ganz kurz vorher gelöst worden.

Man ist zunächst geneigt, an ein Artefakt (Kunstprodukt) des Apparates zu denken, jedoch kann ein Artefakt unmöglich oedematisieren.

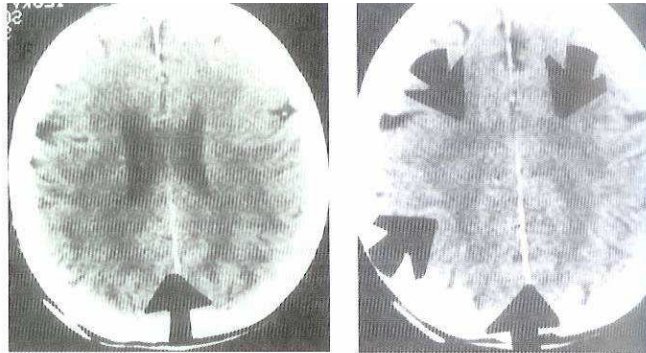
Es handelt sich um die Bilder eines italienischen Patienten aus Rom, der als Gastarbeiter in Südfrankreich arbeitete. Dieser hatte, wie das dort so üblich ist, in Rom nahe dem Flughafen Leonardo da Vinci angefangen ein Haus zu bauen. Ein Jahr später, als der Rohbau fast fertig war, kam die Baupolizei und ordnete die Stilllegung des Baus an. Der Patient erlitt einen Revierärger-Konflikt und Leber-Gallengangs-Ca. Doch nach einigen Tagen begann er nachts weiterzubauen. Da er jeweils nur im



Urlaub weiterbauen konnte, begann ein Katz-und-Mausspiel mit der Baupolizei. Vermal legte man ihm den Bau still, jedesmal erlitt er ein DR-Rezidiv. Aber er steckte das alles weg in Vorfreude auf seinen hübschen Altersruhesitz. Und wirklich erreichte er vier Jahre später, daß er gegen ein Bußgeld sein Haus fertigstellen durfte, wie das auch dort so üblich ist. Durch die nun eintretende definitive Lösung bekam der Patient eine Leberschwellung, die Ärzte vermuteten eine Leber-Ca. Durch diese Verdachtsdiagnose erlitt der Mann ein Krebsangst (Frontalangst)-DHS mit Kiemerring-Ulcera. Als er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, kam im Februar des darauffolgenden Jahres zu einer Schwellung in der Halsgegend, was die Schulmediziner als Lymphknoten fehldeuteten. Kurz danach wurde ihm die Diagnose „metastasierendes Leberkarzinom“ ins Gesicht geschleudert. Hierdurch erlitt der Patient einen gewaltigen brutalen Trennungskonflikt, den wir auf der hier vorliegenden Aufnahme gut erkennen können. Er zitterte am ganzen Leibe, hatte einen zusätzlichen Todesangstkonflikt und nahm rasch an Gewicht ab. Der Patient konnte jedoch trotzdem eine innerliche Lösung erreichen - die Lungenrundherde des Todesangst-Konfliktes gingen sogar leicht zurück. Aber das Leben blieb nicht stehen. Der alte Revierärger kehrte in Form eines Rezidiv-DHS zurück. Wegen seiner Erkrankung konnte er ja nun nicht mehr weiterbauen, so die Kinder „spurten nicht“, hatten keinerlei Interesse daran, den Bau fertigstellen und die Geldbuße zu zahlen. Es gab eine dramatische familiäre Auseinandersetzung. Auch darüber kam der Patient noch einmal hinweg. Jedoch kam es in der Heilungsphase zu einer Potenzierung der verschiedenen Leberschwellungen, wodurch der Patient ins Koma fiel und in völliger Vagotonie starb.

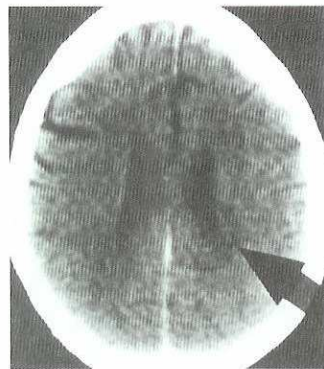
Diferentes estratos de una serie de TAC cerebrales pertenecientes al mismo paciente. El FH de al lado todavía está en fase activa ampliamente, se proyecta en parte en la médula, pero pertenece a la corteza postsensorial (conflicto de separación dolorosa que tiene que ver con el periostio de la pierna izquierda). Vemos ya un anillo que entra en solución, es decir, el conflicto se ha resuelto hace poco tiempo.

Primero se pensó en un artefacto del aparato, pero un artefacto no puede edematizarse.



Zwei HHle zentral im postsensorischen (für das Periost zuständigen) Rindenzentrum in der pcl-Phase. Die Schießscheibenringe sind oedematisiert, zeigen allmählich verlaufende Lösungsringe; der Beweis, daß es sich nicht um Artefakte gehandelt hat.

10.6.1 Fallbeispiel: Italienischer Gastarbeiter



Verschiedene Schichten einer CCT-Serie desselben Patienten. Der nebenstehende HH ist noch weitgehend in aktiver Phase, projiziert sich z.T. ins Marklager, gehört aber zum postsensorischen Rindenzentrum, (schmerzhafter Trennungs-Konflikt das Periost des linken Beins betreffend). Wir sehen schon einen Ring in Lösung gehen, d.h. der Konflikt ist also offenbar gerade ganz kurz vorher gelöst worden.

Man ist zunächst geneigt, an ein Artefakt (Kunstprodukt) des Apparates zu denken, jedoch kann ein Artefakt unmöglich oedematisieren.

Es handelt sich um die Bilder eines italienischen Patienten aus Rom, der als Gastarbeiter in Südfrankreich arbeitete. Dieser hatte, wie das dort so üblich ist, in Rom nahe dem Flughafen Leonardo da Vinci angefangen ein Haus zu bauen. Ein Jahr später, als der Rohbau fast fertig war, kam die Baupolizei und ordnete die Stilllegung des Baus an. Der Patient erlitt einen Revierärger-Konflikt und Leber-Gallengangs-Ca. Doch nach einigen Tagen begann er nachts weiterzubauen. Da er jeweils nur im Urlaub weiterbauen konnte, begann ein Katz-und-polizei. Viermal legte man ihm den Bau still, jedes Mal ein Rezidiv. Aber er steckte das alles weg in Vorfreude. Und wirklich erreichte er vier Jahre später sein Haus fertigstellen durfte, wie das durch die nun eintretende definitive Lösung bekannt wurde, die Ärzte vermuteten eine Leber-Ca. Diagnose erlitt der Mann ein Krebsangst (Frontal-lobengangs-Ulcera. Als er sich wieder einigermaßen im Februar des darauffolgenden Jahres zu einer Schulmedizin als Lymphknoten fühlte, wurde ihm die Diagnose „metastasierendes Lebergeschleudert. Hierdurch erlitt der Patient einen Trennungs-Konflikt, den wir auf der hier vorliegenden CCT-Serie sehen können. Er zitterte am ganzen Leibe, hatte einen inneren Konflikt und nahm rasch an Gewicht ab. Der Patient wollte allem eine innerliche Lösung erreichen - die Lungen-angst-Konflikte gingen sogar leicht zurück. Aber stehen. Der alte Revierärger kehrte in Form eines neuen Weges seiner Erkrankung konnte er ja nun nicht mehr Kinder „spurten nicht“, hatten keinerlei Interesse an der Stilllegung und die Geldbuße zu zahlen. Es gab eine doppelte Einmündung. Auch darüber kam der Patient noch kam es in der Heilungsphase zu einer Potenzierung des noedeme, wodurch der Patient ins Koma fiel und starb.

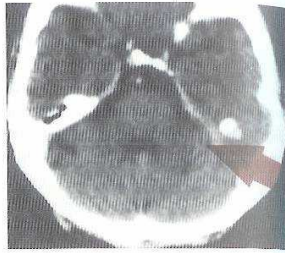
Se trata de imágenes de un paciente italiano de Roma, que trabajaba en Francia meridional. Como sucede a menudo, había comenzado a construirse una casa en Roma, en las cercanías del aeropuerto Leonardo da Vinci. Un año después, cuando la construcción estaba casi terminada, un inspector fue a controlarlo y ordenó que se cerrara la obra. El paciente sufrió un conflicto de rencor en el territorio y un adenocarcinoma de los conductos biliares. Sin embargo tras algunos días comenzó a construir de noche.

Dado que sólo podía construir durante las vacaciones, comenzó a jugar al "gato y al ratón" con el inspector. Cuatro veces le clausuraron la obra y cada vez sufrió una recaída de DHS. Pero soportó todo gozando con la idea de una casa bonita para cuando fuese pensionista. De hecho cuatro años después consiguió terminar la casa gracias a una indemnización. Gracias a la solución definitiva, al paciente

se le hinchó el hígado y los médicos sospecharon un cáncer de hígado. Por este diagnóstico el hombre sufrió un DHS de miedo del cáncer (miedo frontal) con úlcera de los conductos de los arcos branquiales. Cuando, en cierta medida, se había calmado nuevamente, en febrero del año siguiente apareció una hinchazón en la región del cuello que los médicos malinterpretaron con linfonodos. Tras un breve tiempo le escupieron a la cara el diagnóstico de "carcinoma hepático con metástasis". El paciente sufrió por ello un violento y brutal conflicto de separación que podemos reconocer bien en la foto que mostramos aquí. Tembló de la cabeza a los pies, tubo otro conflicto de miedo de la muerte y comenzó a perder rápidamente peso. A pesar de todo, el paciente estuvo en condiciones de llegar a una solución interior, los focos redondos pulmonares del conflicto de miedo de la muerte retrocedieron ligeramente. Pero la vida no se paró. El viejo rencor en el territorio volvió en forma de una recaída del DHS: a causa de su enfermedad ya no podía seguir construyendo, y sus hijos no querían seguir su modelo, no tenían ningún interés en terminar la construcción y pagar los gastos. Se produjo un dramático conflicto en la familia. Una vez más el paciente consiguió salir. Sin embargo en la fase de reparación se llegó a un potenciamiento de los diferentes edemas cerebrales, por los cuales el paciente entró en coma y murió en total vagotonía.



Weiteres CCT aus der gleichen Serie, bei dem man sehr schön die unterschiedlich oedematisierten Schießscheibenringe erkennen kann.



Aktiver HH für den erwähnten Todesangst-Konflikt durch Diagnosenstellung. Die Schießscheiben fangen gerade an, etwas zu oedematisieren.

10.6.2 Fallbeispiel: 60jährige Frau eines Universitäts-Rektors

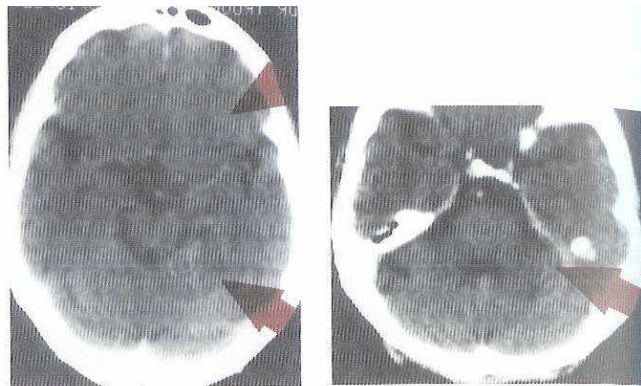


CCT vom 7.5.90 einer 60jährigen Patientin, Gattin eines Universitätsrektors, der seine Frau vor 15 Jahren verlassen hatte. Aus religiösen Gründen war eine Scheidung als nicht möglich erachtet worden. Vor fünf Jahren lernte die Patientin einen neuen Mann kennen, der aber noch nicht geschieden war. 1989 ließ sich der Freund dann scheiden. Aber die Patientin konnte sich ihrerseits nicht entschließen, sich scheiden zu lassen und ihn zu heiraten. In diesem Moment zog der Freund zu einer anderen Frau. Die Patientin erlitt ein motorisches DHS, den Freund nicht festhalten zu können und einen Trennungskonflikt, weil der Freund ihr aus den

Otra TAC cerebral de la misma serie en la que se pueden reconocer muy bien los anillos concéntricos con distinta edematización.

FH activo para el mencionado conflicto de miedo a la muerte a causa del diagnóstico recibido. La configuración concéntrica comienza a edematizarse un poco.

10.6.2. Ejemplo: la mujer de sesenta años de un rector universitario



Weiteres CCT aus der gleichen Serie, bei dem man sehr schön die unterschiedlich oedematisierten Schießscheibenringe erkennen kann.

Aktiver HH für den erwähnten Todesangst-Konflikt durch Diagnosenstellung. Die Schießscheiben fangen gerade an, etwas zu oedematisieren.

10.6.2 Fallbeispiel: 60jährige Frau eines Universitäts-Rektors



CCT vom 7.5.90 einer 60jährigen Patientin, Gattin eines Universitätsrektors, der seine Frau vor 15 Jahren verlassen hatte. Aus religiösen Gründen war eine Scheidung als nicht möglich erachtet worden. Vor fünf Jahren lernte die Patientin einen neuen Mann kennen, der aber noch nicht geschieden war. 1989 ließ sich der Freund dann scheiden. Aber die Patientin konnte sich ihrerseits nicht entschließen, sich scheiden zu lassen und ihn zu heiraten. In diesem Moment zog der Freund zu einer anderen Frau. Die Patientin erlitt ein motorisches DHS, den Freund nicht festhalten zu können und einen Trennungskonflikt, weil der Freund ihr aus den

TAC cerebral del 7-5-90 de una paciente de sesenta años, mujer de un rector universitario que la había dejado 15 años antes. Por motivos religiosos no fue posible separarse. Cinco años antes la paciente había conocido otro hombre que, sin embargo, todavía no estaba separado. En 1989 el amante se separó de su mujer. Pero la paciente no conseguía convencerse para separarse también y casarse con el otro. En ese período el amante se echó otra novia. La paciente sufrió un DHS motor de no poder retener al novio y un conflicto de separación porque se le había escapado de las manos, además a nivel orgánico sufrió una parálisis parcial motora y sensorial de las dos manos con una parálisis casi completa del pulgar derecho. Se sospechó una esclerosis múltiple. En esta situación la hija, profesora de neurología, vino y me pidió mi opinión.

En base a las TAC cerebrales que me trajeron podemos reconstruir rápidamente el caso. La hija hizo la terapia a la madre hablándole de un modo exhaustivo del asunto. De hecho la parálisis retrocedió. La madre tuvo la obligatoria crisis epiléptica. Después sucedió lo siguiente: la paciente se enteró de que la nueva novia de su ex-compañero no era una “mujer de bien” y que su novio ya tenía una relación con esta mujer mientras que estaba todavía con ella. Sufrió un DHS del oponer resistencia y de miedo con asco (zurda) con el centro en el relé del glucagón, es decir, con hipoglucemia prevalente.



hnten Todes-
diagnosenstel-
fangen gera-
eren.

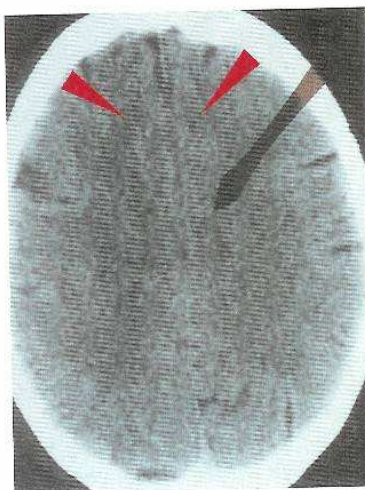
versitäts-

r 60jährigen
Universitäts-
vor 15 Jahren
igiösen Grün-
ng als nicht
en. Vor fünf
tientin einen
er aber noch
1989 ließ sich
den. Aber die
hrerseits nicht
iden zu lassen
n diesem Mo-
einer anderen
itt ein motori-
l nicht festhal-
en Trennungs-
nd ihr aus den

Händen glitt, dazu auf organischer Ebene eine motorische und sensorische Teillähmung beider Hände mit fast völliger motorischer Lähmung des rechten Daumens. Man vermutete eine MS. In dieser Situation kam die Tochter, eine Dozentin für Neurologie zu mir und erbat meinen Rat.

Aufgrund des mitgebrachten CCTs konnten wir den Fall rasch rekonstruieren. Sie therapierte die Mutter, indem sie mit ihr über die Angelegenheit ausführlich sprach. Wirklich ging auch die Lähmung wieder zurück. Die Mutter erlitt den obligaten epileptischen Anfall. Dann aber ereignete sich folgendes: Die Patientin erfuhr, daß die neue Freundin ihres Ex-Freundes „keine Dame“ sei und daß der Freund mit dieser Frau schon eine Beziehung hatte, während er noch mit ihr intim befreundet war. Daraufhin erlitt sie ein DHS des Sich-Sträubens und des Angst-Ekels (Linkshänderin) mit dem Zentrum im Glukagon-Relais, d.h. die Unterzuckerung überwiegt.

CCT vom 3.7.1990 der gleichen Patientin:
Während wir in der vorangegangenen Aufnahme noch die scharfe Ringformation als Zeichen des aktiven Konflikts der motorischen und sensorischen Lähmung sehen können, ist dieser Konflikt auf der Aufnahme zwei Monate später gelöst. Dafür aber sehen wir eine neue aktive Schießscheiben-Konfiguration entsprechend dem zu diesem Zeitpunkt noch aktiven Konflikt des Sich-im-Nachhinein-noch-Sträubens-und-Ekelns im Zuckerrelais. Dieser zweite Konflikt konnte durch intensive Gespräche ebenfalls gelöst werden.



TAC cerebral del 3-7-1990 de la misma paciente: mientras que en la fotografía precedente podemos ver todavía la formación de anillos nítidos como signo del conflicto activo de la parálisis motora y sensorial, este conflicto aparece resuelto en la foto de dos meses después. Pero vemos una nueva configuración concéntrica activa correspondiente al conflicto retroactivo, todavía activo en este momento, del oponer resistencia y de asco en el relé del azúcar. Fue posible resolver este segundo conflicto gracias a las intensas conversaciones que se tuvieron.

10.6.3. Ejemplo: paciente de cincuenta años tras la menopausia

10.6.3 Fallbeispiel: 50jährige Patientin nach Menopause



CCT einer 50jährigen rechtshändigen Patientin nach der Menopause. Rechts fronto-parietal sehen wir einen großen HH in Lösungsodem entsprechend einem Revierangst-Konflikt mit Intrabronchial-Ca. Das DHS hatte sich 7 Monate zuvor ereignet. Der Schwiegersohn der Patientin mußte wegen einer akuten Peritonitis operiert werden, die Ärzte gaben ihm kaum noch Überlebenschancen. Dieser Konflikt dauerte nur 2 Monate an, er war jedoch äußerst heftig! Einen Monat vor Erstellung dieser Aufnahme kam es zu einem Konfliktrezidiv: Der Ehemann der Patientin mußte an einer akuten Leistenhernie¹⁶⁰ operiert werden. Der Rezidiv-Konflikt dauerte 3 Wochen an bis es zur erneuten

Konfliktlösung kam. Der Druck des erneut in den HH einschießenden Heilungsödems brachte diesen offensichtlich zum Zerreißen - ein Beispiel für den sog. „Ziehharmonika-Effekt“: Ein HH in Lösungsodem gerät vorübergehend wieder in Konfliktaktivität, das Oedem bildet sich kurzfristig zurück, nach der erneuten CL schießt wieder Oedem ein, der HH pumpt sich gleichsam von innen wieder auf - irgendwann hält das Gewebe dem Oedemdruck nicht mehr stand und zerreißt, was auch auf der folgenden Aufnahme recht gut zu sehen ist.

Auf der linken Großhirn-Hemisphäre sehen wir weitere sexuelle bzw. halbsexuelle Konflikte, die hängend-aktiv sind. Dazu konnten wir folgendes eruieren: Als die Patientin 17 Jahre alt war, wurde sie von ihrem eigenen Schwager vergewaltigt - ein Konflikt, über den sie im Prinzip nie so richtig hinweggekommen war! Als ihr Sohn 16 Jahre alt war, wurde er Vater eines Kindes - für die Mutter ein Konfliktrezidiv in quasi gleicher Angelegenheit ...

¹⁶⁰ Hernie = Bruch

Im folgenden eine andere CCT einer Patientin: Der Pfeil zeigt auf eine Schießscheiben-Konfiguration (postsensorischen Rindenzentren) Trennungs-Konflikt entschlüsselt. Man sieht sehr gut den bereits zerrissenen HH im Bronchialrezeptions-Konfliktlösung und Konflikte vorliegen!

Was war passiert? Als die Patientin ins Krankenhaus lag, guten Appetit hatte, kam ihre Schwester zu Besuch. Nachts geträumt habe. Ich habe sie kommen, um dich zu holen, aber du bist nicht da! Von Stund an war sie nicht mehr als rechts, aß nicht mehr, wurde von einem französischen Arzt, der sie in einem Gespräch am Kopfende der Seele zu räumen, nachdachte, zählt hatte. Von Stund an war sie nicht mehr da. Die Patientin konnte wieder

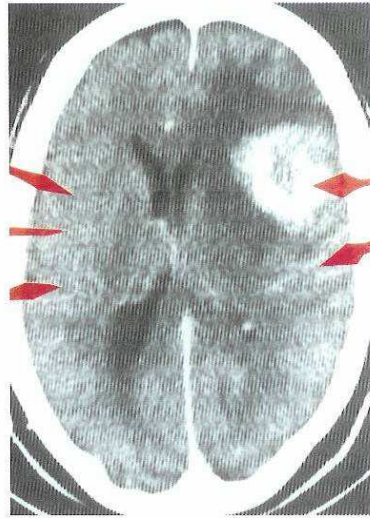
¹⁶¹ Parese = unvollständige Lähmung

TAC cerebral de una paciente de cincuenta años diestra tras la menopausia. A la derecha frontoparietalmente vemos un gran FH con edema de solución correspondiente a un conflicto de miedo en el territorio con carcinoma intrabronquial.

El DHS se había producido siete meses antes. El yerno de la paciente fue operado a causa de una peritonitis aguda y los médicos decían que no había muchas posibilidades de que sobreviviera. Este conflicto duró sólo dos meses, pues el yerno era muy fuerte. Un mes antes de tomar esta fotografía tuvo una recaída del

conflicto: el marido de la paciente tenía que ser operado de una hernia inguinal aguda. Esta recaída duró tres semanas hasta que se llegó a una nueva solución. La presión del edema de reparación en el FH lo laceró, un ejemplo del denominado “efecto fisarmónico”: un FH con edema de solución vuelve a estar temporalmente en actividad conflictiva, el edema disminuye momentáneamente, tras la nueva conflictolisis (CL) el edema se vuelve a formar, al mismo tiempo el FH se hincha de nuevo desde el interior; en un cierto punto el tejido no resiste más la presión del edema, lo que se puede ver bien en las imágenes siguientes. En el hemisferio izquierdo del encéfalo vemos otros conflictos sexuales o semisexuales que están activos en suspensión. Además podríamos decir lo siguiente: cuando la paciente tenía 17 años fue molestada por su cuñado, un conflicto del que no se había liberado. Su hijo, de 16 años, había dejado embarazada a una muchacha: una recaída conflictiva para la madre casi en la misma circunstancia...

10.6.3 Fallbeispiel: 50jährige Patientin nach Menopause



CCT einer 50jährigen rechtshändigen Patientin nach der Menopause. Rechts fronto-parietal sehen wir einen großen HH in Lösungsödem entsprechend einem Revierangst-Konflikt mit Intrabronchial-Ca. Das DHS hatte sich 7 Monate zuvor ereignet. Der Schwiegersohn der Patientin mußte wegen einer akuten Peritonitis operiert werden, die Ärzte gaben ihm kaum noch Überlebenschancen. Dieser Konflikt dauerte nur 2 Monate an, er war jedoch äußerst heftig! Einen Monat vor Erstellung dieser Aufnahme kam es zu einem Konfliktrezidiv: Der Ehemann der Patientin mußte an einer akuten Leistenhernie¹⁶⁰ operiert werden. Der Rezidiv-Konflikt dauerte 3

Wochen an bis es zur erneuten Konfliktlösung kam. Der Druck des erneut in den HH einschließenden Heilungsödems brachte diesen offensichtlich zum Zerreißen - ein Beispiel für den sog. „Ziehharmonika-Effekt“: Ein HH in Lösungsödem gerät vorübergehend wieder in Konfliktaktivität, das Oedem bildet sich kurzfristig zurück, nach der erneuten CL schießt wieder Oedem ein, der HH pumpt sich gleichsam von innen wieder auf - irgendwann hält das Gewebe dem Oedemdruck nicht mehr stand und zerreißt, was auch auf der folgenden Aufnahme recht gut zu sehen ist.

Auf der linken Großhirn-Hemisphäre sehen wir weitere sexuelle bzw. halbsexuelle Konflikte, die hängend-aktiv sind. Dazu konnten wir folgendes eruieren: Als die Patientin 17 Jahre alt war, wurde sie von ihrem eigenen Schwager vergewaltigt - ein Konflikt, über den sie im Prinzip nie so richtig hinweggekommen war! Als ihr Sohn 16 Jahre alt war, wurde er Vater eines Kindes - für die Mutter ein Konfliktrezidiv in quasi gleicher Angelegenheit ...

¹⁶⁰ Hernie = Bruch

Im folgenden eine andere CCT-Schicht der gleichen Patientin: Der Pfeil zeigt auf einen HH mit Schießscheiben-Konfiguration im motorischen und postsensorischen Rindenzentrum, einem (motorischen) Trennungskonflikt entsprechend. Weiterhin sehen wir sehr gut den bereits erwähnten innen zerrissenen HH im Bronchialrelais. Wir haben also Konfliktlösung und Konfliktaktivität gleichzeitig vorliegen!

Was war passiert? Als die Patientin in voller Heilung im Krankenhaus lag, guten Appetit hatte und gut schlafen konnte, kam ihre Schwester zu Besuch und flüsterte: „In der Nacht geträumt habe. Ich habe unsere Mutter im Traum gesehen, sie komme, um dich zu holen.“ Das schlug bei der Patientin ein! Von Stund an war sie an allen vier Extremitäten mehr als rechts, aß nicht mehr, schlief nicht mehr. Sie wurde von einem französischen Arzt, der sich mit der Neuropsychiatrie beschäftigte, in einem Gespräch am Krankenbett, der Patientin die Seele zu räumen, nachdem sie ihm unter Tränen erzählt hatte. Von Stund an waren die Paresen¹⁶¹ mehr ausgeprägt. Die Patientin konnte wieder schlafen und essen.

¹⁶¹ Parese = unvollständige Lähmung

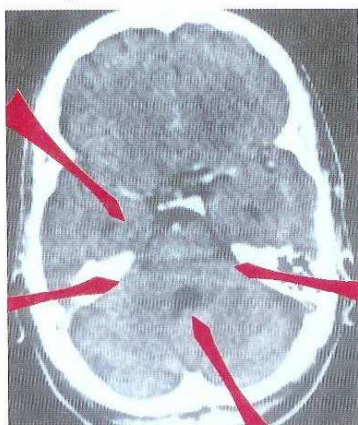
Seguidamente otro estrato de la TAC cerebral de la misma paciente: la flecha indica un FH con configuración concéntrica en la corteza postsensorial, correspondiente a un conflicto de separación (en parte de carácter motor). Además vemos muy bien el ya citado FH lacerado internamente en el relé bronquial. Están presentes al mismo tiempo solución de conflicto y actividad conflictiva.

¿Qué había pasado? Cuando la paciente se encontraba en el hospital en plena vagotonía de curación, tenía buen apetito y podía dormir bien, una mañana su hermana fue a verla y le susurró: “Mira lo que he soñado esta noche. He visto a nuestra madre en sueños y decía que había venido a llevarte”. Eso afectó terriblemente a la pobre paciente. Desde ese momento en adelante se le paralizaron parcialmente las cuatro extremidades, a la izquierda más que a la

derecha, no comió más, no dormía, estaba en total pánico. Un médico francés que conocía la Nueva Medicina, en una conversación con la paciente, consiguió quitar ese enorme peso del alma de la paciente que le había contado entre lágrimas lo que había pasado. Desde entonces las parálisis fueron cada vez a menos. La paciente pudo dormir y comer nuevamente.

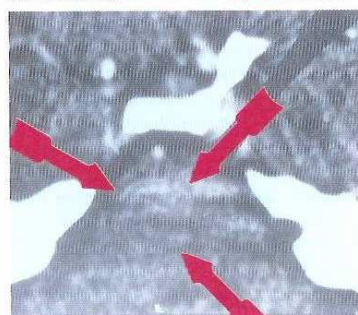
10.6.4. Ejemplo: FH activo con configuración concéntrica en el tronco cerebral

10.6.4 Fallbeispiel: Aktiver HH in Schießscheiben-Konfiguration im Stammhirn



Hier zwei CCT-Bilder verschiedener Schichten der gleichen Patientin.

Auf dem ersten sehen wir einen aktiven HH in scharfer Schießscheiben-Konfiguration. Die Pfeile weisen auf das Dünndarm-Relais im Stammhirn entsprechend einem unverdaulichen Ärgen.



Hier eine tiefere Schicht der gleichen Serie, ebenfalls mit HH in Schießscheiben-Konfiguration aber mit anderem Mittelpunkt, nämlich im Tuben und Urin-Blasen-Relais.

Konflikt: Die Patientin hatte ihr Pferd falsch gelenkt und einen anderen Reiter gegen die Bande gequetscht und schwer verletzt. Dieser beschimpfte sie wüst mit übelsten Vokabeln (Tuben-Ca). Unmittelbar darauf wurden hohe Kosten fällig (unverdaulicher Ärgen), da der Mann lange im Krankenhaus liegen mußte.

10.6.5 Fallbeispiel: Rechtshändiger Patient mit Verlust-Konflikt

Der nächste Fall hat 3 Abbildungen, die sich auf den gleichen Patienten beziehen:

Auf der ersten CT-Aufnahme sehen wir einen großen, scharfen Ring - er ist ein Artefakt. Daneben sind zwei eindeutig noch in ca-Phase befindliche schießscheibenförmige HH zu sehen. Der rechte betrifft ein Herz-Koronar-Ulcus (Revier-Konflikt), der linke betrifft den rechten Hoden (Verlust-Konflikt). Der rechtshändige Patient hatte seine Mutter unerwartet verloren, an der er sehr hing. Man sieht, daß die rechte Schießscheiben-Konfiguration noch sicher in der ca-Phase ist. Die linke dagegen ist schon etwas oedematös geschwollen, ist also gerade dabei in Lösung zu gehen. Der Patient hat dann später (Februar 1993) auf dem Tiefpunkt der pel-Phase einen Herzinfarkt erlitten.



CT des Hodens:

Die Abbildung zeigt eine Hodennekrose des rechten Hodens, der Konflikt war ja noch nicht gelöst!

Foto des Hodens:

Am rechten Hoden ist äußerlich praktisch nichts zu sehen. Der Finger zeigt auf die Stelle der Nekrose.

Die vermutete Hodennekrose (vereinfacht ausgedrückt ein „Loch“), d.h. ein Substanzverlust im Hoden, wurde also vorher nur durch das Hirn-CT diagnostiziert. Im folgende eine



Aquí, dos imágenes de Tac cerebral de diferentes estratos de la misma paciente. En la primera vemos un FH activo en configuración concéntrica con bordes nítidos. Las flechas indican el relé del intestino delgado en el tronco cerebral correspondiente a un rencor indigesto.

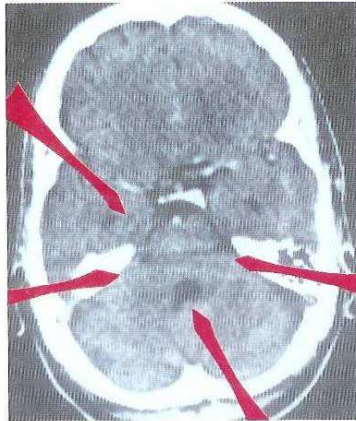
Aquí un estrato más bajo de la misma serie, también con FH con configuración concéntrica pero con otro punto central, justo en el relé de las trompas y de la vejiga urinaria.

Conflicto: la paciente había montado mal su caballo y otro jinete se había caído hiriéndose. Este la insultó salvajemente con los peores insultos (adenocarcinoma de las trompas). Justo después tuvo que pagar mucho dinero (rencor indigesto) ya que el hombre tuvo que permanecer mucho tiempo en el hospital.

10.6.5. Ejemplo: paciente diestro con conflicto de pérdida

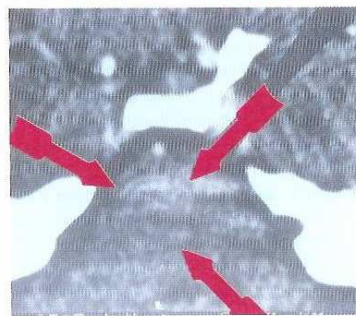
El caso siguiente tiene tres imágenes que se refieren al mismo paciente:

10.6.4 Fallbeispiel: Aktiver HH in Schießscheiben-Konfiguration im Stammhirn



Hier zwei CCT-Bilder verschiedener Schichten der gleichen Patientin.

Auf dem ersten sehen wir einen aktiven HH in scharfer Schießscheiben-Konfiguration. Die Pfeile weisen auf das Dünndarm-Relais im Stammhirn entsprechend einem unverdaulichen Ärger.



Hier eine tiefere Schicht der gleichen Serie, ebenfalls mit HH in Schießscheiben-Konfiguration aber mit anderem Mittelpunkt, nämlich im Tuben und Urin-Blasen-Relais.

Konflikt: Die Patientin hatte ihr Pferd falsch gelenkt und einen anderen Reiter gegen die Bande gequetscht und schwer verletzt. Dieser beschimpfte sie wüst mit übelsten Vokabeln (Tuben-Ca). Unmittelbar darauf wurden hohe Kosten fällig (unverdaulicher Ärger), da der Mann lange im Krankenhaus liegen mußte.

216

10.6.5 Fallbeispiel: Rechtshändiger Patient mit Verlust-Konflikt

Der nächste Fall hat 3 Abbildungen, die sich auf den gleichen Patienten beziehen:

Auf der ersten CT-Aufnahme sehen wir einen großen, scharfen Ring - er ist ein Artefakt. Daneben sind zwei eindeutig noch in ca-Phase befindliche schießscheibenförmige HH zu sehen. Der rechte betrifft ein Herzkoronar-Ulcus (Revier-Konflikt), der linke betrifft den rechten Hoden (Verlust-Konflikt). Der rechtshändige Patient hatte seine Mutter unerwartet verloren, an der er sehr hing. Man sieht, daß die rechte Schießscheiben-Konfiguration noch sicher in der ca-Phase ist. Die linke dagegen ist schon etwas oedematös geschwollen, ist also gerade dabei in Lösung zu gehen. Der Patient hat dann später (Februar 1993) auf dem Tiefpunkt der pcl-Phase einen Herzinfarkt erlitten.

CT des Hodens:

Die Abbildung zeigt eine Hodennekrose des rechten Hodens, der Konflikt war ja noch nicht gelöst!

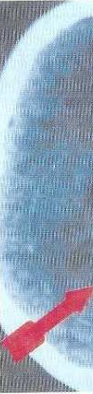
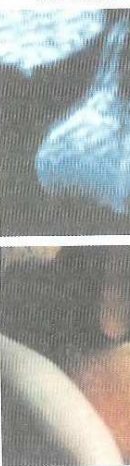


Foto des Hodens:

Am rechten Hoden ist äußerlich praktisch nichts zu sehen. Der Finger zeigt auf die Stelle der Nekrose.

Die vermutete Hodennekrose (vereinfacht ausgedrückt ein „Loch“), d.h. ein Substanzverlust im Hoden, wurde also vorher nur durch das Hirn-CT diagnostiziert. Im folgenden eine



En la primera imagen TAC vemos un gran anillo bien nítido, un artefacto. Al lado se pueden ver dos FH todavía claramente en fase de configuración concéntrica. El de la derecha tiene que ver con una úlcera de las arterias coronarias (conflicto de territorio), el izquierdo con el testículo derecho (conflicto de pérdida). El paciente diestro había perdido inesperadamente a su madre, a la que estaba muy apegado. Se ve que la configuración concéntrica derecha está todavía en la fase CA. La izquierda sin embargo ya está un poco hinchada por el edema, es decir, está entrando en solución. El paciente seguidamente (febrero 1993) sufrió un infarto cardíaco en el punto culminante de la fase PCL.

TAC del testículo:

La imagen muestra una necrosis del testículo derecho: el conflicto todavía no se había resuelto.

Foto del testículo:

En el testículo derecho, externamente, no se ve prácticamente nada. El dedo muestra el punto de la necrosis.

La supuesta necrosis del testículo (en palabras simples un “agujero”), es decir, una pérdida de sustancia en el testículo, que fue diagnosticada precedentemente gracias a la TAC cerebral.

Certificación del caso:

Centro de la Nueva Medicina en Austria
Dirección Dr. Med. Ryke Geerd Hamer

Burgau, 27 de enero de 1993

Se certifica que al Sr., únicamente en base a la TAC cerebral y a la anamnesis, sin que el paciente haya sufrido molestias aparte de una tirantez en el testículo derecho, se le ha encontrado una necrosis en el testículo derecho, encontrada puntualmente mediante una TAC. En base a la TAC cerebral se revela, justamente, una situación intermedia entre una necrosis (=fase activa) y una reconstitución de la necrosis (= fase de reparación).

Dr. Hangl Willibald.

El caso siguiente es de una paciente zurda y consta de 7 fotografías:

10.6.6. Ejemplo: zurda con parálisis parcial a la izquierda

25.1.90, FH en fase CA

25.2.90, FH justo tras la CL

Zentrum für Neue Medizin in Österreich

Leitung Dr. med. Ryka Geerd HAMER

Burgau,

27. Januar 1993

Es wird bestätigt, daß bei Hr. ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~
allein auf Grund des Häm CT und Prognose
ohne daß der Pat. außer einem leichten
Ziehen am rechten Hoden über Schmerzen
geklagt hätte, festgestellt eine Nekrose im
re Hoden gesucht und CT-mäßig
gefunden bzw. verifiziert worden ist.
Entsprechend dem Häm CT ergibt sich
hieran eine Bildung zw. Nekrose
Nekrose (= Atrophie) und Wiederaufüllung
der Nekrose (= Heilungsphase)

A-8291 BURG AU Altes Schloss

Telefon 0542/33832040

Dr. Hans Gellibald, Ambros, Tulln

Die nächste
men:

10.6.6 Fa
links



25.1.90



10.4.90,

10.4.90, fin de la fase PCL

Test del aplauso. Foto de una paciente zurda.

Las tres imágenes de la TAC cerebral precedente muestra la evolución de un Foco de Hamer durante casi cuatro meses.

La paciente es zurda, como se ve en la foto. Había enfermado de una parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, y en menor medida también del brazo derecho.

El DHS se produjo en junio de 1989: la paciente, infelizmente casada, había perdido un amigo que no había podido retener (de un modo dramático) en el abrazo del brazo izquierdo y de la pierna izquierda (zurda), menos en las extremidades derechas. Se trata por lo tanto del “brazo del partner” y de la “pierna del partner” y en menor medida del brazo derecho (madre/niño) con el conflicto de no poder retener. La paciente había deseado tener un hijo de su amigo, había deseado quedarse embarazada, pero sucedió una pérdida dramática.

En la primera imagen de la TAC el conflicto está todavía activo. Se ven los cercos nítidos de la configuración concéntrica del FH, pero se nota también que los anillos llegan al hemisferio izquierdo (débil parálisis del brazo derecho). El centro del FH está a la derecha en el centro motor, que afecta a la motricidad del abrazo del

partner con el brazo izquierdo (zurda) y el abrazo íntimo del partner con la pierna izquierda. La conflictolisis obtenida gracias a la intervención de la médico de cabecera, un experto de Nueva Medicina, junto con la paciente, se produjo el 20.2.1990, justo cuatro semanas tras la primera TAC cerebral que se hizo el 25.1.1990.

En esta segunda TAC del 25.2.90, más o menos en el mismo estrato, vemos que el FH se está "abriendo", es decir, que los anillos en el exterior se vuelven irregulares e interrumpidos, pero el centro todavía es visible.

Foto sucesiva del 10.4.90, del mismo estrato aunque no siempre con el mismo ángulo de inclinación de los estratos, en el que el FH se desplaza un poco hacia delante o un poco hacia atrás.

Die drei vorherigen CCT-Aufnahmen zeigen die Entwicklung eines Hamerschen Herdes über fast 4 Monate.

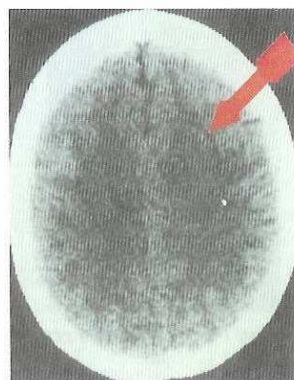
Die Patientin ist, wie das Foto zeigt, Linkshänderin. Sie erkrankte an einer Teillähmung des linken Arms und des linken Beins, in geringerem Maße auch des rechten Arms.

Das DHS ereignete sich im Juni 1989: Die Patientin verlor, in unglücklicher Ehe verheiratet, einen sehr geliebten Freund, den sie - auf dramatische Weise - nicht in der Umarmung des linken Arms und des linken Beins (Linkshänderin!), weniger der rechten Extremitäten, festhalten konnte. Es geht also um den „Partner-Arm“ und das „Partner-Bein“ und in geringerem Maße auch um den rechten (Mutter/Kind)-Arm mit dem Konflikt, nicht festhalten zu können. Die Patientin hatte sich von ihrem Freund ein Kind gewünscht, hatte schon gehofft, schwanger zu sein, darüber war es zum dramatischen Verlustereignis gekommen.

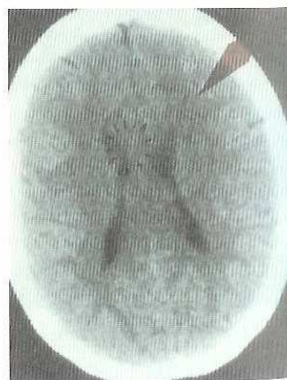
Auf der ersten CT-Aufnahme ist der Konflikt noch aktiv. Wir sehen die scharfen Kreise der Schießscheiben-Konfiguration des HHs, sehen aber auch, daß die Ringe auf die linke Hemisphäre hinüberreichen (schwache Lähmung des rechten Arms). Das Zentrum des HHs ist rechts im motorischen Zentrum, betreffend die Motorik für die Partnerumarmung mit dem linken Arm (Linkshänderin!) und die intime Partnerumarmung mit dem linken Bein. Die Conflictolyse, die die von der Neuen Medizin begeisterte Hausärztin der Patientin mit dieser zusammen erarbeitete, gelang am 20.2.1990, knapp vier Wochen nach dem ersten Hirn-CT, das vom 25.1.1990 stammt.

In diesem zweiten CT vom 25.2.90, etwa von der gleichen Schicht, sehen wir, wie der HH gerade „aufbricht“, d.h. die Ringe werden außen unregelmäßig und unvollständig, das Zentrum ist aber noch zu sehen.

Die nächsten Aufnahmen vom 10.4.90, ebenfalls etwa die gleiche Schicht, wenn auch nicht immer exakt der gleiche Neigungswinkel der Schichten, wodurch der



10.4.90



10.4.90

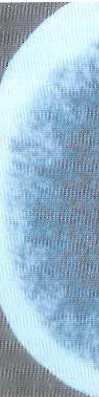
HH mal ein bißchen nach vorne oder nach hinten rutschen teilweise bereits in glöse Vernarbung übergegangen ist.

Zu erwähnen ist natürlich noch, daß am 10.3.1990 (epileptische Krise) stattfand, der die Patientin jedoch ja die Regeln der Neuen Medizin durch ihre Hausärztin worden waren.

Eigentlich war die Patientin, zwischen Juli 1989 und „MS“-Verdacht gelaufen. Aber dieser Unsinn konnte nicht geredet werden: Die große Gefahr ist ja immer, daß Diagnose-Schock einen zweiten motorischen Konflikt - erleiden, weil man ihnen sagt, sie würden möglicherweise stuhl gefesselt sein. Von diesem Konflikt kommen sie da

Letzte CT-Aufnahme vom 24.4.1990 der gleichen Patientin:

Man sieht, daß die Schießscheiben inzwischen leichte „Stechapfelform“ haben, d.h. der Höhepunkt der pcl-Oedemphase ist hier bereits vorbei, die Vernarbungsphase ist im Gang.



10.6.7 Fallbeispiel: Patientin mit Angst

Die folgende Fallgeschichte umfaßt 4 CCT-Aufnahmen. Es handelt sich um 3 Serien von CCTs einer Patientin, die jeweils ca. 6 Wochen angefertigt wurden.

Bei der Patientin lag ein Angst-Ekel-Konflikt vor ihrem schwulen Chef, der „gemein“ empfand.

CCT vom 24.1.90, HH in ca-Phase:

Das Zentrum der Schießscheiben-Konfiguration liegt der Diabetes über die Hypoglykämie, d.h. es über Insuffizienz gegenüber der Alpha-Inselzell-Insuffizienz.

Vemos que el FH ha entrado ya en parte en cicatrización glial.

Por supuesto también hay que decir que el 10.3.90 se produjo un ataque epiléptico (crisis epiléptica) que sin embargo no sorprendió a la paciente porque su doctora ya la había concienciado según las leyes de la Nueva Medicina.

Entre julio de 1989 y febrero de 1990 a la paciente se le diagnosticó una supuesta SM. Pero por suerte se la pudo convencer rápidamente que aquel diagnóstico era insensato.

El gran peligro es siempre el que los pacientes sufran un segundo conflicto motor, sobretodo en las piernas, a causa de un diagnóstico chocante, porque se les dice que probablemente se quedarán en una silla de ruedas. En la mayor parte de los casos no se liberan de este conflicto.

Die drei vorherigen CCT-Aufnahmen zeigen die Entwicklung eines Hamerschen Herdes über fast 4 Monate.

Die Patientin ist, wie das Foto zeigt, Linkshänderin. Sie erkrankte an einer Teillähmung des linken Arms und des linken Beins (Linkshänderin!), weniger der rechten Extremitäten, festhalten konnte. Es geht also um den „Partner-Arm“ und das „Partner-Bein“ und in geringerem Maße auch um den rechten (Mutter/Kind)-Arm mit dem Konflikt, nicht festhalten zu können. Die Patientin hatte sich von ihrem Freund ein Kind gewünscht, hatte schon gehofft, schwanger zu sein, darüber war es zum dramatischen Verlustereignis gekommen.

Das DHS ereignete sich im Juni 1989: Die Patientin verlor, in unglücklicher Ehe verheiratet, einen sehr geliebten Freund, den sie - auf dramatische Weise - nicht in der Umarmung des linken Arms und des linken Beins (Linkshänderin!), weniger der rechten Extremitäten, festhalten konnte. Es geht also um den „Partner-Arm“ und das „Partner-Bein“ und in geringerem Maße auch um den rechten (Mutter/Kind)-Arm mit dem Konflikt, nicht festhalten zu können. Die Patientin hatte sich von ihrem Freund ein Kind gewünscht, hatte schon gehofft, schwanger zu sein, darüber war es zum dramatischen Verlustereignis gekommen.

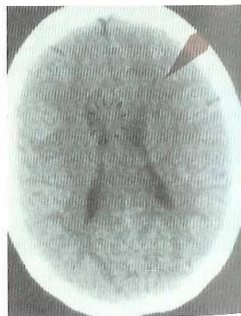
Auf der ersten CT-Aufnahme ist der Konflikt noch aktiv. Wir sehen die scharfen Kreise der Schießscheiben-Konfiguration des HHs, sehen aber auch, daß die Ringe auf die linke Hemisphäre hinüberreichen (schwache Lähmung des rechten Arms). Das Zentrum des HHs ist rechts im motorischen Zentrum, betreffend die Motorik für die Partnerumarmung mit dem linken Arm (Linkshänderin!) und die intime Partnerumarmung mit dem linken Bein. Die Conflictolyse, die die von der Neuen Medizin begeisterte Hausärztin der Patientin mit dieser zusammen erarbeitete, gelang am 20.2.1990, knapp vier Wochen nach dem ersten Hirn-CT, das vom 25.1.1990 stammt.

In diesem zweiten CT vom 25.2.90, etwa von der gleichen Schicht, sehen wir, wie der HH gerade „aufbricht“, d.h. die Ringe werden außen unregelmäßig und unvollständig, das Zentrum ist aber noch zu sehen.

Die nächsten Aufnahmen vom 10.4.90, ebenfalls etwa die gleiche Schicht, wenn auch nicht immer exakt der gleiche Neigungswinkel der Schichten, wodurch der



10.4.90



10.4.90

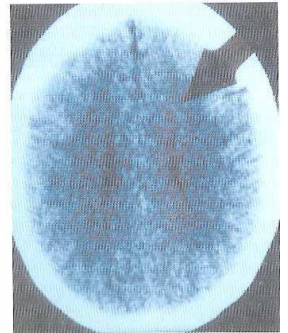
HH mal ein bißchen nach vorne oder nach hinten rutscht, wir sehen, daß der HH teilweise bereits in glöse Vernarbung übergegangen ist.

Zu erwähnen ist natürlich noch, daß am 10.3.1990 ein epileptischer Anfall (epileptische Krise) stattfand, der die Patientin jedoch nicht überraschte, da ihr ja die Regeln der Neuen Medizin durch ihre Hausärztin bestens bekannt gemacht worden waren.

Eigentlich war die Patientin, zwischen Juli 1989 und Februar 1990 schon unter „MS“-Verdacht gelaufen. Aber dieser Unsinn konnte ihr zum Glück schnell ausgedrückt werden: Die große Gefahr ist ja immer, daß die Patientin durch den Diagnose-Schock einen zweiten motorischen Konflikt - hauptsächlich der Beine - erleiden, weil man ihnen sagt, sie würden möglicherweise zeitlebens an den Rollstuhl gefesselt sein. Von diesem Konflikt kommen sie dann meist nie mehr los.

Letzte CT-Aufnahme vom 24.4.1990 der gleichen Patientin:

Man sieht, daß die Schießscheiben inzwischen leichte „Stechapfelform“ haben, d.h. der Höhepunkt der pcl-Oedemphase ist hier bereits vorbei, die Vernarbungsphase ist im Gang.



10.6.7 Fallbeispiel: Patientin mit Angst-Ekel-Konflikt

Die folgende Fallgeschichte umfaßt 4 CCT-Aufnahmen:

Es handelt sich um 3 Serien von CCTs einer Patientin, die im Abstand von jeweils ca. 6 Wochen angefertigt wurden.

Bei der Patientin lag ein Angst-Ekel-Konflikt vor kombiniert mit einem Sträubens-Konflikt vor ihrem schwulen Chef, den sie als „ekelhaft“ und „gemein“ empfand.

CCT vom 24.1.90, HH in ca-Phase:

Das Zentrum der Schießscheiben-Konfiguration liegt rechts. Deshalb überwiegt der Diabetes über die Hypoglykämie, d.h. es überwiegt die Beta-Inselzell-Insuffizienz gegenüber der Alpha-Inselzell-Insuffizienz.

Última imagen de la TAC del 24.4.1990 de la misma paciente: se ve que el diseño concéntrico durante ese tiempo ha cogido una forma parecida a una “estrella”, es decir, el punto culminante de la fase PCL edematosa ya ha pasado, y está en curso la fase de cicatrización.

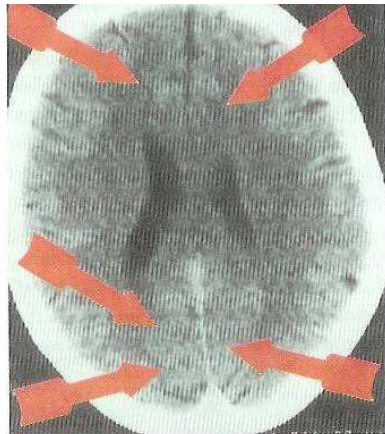
10.6.7. Ejemplo: una paciente con conflicto de miedo-asco

La historia del caso siguiente está documentada con 4 imágenes de TAC cerebral: se trata de tres series de TAC cerebrales de una paciente que se realizaron a un intervalo de unas 6 semanas.

La paciente tenía un conflicto de miedo-asco combinado con un conflicto de poner resistencia a su jefe homosexual, al que ella consideraba “no de su agrado” y “malo”.

TAC cerebral del 24.1.90, FH en fase CA:

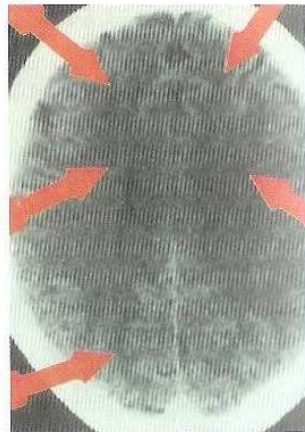
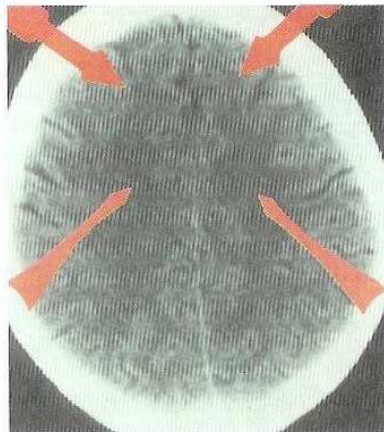
El centro de la configuración concéntrica se encuentra a la derecha. Por lo tanto la diabetes prevalece sobre la hipoglucemia, es decir, primacía de la insuficiencia de las células insulares beta respecto al a insuficiencia de las células insulares alfa.



24.1.1990

Wir sehen auf der gleichen Aufnahme dorsal einen großen HH, der schon mehrfach vernarbt ist, in erneuter Schießscheiben-Konfiguration die beiden Glaskörper auf organischer Ebene betreffend. Der biologische Konflikt: Sie war ein Jahr vorher auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle (Apotheke) von hinten verfolgt, überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Rezidive: Sie mußte jeden Tag den gleichen Weg von und zur Apotheke nehmen. Die Patientin bekam folgerichtig einen beiderseitigen Grünen Star.

CCT der ...
Monate später.
Man sieht nur noch eine N...
im Diabetes- bzw. Hypoglykämie



Oben: CCT-Aufnahmen vom 15.3.90:

Beide Konflikte sind in pcl-Phase, der frontale noch mehr als der occipitale. Man sieht aber, daß die jetzt oedematisierten Schießscheiben an der gleichen Stelle sind. So etwas nennen wir eine normale Entwicklung eines HHs nach Lö-

10.6.8 Fallbeispiel

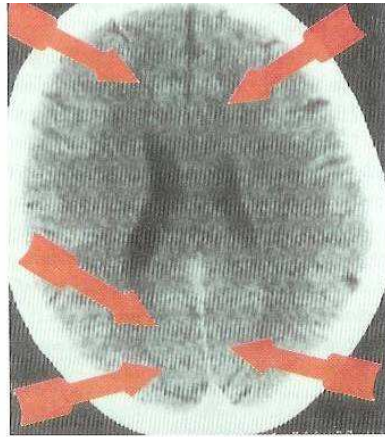


Serie von vier CCTs einer ...
scher pcl-Phase.

La paciente se despidió al poco tiempo de esta fotografía. En la misma imagen vemos dorsal-mente un gran FH, que ya está cicatrizado varias veces y que tiene que ver, en una nueva configuración concéntrica, con los dos cuerpos vítreos a nivel orgánico. El conflicto biológico: un año antes, mientras se dirigía a su puesto de trabajo (en una farmacia), la siguieron y la atacaron por la espalda amenazándola con un cuchillo. La recaída: cada día tenía que hacer el mismo camino para ir y volver de la farmacia. A la paciente como consecuencia se le produjo un glaucoma en los dos ojos.

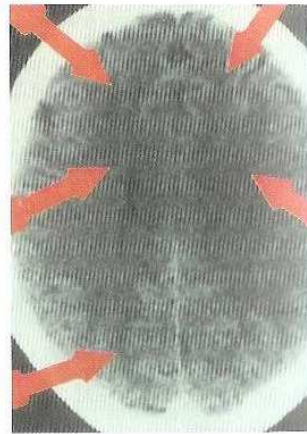
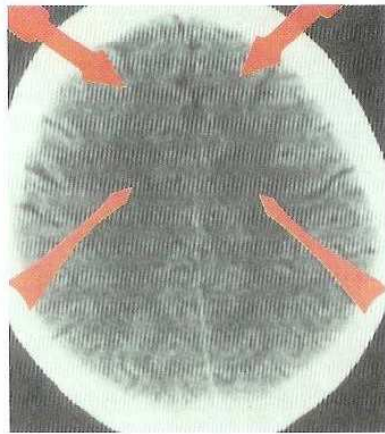
Arriba: imágenes de la TAC cerebral del 15.3.90:

Los dos conflictos están en fase PCL, el frontal todavía más que el occipital. Sin embargo se ve que los diseños concéntricos edematizados están en la misma posición que cuando el foco estaba activo. Esto es lo que consideramos una evolución normal del FH tras la solución del conflicto.



24.1.1990

Wir sehen auf der gleichen Aufnahme dorsal einen großen HH, der schon mehrfach vernalbt ist, in erneuter Schießscheiben-Konfiguration die beiden Glaskörper auf organischer Ebene betreffend. Der biologische Konflikt: Sie war ein Jahr vorher auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle (Apotheke) von hinten verfolgt, überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Rezidive: Sie mußte jeden Tag den gleichen Weg von und zur Apotheke nehmen. Die Patientin bekam folgerichtig einen beiderseitigen Grünen Star.



Oben: CCT-Aufnahmen vom 15.3.90:

Beide Konflikte sind in pcl-Phase, der frontale noch mehr als der occipitale. Man sieht aber, daß die jetzt oedematisierten Schießscheiben an der gleichen Stelle sind. So etwas nennen wir eine normale Entwicklung eines HHs nach Lö-

TAC cerebral de la misma paciente con un intervalo de otros dos meses y medio. Se ve sólo una cicatriz del FH en el relé de la diabetes o de la hipoglucemia.

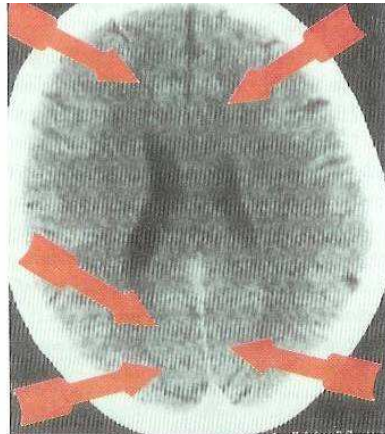
CCT der 8. Monate später. Man sieht nur noch eine N im Diabetes- bzw. Hypoglyk

10.6.8 Fallbeispiel

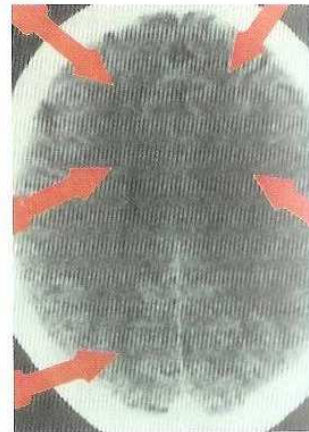
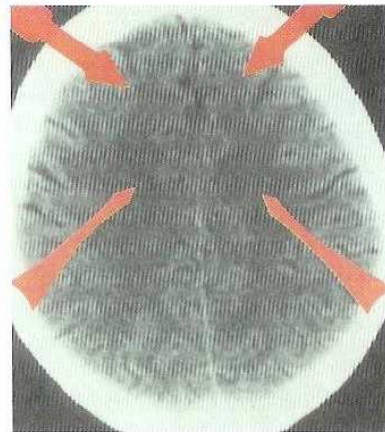


Serie von vier CCTs einer scher pcl-Phase.

10.6.8. Ejemplo: adenocarcinoma ductal de la mama



24.1.1990



Oben: CCT-Aufnahmen vom 15.3.90:

Beide Konflikte sind in pcl-Phase, der frontale noch mehr als der occipitale. Man sieht aber, daß die jetzt oedematisierten Schießscheiben an der gleichen Stelle sind. So etwas nennen wir eine normale Entwicklung eines HHs nach Lö-

Wir sehen auf der gleichen Aufnahme dorsal einen großen HH, der schon mehrfach vernarbt ist, in erneuter Schießscheiben-Konfiguration die beiden Glaskörper auf organischer Ebene betreffend. Der biologische Konflikt: Sie war ein Jahr vorher auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle (Apotheke) von hinten verfolgt, überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Rezidive: Sie mußte jeden Tag den gleichen Weg von und zur Apotheke nehmen. Die Patientin bekam folgerichtig einen beiderseitigen Grünen Star.

CCT der Sch...
Monate später.
Man sieht nur noch eine N...
im Diabetes- bzw. Hypoglyk...

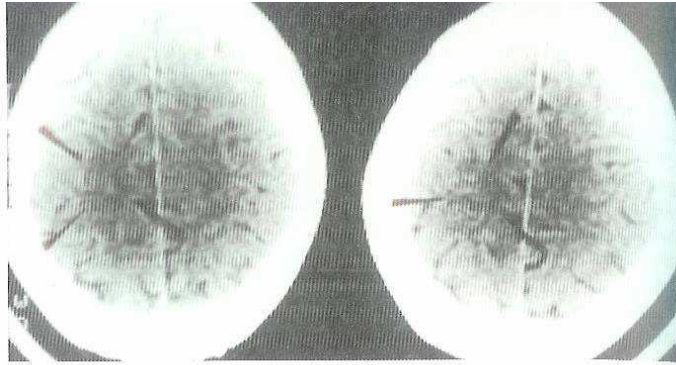
10.6.8 Fallbeispiel



Serie von vier CCTs einer...
scher pcl-Phase.
Das Bild...

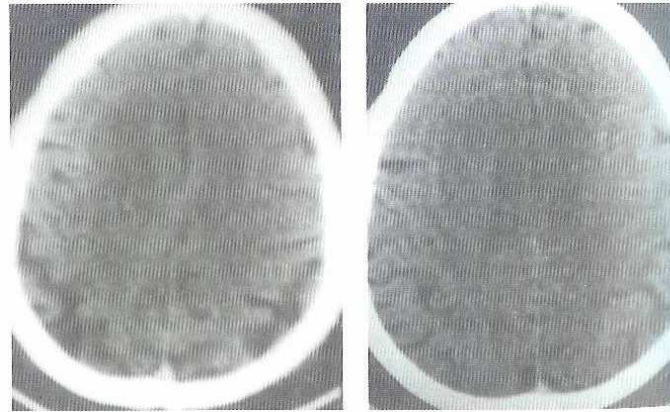
Serie de cuatro TAC cerebrales de una joven mujer con un adenocarcinoma ductal de la mama en reciente fase PCL.

El radiólogo ha movido una vez a la paciente desde la línea central 2 cm hacia la izquierda (véanse las fotos de la izquierda) y otra vez dos cm hacia la derecha (ver las fotos de la derecha). La localización de los FH, como se ve, no cambia por esto.



10.6.9 Fallbeispiel: Londoner Banker

Die nächsten 7 Fotos gehören zur Fallgeschichte eines Londoner Bankers



HH für motorischen Konflikt. Es sind nur noch wenige Schiebscheiben zu erkennen, sie zeigen bereits „Stechapelform“, der Höhepunkt der Heilung ist also schon überschritten. Auf der ersten CCT-Aufnahme sind einige Schiebscheibenringe sowie das Einschlagzentrum des Konfliktes noch zu erkennen, auf den nächsten Aufnahmen wird dies immer schwerer möglich.

Weitere 3 CCTs, auf denen man die motorische Schiebscheibe bzw. deren allmähliches Verschwinden sehr gut beobachten kann. Ein Artefakt ist also ausgeschlossen!

Die fünf abgebildeten CCT-Aufnahmen der gleichen Serie sind von einem Bankier aus einem Krankenhaus in London. Typischer Fall von Fehldiagnose: Der Patient hatte nach einem dramatischen Streit mit seinem Abteilungsleiter, bei dem ihm die Beförderung verweigert worden war, eine motorische Lähmung erlitten, mehr des rechten als des linken Beines, ebenso mehr des rechten als des

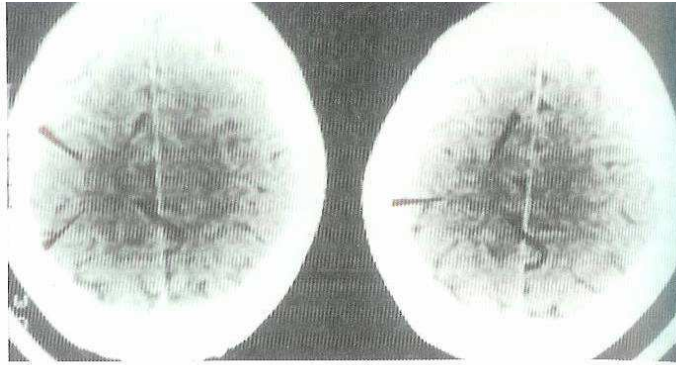


linken Armes. Nun wurde er durchuntersucht auf Krebserkrankungen (Krebstumor) und ein altes Leber-Ca. Das konfliktfolgende Abdomen¹⁶²-CT), sowie die c

¹⁶² Abdomen = Bauch, Unterleib

10.6.9. Ejemplo: un empleado de banca londinense

Las siete fotografías siguientes pertenecen a la historia de un empleado de banca de Londres.



10.6.9 Fallbeispiel: Londoner Banker

Die nächsten 7 Fotos gehören zur Fallgeschichte eines Londoner Bankers



HH für motorischen Konflikt. Es sind nur noch wenige Schießscheiben zu erkennen, sie zeigen bereits „Stechapfelform“, der Höhepunkt der Heilung ist also schon überschritten. Auf der ersten CCT-Aufnahme sind einige Schießscheibenringe sowie das Einschlagzentrum des Konfliktes noch zu erkennen, auf den nächsten Aufnahmen wird dies immer schwerer möglich.

Weitere 3 CCTs, auf denen man die motorische Schießscheibe bzw. deren allmähliches Verschwinden sehr gut beobachten kann. Ein Artefakt ist also ausgeschlossen!

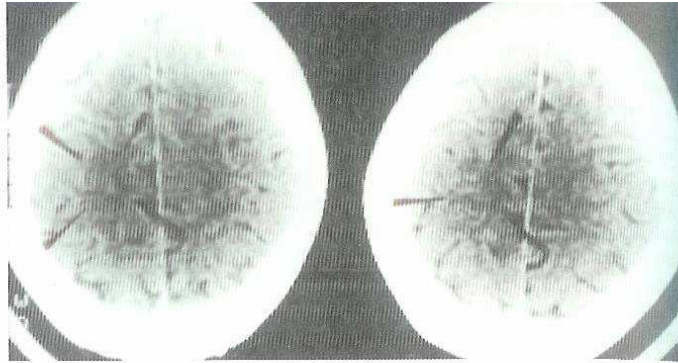
Die fünf abgebildeten CCT-Aufnahmen der gleichen Serie sind von einem Bankier aus einem Krankenhaus in London. Typischer Fall von Fehldiagnose: Der Patient hatte nach einem dramatischen Streit mit seinem Abteilungsleiter, bei dem ihm die Beförderung verweigert worden war, eine motorische Lähmung erlitten, mehr des rechten als des linken Beines, ebenso mehr des rechten als des



linken Armes. Nun wurde er durchuntersucht auf Krebserkrankungen (Krebstumor) und ein altes Leber-Ca. Das Konfliktbild (folgendes Abdomen¹⁶²-CT), sowie die c

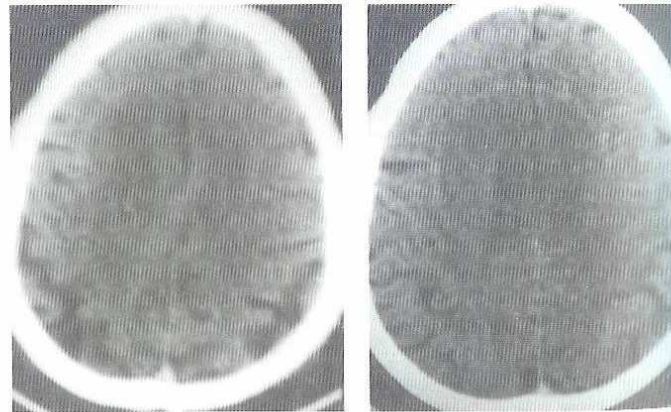
¹⁶² Abdomen = Bauch, Unterleib

FH del conflicto motor. El diseño concéntrico es ahora poco reconocible, mostrándose ya con la forma arrugada, también se ha superado ya el punto culminante de la reparación. En la primera imagen de la TAC son visibles algunos anillos, así como el centro del conflicto, en las fotos sucesivas cada vez es más difícil.



10.6.9 Fallbeispiel: Londoner Banker

Die nächsten 7 Fotos gehören zur Fallgeschichte eines Londoner Bankers



HH für motorischen Konflikt. Es sind nur noch wenige Schießscheiben zu erkennen, sie zeigen bereits „Stechapfelform“, der Höhepunkt der Heilung ist also schon überschritten. Auf der ersten CCT-Aufnahme sind einige Schießscheiberringe sowie das Einschlagzentrum des Konfliktes noch zu erkennen, auf den nächsten Aufnahmen wird dies immer schwerer möglich.

Weitere 3 CCTs, auf denen man die motorische Schießscheibe bzw. deren allmähliches Verschwinden sehr gut beobachten kann. Ein Artefakt ist also ausgeschlossen!

Die fünf abgebildeten CCT-Aufnahmen der gleichen Serie sind von einem Bankier aus einem Krankenhaus in London. Typischer Fall von Fehldiagnose: Der Patient hatte nach einem dramatischen Streit mit seinem Abteilungsleiter, bei dem ihm die Beförderung verweigert worden war, eine motorische Lähmung erlitten, mehr des rechten als des linken Beines, ebenso mehr des rechten als des

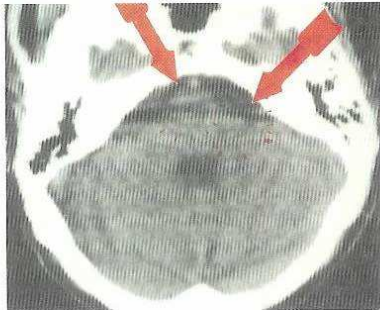


linken Armes. Nun wurde er durchuntersucht: kreas-Ca und ein altes Leber-Ca. Das konfliktfolgendes Abdomen¹⁶²-CT), sowie die

¹⁶² Abdomen = Bauch, Unterleib

Otras 3 TAC cerebrales en las que se puede observar bien la configuración concéntrica en la corteza motora o su progresiva desaparición. Hay que excluir la posibilidad de un artefacto.

Las cinco imágenes TAC presentadas de la misma serie pertenecen a un empleado de banca que estaba en el hospital en Londres. Típico caso de diagnóstico errado: el paciente, tras una dramática pelea con su jefe de departamento, que le había negado un ascenso, había sufrido una parálisis motora, más de la pierna derecha que de la izquierda, así como más del brazo derecho que del izquierdo. Entonces se le examinó y se encontró un viejo carcinoma del páncreas y un viejo carcinoma del hígado. Naturalmente no se pudo ver el carcinoma del intestino delgado en conflicto activo (siguiente TAC del abdomen) ni tampoco la correspondiente configuración concéntrica en fase CA (sección de TAC cerebral mostrada seguidamente).



Der zugehörige HH rechts lateral im Stammhirn (Pfeil rechts) für das solitäre Leber- bzw. Pankreas-Ca hat Vernarbung, etwas Oedem, evtl. wieder ganz leicht angedeutete Schießeisen-Konfiguration, die sich in das Oedem projiziert. Der Grund dafür könnte der sein, daß die für diesen HH zuständigen Konflikte (Verhungerungs-Konflikt und Konflikt, einen Brocken nicht verdauen zu können) auch beruf-

Während der motorische Konflikt für alle 4 Extremitäten, rechts stärker als links, schon in der *pel*-Phase ist und schon „Stechapfelform“ anzunehmen beginnt, d.h. den Höhepunkt schon überschritten hat, ist die „Dünndarm-Schießscheibe“ noch in voller Aktivität. D.h. also, daß ein mehrschichtiger Konflikt keineswegs auf allen Ebenen in gleichem Takt gelöst wird. Der eine Aspekt wird gelöst, während der andere noch aktiv bleibt.

Hätte man die Neue Medizin angewendet, dann hätte man gesehen, daß das Pankreas-Ca und das Leber-Ca, die im gleichen Takt gelaufen waren, schon eine ältere Vorgeschichte gehabt haben müssen und jetzt möglicherweise als Schiene wieder reaktiviert wurden. Während der corticale motorische, Konflikt schon mit einer epileptischen Krise (tonisch-klonischer Krampfanfall) den Höhepunkt der

Zufällig sehen wir im vorangehenden Bauch-
sion des Dünndarms. Man hätte dieses Stück
Stück exstirpiert und hätte dem Patienten die
verschaffen können. So aber führte man den
frisches Leber/Pankreas-Ca zurück und erklä-
bel. In diesem Fall entspricht der motorische
Nicht-weiter-aufsteigen-Könnens, bzw. des
Dünndarm-Ca dem damit verbundenen un-
daß die Neue Medizin durch ihre Differential-
nen der bisherigen Medizin um einiges voraus

Bei dieser Serie sieht man sehr gut, wie eine Konfiguration in der pcl-Phase in der einen Schicht der anderen schon mehr oder weniger zu verschiebungsfähig ist, d.h. brutaler Trennungskonflikt.

El FH relativo a la derecha lateralmente en el tronco cerebral (flecha a la derecha) del adenocarcinoma solitario del hígado o del páncreas presenta una cicatriz, un podo edematosa, con una probable nueva configuración concéntrica apenas visible en el edema. El motivo podría ser que los conflictos pertenecientes a este

FH (conflicto de morir de hambre y conflicto de no poder digerir un bocado) estaban ligados a la profesión y ahora reaccionaban de nuevo (vía). Además tenemos el FH (flecha izquierda) en el relé del intestino delgado para el conflicto de rencor indigesto. En conjunto tenemos entonces 3 diferentes formas concéntricas en el mismo paciente, de las cuales una (hígado/páncreas) está en un relé antiguo cicatrizado.

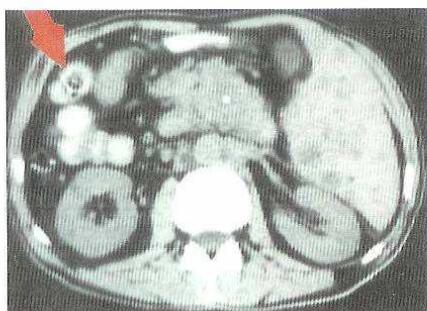
Mientras que el FH del conflicto motor para las cuatro extremidades, a la derecha más fuerte que a la izquierda, está ya en la fase PCL, y comienza a tomar una forma arrugada, es decir, ya ha superado el punto culminante, la configuración concéntrica del intestino delgado está todavía en plena actividad. Eso significa entonces que de ningún modo un conflicto con varios contenidos se resuelve en todos los niveles al mismo ritmo. Un aspecto se soluciona, mientras que otro permanece todavía activo.

Si se hubiese aplicado la Nueva Medicina, se habría podido ver que el adenocarcinoma del páncreas y del hígado, que se habían formado al mismo tiempo, debían haber tenido una historia precedente más antigua y ahora seguramente se reactivaban como vía. Mientras el conflicto cortical motor ha superado ya el punto culminante de la fase PCL con una crisis epiléptica (ataque convulsivo tónico-clónico), el conflicto del intestino delgado está todavía, como hemos dicho, en plena actividad.

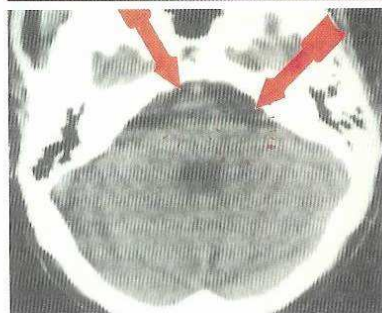
Casualmente en la TAC precedente del abdomen vemos el preíleo por oclusión del intestino delgado. Si se hubiese extirpado un pequeño trozo de intestino delgado se habría podido facilitar al paciente un pronóstico muy bueno. Pero el preíleo se reconduce a un supuesto adenocarcinoma reciente del hígado/páncreas y se le explicó al paciente que no era operable. En este caso el conflicto motor corresponde al pensamiento “de no poder subir más arriba” o de estar ligado y adenocarcinoma del intestino delgado corresponde al rencor indigesto que conlleva. Se ve que la Nueva Medicina gracias a su diagnóstico diferenciado en tres niveles es notablemente más perspicaz que la medicina anterior.

10.6.10. Ejemplo: conflicto de separación brutal

Konfiguration in ca-Phase (nachfolgend abgebildeter CCT-Schnitt) hatte man natürlich nicht sehen können.



Der Pfeil zeigt auf das aktive Dünndarm-Ca. Außerdem sehen wir die alten solitären Ca-Herde im Pankreas und in der Leber.



Der zugehörige HH rechts lateral im Stammhirn (Pfeil rechts) für das solitäre Leber- bzw. Pankreas-Ca hat Vernarbung, etwas Oedem, evtl. wieder ganz leicht angedeutete Schießscheiben-Konfiguration, die sich in das Oedem projiziert. Der Grund dafür könnte der sein, daß die für diesen HH zuständigen Konflikte (Verhungerungs-Konflikt und Konflikt, einen Brocken nicht verdauen zu können) auch beruf-

lich bedingt waren und nun wieder mitreagierten (Schiene!). Außerdem der HH (linker Pfeil) im Dünndarm-Relais für den unverdaulichen Ärger-Konflikt. Insgesamt haben wir also 3 verschiedene Schießscheiben bei dem gleichen Patienten, davon die eine (Leber/Pankreas) in einem alten vernarbten Relais.

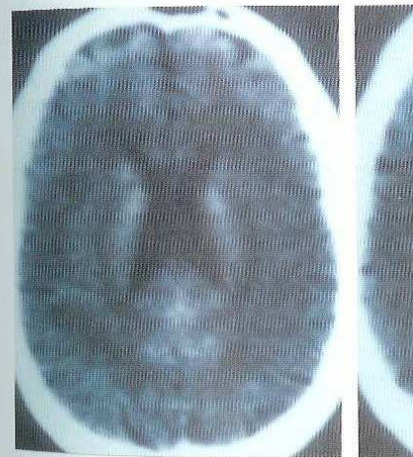
Während der motorische Konflikt für alle 4 Extremitäten, rechts stärker als links, schon in der pcl-Phase ist und schon „Stechapfelform“ anzunehmen beginnt, d.h. den Höhepunkt schon überschritten hat, ist die „Dünndarm-Schießscheibe“ noch in voller Aktivität. D.h. also, daß ein mehrschichtiger Konflikt keineswegs auf allen Ebenen in gleichem Takt gelöst wird. Der eine Aspekt wird gelöst, während der andere noch aktiv bleibt.

Hätte man die Neue Medizin angewendet, dann hätte man gesehen, daß das Pankreas-Ca und das Leber-Ca, die im gleichen Takt gelaufen waren, schon eine ältere Vorgeschichte gehabt haben müssen und jetzt möglicherweise als Schiene wieder reaktiviert wurden. Während der corticale motorische Konflikt schon mit einer epileptischen Krise (tonisch-klonischer Krampfanfall) den Höhepunkt der

pcl-Phase überschritten hat, ist der Dünndarm-Konflikt noch aktiv.

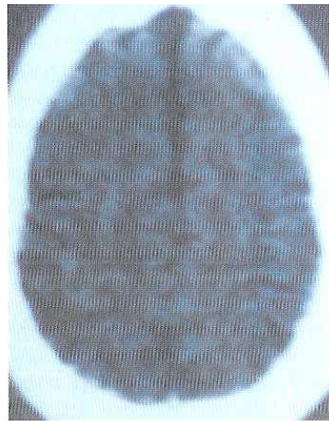
Zufällig sehen wir im vorangehenden Bauch-CT die Konfiguration des Dünndarms. Man hätte dieses Stück exstirpiert und hätte dem Patienten das Leben verschaffen können. So aber führte man den Patienten mit dem frischen Leber/Pankreas-Ca zurück und erklärte es als Schiene. In diesem Fall entspricht der motorische Konflikt dem Nicht-weiter-aufsteigen-Könnens, bzw. des Dünndarm-Ca dem damit verbundenen unvollständigen Verdauungs-Konflikt, daß die Neue Medizin durch ihre Differentialdiagnostik von der bisherigen Medizin um einiges voraus-

10.6.10 Fallbeispiel: Brutaler Trennungskonflikt



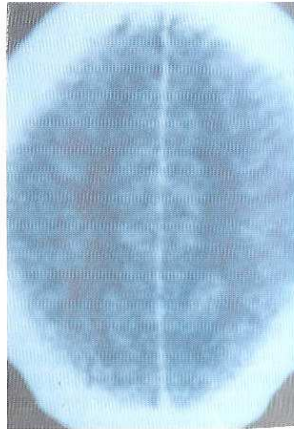
Bei dieser Serie sieht man sehr gut, wie eine Konfiguration in der pcl-Phase in der einen Schicht zu sehen ist, während in der anderen schon mehr oder weniger zu verschwinden beginnt, d.h. brutaler Trennungskonflikt.

En esta serie se ve muy bien como una configuración concéntrica edematizada en la fase PCL todavía es bien visible en un estrato y en el otro comienza a desaparecer más o menos; conflicto central del peristolio, es decir, conflicto de separación brutal en solución.



Auf dieser letzten Aufnahme ist die Schießecke fast völlig in Oedem aufgelöst.

10.6.11 Auf den nachfolgenden zwei Fotos sehen wir

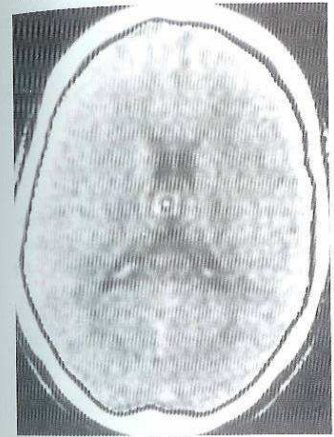


Wir sehen einen HH für einen sensorisch-postsensorischen (Periost)-Trennungskonflikt, der schon den Höhepunkt der pcl-Phase überschritten hat und schon

228

Stechapfel-Konfiguration anzunehmen beginnt. Auf or- gehörig: Exanthem¹⁶³, Urtikaria¹⁶⁴, Pruritus¹⁶⁵, verschie dasselbe - die sich in der Heilungsphase befindende auf

Im folgenden werden einige besonders interessante stellt, die allesamt die mit der Firma Siemens erarbe en erfüllen. Also: Keine Artefakte!



22.4.86

Schießeckenformation scharf markiert, Konflikt in Aktivität CCT mit Ko dematisiert, narben

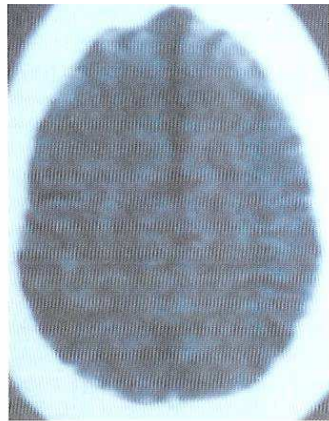
¹⁶³ Exanthem = entzündliche Hautveränderung der äußeren

¹⁶⁴ Urtikaria = Nesselsucht, Quaddelsucht

¹⁶⁵ Pruritus = Hautjucken mit zwanghaftem Kratzen

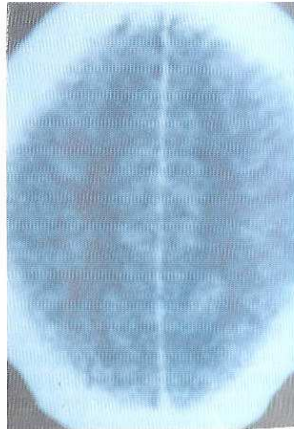
En esta última fotografía la configuración concéntrica está casi completamente disuelta en el edema

10.6.11. En las dos fotografías siguientes vemos...



Auf dieser letzten Aufnahme ist die Schießeibe fast völlig in Oedem aufgelöst.

10.6.11 Auf den nachfolgenden zwei Fotos sehen wir

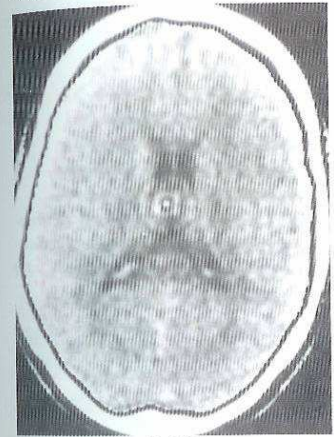


Wir sehen einen HH für einen sensorisch-postsensorischen (Periost)-Trennungskonflikt, der schon den Höhepunkt der pcl-Phase überschritten hat und schon

228

Stechpfeil-Konfiguration anzunehmen beginnt. Auf or- gehörig: Exanthem¹⁶³, Urtikaria¹⁶⁴, Pruritus¹⁶⁵, verschä- dasselbe - die sich in der Heilungsphase befindende auf

Im folgenden werden einige besonders interessante stellt, die allesamt die mit der Firma Siemens erarbe- en erfüllen. Also: Keine Artefakte!



22.4.86

Schießeibenformation scharf mar- kiert, Konflikt in Aktivität

CCT mit Ko- dematisiert, narben

¹⁶³ Exanthem = entzündliche Hautveränderung der äuß

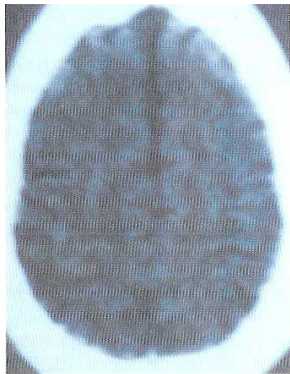
¹⁶⁴ Urtikaria = Nesselsucht, Quaddelsucht

¹⁶⁵ Pruritus = Hautjucken mit zwanghaftem Kratzen

Vemos un FH para un conflicto de separación (periostio) sensorial-postsensorial que ya ha superado el punto culminante de la fase PCL y ya ha comenzado a tomar la configuración arrugada.

A nivel orgánico encontramos: esantema, urticaria, prurito, diferentes clasificaciones para un único proceso en curso: la reparación del estrato epidérmico externo.

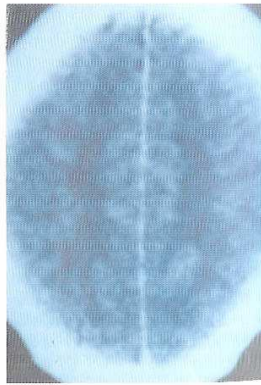
Seguidamente se presentan brevemente algunas TAC cerebrales particularmente interesantes, que cubren todos los criterios de exclusión elaborados con la firma Siemens. Por lo tanto: ningún artefacto.



Auf dieser letzten Aufnahme ist die Schießeibe fast völlig in Oedem aufgelöst.

10.6.11 Auf den nachfolgenden zwei Fotos sehen wir

...



Wir sehen einen HH für einen sensorisch-postsensorischen (Periost)-Trennungskonflikt, der schon den Höhepunkt der pcl-Phase überschritten hat und schon

228

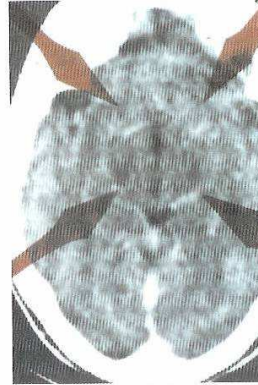
Stechapfel-Konfiguration anzunehmen beginnt. Auf organischer Ebene sind gehörig: Exanthem¹⁶³, Urtikaria¹⁶⁴, Pruritus¹⁶⁵, verschiedene Begriffe für ein dasselbe - die sich in der Heilungsphase befindende äußere Hautschicht.

Im folgenden werden einige besonders interessante CCTs nur kurz vorgestellt, die allesamt die mit der Firma Siemens erarbeiteten Ausschlußkriterien erfüllen. Also: Keine Artefakte!



22.4.86

Schießeibenformation scharf markiert, Konflikt in Aktivität



5.9.86

CCT mit Kontrast, Ringformation demaisiert, bereits gliomatös am Narben

¹⁶³ Exanthem = entzündliche Hautveränderung der äußeren Haut

¹⁶⁴ Urtikaria = Nesselsucht, Quaddelsucht

¹⁶⁵ Pruritus = Hautjucken mit zwanghaftem Kratzen

22.4.86

Configuración concéntrica muy nítida, conflicto activo.

5.9.86

TAC cerebral con contraste, configuración de anillos edematizada, ya gliomatosa en vías de cicatrización.

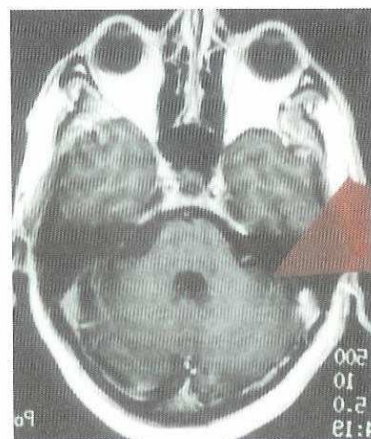


Entwicklung einer Schießscheibenformation bei einem jungen Patienten.



HH in aktiver Schießscheiben-Konfiguration für lang andauernden Todesangst-Konflikt im Stammhirn.

Der Patient war auf offener Straße überfallen und mit dem Messer bedroht worden.



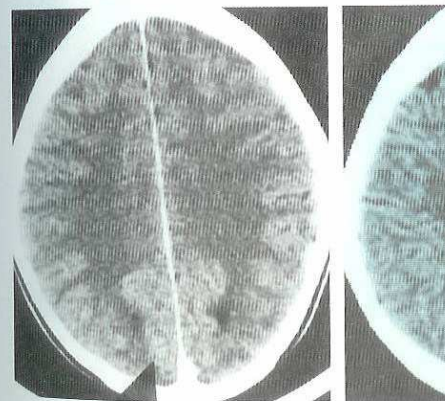
In der entsprechenden Kernspin-Aufnahme lassen sich ebenfalls die Ringstrukturen des aktiven HH erkennen.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Konflikt, wie in diesem Fall, sehr lange andauert hat und sehr intensiv war.

Ringformation, die von der linken Seite her durch zwei oedematisierte weitere Herde „eingedellt“ wird.



Entwicklung der Ringformation im CCT bei einer j



3.11.89

HH in scharfer Schießscheiben-Konfiguration

HH vernarb- noch erkenn

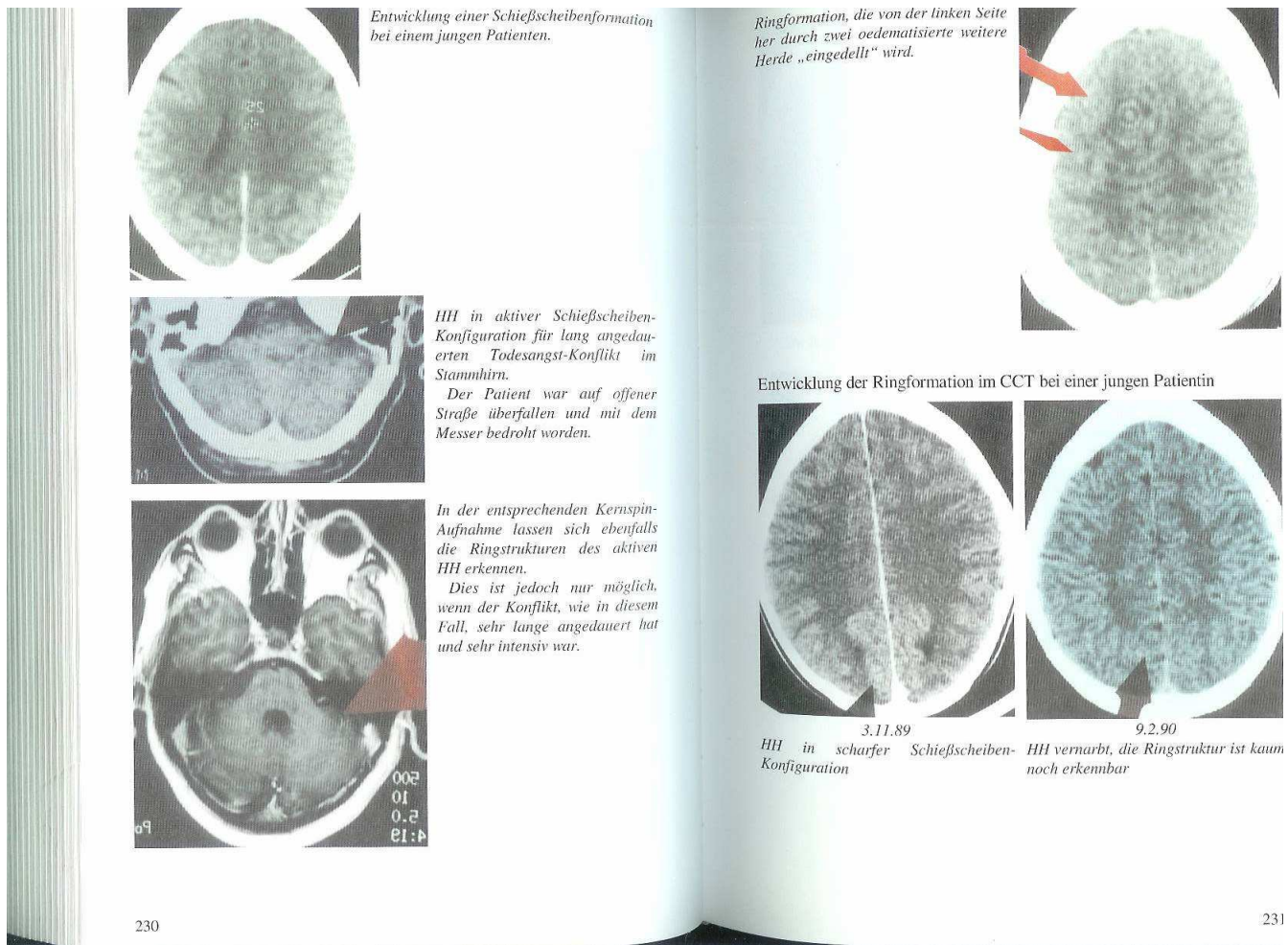
Evolución de una configuración concéntrica en un joven paciente.

FH en configuración concéntrica activa para un conflicto, de larga duración, de miedo de la muerte en el tronco cerebral.

El paciente había sido agredido y amenazado con un cuchillo por la calle.

En este caso, en la correspondiente sección de RM se pueden reconocer excepcionalmente las estructuras en anillo del Foco de Hamer activo.

Sin embargo eso sólo es posible si el conflicto, como en este caso, ha durado mucho tiempo y ha sido muy intenso.

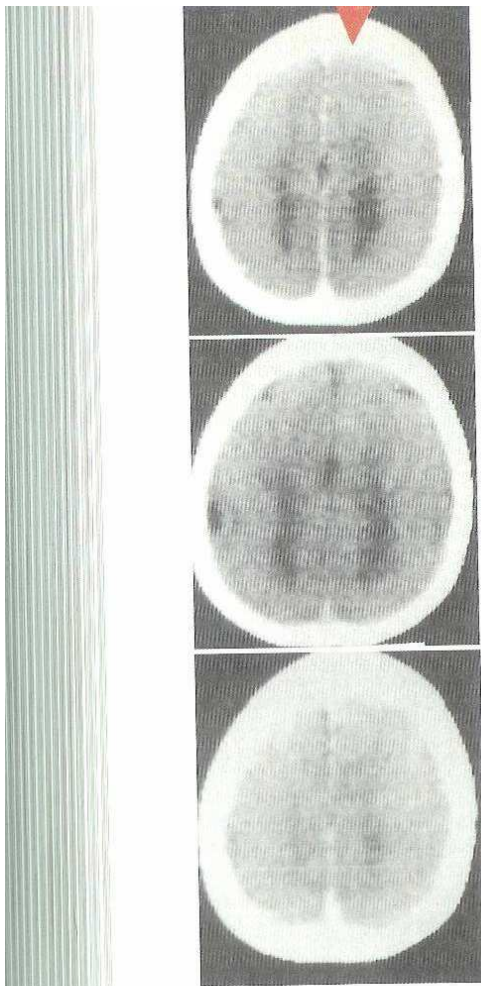


Configuracin en anillos que es “aplastada” por el lado izquierdo a causa de otros dos focos edematizados.

Evolucin de la configuracin en anillos en la TAC cerebral de una joven paciente.

FH en configuracin conctrica ntida.

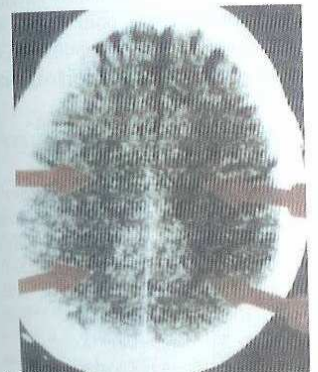
FH cicatrizado, la estructura en anillos a duras penas se reconoce.



CTI-Serie mit deutlicher, unterschiedlich oedematizierter Ringstruktur mit Massenverschiebung



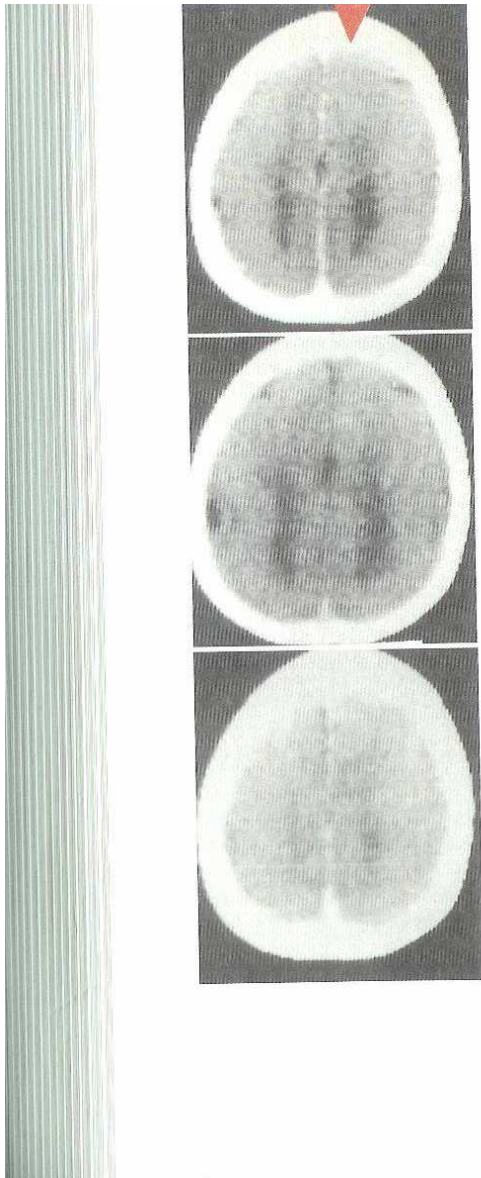
Ein österreichischer Patient: Zwei HH mit



Zwei deutliche, sich überschneidende, HH
Oedemringe
HH
form
eina
ist v

Serie de TAC cerebrales con estructura en anillos nítida, diversamente edematizada con proceso de movimiento expansivo.

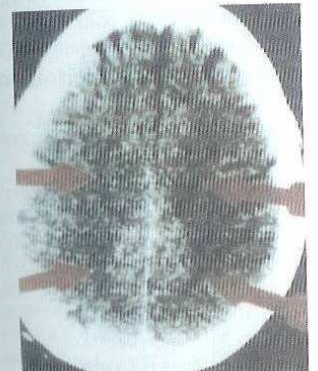
Un paciente austriaco: dos FH con estructura en anillos edematizada.



CCI-Serie mit deutlicher, unterschiedlich oedematisierter Ringstruktur mit Massenverschiebung



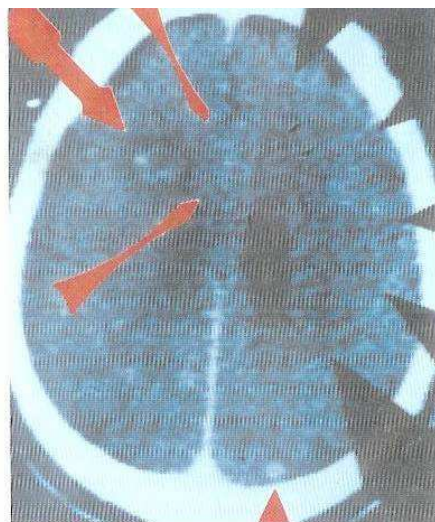
Ein österreichischer Patient: Zwei HHe mit



Zwei deutliche, sich überschneidende, HH b
form
einan
ist vo

Dos anillos edematosos bien visibles.

FH en el que tres formaciones diferentes en anillo se proyectan una al lado de la otra o una en la otra. La de la izquierda está completamente en edema de solución.



Die folgende sehr interessante Aufnahme zeigt einen halbkreisförmigen HH rechts für einen motorischen Konflikt in pcl-Phase mit Lösungsödem. Daneben (schlanke Pfeile) ein zentraler HH in der ca-Phase im Zuckerrelais. Weiter ein schon weitgehend abgeheilter HH links, bereits durch Glia-Einlagerung weiß anfärbbar, die rechte Schulter betreffend, genauer gesagt: rekalzifizierte Osteolysen bei Selbstwerteinbruch-Konflikt im Partner-Verhältnis. Unten ein fast völlig geheilter HH in der rechten Sehirinde entsprechend einem alten Angst-im-Nacken-Konflikt.

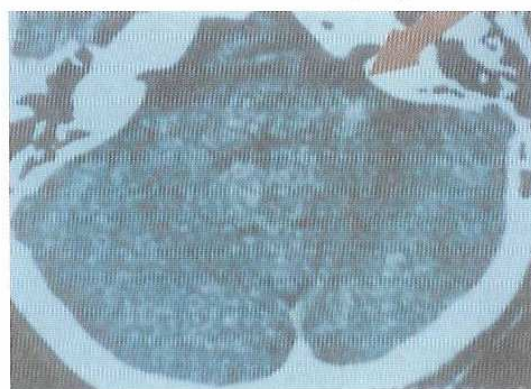
Im Abdomen-CT sehen wir das zugehörige sog. solitäre Leber-Ca des kleinen Mädchens aus Südfrankreich:

Konflikt: Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft. Als ein Supermarkt daneben aufmachte, und die Umsätze entsprechend zurückgingen, jammerte der Vater dauernd: „O Gott, wir werden verhungern, wieso auch nicht? Das ist Angst, die monatelang angeht.“

Anfangs fiel es mir sehr im Gegensatz zu dem ausgedehnten nichts besonders Auffällige Konfiguration erst verstand. Formationen in der ca- und sind solche Bilder sehr klar

10.6.12 Fallbeispiel: Fünfjähriges Mädchen mit Verhungerungs-Konflikt

CCT und Abdomen CT eines fünfjährigen Mädchens



Der HH im Leber-Relais (Stammhirn lateral rechts) zeigt deutliche Schießscheiben-Konfiguration, d.h. der zugehörige Verhungerungs-Konflikt muß noch aktiv sein.

10.6.13 Fallbeispiel

CT der aushängenden Brust einer rechtshändigen Frau mit abgelaufenem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt, die in der pcl-Phase wochenlang starken Nachtschweiß, d.h. eine Tbc der linken Brust hatte. Im CT der Brust in Hängelage läßt sich die frische Kaverne in der linken Brust (linker Pfeil) sehr gut erkennen. Dies wäre bei einer normalerweise üblichen Mammographie nicht

La siguiente fotografía, muy interesante, muestra un FH en forma semicircular a la derecha por un conflicto motor en la fase PCL con edema de solución.

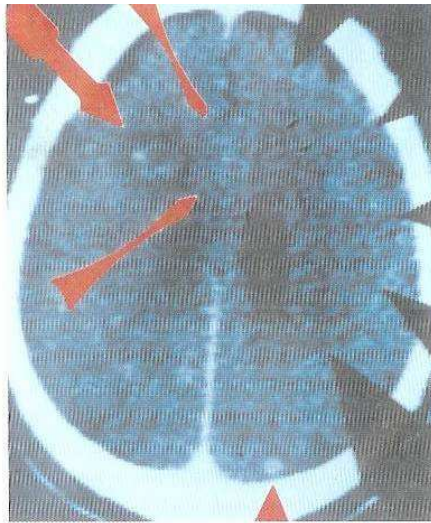
Al lado (flecha fina) un FH central en la fase CA en el relé del azúcar.

Más adelante un FH ya muy cicatrizado a la izquierda, que puede tomar ya un color blanco a causa de la acumulación de tejido glial, que tiene que ver con la espalda derecha o, con más precisión: osteolisis recalcificada por conflicto de desvaloración de sí en la relación con el partner.

Abajo un FH casi completamente cicatrizado en la corteza visual derecha correspondiente a un antiguo conflicto de miedo en la nuca.

10.6.12. Ejemplo: niña de cinco años con conflicto de miedo a morir de hambre

TAC cerebral y TAC abdominal de una niña de cinco años.



Die folgende sehr interessante Aufnahme zeigt einen halbkreisförmigen HH rechts für einen motorischen Konflikt in pcl-Phase mit Lösungsödem. Daneben (schlanke Pfeile) ein zentraler HH in der ca-Phase im Zuckerrelais. Weiter ein schon weitgehend abgeheilter HH links, bereits durch Glia-Einlagerung weiß anfärbbar, die rechte Schulter betreffend, genauer gesagt: rekalzifizierte Osteolysen bei Selbstwerteinbruch-Konflikt im Partner-Verhältnis. Unten ein fast völlig geheilter HH in der rechten Sehirinde entsprechend einem alten Angst-im-Nacken-Konflikt.

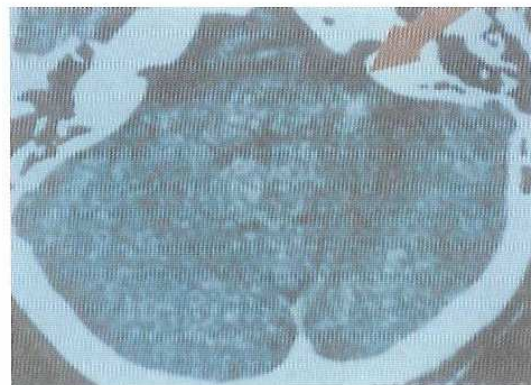
Im Abdomen-CT sehen wir das zugehörige sog. solitäre Leber-Ca des kleinen Mädchens aus Südfrankreich:

Konflikt: Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft. Als ein Supermarkt daneben aufmachte, und die Umsätze entsprechend zurückgingen, jammerte der Vater dauernd: „O Gott, wir werden verhungern, wieso auch nicht? Das ist Angst, die monatelang angeht.“

Anfangs fiel es mir sehr im Gegensatz zu dem ausgedehnten nichts besonders Auffällige Konfiguration erst verstand. Formationen in der ca- und sind solche Bilder sehr klar

10.6.12 Fallbeispiel: Fünfjähriges Mädchen mit Verhungerungs-Konflikt

CCT und Abdomen CT eines fünfjährigen Mädchens

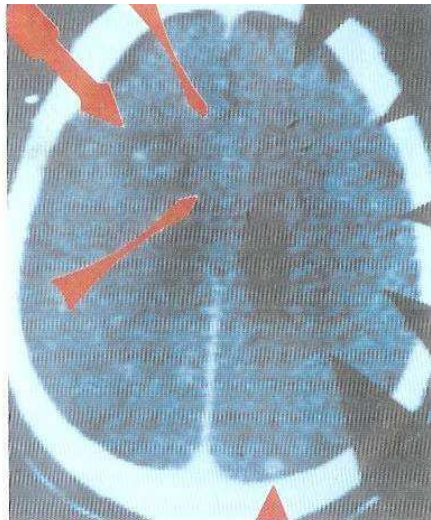


Der HH im Leber-Relais (Stammhirn lateral rechts) zeigt deutliche Schießscheiben-Konfiguration, d.h. der zugehörige Verhungerungs-Konflikt muß noch aktiv sein.

10.6.13 Fallbeispiel

CT der aushängenden Brust einer rechtshändigen Frau mit abgelaufenem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt, die in der pcl-Phase wochenlang starken Nachtschweiß, d.h. eine Tbc der linken Brust hatte. Im CT der Brust in Hängelage läßt sich die frische Kaverne in der linken Brust (linker Pfeil) sehr gut erkennen. Dies wäre bei einer normalerweise üblichen Mammographie nicht

El FH en el relé del hígado (tronco cerebral lateral a la derecha) muestra una nítida configuración concéntrica, es decir, el correspondiente conflicto de miedo a morir de hambre todavía debía estar activo.



Die folgende sehr interessante Aufnahme zeigt einen halbkreisförmigen HH rechts für einen motorischen Konflikt in pcl-Phase mit Lösungsödem. Daneben (schlanke Pfeile) ein zentraler HH in der ca-Phase im Zuckerrelais. Weiter ein schon weitgehend abgeheilter HH links, bereits durch Glia-Einlagerung weiß anfärbbar, die rechte Schulter betreffend, genauer gesagt: rekalzifizierte Osteolysen bei Selbstwerteinbruch-Konflikt im Partner-Verhältnis. Unten ein fast völlig geheilter HH in der rechten Sehirinde entsprechend einem alten Angst-im-Nacken-Konflikt.

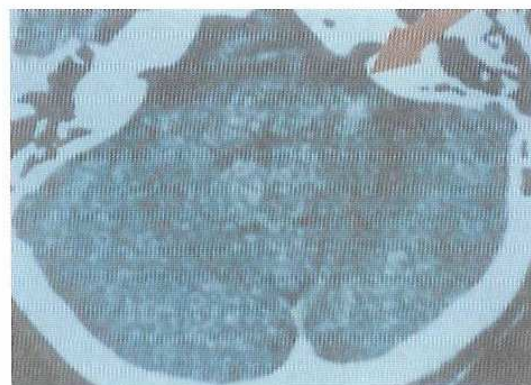
Im Abdomen-CT sehen wir das zugehörige sog. solitäre Leber-Ca des kleinen Mädchens aus Südfrankreich:

Konflikt: Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft. Als ein Supermarkt daneben aufmachte, und die Umsätze entsprechend zurückgingen, jammerte der Vater dauernd: „O Gott, wir werden verhungern, wieso auch nicht? Das ist Angst, die monatelang angeht.“

Anfangs fiel es mir sehr gegenstandslos an, im Gegensatz zu dem ausgeprägten, nichts besonders Auffälliges. Die Konfiguration erst verstärkte Formationen in der ca- und sind solche Bilder sehr klar.

10.6.12 Fallbeispiel: Fünfjähriges Mädchen mit Verhungers-Konflikt

CCT und Abdomen CT eines fünfjährigen Mädchens



Der HH im Leber-Relais (Stammhirn lateral rechts) zeigt deutliche Schießscheiben-Konfiguration, d.h. der zugehörige Verhungers-Konflikt muß noch aktiv sein.

10.6.13 Fallbeispiel

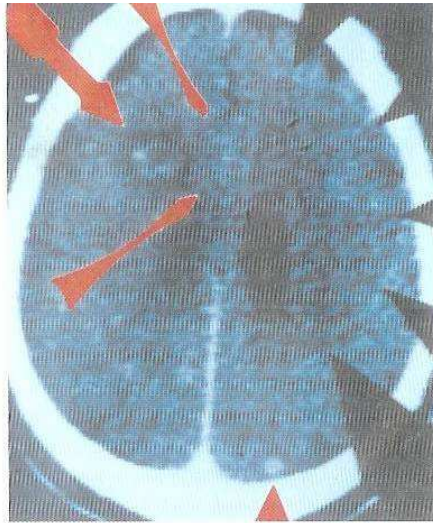
CT der aushängenden Brust einer rechtshändigen Frau mit abgelaufenem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt, die in der pcl-Phase wochenlang starken Nachtschweiß, d.h. eine Tbc der linken Brust hatte. Im CT der Brust in Hängelage läßt sich die frische Kaverne in der linken Brust (linker Pfeil) sehr gut erkennen. Dies wäre bei einer normalerweise üblichen Mammographie nicht.

En la TAC abdominal vemos el correspondiente adenocarcinoma solitario del hígado de la niña de Francia meridional:

Conflicto: los padres tenían una tienda de alimentación. Cuando al lado se construyó un supermercado y su facturación disminuyó, el padre se lamentó repetidamente: “Dios mío, moriremos de hambre”. La niña de 5 años se lo tomó al pie de la letra, ¿y cómo no hacerlo? Al final la niña murió por este miedo a morir de hambre que duró durante meses.

Al principio me resultó muy difícil entender un cuadro así, porque contrariamente al informe hepático, el cerebro no mostraba nada particularmente vistoso. Pero una vez que se ha comprendido la configuración concéntrica, o se ha aprendido a distinguir entre las distintas formaciones en la fase CA y en la fase PCL, entonces estas imágenes son claras y comprensibles.

10.6.13. Ejemplo: TBC y cáncer de mama



Die folgende sehr interessante Aufnahme zeigt einen halbkreisförmigen HH rechts für einen motorischen Konflikt in pcl-Phase mit Lösungsödem. Daneben (schlanke Pfeile) ein zentraler HH in der ca-Phase im Zuckerrelais. Weiter ein schon weitgehend abgeheilter HH links, bereits durch Glia-Einlagerung weiß anfärbbar, die rechte Schulter betreffend, genauer gesagt: rekalzifizierte Osteolysen bei Selbstwerteinbruch-Konflikt im Partner-Verhältnis. Unten ein fast völlig geheilter HH in der rechten Sehirinde entsprechend einem alten Angst-im-Nacken-Konflikt.

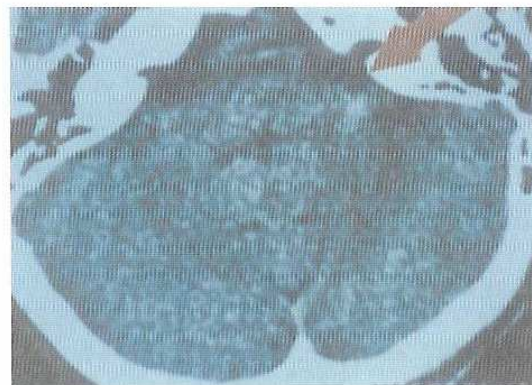
Im Abdomen-CT sehen wir das zugehörige sog. solitäre Leber-Ca des kleinen Mädchens aus Südfrankreich:

Konflikt: Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft. Als ein Supermarkt daneben aufmachte, und die Umsätze entsprechend zurückgingen, jammerte der Vater dauernd: „O Gott, wir werden verhungern, wieso auch nicht? Das ist Angst, die monatelang angeht.“

Anfangs fiel es mir sehr gegenstandslos an, da es im Gegensatz zu dem ausgesprochen auffälligen Konfigurationsmerkmal erst verstarb. Formationen in der ca- und sind solche Bilder sehr klar.

10.6.12 Fallbeispiel: Fünfjähriges Mädchen mit Verhungerungs-Konflikt

CCT und Abdomen CT eines fünfjährigen Mädchens

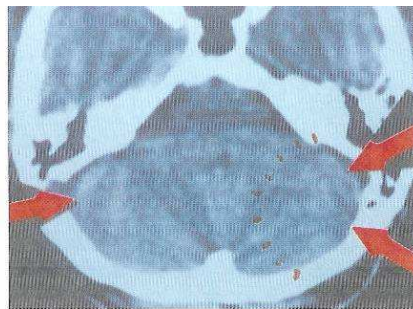


Der HH im Leber-Relais (Stammhirn lateral rechts) zeigt deutliche Schießscheiben-Konfiguration, d.h. der zugehörige Verhungerungs-Konflikt muß noch aktiv sein.

10.6.13 Fallbeispiel

CT der aushängenden Brust einer rechtshändigen Frau mit abgelaufenem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt, die in der pcl-Phase wochenlang starken Nachtschweiß, d.h. eine Tbc der linken Brust hatte. Im CT der Brust in Hängelage läßt sich die frische Kaverne in der linken Brust (linker Pfeil) sehr gut erkennen. Dies wäre bei einer normalerweise üblichen Mammographie nicht möglich.

TAC de los pechos colgando de una mujer diestra, con conflicto finalizado de preocupación madre-niño, que en la fase PCL había tenido un fuerte sudor nocturno durante semanas, es decir, una TBC de la mama izquierda. En la TAC del seno se reconoce muy bien la caverna reciente en la mama izquierda (flecha izquierda). Esto no sería posible con una simple mamografía, porque el seno se oprime. En la mama derecha (flecha derecha) vemos otra caverna cicatrizada, pero más antigua.



HH mit Oedem im rechten lateralen Kleinhirn (rechte Pfeile). Wir können diesem Oedem nicht ansehen, ob eine Tbc geholfen hat, auf organischer Ebene das Mamma-Ca zu verkäsen oder ob dies nicht der Fall war. Die Vorgänge im Gehirn sind die gleichen.

Auch auf der linken Kleinhirnseite (linker Pfeil) ist eine alte Narbe sichtbar, die eine alte Narbe sichtbar, die

einem früheren Mamma-Ca der rechten Brust mit nachgefolgter Tbc entspricht (Partner-Konflikt).

10.6.14 Fallbeispiel: Adenoidem Brustkrebs links



Junge Frau mit 2 aktiven, Zellvermehrung machenden Brustdrüsen-Tumoren.

Der untere Tumor der rechtehändigen Frau entspricht einem schon sehr lange gehenden Tochter/Mutter-Streit-Konflikt.

Der obere kleinere einem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt wegen einer Amniozentese¹⁶⁶ zum Zweck des Vaterschaftsnachweises, da sie ein uneheliches Kind erwartete.

Die Patientin bekam eine furchtbare Angst, daß das Kind durch diesen Eingriff geschädigt

worden sei. In der Folgezeit lief der gesamte Vaterschaftsprozess auf dieser eingefahrenen Schiene, obgleich das Kind längst gesund geboren war.

¹⁶⁶ Amniozentese = Fruchtwasseruntersuchung

Mammographie der linken Brust. Man sieht den großen und den kleineren adenoiden Knoten. Die Patientin hatte aber keinerlei Beschwerden und hat in dieser Brust beim Stillen ihres Kindes sogar mehr Milch gehabt als in der rechten.



Diese CCT-Aufnahme des Kleinhirns zeigt im rechten lateralen Bereich zwei aktive Schießscheibenring-Formationen, die sich überlappen. Die beiden HHe in Aktivität entsprechen den hängend-aktiven Mutter/Kind- bzw. Tochter/Mutter-Konflikten.



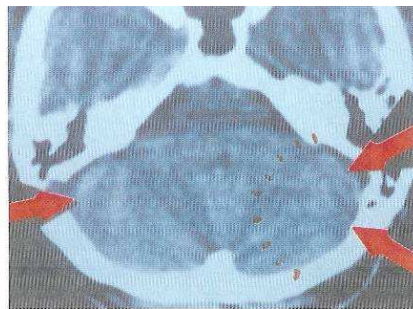
10.6.15 Fallbeispiel: Kleiner französischer Jungen

Zwei Hirn-CT-Bilder und eine Lungenaufnahme zeigen den kleinen Kameraden aus Spaß an einen Baum geklettert, als sie kämen zurück mit Kanonen und würden ihn nicht loslassen. Er konnte sich nicht befreien, weil er mit den Händen gefesselt war. Er wurde erst spät abends von einem Spaziergänger gefunden.

FH con edema en el cerebelo lateral derecho (flecha derecha). Sólo con la observación de este edema no se puede afirmar si el adenocarcinoma de mama a nivel orgánico ha sido caseificado por TBC. Los procesos en el cerebelo son iguales.

También en el lado izquierdo del cerebelo (flecha izquierda) se ve una vieja cicatriz que corresponde a un anterior adenocarcinoma de la mama derecha con sucesiva TBC (conflicto del partner).

10.6.14. Ejemplo: cáncer de mama adenoido a la izquierda



HH mit Oedem im rechten lateralen Kleinhirn (rechte Pfeile). Wir können diesem Oedem nicht ansehen, ob eine Tbc geholfen hat, auf organischer Ebene das Mamma-Ca zu verkäsen oder ob dies nicht der Fall war. Die Vorgänge im Gehirn sind die gleichen.

Auch auf der linken Kleinhirnseite (linker Pfeil) ist eine alte Narbe sichtbar, die

einem früheren Mamma-Ca der rechten Brust mit nachgefolgter Tbc entspricht (Partner-Konflikt).

10.6.14 Fallbeispiel: Adenoidem Brustkrebs links



Junge Frau mit 2 aktiven, Zellvermehrung machenden Brustdrüsen-Tumoren.

Der untere Tumor der rechtehändigen Frau entspricht einem schon sehr lange gehenden Tochter/Mutter-Streit-Konflikt.

Der obere kleinere einem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt wegen einer Amniozentese¹⁶⁶ zum Zweck des Vaterschaftsnachweises, da sie ein uneheliches Kind erwartete.

Die Patientin bekam eine furchtbare Angst, daß das Kind durch diesen Eingriff geschädigt

worden sei. In der Folgezeit lief der gesamte Vaterschaftsprozess auf dieser eingefahrenen Schiene, obgleich das Kind längst gesund geboren war.

¹⁶⁶ Amniozentese = Fruchtwasseruntersuchung

Mammographie der linken Brust. Man sieht den großen und den kleineren adenoiden Knoten. Die Patientin hatte aber keinerlei Beschwerden und hat in dieser Brust beim Stillen ihres Kindes sogar mehr Milch gehabt als in der rechten.



Diese CCT-Aufnahme des Kleinhirns zeigt im rechten lateralen Bereich zwei aktive Schießscheibenring-Formationen, die sich überlappen. Die beiden HHE in Aktivität entsprechen den hängend-aktiven Mutter/Kind- bzw. Tochter/Mutter-Konflikten.

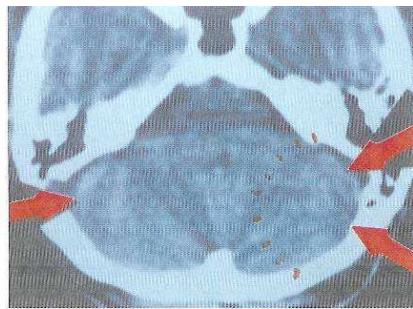


10.6.15 Fallbeispiel: Kleiner französischer Jungen

Zwei Hirn-CT-Bilder und eine Lungenaufnahme zeigen den kleinen Jungen aus Spaß an einen Baum geklettert, als sie kamen zurück mit Kanonen und würden ihn nicht lassen. Er konnte sich nicht befreien, weil er mit den Händen gefesselt war. Er wurde erst spät abends von einem Spaziergänger gefunden.

Joven mujer con dos proliferaciones celulares activas que forman tumores en las glándulas mamarias.

El tumor inferior de la mujer diestra corresponde a un conflicto de pelea madre/hija que dura ya mucho tiempo. El superior más pequeño corresponde a un conflicto de preocupación madre/niño a causa de una amniocentesis producida para realizar la paternidad, dado que estaba embarazada de un niño ilegítimo. La paciente tenía un miedo terrible de que el niño sufriera lesiones por esta operación. Seguidamente todo el proceso de la paternidad continuó en esta vía, aunque el niño hubiese nacido ya hace tiempo.



HH mit Oedem im rechten lateralen Kleinhirn (rechte Pfeile). Wir können diesem Oedem nicht ansehen, ob eine Tbc geholfen hat, auf organischer Ebene das Mamma-Ca zu verkäsen oder ob dies nicht der Fall war. Die Vorgänge im Gehirn sind die gleichen.

Auch auf der linken Kleinhirnseite (linker Pfeil) ist eine alte Narbe sichtbar, die

einem früheren Mamma-Ca der rechten Brust mit nachgefolgter Tbc entspricht (Partner-Konflikt).

10.6.14 Fallbeispiel: Adenoidem Brustkrebs links



Junge Frau mit 2 aktiven, Zellvermehrung machenden Brustdrüsen-Tumoren.

Der untere Tumor der rechts-händigen Frau entspricht einem schon sehr lange gehenden Tochter/Mutter-Streit-Konflikt.

Der obere kleinere einem Mutter/Kind-Sorge-Konflikt wegen einer Amniozentese¹⁶⁶ zum Zweck des Vaterschaftsnachweises, da sie ein uneheliches Kind erwartete.

Die Patientin bekam eine furchtbare Angst, daß das Kind durch diesen Eingriff geschädigt

worden sei. In der Folgezeit lief der gesamte Vaterschaftsprozess auf dieser eingefahrenen Schiene, obgleich das Kind längst gesund geboren war.

¹⁶⁶ Amniozentese = Fruchtwasseruntersuchung

Mammographie der linken Brust. Man sieht den großen und den kleineren adenoiden Knoten. Die Patientin hatte aber keinerlei Beschwerden und hat in dieser Brust beim Stillen ihres Kindes sogar mehr Milch gehabt als in der rechten.



Diese CCT-Aufnahme des Kleinhirns zeigt im rechten lateralen Bereich zwei aktive Schießscheibenring-Formationen, die sich überlappen. Die beiden HHe in Aktivität entsprechen den hängend-aktiven Mutter/Kind- bzw. Tochter/Mutter-Konflikten.



10.6.15 Fallbeispiel: Kleiner französischer Jungen

Zwei Hirn-CT-Bilder und eine Lungenaufnahme zeigen den seine Kameraden aus Spaß an einen Baum gebundenen Jungen. Er kam zurück mit Kanonen und würden ihn nicht befreien, weil er mit den Händen war. Er wurde erst spät abends von einem Spaziergänger

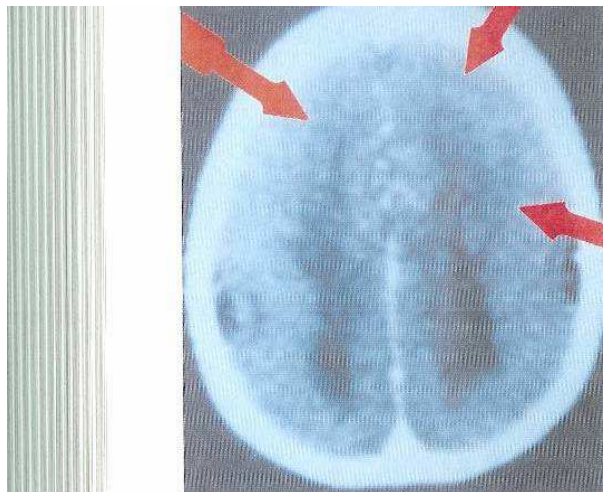
Mamografía de la mama izquierda. Se ven el nódulo adenoido grande y el más pequeño. Sin embargo la paciente no tenía ningún dolor y en esta mama, durante la lactancia de su niño, tenía incluso más leche que en la derecha.

Esta imagen de TAC cerebral del cerebelo muestra en la zona lateral derecha dos configuraciones concéntricas activas, que se superponen en parte. Los dos FH en

aktivität entsprechen a los conflictos activos en suspenso madre/niño o madre/hija.

10.6.15. Ejemplo: muchachito francés

Dos imágenes de TAC cerebral y una fotografía pulmonar de un niño de ocho años al que sus compañeros habían atado a un árbol para divertirse. Dijeron que volverían con una pistola y que le dispararían. El niño no pudo liberarse porque le habían atado las manos al árbol. Fue liberado por la tarde por una persona que paseaba por allí.



CT aus den 111 für eine motori-
sche Lähmung beider Arme zeigt.
Man sieht die einzelnen Schieß-
scheibenringe im motorischen
Rindenzentrum.

Die Arme des Jungen waren
weitgehend gelähmt.



Die Lungenaufnahme zeigt einen
großen Lungenrundherd und weitere
kleinere.

Das Kind hatte monatelang jede
Nacht im Traum das schreckliche
Erlebnis wieder geträumt und Todes-
angst ausgestanden. Es gelang ihm
schließlich den Konflikt zu lösen.
Durch die übermäßig lange Kon-
fliktdauer starb er vor allem an den
Folgen einer Lungentuberkulose. Der
Junge hatte wochenlang starken
Nachtschweiß gehabt, subfebrile
Temperaturen und Hämoptoe¹⁶⁷, er
wurde aber nicht auf Tuberkulose
behandelt, weil der Lungentumor
ganz im Vordergrund der Behandlung
stand.

Auf dem CT des Stammhirns
sehen wir den zugehörigen HH
Alveolar-Relais im rech-
Stammhirn in pcl-Phase mit
sungsoedem (Pfeil). Trotz so
eindeutiger Diagnose will le
noch immer niemand an Tu-
kulose denken.

10.6.16 Drei Fallbe

Wir sehen ein generalisie-
Marklager-Oedem als Zei-
der Heilung und des wieder-
langen Selbstwertes jedoch
besonderer Betonung des Re-
für den linken Schenkelhals (g-
ster Konflikt „Das halte ich n-
durch!“) und des Relais für
rechte Schulter entsprechen
einem gelösten Part-
Selbstwerteinbruch-Konflikt.

Zustand nach gelösten Sel-
wert-Konflikten eines a-
Herrn, dem man den Vorsitz
Dorfverschönerungsausschu-
weggenommen hatte. Die K-
fliktlösung war dadurch ein-
treten, daß der Bürgermeister

TAC cerebral que muestra el FH para una parálisis motora de los dos brazos. Se ven los anillos individuales concéntricos en el centro cortical motor. Los brazos del muchacho estaban casi totalmente paralizados.

La radiografía de los pulmones muestra un gran adenocarcinoma pulmonar y otro más pequeño.

El niño, cada noche durante meses, revivió en sueños la terrible experiencia sufriendo el miedo a la muerte. Al final consiguió resolver el conflicto.

Murió a continuación de una tuberculosis pulmonar, sobretodo a causa de una duración excesivamente larga del conflicto.

El muchacho tuvo un fuerte sudor nocturno durante semanas, valores de temperatura subfebriles y hemotisis, pero no se le trató la tuberculosis, porque se sostenía que lo primero que había que curar era el tumor pulmonar.



CT aus den mit für eine motori-
sche Lähmung beider Arme zeigt.
Man sieht die einzelnen Schieß-
scheibenringe im motorischen
Rindenzentrum.

Die Arme des Jungen waren
weitgehend gelähmt.



Die Lungenaufnahme zeigt einen
großen Lungenrundherd und weitere
kleinere.

Das Kind hatte monatelang jede
Nacht im Traum das schreckliche
Erlebnis wieder geträumt und Todes-
angst ausgestanden. Es gelang ihm
schließlich den Konflikt zu lösen.
Durch die übermäßig lange Kon-
fliktdauer starb er vor allem an den
Folgen einer Lungentuberkulose. Der
Junge hatte wochenlang starken
Nachtschweiß gehabt, subfebrile
Temperaturen und Hämoptoe¹⁶⁷, er
wurde aber nicht auf Tuberkulose
behandelt, weil der Lungentumor
ganz im Vordergrund der Behandlung
stand.

Auf dem CT des Stammhirns
sehen wir den zugehörigen H
Alveolar-Relais im rec
Stammhirn in pcl-Phase mit
sungsodem (Pfeil). Trotz s
eindeutiger Diagnose will le
noch immer niemand an Tu
kulose denken.

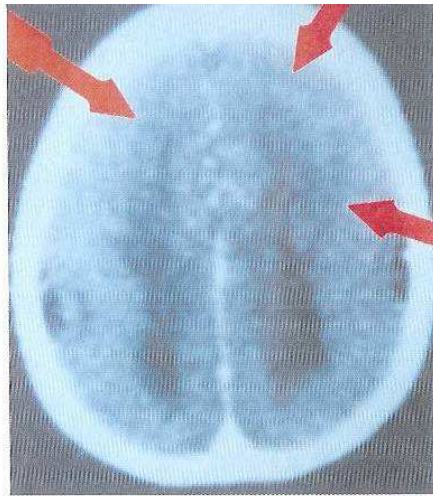
10.6.16 Drei Fallbe

Wir sehen ein generalisi
Marklager-Oedem als Ze
der Heilung und des wied
langen Selbstwertes jedoch
besonderer Betonung des R
für den linken Schenkelhals (s
ster Konflikt „Das halte ich
durch!“) und des Relais fü
rechte Schulter entsprec
einem gelösten Par
Selbstwerteinbruch-Konflikt.

Zustand nach gelösten Se
wert-Konflikten eines
Herrn, dem man den Vors
Dorfverschönerungsaussch
weggenommen hatte. Die
fliktlösung war dadurch e
treten, daß der Bürgermeist

En la TAC del tronco cerebral vemos el correspondiente FH en el relé alveolar en el tronco cerebral derecho en fase PCL con edema de solución (flecha). A pesar de un diagnóstico tan claro, por desgracia nadie pensó nunca en una tuberculosis.

10.6.16 Tres ejemplos de leucemia



CT aus den mit für eine motorische Lähmung beider Arme zeigt. Man sieht die einzelnen Schießscheibenringe im motorischen Rindenzentrum.

Die Arme des Jungen waren weitgehend gelähmt.



Die Lungenaufnahme zeigt einen großen Lungenrundherd und weitere kleinere.

Das Kind hatte monatelang jede Nacht im Traum das schreckliche Erlebnis wieder geträumt und Todesangst ausgestanden. Es gelang ihm schließlich den Konflikt zu lösen. Durch die übermäßig lange Konfliktdauer starb er vor allem an den Folgen einer Lungentuberkulose. Der Junge hatte wochenlang starken Nachtschweiß gehabt, subfebrile Temperaturen und Hämoptoe¹⁶⁷, er wurde aber nicht auf Tuberkulose behandelt, weil der Lungentumor ganz im Vordergrund der Behandlung stand.

Auf dem CT des Stammhirns sehen wir den zugehörigen Hämorrhagischen Alveolar-Relais im rechten Stammhirn in pcl-Phase mit Schwellungsoedem (Pfeil). Trotz der eindeutigen Diagnose will le noch immer niemand an Tuberkulose denken.

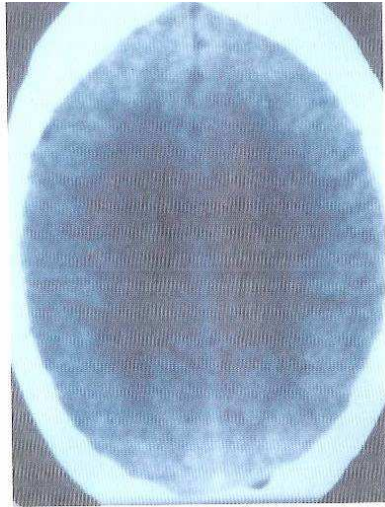
10.6.16 Drei Fallbe

Wir sehen ein generalisiertes Marklager-Oedem als Zeichen der Heilung und des wiederlangen Selbstwertes jedoch mit besonderer Betonung des Relais für den linken Schenkelhals (Pfeil) für den linken Schenkelhals (Pfeil) und des Relais für die rechte Schulter entsprechend einem gelösten Partner-Selbstwerteinbruch-Konflikt.

Zustand nach gelösten Selbstwert-Konflikten eines Herrn, dem man den Vorsitz der Dorfverschönerungsausschusses weggenommen hatte. Die Konfliktlösung war dadurch eingetreten, daß der Bürgermeister

Vemos un edema en la médula generalizado como signo de reparación y de la autoestima recuperada, pero con acentuación particular del relé del cuello del fémur izquierdo (conflicto resuelto "no lo consigo" y del relé para la espalda derecha correspondiente a un conflicto resuelto de desvaloración de sí en relación al partner.

Situación tras haber resuelto los conflictos de desvaloración de sí de un anciano señor al que se le quitó la presidencia del comité de salvaguardia de las maravillas artísticas del pueblo. La solución del conflicto se produjo gracias al hecho de que el alcalde le pidió perdón personalmente y lo rehabilitó.

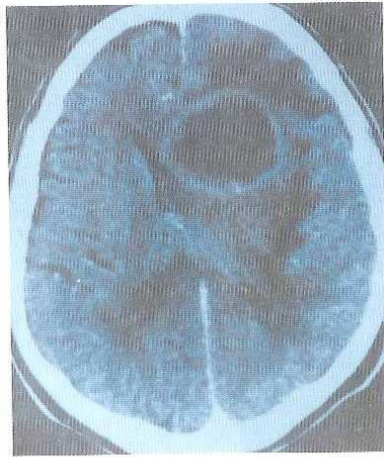


Edema aus ein generalisiertes Marklager-Oedem bei Leukämie einer jungen Frau aus einer Sekte, die menschlich und beruflich Schiffbruch erlitten hatte. CL: Es gelang der Patientin, einen neuen Anfang zu machen.

Höhere Schen des CT-Scans gleichen Zyste. Bei Kenntnis der Neuen Medizin ist klar, daß wir bei einem solchen Befund im Marklager des Gehirns auch mit einer gleichzeitigen leukämischen Phase des Patienten rechnen müssen.



Die nächsten 3 Aufnahmen betreffen einen Patienten mit massiver Entkalkung des linken Oberarmkopfes, jetzt in Lösung:



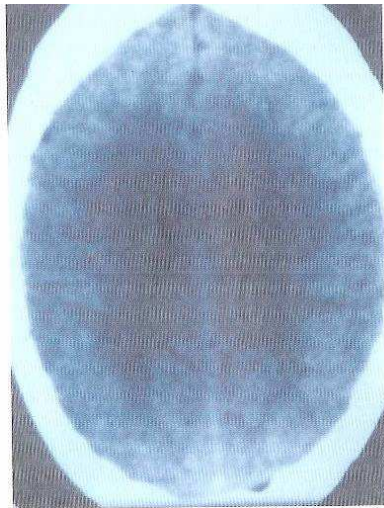
Im Gehirn-CT sehen wir eine Zyste im rechten Marklager des Großhirns (Relais für die linke Schulter bzw. Humeruskopf), entsprechend einem Vater/Kind-Selbstwerteinbruch-Konflikt: „Ich war als Vater nicht gerecht, habe meinen Sohn benachteiligt.“ Es gab sehr häufige Rezidive, schließlich eine endgültige Konfliktlösung. Durch die lange Konfliktdauer und die Intensität des Konfliktes kam es zu Zerreißung des Hirngewebes und Zystenbildung. Die Zystenschale ist bereits glös vernarbt. Der Befund sieht viel schlimmer aus als er ist.

Zugehörige Osteolyse des linken Oberarmkopfes („Vater/Kind-Schulter“) bei rechtshändigem Vater.



Edema de la médula generalizado en la leucemia de una joven mujer que pertenece a una secta que la había destrozado a nivel personal y profesional. CL: la paciente consiguió volver a empezar todo de nuevo.

Las tres imágenes siguientes se refieren a un paciente con una fuerte descalcificación en la cabeza del húmero izquierdo, ahora en solución:

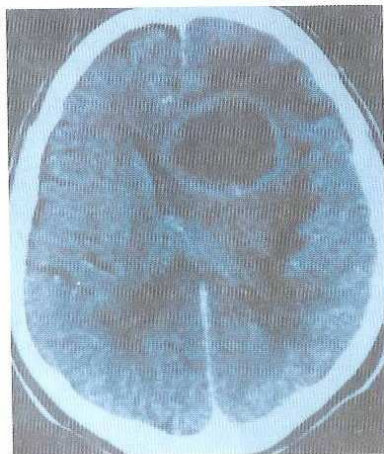


Ebenfalls ein generalisiertes Marklager-Oedem bei Leukämie einer jungen Frau aus einer Sekte, die menschlich und beruflich Schiffbruch erlitten hatte. CL: Es gelang der Patientin, einen neuen Anfang zu machen.

Höhere Schicht des CT-Scans: gleiche Zyste. Bei Kenntnis der Neuen Medizin ist klar, daß wir bei einem solchen Befund im Marklager des Gehirns auch mit einer gleichzeitigen leukämischen Phase des Patienten rechnen müssen.



Die nächsten 3 Aufnahmen betreffen einen Patienten mit massiver Entkalkung des linken Oberarmkopfes, jetzt in Lösung:



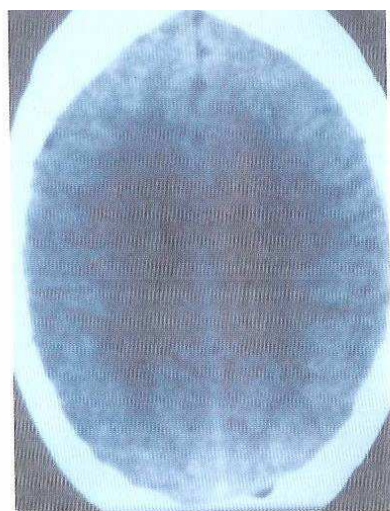
Im Gehirn-CT sehen wir eine Zyste im rechten Marklager des Großhirns (Relais für die linke Schulter bzw. Humeruskopf), entsprechend einem Vater/Kind-Selbstwerteinbruch-Konflikt: „Ich war als Vater nicht gerecht, habe meinen Sohn benachteiligt.“ Es gab sehr häufige Rezidive, schließlich eine endgültige Konfliktlösung. Durch die lange Konfliktdauer und die Intensität des Konfliktes kam es zu Zerreißung des Hirngewebes und Zystenbildung. Die Zystenschale ist bereits glös vernarbt. Der Befund sieht viel schlimmer aus als er ist.

Zugehörige Osteolyse des linken Oberarmkopfes („Vater/Kind-Schulter“) bei rechtshändigem Vater.



En la TAC cerebral vemos un quiste en la médula cerebral (relé de la espalda izquierda o de la cabeza del húmero), correspondiente a un conflicto de desvaloración de si padre/niño: “No he sido un buen padre, he dañado a mi hijo”. Se produjeron frecuentes recaídas, y al final una solución definitiva del conflicto. A causa de la larga duración del conflicto y de su intensidad se produjo una laceración del tejido cerebral y la formación de un quiste. La cápsula del quiste ya

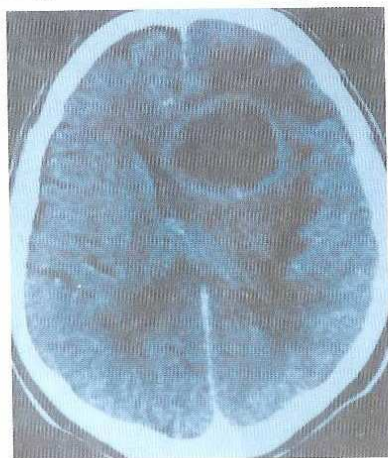
está cicatrizada con tejido glial. La muestra parece mucho más terrible de lo que realmente es.



Ebenfalls ein generalisiertes Marklager-Oedem bei Leukämie einer jungen Frau aus einer Sekte, die menschlich und beruflich Schiffbruch erlitten hatte. CL: Es gelang der Patientin, einen neuen Anfang zu machen.

Höhere Stellen der Seele mit gleichen Zyste. Bei Kenntnis der Neuen Medizin ist klar, daß wir bei einem solchen Befund im Marklager des Gehirns auch mit einer gleichzeitigen leukämischen Phase des Patienten rechnen müssen.

Die nächsten 3 Aufnahmen betreffen einen Patienten mit massiver Entkalkung des linken Oberarmkopfes, jetzt in Lösung:



Im Gehirn-CT sehen wir eine Zyste im rechten Marklager des Großhirns (Relais für die linke Schulter bzw. Humeruskopf), entsprechend einem Vater/Kind-Selbstwerteinbruch-Konflikt: „Ich war als Vater nicht gerecht, habe meinen Sohn benachteiligt.“ Es gab sehr häufige Rezidive, schließlich eine endgültige Konfliktlösung. Durch die lange Konfliktdauer und die Intensität des Konfliktes kam es zu Zerreißung des Hirngewebes und Zystenbildung. Die Zystenschale ist bereits glös vernarbt. Der Befund sieht viel schlimmer aus als er ist.

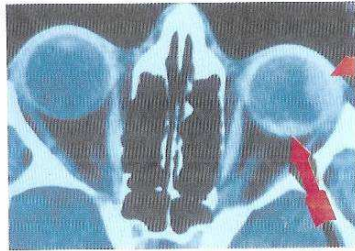
Zugehörige Osteolyse des linken Oberarmkopfes („Vater/Kind-Schulter“) bei rechtshändigem Vater.

Sección superior de la TAC cerebral del mismo quiste. Si se conoce la Nueva Medicina resulta claro que cuando aparece una muestra así en la médula cerebral, se espera que al mismo tiempo se produzca una fase leucémica.

Osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo (“espalda padre/niño”) en un padre diestro.

10.6.17. Un ejemplo de desprendimiento de la retina por un conflicto de miedo en la nuca

10.6.17 Ein Fallbeispiel von Netzhautablösung bei Angst-im-Nacken-Konflikt



Nebenstehend das CT eines Patienten, auf dem auch die Augen zu erkennen sind. Die Pfeile weisen auf eine vernarbte Netzhautablösung im Bereich der Fovea centralis¹⁶⁸ und lateral im rechten Auge.



Im CCT-Schnitt, auf dem die Sehrinde getroffen ist, sehen wir chronisch-rezidivierende HHs. Der Prozeß ist also noch keineswegs zur Ruhe gekommen, sondern das narbige Sehrinden-Relais links ist gerade wieder in Aktivität geraten.

¹⁶⁸ Fovea centralis = die vertiefte zentrale Stelle des gelben Flecks

10.6.18 Fallbeispiele für starke Glioma eines HHs



Oedematisierte Ringe eines motorisch-sensorischen Konfliktes mit beginnender Glia-Einlagerung.



Der gleiche Vorgang durch das Kontrastmittel, wesentliche Gravitation, aber nicht ist! Der Patient, erstmals ein Kontrastmittel anzufragen.

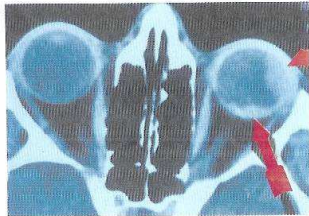
CCT eines anderen Patienten mit ähnlichen Herden in pcl-Phase, hier schon stark mit Glia eingelagerte, ringförmige Struktur im motorischen und sensorischen Rindenzentrum. Der Patient war mit der rechten Hand in die Kreissäge geraten und konnte sie nicht schnell genug wegziehen.



Al lado se ve la TAC de un paciente en la que se reconocen también los ojos. Las flechas indican un desprendimiento de la retina cicatrizado en la zona de la fovea central y lateralmente en el ojo derecho.

En la sección de la TAC cerebral en la que se encuentra la corteza visual vemos los FH con recaídas crónicas. El proceso por lo tanto todavía no ha terminado, pero el relé de la corteza visual cicatrizada a la izquierda ya ha entrado nuevamente en actividad.

10.6.17 Ein Fallbeispiel von Netzhautablösung bei Angst-im-Nacken-Konflikt



Nebenstehend das CT eines Patienten, auf dem auch die Augen zu erkennen sind. Die Pfeile weisen auf eine vernarbte Netzhautablösung im Bereich der Fovea centralis¹⁶⁸ und lateral im rechten Auge.



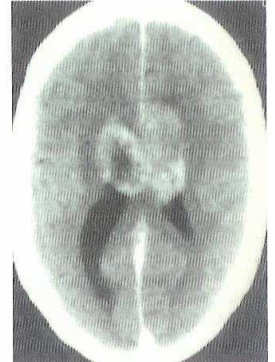
Im CCT-Schnitt, auf dem die Sehrinde getroffen ist, sehen wir chronisch-rezidivierende HHs. Der Prozeß ist also noch keineswegs zur Ruhe gekommen, sondern das narbige Sehrinden-Relais links ist gerade wieder in Aktivität geraten.

¹⁶⁸ Fovea centralis = die vertiefte zentrale Stelle des gelben Flecks

10.6.18 Fallbeispiele für starke gliomatose Heilung eines HHs



Oedematisierte Ringe eines motorisch-sensorischen Konfliktes mit beginnender Glia-Einlagerung.



Der gleiche Vorgang im CCT sieht durch das Kontrastmittel rein optisch wesentlich gravierender aus, was aber nicht ist! Daher empfehle ich stets, erstmalig ein CCT ohne Kontrastmittel anzufertigen ...

CCT eines anderen Patienten mit ähnlichen Herden in pcl-Phase, hier schon stark mit Glia eingelagerte, ringförmige Struktur im motorischen und sensorischen Rindenzentrum. Der Patient war mit der rechten Hand in die Kreissäge geraten und konnte sie nicht schnell genug wegziehen.



10.6.18. Ejemplo de reparación de FH fuertemente gliomatosa

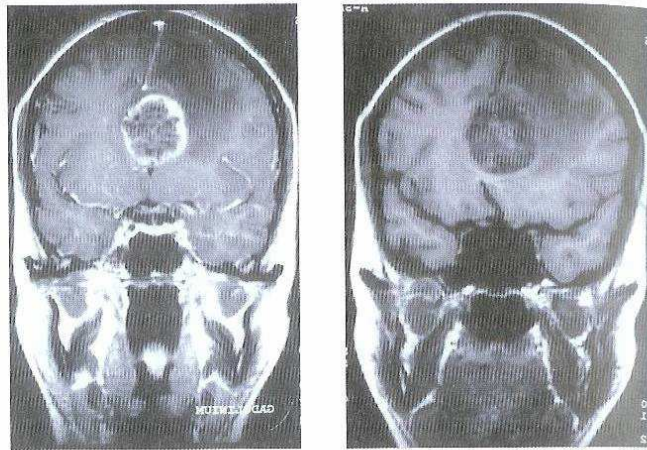
Anillos edematizados de un conflicto motor-sensorial con incipiente acumulación de tejido glial.

El mismo proceso en la TAC cerebral, a causa del medio de contraste, parece que es más grave que el examen visual, lo que sin embargo no es así. Por esto aconsejo siempre, lo primero, realizar una TAC cerebral sin medio de contraste.

TAC cerebral de otro paciente con focos parecidos en fase PCL, aquí ya con fuerte acumulación de glia, estructura en anillos en el centro cortical motor y sensorial. La mano derecha del paciente se metió en la sierra eléctrica porque no consiguió sacarla lo suficientemente rápido.

10.6.19. Ejemplo: abusada por su padre a los 5 años

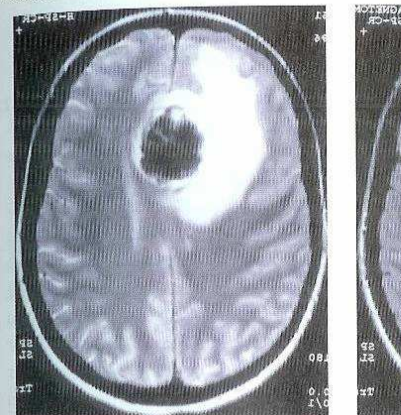
10.6.19 Fallbeispiel: Mit 5 Jahren vom Vater mißbraucht



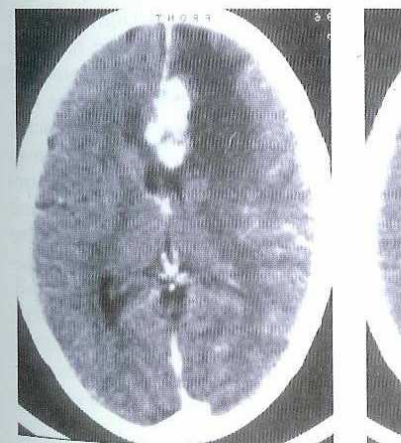
Diese Bilder sind ein erschütterndes Dokument einer 35jährigen linkshändigen Patientin, die vor 30 Jahren als 5jähriges Kind von ihrem Vater sexuell mißbraucht wurde. Sie wurde gezwungen, sein Glied in den Mund zu nehmen, wovor sie sich ekelte. Sie erlitt als Linkshänderin einen Diabetes (bei einer Rechtshänderin wäre es eine Unterzuckerung mit Alphazell-Glukagon-Insuffizienz). Bei ihr wurde der Diabetes nie bemerkt. Erst ganz zum Schluß, als kurz nach dem Tod des Vaters, den sie 5 Jahre als Bettlägerigen pflegen mußte, die Lösung des Konfliktes einsetzte. Bei der Diagnose des „Hirntumors“ wurde dann auch der Diabetes festgestellt, der aber jetzt rückläufig ist. Der Konflikt war also 30 Jahre hängend aktiv - ein 30jähriges Martyrium für die Patientin!

Für uns stellt diese zufällig gemachte Kernspintomographie einen wissenschaftlichen „Glücksfall“ dar, weil uns Kernspinaufnahmen, die nach solch langer Konfliktdauer in der geraden beginnenden Heilungsphase zufällig genau im „richtigen Moment“ gemacht worden sind, ein außergewöhnlich gut sichtbares Phänomen demonstrieren (mit Kontrast links, ohne rechts): Wir sehen im Inneren des gerade in Lösung gehenden großen HH noch die alten Schießscheibenringe, die nur noch kurz so gut zu sehen sind, weil sie dann im Oedem verschwimmen. Normalerweise können wir mit dem Kernspin-Tomogramm Schießscheibenringe des HH erst nach 2 bis 3 Jahren

Konfliktdauer erkennen. Und dann färben s
trastmittel an. Hier aber hat der Radiologe
wischt und zufällig auch die richtige Aufnah
Die Schießscheibenringe tauchen noch einma
der pcl-Phase weiß an, um dann meist im
der rechten Aufnahme ohne Kontrastmittel is



Gleiche Patientin 2 Monate später (Comput



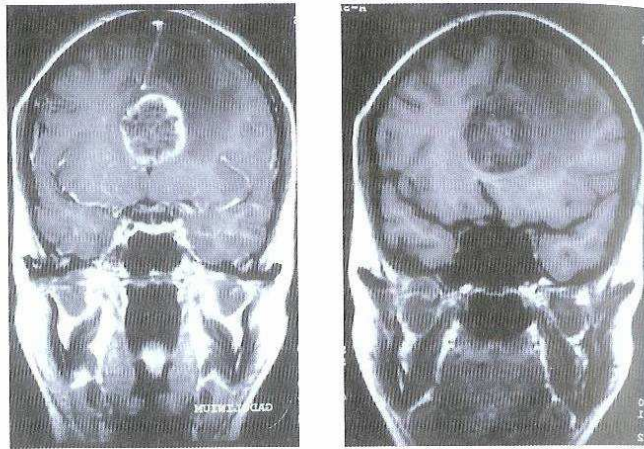
Estas imágenes son un documento sobrecogedor de una paciente zurda de 35 años, que 30 años antes, cuando tenía cinco años, sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Fue obligada a meterse en la boca su miembro, lo que hizo con asco. Por ser zurda sufrió una diabetes (en el caso de una diestra habría sido una hipoglucemia con insuficiencia de glucagón-células alfa). La diabetes no fue descubierta nunca. Sólo al final, poco después de la muerte del padre, al que tuvo que curar durante sus cinco últimos años, se produjo la solución del conflicto. En el diagnóstico del “tumor cerebral” se descubre también la diabetes, que sin embargo ya estaba remitiendo. Entonces el conflicto permaneció en suspenso durante 30 años: un martirio de 30 años para la paciente.

Para nosotros esta resonancia magnética realizada por casualidad es una “suerte” científica, porque las RM, que se han realizado por casualidad en el momento “justo” tras un conflicto de tan larga duración al inicio de la fase de reparación, nos muestran un fenómeno muy bien visible (con contraste a la izquierda, sin contraste a la derecha): en el interior del gran FH que está entrando en solución vemos todavía los antiguos anillos concéntricos, que sólo se podrán reconocer así de bien durante poco tiempo, porque después desaparecen en el edema. Normalmente en la RM podemos reconocer los anillos concéntricos del FH sólo cuando el conflicto ha durado por lo menos 2 o 3 años.

Y entonces no cambian de color ni siquiera con medio de contraste.

Sin embargo aquí el radiólogo, por casualidad, ha elegido el día correcto y, siempre por casualidad, también la técnica justa con el medio de contraste. Los anillos concéntricos aparecen una vez más y se vuelven de color blanco en la fase PCL para después sumergirse en el edema. En la fotografía a la derecha sin medio de contraste prácticamente no se ve ningún anillo.

10.6.19 Fallbeispiel: Mit 5 Jahren vom Vater mißbraucht



Diese Bilder sind ein erschütterndes Dokument einer 35jährigen linkshändigen Patientin, die vor 30 Jahren als 5jähriges Kind von ihrem Vater sexuell mißbraucht wurde. Sie wurde gezwungen, sein Glied in den Mund zu nehmen, wovon sie sich ekelte. Sie erlitt als Linkshänderin einen Diabetes (bei einer Rechtshänderin wäre es eine Unterzuckerung mit Alphazell-Glukagon-Insuffizienz). Bei ihr wurde der Diabetes nie bemerkt. Erst ganz zum Schluß, als kurz nach dem Tod des Vaters, den sie 5 Jahre als Bettlägerigen pflegen mußte, die Lösung des Konfliktes einsetzte. Bei der Diagnose des „Hirntumors“ wurde dann auch der Diabetes festgestellt, der aber jetzt rückläufig ist. Der Konflikt war also 30 Jahre hängend aktiv - ein 30jähriges Martyrium für die Patientin!

Für uns stellt diese zufällig gemachte Kernspintomographie einen wissenschaftlichen „Glücksfall“ dar, weil uns Kernspinaufnahmen, die nach solch langer Konfliktdauer in der geraden beginnenden Heilungsphase zufällig genau im „richtigen Moment“ gemacht worden sind, ein außergewöhnlich gut sichtbares Phänomen demonstrieren (mit Kontrast links, ohne rechts): Wir sehen im Inneren des gerade in Lösung gehenden großen HH noch die alten Schießscheibenringe, die nur noch kurz so gut zu sehen sind, weil sie dann im Oedem verschwimmen. Normalerweise können wir mit dem Kernspin-Tomogramm Schießscheibenringe des HH erst nach 2 bis 3 Jahren

Konfliktdauer erkennen. Und dann färben sie sich mit Kontrastmittel an. Hier aber hat der Radiologe gewischt und zufällig auch die richtige Aufnahme gemacht. Die Schießscheibenringe tauchen noch einmal in der pcl-Phase weiß an, um dann meist im C-Phase der rechten Aufnahme ohne Kontrastmittel



Gleiche Patientin 2 Monate später (Computer)



La misma paciente dos meses después (tomograma computerizado).

En estos casos, si se espera tranquilamente que la fase de reparación termine, no puede suceder nada. En el presente caso todavía menos, dado que no hay motivos para temer impedimentos al flujo del líquido cerebroespinal. Aquí no es necesario administrar cortisona. “Sólo” hay que tener la moral alta y hay que evitar los ataques de pánico (“hay que operar inmediatamente, ingresar en el hospital...”).

10.6.20. Ejemplo: los corazones negros

Marco en el momento de su DHS (conflicto de ataque al corazón) tenía dos años. Su padre, al que amaba más que nada, fue ingresado en el hospital en circunstancias muy dramáticas por un supuesto "infarto cardíaco, porque había sufrido ya a menudo angina de pecho.

Durante meses Marco se lo contó a todo el mundo y puntaba sólo corazones negros. Realmente no se trató de un infarto cardíaco, como después se supo, pero Marco se había identificado tanto con el padre que él mismo experimentó un "ataque al propio corazón". Dado que el padre siguió teniendo los dolores de la angina de pecho, la vía de Marco permaneció activa y continuó pintando corazones negros.

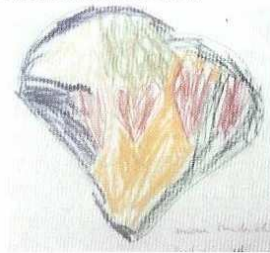
Wenn man in solchen Fällen ruhig zuwartet, bis die Heilungsphase vorüber ist, kann eigentlich gar nicht viel passieren. In diesem Fall um so weniger, als keine Abflußbehinderungen für den Liquor cerebrospinalis¹⁶⁹ zu befürchten ist. Man braucht hier nicht einmal Cortison zu geben. „Nur“ die Moral muß aufrechterhalten werden, und Panik muß vermieden werden („Sofort operieren, sofort in die Klinik ...“).

10.6.20 Fallbeispiel: Die schwarzen Herzen

Markus war zum Zeitpunkt seines DHS (Attacke-gegen-das-Herz-Konflikt) 2 Jahre alt. Sein Vater, den er über alles liebte, wurde unter sehr dramatischen Umständen, weil er schon öfter Angina pectoris gehabt hatte, unter der Verdachts-Diagnose „Herzinfarkt“ in die Klinik gefahren.



fort schwarze Herzen!

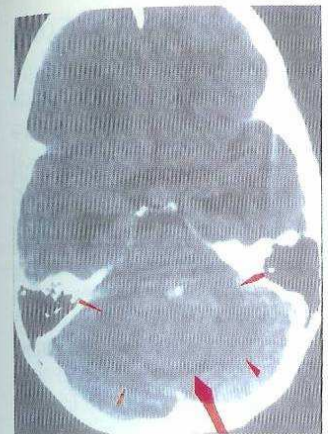


schnitten. Markus starb einen völlig unnötigen Tod.

Markus erzählte es monatelang jedem und malte nur schwarze Herzen. Zwar war es kein Herzinfarkt gewesen, wie sich dann herausstellt, aber Markus hatte sich so mit ihm identifiziert, daß er die „Attacke gegen sein eigenes Herz“ empfand. Da der Vater auch wirklich noch danach immer wieder Angina-pectoris-Schmerzen hatte, blieb bei Markus die Schiene aktiv! Er malte immer-

Mit 6 Jahren, als er in die Schule kam, löste sich sein Konflikt. Jetzt malte er hellgelbe Herzen. Wegen der Hirn-Symptomatik, die sich naturgemäß in der Heilungsphase einstellte, Schwindel, Brechreiz ..., brachte man ihn ins Krankenhaus. Dort stellte man (im Herzbeutel-Relais) einen großen vermeintlichen „Hirntumor“ fest, den es mit Stumpf und Stiel auszurotten galt. Die Hälfte des Kleinhirns wurde ihm wegge-

¹⁶⁹ Liquor cerebrospinalis = Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit



CT 1991

Kernspin-Tomogramm von der Seite.

gleiche
verschie



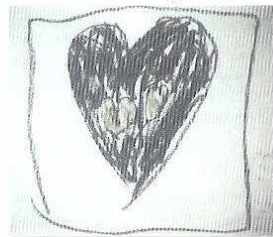
Bei Ärzten der Neuen Medizin wäre ein solches Selbst wenn es zu einer vorübergehenden Kompression kommt und zum Liquor-Aufstau, ist das heute eine Operation, denn das kann man mit Cortison behandeln. Operation der ignoranten Zauberlehrlinge als s

A los seis años, cuando fue al colegio, su conflicto se resolvió. Entonces pintaba corazones amarillo claro. A causa de la sintomática cerebral que naturalmente se verificó en la fase de reparación con pequeños desmayos, conatos de vómito, etc, fue le llevado al hospital. Allí le encontraron (en el relé del pericardio) un supuesto y gran "tumor cerebral" que había que extirpar radicalmente. Se le extirpó la mitad del cerebello. Marco murió con una muerte absolutamente inútil.

Wenn man in solchen Fällen ruhig zuwartet, bis die Heilungsphase vorüber ist, kann eigentlich gar nicht viel passieren. In diesem Fall um so weniger, als keine Abflußbehinderungen für den Liquor cerebrospinalis¹⁶⁹ zu befürchten ist. Man braucht hier nicht einmal Cortison zu geben. „Nur“ die Moral muß aufrechterhalten werden, und Panik muß vermieden werden („Sofort operieren, sofort in die Klinik ...“).

10.6.20 Fallbeispiel: Die schwarzen Herzen

Markus war zum Zeitpunkt seines DHS (Angriff-gegen-das-Herz-Konflikt) 2 Jahre alt. Sein Vater, den er über alles liebte, wurde unter sehr dramatischen Umständen, weil er schon öfter Angina pectoris gehabt hatte, unter der Verdachts-Diagnose „Herzinfarkt“ in die Klinik gefahren.



fort schwarze Herzen!

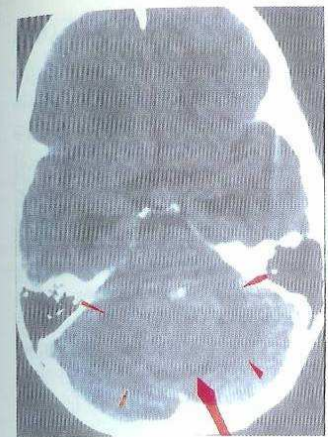


schnitten. Markus starb einen völlig unnötigen Tod.

Markus erzählte es monatelang jedem und malte nur schwarze Herzen. Zwar war es kein Herzinfarkt gewesen, wie sich dann herausstellt, aber Markus hatte sich so mit ihm identifiziert, daß er die „Angriff gegen sein eigenes Herz“ empfand. Da der Vater auch wirklich noch danach immer wieder Angina-pectoris-Schmerzen hatte, blieb bei Markus die Schiene aktiv! Er malte immer-

Mit 6 Jahren, als er in die Schule kam, löste sich sein Konflikt. Jetzt malte er hellgelbe Herzen. Wegen der Hirn-Symptomatik, die sich naturgemäß in der Heilungsphase einstellte, Schwindel, Brechreiz ..., brachte man ihn ins Krankenhaus. Dort stellte man (im Herzbeutel-Relais) einen großen vermeintlichen „Hirntumor“ fest, den es mit Stumpf und Stiel auszurotten galt. Die Hälfte des Kleinhirns wurde ihm wegge-

¹⁶⁹ Liquor cerebrospinalis = Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit



CT 1991

Kernspin-Tomogramm von der Seite.



gleiche verschie



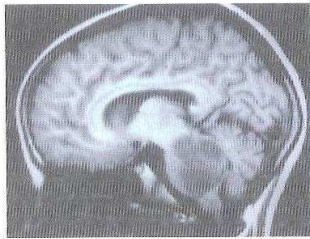
Bei Ärzten der Neuen Medizin wäre ein solcher Selbst wenn es zu einer vorübergehenden K kommt und zum Liquor-Aufstau, ist das heute Operation, denn das kann man mit Cortison Operation der ignoranten Zauberlehrlinge als

Misma sección que a la izquierda pero con diferente contraste luminoso.

Los médicos de la Nueva Medicina no habrían dejado morir jamás a un paciente en estas circunstancias. Incluso aunque se llegase a una compresión temporal del cuarto ventrículo y a un derrame de líquido cerebroespinal, no habría habido motivo suficiente para una operación, porque la situación sólo se puede controlar con la cortisona, mientras que la operación que realizan los ignorantes aprendices de brujo resulta mortal.

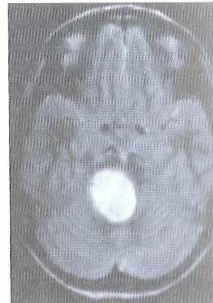
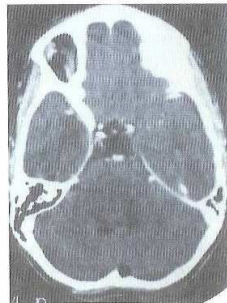
10.6.21. Ejemplo: abuso sexual por parte del padrino

10.6.20 Fallbeispiel: sexueller Mißbrauch durch den Patenonkel



Dies Mädchen von damals 3 Jahren, von dem diese Bilder sind, wurde ein Jahr lang von seinem Patenonkel sexuell mißbraucht. Es erlitt einen häßlichen halbgenitalen Konflikt im Uterus-corpus-Relais. Die Mutter war Mitwisslerin dieses Mißbrauchs.

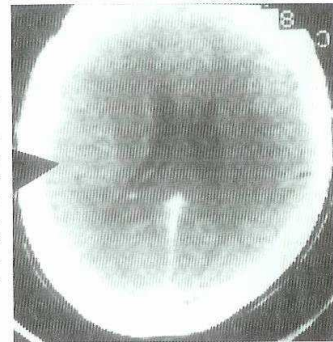
Als nach einem Jahr die Sache aufhörte, bekam das Kind eine Lösung des Konfliktes und damit ein großes Oedem im Uterus-Relais des Stammhirns (Pons). Es wurde somnolent¹⁶⁹ wegen einer Liquor-Abflußbehinderung. Traurigerweise wurde es von den Zauberlehrlingen operiert, ein Großteil des Hirnstamms weggeschnitten. Das Kind starb elendiglich einen völlig unnötigen Tod, der in der Neuen Medizin mit Sicherheit dadurch verhindert worden wäre, daß man die kritische Zeit ohne Operation mit konservativen Mitteln überbrückt hätte.



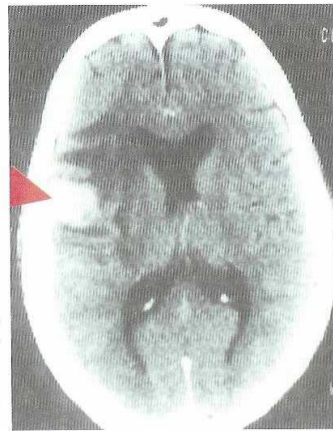
¹⁶⁹ Somnolenz = Schläfrigkeit

10.7 Der weiblich-sexuelle Konflikt im CCT

CCT einer rechtshändigen 40jährigen Patientin mit Gebärmutterhals-Ca. Der HH links peririnsulär ist aktiv. Sexueller Konflikt: Ihr Ehemann sagte ihr nach der schönsten Liebesnacht: „Ach, das ist doch unwichtig.“ Es wurde ein Gebärmutterhals-Karzinom diagnostiziert nebst (nach der Neuen Medizin) Koronarvenen-Ulcera. CL: Trennung vom Ehemann. Die Patientin überlebte die epileptische Krise der Lungenembolie. Nach drei Monaten war der Abstrich-Befund negativ!



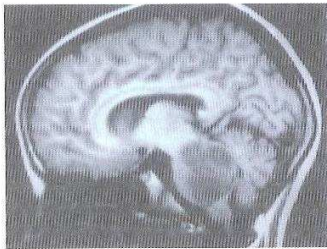
CCT einer ebenfalls rechtshändigen 34jährigen Patientin, die ebenfalls ein Gebärmutterhals-Karzinom mit Koronarvenen-Ulcera hatte. Der zugehörige HH hat Lösungsödem. Der sexuelle Konflikt: Ihr Lebensgefährte hatte mit ihrer besten Freundin geschlafen und ein Kind gezeugt. Die CL erfolgte durch Aussöhnung der beiden Freundinnen. Der Konflikt hatte 7 Monate gedauert. Die Patientin überlebte jedoch die dramatische epileptische Krise (Rechtsherz-Infarkt bzw. Lungenembolie), die unmittelbar nach Erstellung dieser Bilder eintrat, mit hohen Cortisondosen. Ebenso überlebte sie das Gebärmutterhals-Karzinom und den zugehörigen „Hirntumor“ ohne eine schulmedizinische Therapie.



La muchachita, que entonces tenía tres años, a la que pertenecen estas imágenes, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrino durante un año. Sufrió un conflicto de fondo semisexual repugnante en el relé del cuerpo del útero. La madre tenía conocimiento de estas violaciones. Cuando esto cesó tras un año, la niña tuvo una solución del conflicto y por lo tanto un gran edema en el relé del útero en el tronco cerebral (puente). Siempre tenía sueño a causa del flujo obstaculizado del líquido cerebro-espinal. Desafortunadamente para ella la operaron los aprendices de brujo, quienes la extirparon gran parte del tronco cerebral. La niña murió miserablemente de una muerte que se podía haber evitado, que la Nueva Medicina habría evitado seguramente porque el momento crítico se habría superado con remedios conservativos sin intervención quirúrgica.

10.7. El conflicto sexual femenino en la TAC cerebral.

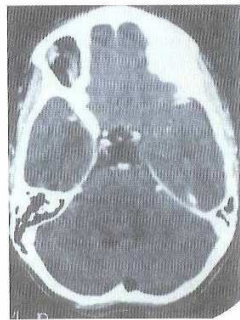
10.6.20 Fallbeispiel: sexueller Mißbrauch durch den Patenonkel



Dies Mädchen von damals 3 Jahren, von dem diese Bilder sind, wurde ein Jahr lang von seinem Patenonkel sexuell mißbraucht. Es erlitt einen häßlichen halbgenitalen Konflikt im Uterus-corporis-Relais. Die Mutter war Mitwisserin dieses Mißbrauchs.

Als nach einem Jahr die Sache aufhörte, bekam das Kind eine

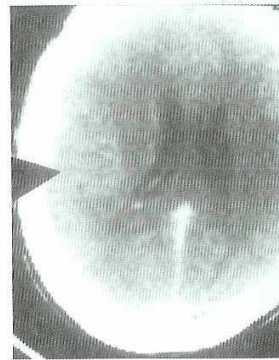
Lösung des Konfliktes und damit ein großes Oedem im Uterus-Relais des Stammhirns (Pons). Es wurde somnolent¹⁶⁹ wegen einer Liquor-Abflußbehinderung. Traurigerweise wurde es von den Zauberlehrlingen operiert, ein Großteil des Hirnstamms weggeschnitten. Das Kind starb elendiglich einen völlig unnötigen Tod, der in der Neuen Medizin mit Sicherheit dadurch verhindert worden wäre, daß man die kritische Zeit ohne Operation mit konservativen Mitteln überbrückt hätte.



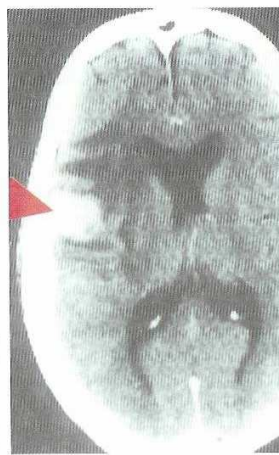
¹⁶⁹ Somnolenz = Schläfrigkeit

10.7 Der weiblich-sexuelle Konflikt im CCT

CCT einer rechtshändigen 40jährigen Patientin mit Gebärmutterhals-Ca. Der HH links periinsulär ist aktiv. Sexueller Konflikt: Ihr Ehemann sagte ihr nach der schönsten Liebesnacht: „Ach, das ist doch unwichtig.“ Es wurde ein Gebärmutterhals-Karzinom diagnostiziert nebst (nach der Neuen Medizin) Koronarvenen-Ulcera. CL: Trennung vom Ehemann. Die Patientin überlebte die epileptische Krise der Lungenembolie. Nach drei Monaten war der Abstrich-Befund negativ!



CCT einer ebenfalls rechtshändigen 34jährigen Patientin, die ebenfalls ein Gebärmutterhals-Karzinom mit Koronarvenen-Ulcera hatte. Der zugehörige HH hat Lösungsödem. Der sexuelle Konflikt: Ihr Lebensgefährte hatte mit ihrer besten Freundin geschlafen und ein Kind gezeugt. Die CL erfolgte durch Aussöhnung der beiden Freundinnen. Der Konflikt hatte 7 Monate gedauert. Die Patientin überlebte jedoch die dramatische epileptische Krise (Rechtsherz-Infarkt bzw. Lungenembolie), die unmittelbar nach Erstellung dieser Bilder eintrat, mit hohen Cortisondosen. Ebenso überlebte sie das Gebärmutterhals-Karzinom und den zugehörigen „Hirntumor“ ohne eine schulmedizinische Therapie.



TAC de una paciente de cuarenta años diestra con carcinoma del cuello del útero. El FH a la izquierda periinsular está activo. Conflicto sexual: su marido le había dicho tras una bellísima noche de amor que no había tenido mucha importancia. Se le diagnosticó un carcinoma del cuello del útero además de una úlcera de las venas coronarias (según la Nueva Medicina). CL: separación del marido. La paciente sobrevivió a la crisis epileptoide de la embolia pulmonar. Después de tres meses el parte médico de la muestra era negativo.

TAC de una paciente de 34 años, también diestra, que tenía un carcinoma del cuello del útero con úlcera de las venas coronarias. El correspondiente FH tiene un edema de solución. El conflicto sexual: su compañero se había ido a la cama con su mejor amiga, dejándola embarazada. La CL se produce con la reconciliación de las dos amigas. El conflicto duró siete meses. Sin embargo la paciente gracias a las elevadas dosis de cortisona, sobrevivió a la dramática crisis epileptoide (infarto cardíaco derecho o embolia pulmonar), que se produjo justo después de realizar estas imágenes. Sobrevivió también al carcinoma del cuello del útero y al correspondiente “tumor cerebral” sin ninguna terapia de la medicina tradicional.

10.8. El conflicto de territorio masculino en la TAC

10.8 Der männliche Revier-Konflikt im CCT



Das männliche Pendant zum sexuellen Konflikt: Der Revier-Konflikt. Der HH im CCT liegt beim rechtshändigen Mann stets rechts periinsulär.

Dies ist eines der „schönsten“ Bilder meiner Sammlung. Man sieht einen großen, gliös markierten HH rechts periinsulär mit großem perifocalem und intrafocalem Oedem (rechter Pfeil). Der linke untere Pfeil bezeichnet occipital-basal links das Relais für den linken Hoden (Gehirn-Organ nicht gekreuzt). Auch dieser HH hat intra- und perifocales Oedem. Schließlich ist noch eine Oede-

matisation des Marklagers dorsal der Hinterhörner beiderseits sichtbar, entsprechend einem Selbstwerteinbruch mit Osteolysen im Bereich des Beckens beiderseits. Alle Konflikte sind also in Lösung.

Was war passiert? Es handelte sich um einen älteren Bauern aus Niedersachsen, dessen einziger Sohn bei einem Motorradunfall schwer verunglückte, wie dem Vater zunächst gesagt wurde, gab es kaum noch Überlebenschancen. Der Vater glaubte, seine Sohn würde, wenn überhaupt, nur als Krüppel überleben. Er erlitt, da der Sohn auch gleichzeitig der einzige Hoferbe war, einen gewaltigen Revier-Konflikt, den man nur aus der bäuerlichen Mentalität nachempfinden kann. Gleichzeitig erlitt er jedoch, wie jeder gute Vater normalerweise, einen Verlust-Konflikt mit Hoden-Karzinom links. Vom Tag des Unfalls an hatte er täglich Herzstiche, angina pectoris. Der Revier-Konflikt dauerte ein halbes Jahr an. Der Sohn konnte schließlich die Intensivstation verlassen, für den Vater die Konfliktlösung! Vier Wochen nachdem sein Sohn wieder arbeiten konnte, bekam der Vater - auf dem Höhepunkt der Heilungsphase (mit Koronararterien-Ulcus-Schwellung) - einen Linksherz-Infarkt mit Schwindel, Kopfschmerz, Gleichgewichtsstörungen. Außerdem kam es als Zeichen der pcl-Phase der Hodennekrose zu einer Hodenschwellung. Bevor ein Neurochirurg sich für eine Operation der „Tumoren“ seines Gehirns interessieren konnte, verließ der Patient eilends die Klinik.

10.8.1 Beispiele für eine sog. Relation im CCT; hier anhand des sexuellen und Revier-Konflikt

Zustand nach abgelaufener schizophrener Konstellation - beide HHe haben Lösungsödem. Rechts ist durch das intrafocale Oedem und die Zerreißung des Gewebes im Innern des HHs eine Zyste entstanden. Die Patientin hatte Hirndruck und man hätte versuchen können, sie mit einer Cortison-Medikation zu retten. Statt dessen wurde sie wegen „generalisierter Hirnmetastasen“ mit Morphin quasi eingeschläfert.



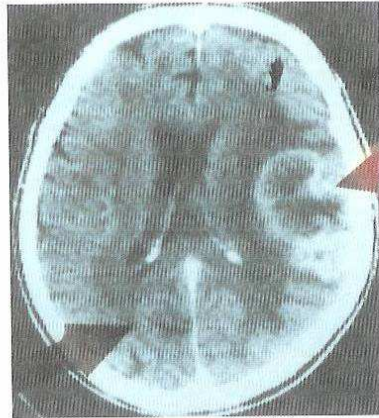
Zwei Schießscheiben-Konfigurationen in ca-Phase im rechten und linken periinsulären Bereich. Dies entspricht einer schizophrenen Konstellation und zwar in diesem Falle einer solchen mit postmortalem Zwangsdenken bei der Chefin einer Religionsgemeinschaft, die tagtäglich darüber nachdachte, welche andere hübsche Frau ihr gutaussehender Mann nach ihrem Tode (sie war schwerkrank) haben würde.

El equivalente masculino del conflicto sexual: el conflicto de territorio. En el hombre diestro el FH en la TAC se encuentra siempre a la derecha periinsularmente. Esta es una de las “más bellas” imágenes de mi colección. Se ve un vasto FH con tejido glial a la derecha periinsularmente con un gran edema perifocal e intrafocal (flecha derecha). La flecha de abajo a la izquierda indica el relé occipito-basal a la izquierda para el testículo izquierdo (inervado homolateralmente desde el cerebro al órgano). También este FH tiene un edema intra y perifocal. Al final se ve una edematización de la médula cerebral dorsalmente a los cuernos posteriores de los dos ventrículos laterales, correspondiente a una desvaloración de sí mismo con osteólisis en la zona de la pelvis en los dos lados. Todos los conflictos están por lo tanto en solución.

¿Qué había sucedido? Se trataba de un anciano agricultor de la Baja Sajonia cuyo único hijo se había herido gravemente en un accidente de motocicleta, y como dijo el padre, había pocas esperanzas de que sobreviviese. El padre creía que si el hijo hubiese sobrevivido sería solamente un estorbo. Dado que su hijo era también el único heredero de la granja, sufrió un violento conflicto de territorio que sólo se puede comprender si se tiene una mentalidad granjera. Y al mismo tiempo sufrió también, como es normal en cualquier buen padre, un conflicto de pérdida con carcinoma del testículo izquierdo. Desde el día del accidente tuvo pinchazos en el corazón, angina de pecho, todo ello a diario. El conflicto de territorio duró unos seis meses. Al final el hijo pudo abandonar la sección de cuidados intensivos y eso fue la solución del conflicto para el padre. Cuatro semanas después de que el hijo había comenzado nuevamente a trabajar, el padre, en el punto máximo de la fase de reparación (con hinchazón ulcerosa de las arterias coronarias) tuvo un infarto cardíaco izquierdo con vértigos, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio. Además, como señal de la fase PCL de la necrosis testicular se llegó a la hinchazón de un testículo. Antes de que un neurocirujano quisiera operar sus “tumores cerebrales” el paciente dejó a toda prisa la clínica.

10.8.1. Ejemplo de una denominada constelación esquizofrénica en la TAC; aquí en presencia de una combinación de conflicto sexual y de territorio

10.8 Der männliche Revier-Konflikt im CCT



Das männliche Pendant zum sexuellen Konflikt: Der Revier-Konflikt. Der HH im CCT liegt beim rechtshändigen Mann stets rechts periinsulär.

Dies ist eines der „schönsten“ Bilder meiner Sammlung. Man sieht einen großen, gliös markierten HH rechts periinsulär mit großem perifocalem und intrafocalem Oedem (rechter Pfeil). Der linke untere Pfeil bezeichnet occipital-basal links das Relais für den linken Hoden (Gehirn-Organ nicht gekreuzt). Auch dieser HH hat intra- und perifocales Oedem.

Schließlich ist noch eine Oedematisation des Marklagers dorsal der Hinterhörner beiderseits sichtbar, entsprechend einem Selbstwerteinbruch mit Osteolysen im Bereich des Beckens beiderseits. Alle Konflikte sind also in Lösung.

Was war passiert? Es handelte sich um einen älteren Bauern aus Niedersachsen, dessen einziger Sohn bei einem Motorradunfall schwer verunglückte, wie dem Vater zunächst gesagt wurde, gab es kaum noch Überlebenschancen. Der Vater glaubte, seine Sohn würde, wenn überhaupt, nur als Krüppel überleben. Er erlitt, da der Sohn auch gleichzeitig der einzige Hörerbe war, einen gewaltigen Revier-Konflikt, den man nur aus der bäuerlichen Mentalität nachempfinden kann. Gleichzeitig erlitt er jedoch, wie jeder gute Vater normalerweise, einen Verlust-Konflikt mit Hoden-Karzinom links. Vom Tag des Unfalls an hatte er täglich Herzstiche, angina pectoris. Der Revier-Konflikt dauerte ein halbes Jahr an. Der Sohn konnte schließlich die Intensivstation verlassen, für den Vater die Konfliktlösung! Vier Wochen nachdem sein Sohn wieder arbeiten konnte, bekam der Vater - auf dem Höhepunkt der Heilungsphase (mit Koronararterien-Ulcus-Schwellung) - einen Linksherz-Infarkt mit Schwindel, Kopfschmerz, Gleichgewichtsstörungen. Außerdem kam es als Zeichen der pcl-Phase der Hodennekrose zu einer Hodenschwellung. Bevor ein Neurochirurg sich für eine Operation der „Tumoren“ seines Gehirns interessieren konnte, verließ der Patient eilends die Klinik.

10.8.1 Beispiele für eine sog. Schizophrenie im CCT; hier anhand der sexuellen und Revier-Konflikte

Zustand nach abgelaufener schizophrener Konstellation - beide HHs haben Lösungsödem. Rechts ist durch das intrafocale Oedem und die Zerreißung des Gewebes im Innern des HHs eine Zyste entstanden. Die Patientin hatte Hirndruck und man hätte versuchen können, sie mit einer Cortison-Medikation zu retten. Statt dessen wurde sie wegen „generalisierter Hirnmetastasen“ mit Morphium quasi eingeschläfert.



Zwei Schießscheiben-Konfigurationen in ca-Phase im rechten und linken periinsulären Bereich. Dies entspricht einer schizophrenen Konstellation und zwar in diesem Falle einer solchen mit postmortalem Zwangsdenken bei der Chefin einer Religionsgemeinschaft, die tagtäglich darüber nachdachte, welche andere hübsche Frau ihr gutaussehender Mann nach ihrem Tode (sie war schwerkrank) haben würde.

Estado tras una constelación esquizofrénica: los dos FH tienen un edema en solución. A la derecha se ha formado un quiste por el edema intrafocal y la laceración del tejido dentro del FH. La paciente tenía una presión cerebral y se habría podido intentar salvarla con una cura de cortisona. Por el contrario fue prácticamente sedada con la morfina a causa de la “metástasis cerebral generalizada”.

Dos configuraciones concéntricas en fase CA en la zona periinsular derecha e izquierda. Esto corresponde a una constelación esquizofrénica y precisamente en este caso a una constelación obsesiva postmortal en una mujer jefa de una

comunidad religiosa que pensaba diariamente cual sería la otra mujer que tendría a su marido, bien parecido, a su muerte (estaba gravemente enferma).

10.9. Configuraciones concéntricas en el hígado

10.9 Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber



Mehrere Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber: Stets frühes Stadium eines sog. solitären Leberkarzinoms. Die Schießscheiben-Kontfiguration des Organs steht mit der Schießscheiben-Kontfiguration des Gehirns in Korrespondenz, genauer gesagt können mehrere Organ-

schießscheiben-Kontfigurationen mit einer Gehirnschießscheiben-Kontfiguration in Korrespondenz stehen.

Das Aufregende an diesem empirisch gefundenen Zusammenhang ist, daß praktisch das Gehirn und das Organ im gleichen Takt „schießscheiben-konfigurationsmäßig“ schwingen, d.h. wir können uns das Organ mit seinen Zellkernen, die alle miteinander vernetzt sind quasi als ein zweites Gehirn vorstellen, als Organgehirn. Kopfgehirn und Organgehirn schwingen in der gleichen Phase in gleicher Weise, wie unsere Schießscheiben-Kontfigurationen zeigen. Mal gibt das Kopfgehirn Befehle an das Organgehirn, z.B. Motorik, mal gibt das Organgehirn Informationen an das Kopfgehirn, z.B. Sensorik. Wir wußten diese Dinge z.T. schon aus der Neurologie, kamen aber bisher nicht weiter, weil wir die Zusammenhänge der Neuen Medizin nicht kannten.

Die folgenden Aufnahmen zeigen den Verlauf solcher Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber:



Auf den beiden nachfolgenden Abbildungen sehen wir bereits verkalkte Herde, wieder neue aktive Herde und Heilungsverläufe, die einem chronisch-rezidivierenden Prozeß entsprechen.

Erneute Heilungsphase dieses Restzustandes (Verkalkung) mit erneut abgelaufenem Leber-Solitär-Karzinom, entsprechend einer chronisch rezidivierenden Verhungerungs-Angst. Immer sieht man die Rundstruktur der „Leber-Rundherde“, die von der ursprünglichen Schießscheiben-Kontfiguration ausgeht.

Das gleiche Phänomen sehen wir auch im Knochen, wenn im CT-Schnitt zufällig die aktive Phase, d.h. die Organschießscheiben-Kontfiguration getroffen wurde.

Das Bild zeigt 2 aktive Herde in Schießscheibenformation eines Wirbelkörpers. Das CT besagt, daß Knochen-Osteolysen, also Entkalkungen, des Wirbels im Gange sind, entsprechend einem aktiven Selbstwerteinbruch-Konflikt.



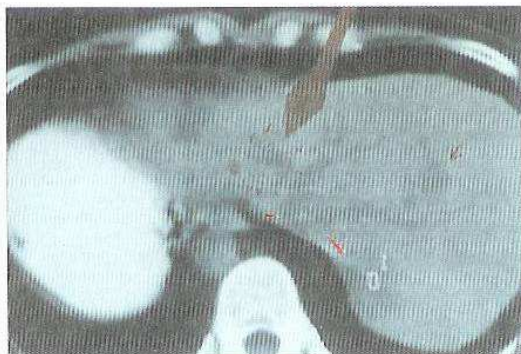
Algunas configuraciones concéntricas en el hígado: son siempre el estado precoz de un denominado adenocarcinoma hepático solitario. La configuración concéntrica del órgano está en correspondencia con la configuración concéntrica

del cerebro, o dicho con más precisión, varias configuraciones concéntricas en el órgano pueden corresponder a una única configuración concéntrica en el cerebro.

Lo interesante de esta correlación encontrada empíricamente está en el hecho de que prácticamente el cerebro y el órgano oscilan al mismo ritmo con las configuraciones concéntricas, es decir, podemos imaginar el órgano con sus núcleos celulares, que están todos conectados entre ellos, casi como un segundo cerebro, como un cerebro del órgano. El cerebro del órgano y el cerebro central oscilan en la misma fase de un modo igual, como muestran nuestras configuraciones concéntricas. A veces el cerebro central da órdenes al cerebro del órgano, por ejemplo la motricidad, a veces el cerebro del órgano proporciona informaciones al cerebro central, por ejemplo la sensibilidad. Esto ya lo sabíamos en parte por la neurología, pero hasta ahora se había ido más allá porque no se conocían las correlaciones descubiertas por la Nueva Medicina.

Las imágenes siguientes muestran la evolución de tales configuraciones concéntricas en el hígado:

10.9 Schießscheiben-Konfigurationen in der Leber



Mehrere Schießscheiben-Konfigurationen in der Leber: Stets frühes Stadium eines sog. solitären Leberkarzinoms. Die Schießscheiben-Konfiguration des Organs steht mit der Schießscheiben-Konfiguration des Gehirns in Korrespondenz, genauer gesagt können mehrere Organ-

schießscheiben-Konfigurationen mit einer Gehirnschießscheiben-Konfiguration in Korrespondenz stehen.

Das Aufregende an diesem empirisch gefundenen Zusammenhang ist, daß praktisch das Gehirn und das Organ im gleichen Takt „schießscheibenkonfigurationsmäßig“ schwingen, d.h. wir können uns das Organ mit seinen Zellkernen, die alle miteinander vernetzt sind quasi als ein zweites Gehirn vorstellen, als Organgehirn. Kopfgehirn und Organgehirn schwingen in der gleichen Phase in gleicher Weise, wie unsere Schießscheiben-Konfigurationen zeigen. Mal gibt das Kopfgehirn Befehle an das Organgehirn, z.B. Motorik, mal gibt das Organgehirn Informationen an das Kopfgehirn, z.B. Sensorik. Wir wußten diese Dinge z.T. schon aus der Neurologie, kamen aber bisher nicht weiter, weil wir die Zusammenhänge der Neuen Medizin nicht kannten.

Die folgenden Aufnahmen zeigen den Verlauf solcher Schießscheiben-Konfigurationen in der Leber:



Auf den beiden nachfolgenden Abbildungen sehen wir bereits verkalkte Herde, wieder neue aktive Herde und Heilungsverläufe, die einem chronisch-rezidivierenden Prozeß entsprechen.

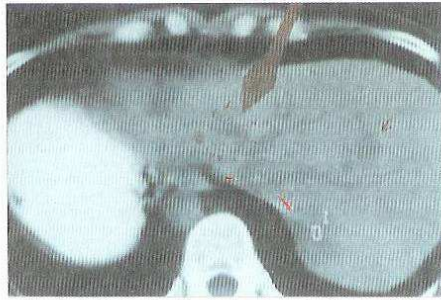
Erneute Heilungsphase dieses Restzustandes (Verkalkung) mit erneuter abgelaufenem Leber-Solitär-Karzinom, entsprechend einer chronisch rezidivierenden Verhungerungs-Angst. Immer sieht man die Rundstruktur der „Leber-Rundherde“, die von der ursprünglichen Schießscheiben-Konfiguration ausgeht.

Das gleiche Phänomen auch im Knochen, wenn Schnitt zufällig die aktive d.h. die Organschieß-Konfiguration getroffen.

Das Bild zeigt 2 aktive in Schießscheiben eines Wirbelkörpers. besagt, daß Osteolysen, also Entzündung des Wirbels im Gang entsprechend einem akuten Werteinbruch-Konflikt.

En las dos secciones siguientes vemos los focos ya calcificados, los nuevos focos activos y los procesos de reparación que corresponden a un proceso crónico de recaída.

10.9 Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber

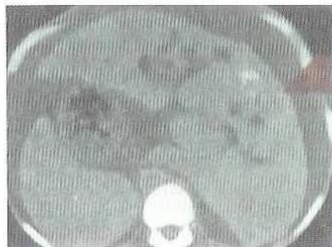


Mehrere Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber: Stets frühes Stadium eines sog. solitären Leberkarzinoms. Die Schießscheiben-Kontfiguration des Organs steht mit der Schießscheiben-Kontfiguration des Gehirns in Korrespondenz, genauer gesagt können mehrere Organ-

schießscheiben-Kontfigurationen mit einer Gehirnschießscheiben-Kontfiguration in Korrespondenz stehen.

Das Aufregende an diesem empirisch gefundenen Zusammenhang ist, daß praktisch das Gehirn und das Organ im gleichen Takt „schießscheiben-konfigurationsmäßig“ schwingen, d.h. wir können uns das Organ mit seinen Zellkernen, die alle miteinander vernetzt sind quasi als ein zweites Gehirn vorstellen, als Organgehirn. Kopfgehirn und Organgehirn schwingen in der gleichen Phase in gleicher Weise, wie unsere Schießscheiben-Kontfigurationen zeigen. Mal gibt das Kopfgehirn Befehle an das Organgehirn, z.B. Motorik, mal gibt das Organgehirn Informationen an das Kopfgehirn, z.B. Sensorik. Wir wußten diese Dinge z.T. schon aus der Neurologie, kamen aber bisher nicht weiter, weil wir die Zusammenhänge der Neuen Medizin nicht kannten.

Die folgenden Aufnahmen zeigen den Verlauf solcher Schießscheiben-Kontfigurationen in der Leber:



Auf den beiden nachfolgenden Abbildungen sehen wir bereits verkalkte Herde, wieder neue aktive Herde und Heilungsverläufe, die einem chronisch-rezidivierenden Prozeß entsprechen.



Erneute Heilungsphase dieses Restzustandes (Verkalkung) mit erneut abgelaufenem Leber-Solitär-Karzinom, entsprechend einer chronisch rezidivierenden Verhungerungs-Angst. Immer sieht man die Rundstruktur der „Leber-Rundherde“, die von der ursprünglichen Schießscheiben-Kontfiguration ausgeht.

Das gleiche Phänomen sehen wir auch im Knochen, wenn im CT-Schnitt zufällig die aktive Phase, d.h. die Organschießscheiben-Kontfiguration getroffen wurde.

Das Bild zeigt 2 aktive Herde in Schießscheibenform eines Wirbelkörpers. Das CT besagt, daß Knochen-Osteolysen, also Entkalkungen, des Wirbels im Gange sind, entsprechend einem aktiven Selbstwerteinbruch-Konflikt.



Nueva fase de reparación de este estado residual (calcificación) con carcinoma hepático solitario tras la fase de solución, correspondiente a un miedo de morir de hambre que se repite de modo crónico. Se ve siempre la estructura circular de los “adenocarcinomas hepáticos” que deriva de la configuración concéntrica originaria.

También en los huesos vemos el mismo fenómeno cuando en la TAC se encuentra fortuitamente la fase activa, es decir, la configuración concéntrica en el órgano.

La imagen muestra dos focos activos en la configuración concéntrica de un cuerpo vertebral.

La TAC indica que están en curso la osteólisis ósea, es decir, descalcificaciones, de la vértebra que corresponde a un conflicto activo de desvaloración de sí mismo.



Daneben sehen wir auf einem anderen Bild der gleichen Serie auch noch randständig aktive Herde, insgesamt also 3 Ringformationen des „Organgehirns“.

10.9.1 Verhungerungs-Konflikt, weil die Köchinnen gehen

Diesen Fall einer 43jährigen rechtshändigen Patientin habe ich in dieses Buch genommen, weil er so eindringlich auf organischer Ebene ist.

Die Patientin hat mit 20 geheiratet in „bessere Kreise“, sie hatte aber ein Manko: Sie haßte Kochen (und Essen) und überhaupt Haushalt. Der Ehemann leistete ihr außer einem Hausmädchen auch eine Köchin. Obwohl sie sehr wenig vom Kochen verstand, quasi gar nichts, spielte sie gerne die strenge Hausfrau. Die Köchinnen bekamen das rasch heraus und eine nach der anderen verließ im Streit das Haus, stets mit der gleichen Begründung, da sie selbst nichts verstehe vom Kochen, wisse sie gar nicht, was sie da verlange. Insgesamt etwa zehn. Wir vermuten, daß sie das erste DHS mit Verhungerungs-SBS erlitt, als eine Köchin, die besser war als alle anderen und mit der sie stets reüssieren konnte, sie am Freitagabend verließ, während sie für Samstag eine große Gesellschaft zum Essen eingeladen hatte. Jedesmal, wenn wieder eine Köchin im Streit - meist Freitagabends - das Haus verließ, erlitt sie ein Rezidiv.

Vor 8 Jahren engagierte sie eine ausländische Köchin, die sehr gut war. Nach 3 Jahren sagte diese aber seines Tages, sie habe am letzten Wochenende geheiratet. Da erlitt sie wieder ein Rezidiv und einen Partnertrennungskonflikt (mit duktalem Mamma-Ca rechts), weil sie glaubte, nun gehe auch diese gute Köchin in absehbarer Zeit.

Aber sie ging nicht. Und so erlitt sie für den Verhungerungs-Konflikt wieder eine Lösung mit Nachschweiß wie bei den früheren Rezidiven. Dagegen löste sich der Trennungskonflikt seltsamerweise nicht, weil die Angst, daß die Köchin doch noch gehen könnte, blieb.

Anfang '94 wurde der kleine Schilddrüsenknoten entfernt und die Brust amputiert - die linke „prophylaktisch“, im November '98 an einem Freitagabend, und zwar ohne ein einziges Wort zu sagen. Wieder erlitt die Patientin ein starkes Rezidiv.

Als sie nach einigen Wochen Ersatz mit einer anderen Köchin hatte, bekam sie wieder Nachtschweiß gegen Morgen.

Als man jetzt die Leberherde durch Zufall entdeckte, metastasierendes Mamma-Ca mit „Lebermetastasen“, sei nichts mehr zu machen, nur „Palliativ“.¹⁷³

Durch die Neue Medizin kann sie jetzt den Konflikt der Verhinderung neuer Rezidive beitragen und den Konflikt lösen.

Nebenstehendes CT der Leber ist für jeden Fachmann ein Genuß. Wir haben hier die Besonderheit, daß es zwar verschiedene Köchinnen waren, aber stets nahezu exakt der gleiche Konflikt. Und immer hatten wir in der Lösung eine Tbc mit Nachtschweiß und subfebrilen Temperaturen. Bei dieser Aufnahme vom November '98 befinden wir uns nach



einem besonders starken Rezidiv wieder in der Untersuchung sehen, daß die Kavernen sich durch sog. „intrafokales“ prall ausfüllen und dadurch als Kavernen wieder erscheinen. Solche Kavernen können auch, weil sie ja durch das Parenchym in der Zwischenzeit kollabiert und wieder oder weniger geschlossen bleiben. In solchen Fällen ist das „perifokale“ Oedem. Die beiden schmalen Pfeile zeigen schon wieder mit erheblicher Callusmenge gefüllte Kavernen links und rechts. Der rechte breite obere Pfeil zeigt auf die Kaverne.

¹⁷¹ szirrhus = hier: Zusammenziehung der Brustdrüse

¹⁷² Prophylaxe = Vorbeugung

¹⁷³ palliativ = prämortale Symptom-Behandlung

Al lado vemos en una imagen de la misma serie focos todavía activos marginales, en total 3 formaciones en anillo del “cerebro del órgano”.

10.9.1. Conflicto de morir de hambre porque las cocineras se van

He metido en este libro el caso de una paciente de 43 años diestra porque es muy convincente a nivel orgánico.

La paciente se había casado a los 20 años con un “buen partido”, pero tenía un problema: odiaba cocinar (y comer) y sobretodo ocuparse de la casa. El marido le permitía el lujo de tener una cocinera y una asistente. Aunque entendía bien poco de cocina, prácticamente nada, se metía a hacer de señora de la casa. Las cocineras no lo soportaban y una tras otra iban dejando la casa entre peleas siempre por la misma razón, que no teniendo ni idea de cocina, no sabía ni lo que quería. Pensamos que la mujer sufrió su primer DHS con programa EBS de miedo de morir de hambre cuando una cocinera, que era mejor que todas las otras y con la que siempre consiguió llevarse bien, la dejó un viernes por la tarde cuando el sábado siguiente habían invitado a un gran número de personas a comer. Cada vez que una cocinera, a menudo el viernes por la tarde, dejaba la casa por una pelea, sufría una recaída.

Desde hacía ocho años había cogido una cocinera extranjera que era muy buena. Tras 3 años esta un día le dijo que se había casado el fin de semana anterior. Sufrió nuevamente una recaída y un conflicto de separación del partner (con adenocarcinoma mamario ductal derecho), porque creyó que también esta buena cocinera se iría en poco tiempo. Pero no se fue y la paciente tuvo una solución con sudor nocturno para el conflicto de miedo de morir de hambre, como en las anteriores recaídas. Por el contrario, y extrañamente, el conflicto de separación no se resolvió, porque permaneció el miedo de que la cocinera se fuera.

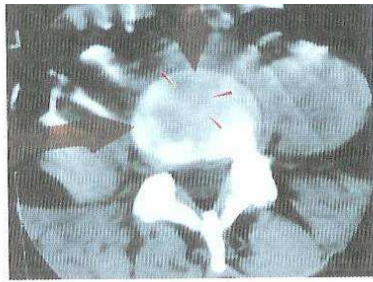
A comienzos del 94 se descubrió el pequeño nódulo cirroso en la mama derecha, que fue amputada y, “profilácticamente, también la izquierda.

Cuatro años después, en noviembre del 98, un viernes por la tarde la cocinera se fue, sin decir ni una sola palabra, tras una pequeña pelea. Nuevamente la paciente sufrió una fuerte recaída.

Cuando algunas semanas después consiguió encontrar otra cocinera, nuevamente tuvo sudoración nocturna hasta la mañana (TBC).

Habiéndole encontrado casualmente ahora adenocarcinomas al hígado, se dijo: adenocarcinoma mamario con “metástasis en el hígado y en los huesos”, ante lo que no cabía paliativamente otra cosa que no fuera quimio y morfina.

Gracias a la Nueva Medicina se puede ahora entender el conflicto, contribuir a evitar nuevas recaídas y librarse de la locura de los “medicuchos”.



Daneben sehen wir auf einem anderen Bild der gleichen Serie auch noch randständig aktive Herde, insgesamt also 3 Ringformationen des „Organgehirns“.

10.9.1 Verhungerungs-Konflikt, weil die Köchinnen gehen

Diesen Fall einer 43jährigen rechtshändigen Patientin habe ich in dieses Buch genommen, weil er so eindringlich auf organischer Ebene ist.

Die Patientin hat mit 20 geheiratet in „bessere Kreise“, sie hatte aber ein Manko: Sie haßte Kochen (und Essen) und überhaupt Haushalt. Der Ehemann leistete ihr außer einem Hausmädchen auch eine Köchin. Obwohl sie sehr wenig vom Kochen verstand, quasi gar nichts, spielte sie gerne die strenge Hausfrau. Die Köchinnen bekamen das rasch heraus und eine nach der anderen verließ im Streit das Haus, stets mit der gleichen Begründung, da sie selbst nichts verstehe vom Kochen, wisse sie gar nicht, was sie da verlange. Insgesamt etwa zehn. Wir vermuten, daß sie das erste DHS mit Verhungerungs-SBS erlitt, als eine Köchin, die besser war als alle anderen und mit der sie stets reüssieren konnte, sie am Freitagabend verließ, während sie für Samstag eine große Gesellschaft zum Essen eingeladen hatte. Jedesmal, wenn wieder eine Köchin im Streit - meist Freitagabends - das Haus verließ, erlitt sie ein Rezidiv.

Vor 8 Jahren engagierte sie eine ausländische Köchin, die sehr gut war. Nach 3 Jahren sagte diese aber seines Tages, sie habe am letzten Wochenende geheiratet. Da erlitt sie wieder ein Rezidiv und einen Partnertrennungskonflikt (mit duktalem Mamma-Ca rechts), weil sie glaubte, nun gehe auch diese gute Köchin in absehbarer Zeit.

Aber sie ging nicht. Und so erlitt sie für den Verhungerungs-Konflikt wieder eine Lösung mit Nachschweiß wie bei den früheren Rezidiven. Dagegen löste sich der Trennungskonflikt seltsamerweise nicht, weil die Angst, daß die Köchin doch noch gehen könnte, blieb.

Anfang '94 wurde der Krebs schließlich entdeckt und die Brust amputiert - die linke „pro Jahre später, im November '98 an einem Freitagabend, und zwar ohne ein einziges Wort zu sagen. Wieder erlitt die Patientin ein starkes Rezidiv.

Als sie nach einigen Wochen Ersatz mit einer hatte, bekam sie wieder Nachtschweiß gegen Mitternacht.

Als man jetzt die Leberherde durch Zufall entdeckte, metastasierendes Mamma-Ca mit „Leber- und Lungenmetastasen“, sei nichts mehr zu machen, nur „Palliativ“.¹⁷³ C

Durch die Neue Medizin kann sie jetzt den Konflikt lösen. Die Verhinderung neuer Rezidive beitragen und den Patienten helfen.

Nebstehendes CT der Leber ist für jeden Fachmann ein Genuß. Wir haben hier die Besonderheit, daß es zwar verschiedene Köchinnen waren, aber stets nahezu exakt der gleiche Konflikt. Und immer hatten wir in der Lösung eine Tbc mit Nachtschweiß und subfebrilen Temperaturen. Bei dieser Aufnahme vom November '98 befinden wir uns nach



einem besonders starken Rezidiv wieder in der tu sehen, daß die Kavernen sich durch sog. „intrafokale“ prall ausfüllen und dadurch als Kavernen wieder solche Kavernen können auch, weil sie ja durch das Parenchym in der Zwischenzeit kollabiert und entweder geschlossen bleiben. In solchen Fällen tritt ein „perifocales“ Oedem. Die beiden schmalen Pfeile zeigen wieder mit erheblicher Callusmenge gefüllte Kavernen links und rechts. Der rechte breite obere Pfeil zeigt auf die Kavernen rechts.

¹⁷¹ szirrös = hier: Zusammenziehung der Brustdrüse

¹⁷² Prophylaxe = Vorbeugung

¹⁷³ palliativ = prämortale Symptom-Behandlung

Esta TAC del hígado es extremadamente interesante para un experto. Aquí está la particularidad de que se trataba de diferentes cocineras, pero siempre del mismo conflicto, casi exactamente. Y siempre en la solución teníamos una TBC con sudor nocturno y temperaturas subfebriles. Con esta imagen de noviembre del 98 nos encontramos, tras una recaída particularmente fuerte, nuevamente en fase de reparación tuberculosa. Vemos que gracias al denominado “edema intrafocal” las cavernas vuelven a llenarse parcialmente volviéndose bien visibles. Pero cavernas semejantes pueden permanecer también más o menos cerradas porque a causa de la presión del parénquima que está alrededor durante ese tiempo estaban en parte consolidadas. En casos parecidos vemos sólo el nuevo edema “perifocal”. Las dos flechas estrechas indican las osteólisis de las costillas hinchadas y de nuevo llenadas con una notable cantidad de callo parasternalmente a la izquierda y a la derecha.

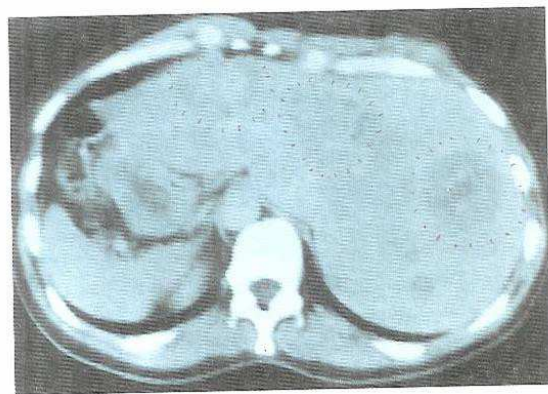
La flecha larga arriba a la derecha indica el estrato de silicona con el que se reconstruyó nuevamente la mama derecha. También la mama izquierda, que había sido amputada "profilácticamente", tiene un implante de silicona que, sin embargo, en esta radiografía se ve solo muy al exterior a la izquierda.

Con la doble amputación se explica la desvaloración de sí ("ya no valgo nada"). El implante de silicona fue para la paciente la solución del conflicto de desvaloración de sí, es decir, la recalcificación que aquí vemos antes que se haya completado.

die aber auf dieser Aufnahme nur ganz links außen angedeutet zu sehen ist. Aus der beidseitigen Amputation erklärt sich der Selbstwerteinbruch („dort taue ich nichts mehr“. Die Silikon-Einlage war für die Patientin die Lösung des Selbstwerteinbruch-Konfliktes, d.h. die Rekalkifizierung, die wir hier vor dem Abschluß sehen.



Auf dieser Kernspin-Aufnahme des Althirns sieht man das Leber-Relais in mäßiger Anfärbung als Zeichen der erneuten Lösung des Rezidivs.



Auf dieser Aufnahme der Leber, die eine etwas höhere Schicht darstellt als die vorherige Leber-CT-Aufnahme, sind einige, nicht alle, chronisch rezidivierenden und chronisch tuberkulosierenden Leberherde markiert. Für sie gilt ebenfalls das oben Gesagte.

Besonders interessant ist, daß man bei den Organ-HH hier die Rundstrukturen wieder gut erkennen kann und das intra- und perifocale Oedem.

10.10 Ke identische

Die folgenden z
lig gemeinsam
renz der Unive
stellt. Beide Pa
ersten Fall ist c
händer, beide h
und erlitten nu
chen Konflikt.
beiden Patient
im Kehlkopf-S
erfuhr wenige
hirnoperieren.
In völliger Pa
Monate etwas
lich weg war -
Operierten, vo

Der andere F
Operation. Ab
Wochenende z
kations-Konfer
davon überzeu
der Patient ar
eröffnete, daß
Tumor für inc
und Chemo kä
Prognose. Er s
und ließ sich r
Beschwerden.

Nach fünf J
nachträglich d
kavernom“ ge
einem „bösa

Der Patient d
Revierärger an
im Herbst '91
Konflikt zusa

En esta imagen de resonancia magnética del paleoencéfalo se ve el relé del hígado con una moderada coloración como signo de la nueva solución de la recaída.

En esta imagen del hígado, que muestra una sección un poco más arriba respecto a la TAC precedente, están señalados no todos, pero algunos de los focos hepáticos en solución tuberculosa crónica y en recaída crónica. También para éstos vale lo que se dijo arriba. Particularmente interesante es el hecho de que en el FH del órgano se pueden reconocer bien las estructuras circulares y el edema intra y perifocal.

10.10. ¡Ninguna operación en el cerebro! Dos casos casi idénticos en comparación

Los dos casos siguientes son muy parecidos entre ellos: los dos fueron presentados juntos por un médico de Genselkirchen en la conferencia de verificación de la Universidad de Düsseldorf, bajo la presidencia del prof. Stemmann.

Los dos pacientes, que eran de pueblos cercanos, se conocían. El primer paciente de 28 años y el segundo de 19, eran los dos diestros. Los dos ya habían en el lado cerebral derecho un conflicto activo y habían sufrido casi al mismo tiempo un segundo conflicto, prácticamente igual. Por lo tanto estaban los dos en constelación esquizofrénica. Se les diagnosticó, más o menos en el mismo período, un “tumor cerebral” en el centro motor-laríngeo. Desde aquel momento sus caminos se separaron: uno conoció la Nueva Medicina demasiado tarde; ignorante se dejó operar el cerebro porque le habían dicho que si no lo hacía moriría enseguida. Con un miedo terrible accedió a la intervención. Durante 2 o 3 meses se sintió un poco mejor, porque naturalmente la presión cerebral causada por el edema había desaparecido, pero seis meses más tarde estaba muerto, como casi todos los operados de cerebro, con poquísimas excepciones.

También el otro paciente estaba en la clínica para operarse. Pero por suerte faltaba la reserva de sangre necesaria. El fin de semana le dieron “vacaciones” y aprovechó para asistir a la conferencia de verificación de Gelsenkirchen. Los médicos presentes consiguieron convencerlo de que la operación del cerebro era un tema muy peligroso. Cuando el lunes el paciente comunicó a los médicos de la sección de neurocirugía que prefería no operarse, se declaró que el tumor no era operable porque era demasiado grande y maligno. Se tomó en consideración solamente la quimio y las irradiaciones, y eso con un pronóstico muy reservado.

El paciente profundizó en el estudio de la Nueva Medicina, la entendió y no se dejó operar. Como se pronosticó, tuvo molestias durante algunos meses, después de que estaba nuevamente sano y en condiciones de trabajar.

Tras cinco años la aseguradora del trabajo cambió a la fuerza el diagnóstico de "tumor cerebral maligno" por un "cavernoma cerebra benigno" porque no se podía aceptar que con un "tumor cerebral maligno" se hubiese curado sin operarse. El paciente del primer caso había tenido un rencor en el territorio en el puesto de trabajo algunos meses antes del segundo conflicto por la casa que estaba construyendo. En el momento del segundo conflicto en otoño del 91, el primero estaba todavía activo y se experimentó como una recaída conflictiva del primero.

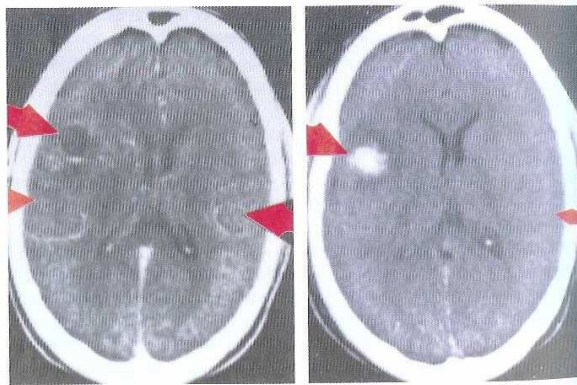
A causa de la construcción de la casa, el paciente estaba bajo un fuerte estrés, también por cuestiones de tiempo, porque construía la casa prácticamente sólo.

Sufrió el segundo conflicto cuando quiso montar una lámpara en las escaleras, se resbaló de un andamio y cayó 7 metros abajo. Consiguió, con un último esfuerzo, agarrarse a una tabla, quedando suspendido en el vacío, y con mucha fatiga y esfuerzo consiguió volver a tierra firme. Después le temblaba todo el cuerpo. El conflicto de susto imprevisto permaneció activo mientras que duró la construcción de la casa, porque tales situaciones se podían repetir, aunque fuera de un modo menos peligroso. Desde entonces trabajaba en condiciones más seguras, pero siempre temblaba cuando trabajaba suspendido "entre el cielo y la tierra".

En primavera la casa estaba terminada y entonces se llegó a la solución del conflicto. Volvieron trágicamente los signos de presión cerebral, disfunciones del habla y una crisis epiléptica, seguidamente llegó el diagnóstico y el pánico causado por la medicina tradicional. De poco sirvió decirle seguidamente que no debería operarse. Murió como una víctima del oscurantismo científico de la medicina oficial, que opera de mala fe, sabiendo bien que tales operaciones tienen una mortalidad casi del 100%.

Streß, auch zeitmäßig, denn er zog den Bau weitgehend in Eigenleistung durch. Den 2. Konflikt erlitt er, als er über dem Treppenhaus eine Lampe montieren wollte, von einem Brett abrutschte und sich schon 7 Meter tiefer mit zerschmettertem Schädel im Kellerniveau liegen sah. Da bekam er noch mit letzter Kraft ein Brett zu fassen, hing in der Luft und konnte sich dann mühsam/langsam zum Treppengeländer zurückhangeln. Danach zitterte er am ganzen Leibe. Der Schreckangst-Konflikt blieb für die Dauer des Hausbaus aktiv, weil sich solche Situationen natürlich laufend in harmloser Art wiederholten. Er sicherte sich zwar von da ab besser ab aber er zitterte immer noch, wenn er wieder zwischen „Himmel und Erde“ arbeitete.

Im Frühjahr war der Hausbau fertig und damit kam die Konfliktlösung...Es stellten sich tragischerweise Hirndruckzeichen ein, Sprachstörungen und ein epileptischer Anfall, danach kam die Diagnose und die Panikmache der Schulmedizin. Es nützte ihm wenig als man später sagte, er hätte sich nie operieren lassen dürfen. Er starb als Opfer der böswilligen Erkenntnisunterdrückung der Schulmedizin, die genau weiß, daß solche Eingriffe eine fast 100%ige Mortalität haben.



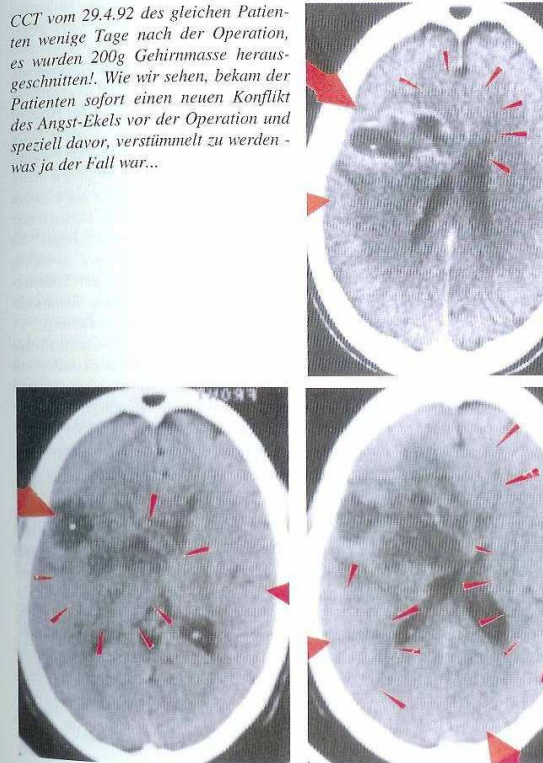
Der Patient hatte einen motorischen Konflikt erlitten als er durchs Treppenhaus des Hausneubaus stürzte, sich im letzten Moment aber noch auffangen konnte. Auf diesen CCT-Aufnahmen vom 8.3.92 (links mit, rechts ohne Kontrastmittel) des 28jährigen Patienten sehen wir folgende HHs:

Linkes Bild: Zustand vor der Operation. Pfeil rechts: Revierärger-Konflikt wegen Hausbau (aktiv). Pfeil links oben: HH für pcl-Phase in Keh-

kopf/Sprachzentrum-Ketals. Pfeil links unten: Identitäts-Konflikt. Der Patient scheint aktiv zu sein. Der Patient war sich nicht sicher, ob er sich operieren lassen sollte. Sein Gefühl sagte ihm: „Nein“!

Rechtes Bild: die gleichen HH wie im linken Bild, diesmal mit Kontrastmittel. Rechter Pfeil: Revierärger-Konflikt. Linker Pfeil: HH in pcl-Phase mit Kontrastmittel angefärbt. Unterer Pfeil links: Identitäts-Konflikt aktiv!

CCT vom 29.4.92 des gleichen Patienten wenige Tage nach der Operation, es wurden 200g Gehirnmassse herausgeschnitten! Wie wir sehen, bekam der Patient sofort einen neuen Konflikt des Angst-Ekels vor der Operation und speziell davor, verstümmelt zu werden - was ja der Fall war...



El paciente había sufrido un conflicto motor cuando había caído al hueco de las escaleras durante la construcción de su nueva casa, consiguiendo al final agarrarse y no caer.

En estas imágenes TAC del 8.3.92 del paciente de veintiocho años (a la derecha con medio de contraste, a la izquierda sin) vemos los siguientes FH:

Imagen izquierda: estado antes de la operación. Flecha a la derecha: conflicto de rencor en el territorio a causa de la construcción de la casa (activo). Flecha a la izquierda: FH por la fase PCL en el relé del centro motor de la laringe.

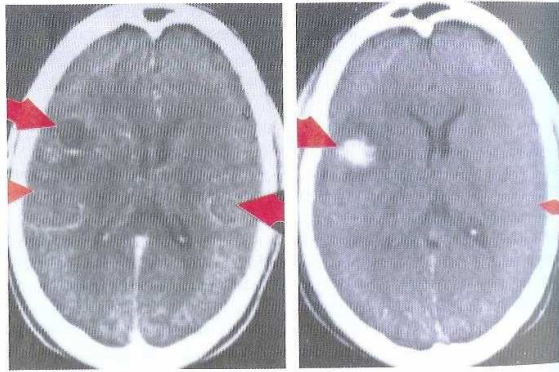
Flecha izquierda abajo: conflicto de identidad. El conflicto aparece activo. El paciente no estaba seguro de querer operarse. Su sentimiento le decía "no".

Imagen a la derecha: el mismo FH que aparece en la figura a la izquierda, esta vez con medio de contraste.

Flecha a la derecha: conflicto de rencor en el territorio. Flecha de abajo a la izquierda: conflicto de identidad activo.

Streß, auch zeitmäßig, denn er zog den Bau weitgehend in Eigenleistung durch. Den 2. Konflikt erlitt er, als er über dem Treppenhaus eine Lampe montieren wollte, von einem Brett abrutschte und sich schon 7 Meter tiefer mit zerschmettertem Schädel im Kellerniveau liegen sah. Da bekam er noch mit letzter Kraft ein Brett zu fassen, hing in der Luft und konnte sich dann mühsam-langsam zum Treppengeländer zurückhangeln. Danach zitterte er am ganzen Leibe. Der Schreckangst-Konflikt blieb für die Dauer des Hausbaus aktiv, weil sich solche Situationen natürlich laufend in harmloser Art wiederholten. Er sicherte sich zwar von da ab besser ab aber er zitterte immer noch, wenn er wieder zwischen „Himmel und Erde“ arbeitete.

Im Frühjahr war der Hausbau fertig und damit kam die Konfliktlösung...Es stellten sich tragischerweise Hirndruckzeichen ein, Sprachstörungen und ein epileptischer Anfall, danach kam die Diagnose und die Panikmache der Schulmedizin. Es nützte ihm wenig als man später sagte, er hätte sich nie operieren lassen dürfen. Er starb als Opfer der böswilligen Erkenntnisunterdrückung der Schulmedizin, die genau weiß, daß solche Eingriffe eine fast 100%ige Mortalität haben.



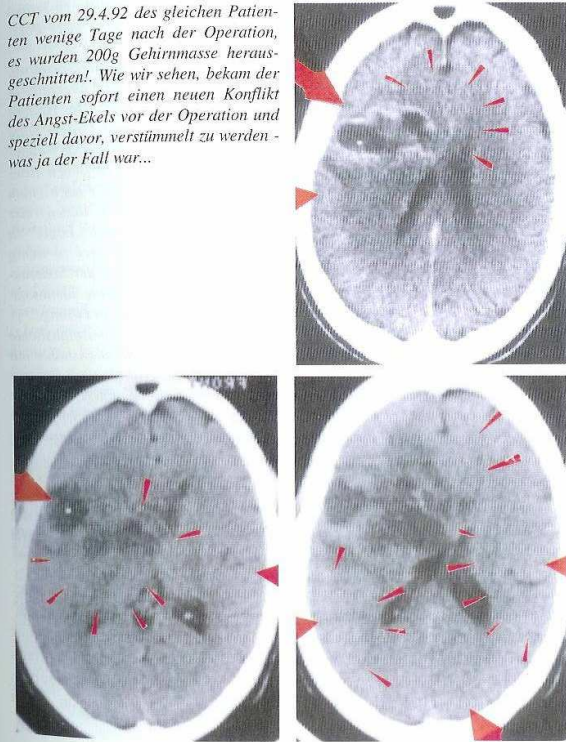
Der Patient hatte einen motorischen Konflikt erlitten als er durchs Treppenhaus des Hausneubaus stürzte, sich im letzten Moment aber noch auffangen konnte.

Auf diesen CCT-Aufnahmen vom 8.3.92 (links mit, rechts ohne Kontrastmittel) des 28jährigen Patienten sehen wir folgende HHs:

Linkes Bild: Zustand vor der Operation. Pfeil rechts: Revierärger-Konflikt wegen Hausbau (aktiv). Pfeil links oben: HH für pcl-Phase in Kehlkopf/Sprachzentrum-Ketals. Pfeil links unten: Identitäts-Konflikt. Der Konflikt scheint aktiv zu sein. Der Patient war sich nicht sicher, ob er sich operieren lassen sollte. Sein Gefühl sagte ihm: „Nein“!

Rehtes Bild: die gleichen HH wie im linken Bild, diesmal mit Kontrastmittel. Rechter Pfeil: Revierärger-Konflikt. Linker Pfeil: HH in pcl-Phase mit Kontrastmittel angefüllt. Unterer Pfeil links: Identitäts-Konflikt aktiv!

CCT vom 29.4.92 des gleichen Patienten wenige Tage nach der Operation, es wurden 200g Gehirnmassse heraus-geschnitten! Wie wir sehen, bekam der Patient sofort einen neuen Konflikt des Angst-Ekels vor der Operation und speziell davor, verstümmelt zu werden - was ja der Fall war...



TAC cerebral del 29.4.92 del mismo paciente algunos días tras la intervención, después de la extirpación de 200 gr. de masa cerebral. Como vemos el paciente sufrió inmediatamente un nuevo conflicto de miedo en la nuca por la operación y sobretodo por quedar inútil, como de hecho fue el caso.

Las dos secciones sucesivas del 11.10.92, poco antes de la muerte del paciente, no podrían ser más claras. El estrato izquierdo es un poco más profundo que el

derecho. En la foto de la izquierda se ve bien como todo el sistema ventricular anterior (cuernos anteriores) se comprime hacia la derecha bajo la hoz. También el cuerno anterior izquierdo está casi totalmente a la derecha de la línea mediana. Sólo nos queda aprender de los errores de los que se oponen a la Nueva Medicina e indicar los motivos de insensatez de su polipragmatismo.

En este paciente vemos que el relé para el recto en el cerebro a la izquierda, que en la primera sección se podía reconocer como activo, ahora está en solución.

Durante ese tiempo se realizó esa operación insensata. En ese punto era realmente innecesaria, el conflicto estaba “realmente resuelto”. El paciente con su caída o su suspensión entre “cielo y tierra” además de un conflicto de susto imprevisto con pérdida de la palabra había sufrido también un conflicto motor para el brazo derecho y la pierna derecha, seguidamente había sufrido también un conflicto de identidad de tipo femenino (“¿tengo que operarme o no?”). A esto le sigue que los cirujanos, para seguir con su “lógica”, y dado que los conflictos habían entrado en solución sucesivamente, habían extirpado demasiada poca sustancia cerebral. Al término de la casa el conflicto de susto imprevisto se había resuelto. Seguidamente se resolvió también el conflicto de identidad a la izquierda cerebralmente y también el conflicto de miedo en la nuca, provocado por la operación; entró en solución.

A causa de la operación se añadió todavía un problema más: la cavidad creada quirúrgicamente se hinchó de líquido convirtiéndose en un quiste. Hasta que el líquido cerebral contenido en la cavidad operatoria tiene un derrame, la cosa se mantiene. Pero apenas el derrame se ve obstaculizado por la cicatrización o, como en este caso, totalmente bloqueado, el paciente sufre una enorme presión cerebral. Entonces para los aprendices de brujo hace falta siempre otra operación, porque el “tumor cerebral maligno ha continuado destruyendo el tejido cerebral”.

En este caso se ve, como también en la TAC cerebral precedente, que el conflicto de rencor en el territorio a la derecha cerebralmente (FH flecha derecha) ha entrado parcialmente en solución, por el contrario a la izquierda en el relé del recto hay un nuevo conflicto activo de pérdida de identidad que ha aparecido en una configuración concéntrica bien nítida (FH flecha a la izquierda), porque se le anunció una nueva operación del cerebro.

Estos pobres pacientes yacen en casa totalmente indefensos e inertes. Los “buenos” amigos y “terapeutas bien intencionados” les importunan con sus palabrerías. El paciente ya no sabe que creer, sólo entiende a medias lo que le dicen y pasa de un miedo a otro. A menudo vemos que explotan nuevos conflictos. A menudo se resuelven rápidamente para ser remplazados por otras recaídas.

La ignorante, tonta y errada medicina tradicional constata sólo que el cáncer continúa creciendo y que se debe operar de nuevo.

Patienten
ist etwas
gesamte
überge-
Mittelli-

u lernen
er Poly-

cerebral,
nfalls in
Hadem
nt hatte
" außer
en Kon-
h einen
en oder
ogik" zu
u wenig
schreck-
entitäts-
mg...
mshöhle
öhle mit
einiger-
ler ganz
für die
ösartige

rechts-
Lösung
fikt des
cht (HH

Lauter
sie ein.
hin nur
Öftmals
rsalven
neuen

Rezidiven abgelöst zu werden. Die ignorante dumme und falsche Schulmedizin konstatiert dann nur: Der Krebs wächst weiter, wir müssen wieder operieren.

CCT vom 14.10.92 wenige Tage vor dem Tod des Patienten. Er wurde mit Morphin quasi eingeschläfert. Immer hört man dann den Spruch: „Ach, da war ja sowieso nichts mehr zu machen!“

Linker Pfeil: Endlich sieht man den HH im motorischen Rindenzentrum (für rechtes Bein), der die Epilepsie verursacht hat.

Rechter Pfeil oben: HH, durch Raumforderung links etwas nach rechts verschoben, betrifft linkes Bein und Arm, gerade in Lösung gehend.

Mittlerer Pfeil rechts: zögerlich in Lösung gehender HH für Revierärger-Konflikt.

Unterer Pfeil rechts: Großer, in Lösung befindlicher Angst-im-Nacken-Konflikt-HH, entsprechend der Angst vor dem Chirurgen, der das Hirn operieren wollte und operiert hat (Alles, was hinter der Hornhaut liegt, empfindet der Patient als hinten oder von hinten = Angst-im-Nacken!)



Der folgende Fall ist das Pendant zum vorangegangenen. Der damals 19jährige Patient ist inzwischen Computerfachman bei der Telekom und kann inzwischen aus dem Stehgreif einen Vortrag über die Neue Medizin halten. Der Konflikt in diesem Fall war fast identisch mit dem des vorangegangenen: Der Patientin sauste als Telekom-Lehrling ein Telefonmast hinunter, weil die Steigeisen nicht gegriffen hatten. Auch bei ihm war dieser Konflikt als ein zweiter Konflikt eingeschlagen und löste eine schizophrene Konstellation aus. Die Konflikte gingen etwa zeitgleich mit den Konflikten des jungen Patienten im vorausgegangenen Fall in Lösung bzw. wurden dann als „Hirntumor“ diagnostiziert. Auch dieser Patient war auf der Gelenkirchener Überprüfungskonferenz vom 18.5.92. Die Wege der beiden jungen Männer hatten sich jedoch kurz vorher schon getrennt, der eine junge Mann, Vater von zwei Kindern, war gerade frisch hirnoperiert...

TAC cerebral del 14.10.92 pocos días antes de la muerte del paciente. Prácticamente se le durmió con la morfina. Siempre se oye decir: Ah, no se podía hacer nada más.

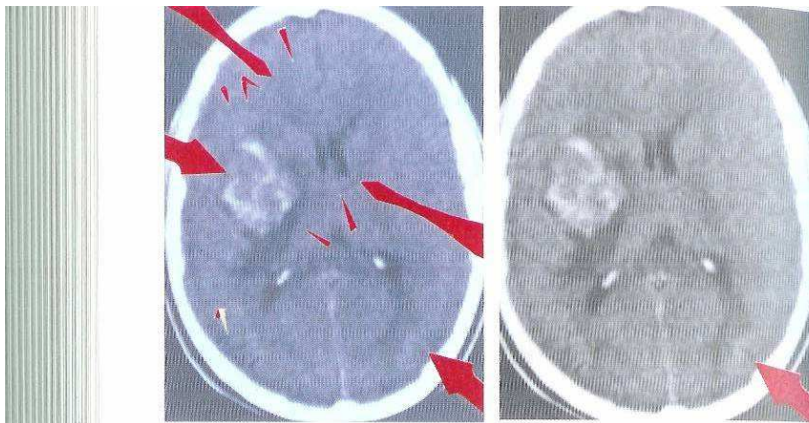
Flecha izquierda: al final se ve el FH en el centro cortical motor (para la pierna derecha) que ha causado la epilepsia.

Flecha derecha arriba: el FH un poco desviado hacia la derecha por falta de espacio a la izquierda tiene que ver con el brazo y la pierna izquierda y está entrando en solución.

Flecha central a la derecha: FH que entra "tímidamente" en solución para el conflicto de rencor en el territorio.

Flecha de abajo a la derecha: gran FH de conflicto de miedo en la nuca que está entrando en solución, correspondiente al miedo del cirujano, que quería operar y ha operado el cerebro (todo lo que está detrás de la cornea se experimenta por el paciente como posterior = miedo en la nuca).

El siguiente caso es el correlativo de este. El paciente que entonces tenía 19 años durante ese tiempo se convirtió en un experto de ordenadores de la Telekom y está en condiciones de mantener una conferencia sobre la Nueva Medicina. El conflicto de este caso era casi idéntico al precedente: el paciente, como aprendiz de Telekom, se cayó de un poste telefónico. También en este caso el conflicto afectaba como segundo conflicto desencadenando una constelación esquizofrénica. Los conflictos entraron en solución casi al mismo tiempo que los del paciente del caso anterior, y fueron diagnosticados como "tumores cerebrales". Este paciente asistió a la conferencia de verificación de Gelsenkirchen el 18.5.92. Pero los caminos de los dos jóvenes se habían separado ya antes, el primero, padre de dos niños, acababa de ser operado del cerebro.



Linkes oberes Bild:

Oberer schmaler Pfeil links: in pcl-Phase befindlicher HH für Angst-Ekel-Konflikt. Organisch: Unterzuckerung, glucagon-produzierende Alpha-Inseldellen des Pankreas. Der Patient sträubt und eckelt sich, am Mast herunterzusausen.

Unterer Pfeil links: der sog. „Hirntumor“ im Brocazentrum. Einen früher sog. „Hirntumor“, der natürlich gar keiner ist, sieht man immer erst in der pcl-Phase als im Prinzip harmlose Reparatur des betroffenen gewesen Relais durch Einlagerung von Glia-Bindegewebszellen. Wir sehen hier, daß auch die Motorik des rechten Arms miteinbezogen war. Wenn solch ein riesiger sog. „Hirntumor“ spontan wieder abheilt, dann braucht man wirklich keinen der „Hirntumore“ zu operieren. Das heißt aber nicht, daß uns diese oedematösen Reparatur-„Baustellen“ durch ihre Raumforderung, Hirndruckzeichen, Kopfschmerzen und epileptischen Anfälle, nicht vorübergehend Kopfzerbrechen machen können. Aber gerade dafür hat unsere Intensivmedizin heute gute Möglichkeiten. 95-98% überleben auch ohne Intensivbehandlung. Und nur ganz wenige Prozent (2 bis 3% etwa) sind so kritisch, daß sie ohne Intensivmaßnahmen sterben würden. Sogar mit Intensivmaßnahmen sterben uns einige dieser 2 bis 3%, denn Herrgötter sind wir auch nicht. Besonders Angst haben wir dabei vor den Rezidiven, die alle Narben in der anschließenden pcl-Phase wieder aufreißen. Aber angesichts der fast hundertprozentigen Mortalität der Hirnoperationen ist das ja quasi gar nichts.

Oberer Pfeil rechts: noch aktiver HH im Relais des motorischen Rinden-zentrums für beide Beine, die er um den Telegraphenmasten geklammert hatte, entsprechend einer Teillähmung beider Beine. Hier und am rechten Arm hatte er früher - und später bei den Rezidiven nochmals - die epileptischen Krisen erlitten.

Nebenstehendes Bild:

Oberer Pfeil von oben: HH motorisches Rindenzentrum betreffend (Teillähmung beider Beine).

Der unterste Pfeil zeigt, ebenso wie der jeweils unterste Pfeil auf den vorangegangenen Bildern: auf einen HH die linke „Kind/Mutter-Körperseite betreffend, der mittlere Pfeil auf das Bronchial-Relais (HH in pcl-Phase). Muskel-Relais für linkes Bein und linke Hüfte und Angst-im-Nacken-Konflikt bildeten stets eine dreifache Schiene bei allen Verboten der Mutter. Das sollte noch für später eine gewisse Bedeutung bekommen, als er gegen den ausdrücklichen Rat der Mutter mit seiner Freundin später mitten in der Nacht seine Urlaubsreise starten wollte. In der ersten Nacht der Krise links-cerebral geriet er augenblicklich für eine Nacht in die schizophrene corticale Konstellation.

Der 19jährige Patient dieses zweiten Falles nun größeren „Hirntumor“, so schien es. Deswegen auch als inoperabel mit infauster Prognose erkannt und ohne Chemo folge der Tod in wenigen Tagen.

Nun, den „Tumor“ hat der Patient natürlich nicht, um eine harmlose Gliaverdichtung als Zeichen der Reparatur des Relais. Natürlich sieht man später kein Tumor mehr geschwollen.

Imagen de arriba a la izquierda:

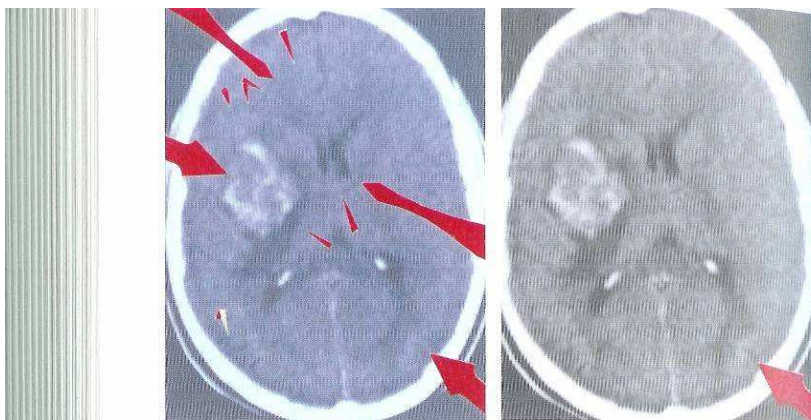
Flecha estrecha a la izquierda arriba: FH en fase PCL para el conflicto de miedo con asco. Orgánicamente: hipoglucemia, células insulares alfa del páncreas que producen glucagón. El paciente se niega y se disgusta con el pensamiento de caer del palo.

Flecha de abajo a la izquierda: el denominado “tumor cerebral” en el área de Broca. Un “tumor cerebral”, como se llamaba en el pasado, pero que obviamente no lo es, es visible sólo en la fase PCL como reparación inofensiva del relé afectado a causa de la acumulación de células de tejido conectivo glial. Aquí vemos que estaba involucrada también la motricidad del brazo derecho. Cuando un “tumor cerebral” tan grande se cicatriza espontáneamente, realmente no hace falta operar. Sin embargo eso no significa que estas “obras” de preparación

edematosa a causa de su proceso expansivo, de la presión cerebral, de los dolores de cabeza y de las crisis epilépticas no produzcan fuertes desajustes temporales.

Y justo con este propósito nuestra medicina intensiva ofrece buenas posibilidades. El 95-98% sobrevive incluso sin tratamiento intensivo. Y sólo pocos, en un porcentaje pequeñísimo (cerca del 2-3%), son tan graves que mueren sin tratamientos intensivos. Incluso con los cuidados intensivos parte de este 2-3% muere, porque no somos dioses. En particular hay que temer las recaídas que laceran de nuevo todas las cicatrices en la fase PCL final. Pero esto no es casi nada frente a la mortalidad de las operaciones del cerebro, cercana al 100%.

Flecha de arriba a la derecha: FH todavía activo en el relé del centro cortical motor para las dos piernas con el que se había aferrado al poste telefónico, correspondiente a una parálisis parcial de los dos tipos. Había sufrido las crisis epilépticas en el brazo derecho en el pasado, y después nuevamente con las recaídas.



Linkes oberes Bild:

Oberer schmaler Pfeil links: in pcl-Phase befindlicher HH für Angst-Ekel-Konflikt. Organisch: Unterzuckerung, glucagon-produzierende Alpha-Inselzellen des Pankreas. Der Patient sträubt und ekelt sich, am Mast herunterzusausen.

Unterer Pfeil links: der sog. „Hirntumor“ im Brocazentrum. Einen früher sog. „Hirntumor“, der natürlich gar keiner ist, sieht man immer erst in der pcl-Phase als im Prinzip harmlose Reparatur des betroffenen gewesenen Relais durch Einlagerung von Glia-Bindegewebszellen. Wir sehen hier, daß auch die Motorik des rechten Arms miteinbezogen war. Wenn solch ein riesiger sog. „Hirntumor“ spontan wieder abheilt, dann braucht man wirklich keinen der „Hirntumore“ zu operieren. Das heißt aber nicht, daß uns diese oedematösen Reparatur-„Baustellen“ durch ihre Raumforderung, Hirndruckzeichen, Kopfschmerzen und epileptischen Anfälle, nicht vorübergehend Kopfzerbrechen machen können. Aber gerade dafür hat unsere Intensivmedizin heute gute Möglichkeiten. 95-98% überleben auch ohne Intensivbehandlung. Und nur ganz wenige Prozent (2 bis 3% etwa) sind so kritisch, daß sie ohne Intensivmaßnahmen sterben würden. Sogar mit Intensivmaßnahmen sterben uns einige dieser 2 bis 3%, denn Herrgötter sind wir auch nicht. Besonders Angst haben wir dabei vor den Rezidiven, die alle Narben in der anschließenden pcl-Phase wieder aufreißen. Aber angesichts der fast hundertprozentigen Mortalität der Hirnoperationen ist das ja quasi gar nichts.

Oberer Pfeil rechts: noch aktiver HH im Relais des motorischen Rinden-zentrums für beide Beine, die er um den Telegraphenmasten geklammert hatte, entsprechend einer Teillähmung beider Beine. Hier und am rechten Arm hatte er früher - und später bei den Rezidiven nochmals - die epileptischen Krisen erlitten.

Nebenhstehendes Bild:

Oberer Pfeil von oben: HH motorisches Rindenzentrum betreffend (Teillähmung beider Beine).

Der unterste Pfeil zeigt, ebenso wie der jeweils unterste Pfeil auf den vorangegangenen Bildern: auf einen HH die linke „Kind/Mutter-Körperseite betreffend, der mittlere Pfeil auf das Bronchial-Relais (HH in pcl-Phase). Muskel-Relais für linkes Bein und linke Hüfte und Angst-im-Nacken-Konflikt bildeten stets eine dreifache Schiene bei allen Verboten der Mutter. Das sollte noch für später eine gewisse Bedeutung bekommen, als er gegen den ausdrücklichen Rat der Mutter mit seiner Freundin später mitten in der Nacht seine Urlaubsreise starten wollte. In der Nacht brach eine Krise links-cerebral geriet er augenblicklich für einige Minuten in die schizophrene corticale Konstellation.

Der 19jährige Patient dieses zweiten Falles nur einen größeren „Hirntumor“, so schienen es. Deswegen wurde er auch als inoperabel mit infauster Prognose erachtet und ohne Chemo folgte der Tod in wenigen Tagen.

Nun, den „Tumor“ hat der Patient natürlich nicht, sondern um eine harmlose Gliaverdichtung als Zeichen einer Reparatur des Relais. Natürlich sieht man später keinen Tumor, der nicht mehr geschwollen.

Imagen de al lado:

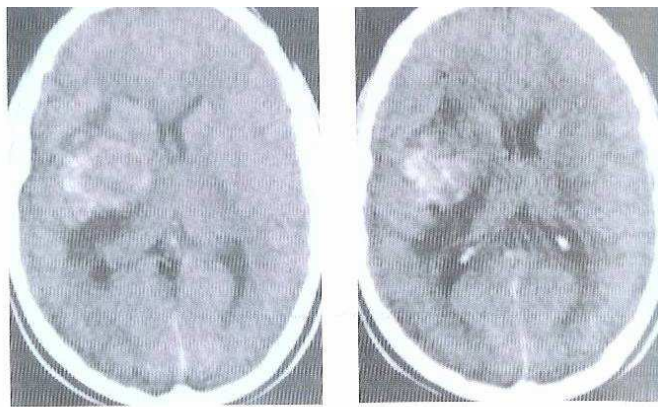
Flecha de arriba: FH referido al centro cortical motor (parálisis parcial de las dos piernas). La flecha de más abajo, como cada flecha inferior en las imágenes precedentes, indica un FH que afecta al lado corporal izquierdo “madre/niño”, la flecha central indica el relé bronquial (FH en fase PCL).

El relé de los músculos de la pierna izquierda y el conflicto de miedo en la nuca siempre han formado una triple vía para todas las prohibiciones de la madre. Esto tenía que haber tenido una cierta importancia cuando él, desobedeciendo el consejo explícito de la madre, quiso hacer un viaje con su novia. Con la crisis epiléptica a la izquierda cerebralmente entró también en constelación esquizofrénica cortical temporalmente por la duración del ataque epiléptico.

El paciente de diecinueve años del segundo caso tenía de hecho un “tumor cerebral” muy grande, así parecía. Por eso al final su caso fue declarado no

operable con pronóstico nefasto. Sin radiación y sin quimio la muerte se produciría en pocos días.

Hoy el paciente tiene todavía, obviamente, el "tumor". Se trata de un espesamiento de tejido glial inocuo como signo de una reparación sucedida en el relé. Naturalmente seguidamente no se ve ya ningún edema, el relé no está hinchado.



Bilder rechts und links: In Abheilung befindlicher sog. „Hirntumor“ einige Monate später.

Diese Fälle zeigen besonders deutlich, daß die Patienten sterben, weil man den Unsinn der Hirnoperationen mit ihnen macht. In unserem Fall hier entschloß sich der Patient nichts zu machen, die Konflikte waren gelöst und konnten eigentlich nicht wiederkommen. Zum Zeitpunkt des DHS hatte es noch ein halbes Jahr gedauert, bis er vom praktischen Lehrabschnitt (mit Telefonmaststeigen) in den nächsten Lehrabschnitt wechseln konnte (Bürotätigkeit). Wir hatten ihm alle wärmstens empfohlen, auf keinen Telegraphenmast o.ä. mehr zu steigen auch nicht aus Spaß. Auch nicht auf etwas ähnliches, z.B. einen Hausfirst. Dies sah der Patient auch ein. Nach 5 Jahren wurde der Patient von der Berufsgenossenschaft einbestellt:

Arzt: „Herr X., wie geht es Ihnen?“

Patient: „Guten Tag, Herr Doktor, mir geht es gut.“ Ich habe keine Beschwerden, keine Anfälle. Seit 4 ½ Jahren geht es mir gut.

Arzt: „Aber Sie haben doch einen Hirntumor?“

Patient: Ja und wenn, es geht mir aber trotzdem ausgezeichnet, ich bin voll leistungsfähig. Es geht mir wirklich gut!“

Arzt: „Ja, aber es darf Ihnen nicht gut gehen. Sie müßten ja sonst nach 5 Jahren jetzt vom Hirntumor als geheilt angesehen werden. Und der Hirntumor ist ja auf den Bildern nach wie vor zu sehen, wenn auch kleiner.“

Patient: „Herr Doktor, was soll ich Ihnen sagen? Es geht mir wirklich vollkommen gut, es fehlt mir nichts.“

Arzt: „Nem, so geht das nicht. Also, auf die Operation und ohne Operation. Also, entweder war Sie gestorben sein oder es war eben kein noch!“

Patient: „Ja aber Herr Doktor, ich war Operation, nur weil kein Blut da war... und wieso inoperabel, man müßte mir ja das da wäre ohnehin nichts mehr zu machen und Chemo.“

Arzt: „Also basta, Sie können keinen Hirntumor ja noch. Wir müssen jetzt eine neue Diagnose Hirnkavernom!“

Patient: „Wenn Sie meinen, Herr Doktor, ich will, mich stört das nicht. Aber was ist das Kavernom?“

Arzt: „Das ist doch völlig gleichgültig, Sie müßten Sie doch schon längst tot sein!“

Patient schmunzelnd: „Ja natürlich, Herr Doktor. Ich habe also nie einen Hirntumor gehabt. Glück, das Sie mich nicht operiert haben.“

Seither läuft der Fall des Patienten unter dem Namen „Hirnkavernom“.

Gleiche CCT-Aufnahme wie die vorhergehende nur mit veränderter Aufnahmetechnik.

Durch die Rezidive hat der Patient „Hirntumor“ in der pcl-Phase wieder Oedem bekommen. Glücklicherweise war es nur ein kurzes Rezidiv. Aber solche Rezidive, besonders wenn sie länger gedauert haben, fürchten wir sehr.

Zwei Monate nach dieser offiziellen nachträglichen Diagnose-Änderung kommt der Patenonkel des Patienten zu diesem und sagt: „Ach lieber Dirk, Du bist doch bei der Telekom, Du weißt doch sicher, wie man eine Satellitenschüssel aufs Dach mon-



Imágenes a la derecha y a la izquierda: el denominado “tumor cerebral” en reparación algunos meses más tarde.

Estos casos muestran de un modo particularmente claro que los pacientes mueren a causa de insensatas operaciones de cerebro. En nuestro ejemplo, el paciente decidió no hacer nada, los conflictos estaban resueltos y no podían volver. Desde el momento del DHS hizo falta casi medio año antes de que pudiese pasar del aprendizaje (con escalas en los postes del teléfono) al nivel sucesivo (actividad de oficina). Todos le habíamos recomendado insistentemente que no se volviese a subir a ningún poste, ni siquiera por diversión. Ni tampoco que hiciera nada parecido, por ejemplo en el techo de una casa. El paciente había comprendido. Tras cinco años le llamaron de la aseguradora del trabajo:

-Médico: Señor X, ¿cómo está?

-Paciente: Buenos días, doctor, estoy bien. No tengo ninguna molestia, ninguna crisis. Desde hace 4 años y medio estoy bien.

-Médico: ¿Sin embargo usted tiene un tumor cerebral?

-Paciente: Sí, pero a pesar de eso estoy estupendamente y en condiciones de trabajar. Estoy de verdad bien.

-Médico: Si, pero usted no puede estar bien. De otra manera debería haberse curado del tumor cerebral que sin embargo se ve todavía en las radiografías como antes, aunque más pequeño.

-Paciente: Señor doctor, ¿qué quiere que le diga? Estoy realmente bien, no me hace falta nada.

-Médico: No puede ser. Con un tumor cerebral se muere, tanto si se opera como si no. Entonces, o se trataba de un tumor cerebral, con lo que debería estar muerto, o no era un tumor cerebral, y por eso usted está vivo todavía.

-Paciente: Si doctor, pero yo estuve en la clínica para operarme, pero como no había sangre... y entonces han dicho que no era operable porque habrían tenido que extirparme la mitad del cerebro, y que ya no había nada que hacer, ni radio ni quimio.

-Medico: Basta, usted no ha tenido ningún tumor cerebral, porque todavía está vivo. Ahora tendremos que encontrar un nuevo diagnóstico, por ejemplo “cavernoma cerebral benigno”.

-Paciente: Si usted lo cree, doctor, puede llamarlo como quiera, no me molesta. ¿Qué es un cavernoma cerebral benigno?

-Médico: Eso es totalmente indiferente, pero siendo benigno se explica porque no ha muerto.

-Paciente sonriendo: Si, ciertamente, señor doctor, lo tomo en cuenta. No he tenido jamás un tumor cerebral y no lo tengo ahora tampoco. Es una suerte que usted no me haya operado.

Desde entonces el caso del paciente sigue con el diagnóstico de “cavernoma benigno”.



Bilder rechts und links: In Abheilung befindlicher sog. „Hirntumor“ einige Monate später.

Diese Fälle zeigen besonders deutlich, daß die Patienten sterben, weil man den Unsinn der Hirnoperationen mit ihnen macht. In unserem Fall hier entschloß sich der Patient nichts zu machen, die Konflikte waren gelöst und konnten eigentlich nicht wiederkommen. Zum Zeitpunkt des DHS hatte es noch ein halbes Jahr gedauert, bis er vom praktischen Lehrabschnitt (mit Telefonmaststeigen) in den nächsten Lehrabschnitt wechseln konnte (Büro-tätigkeit). Wir hatten ihm alle wärmstens empfohlen, auf keinen Telegra-phenmast o.ä. mehr zu steigen auch nicht aus Spaß. Auch nicht auf etwas ähnliches, z.B. einen Hausfirst. Dies sah der Patient auch ein. Nach 5 Jah-ren wurde der Patient von der Berufsgenossenschaft einbestellt:

Arzt: „Herr X., wie geht es Ihnen?“

Patient: „Guten Tag, Herr Doktor, mir geht es gut.“ Ich habe keine Be-schwerden, keine Anfälle. Seit 4 ½ Jahren geht es mir gut.

Arzt: „Aber Sie haben doch einen Hirntumor?“

Patient: Ja und wenn, es geht mir aber trotzdem ausgezeichnet, ich bin voll leistungsfähig. Es geht mir wirklich gut!“

Arzt: „Ja, aber es darf Ihnen nicht gut gehen. Sie müßten ja sonst nach 5 Jahren jetzt vom Hirntumor als geheilt angesehen werden. Und der Hirntumor ist ja auf den Bildern nach wie vor zu sehen, wenn auch klei-ner.“

Patient: „Herr Doktor, was soll ich Ihnen sagen? Es geht mir wirklich vollkommen gut, es fehlt mir nichts.“

Arzt: „Nein, so geht das nicht. Also, an-und ohne Operation. Also, entweder war Sie gestorben sein oder es war eben ke-noch!“

Patient: „Ja aber Herr Doktor, ich wa-Operation, nur weil kein Blut da war...u-wieso inoperabel, man müßte mir ja da-da wäre ohnehin nichts mehr zu mache-und Chemo.“

Arzt: „Also basta, Sie können keinen Hi-ja noch. Wir müssen jetzt eine neue D-Hirnkavernom!“

Patient: „Wenn Sie meinen, Herr Doktor-wollen, mich stört das nicht. Aber was is-nom?“

Arzt: „Das ist doch völlig gleichgültig-müßten Sie doch schon längst tot sein!“

Patient schmunzelnd: „Ja natürlich, He-Ich habe also nie einen Hirntumor gehabt-Glück, das Sie mich nicht operiert haben“

Seither läuft der Fall des Patienten unter Hirnkavernom“.

Gleiche CCT-Aufnahme wie die vor-hergehende nur mit veränderter Auf-nahmetechnik.

Durch die Rezidive hat der „Hirntumor“ in der pcl-Phase wieder Oedem bekommen. Glücklicherweise war es nur ein kurzes Rezidiv. Aber solche Rezidive, besonders wenn sie länger gedauert haben, fürchten wir sehr.

Zwei Monate nach dieser offiziellen nachträglichen Diagnose-Änderung kommt der Patenonkel des Patienten zu diesem und sagt: „Ach lieber Dirk, Du bist doch bei der Telekom, Du weißt doch sicher, wie man eine Satellitenschüssel aufs Dach mon-

Imagen de TAC cerebral igual a la anterior, pero con técnica fotográfica modificada.

A causa de las recaídas el “tumor cerebral” en la fase PCL ha producido de nuevo edema. Afortunadamente se ha tratado sólo de una breve recaída. Pero estas recaídas son muy temibles, sobretudo si duran mucho.

Dos meses después de esta modificación oficial del diagnóstico póstumo el padrino del paciente va a éste y le dice: “Querido Dirk, tu trabajas para la Telekom, seguro que sabes como se monta una antena parabólica en el techo. Ya he comprado todo, sólo tienes que montármela”.

El paciente se negó. Se le había dicho explícitamente, en base a la Nueva Medicina, que podría hacer todo y que probablemente no tendría ningún otro

ataque epiléptico, pero que de ninguna manera, en el futuro próximo, debía subirse a ningún sitio, pues de lo contrario tendría una recaída y nuevamente una crisis epiléptica, según el cálculo hecho.

Sin embargo el padrino continuó insistiendo, interpretando como un despecho el que el paciente no le quisiera hacer este favor. El paciente al final pensó: "Por una vez no pasará nada, además, ya han pasado cinco años y no miraré hacia abajo, y siempre puedo llevar un compañero que me ayude, no hace falta desilusionar al padrino. Entonces, junto con un amigo, montó la antena en el techo del padrino.

Treinta horas después sucedió lo siguiente: tras sólo tres horas de sueño, hacia la una de la madrugada, se fue en coche de vacaciones con la novia, a pesar de las advertencias de la madre. Sin embargo sólo consiguió llegar al país vecino, porque tuvo un ataque epiléptico tras la recaída del conflicto de caída del poste telefónico. Perdió la consciencia y se dio contra un muro. Por lo tanto habíamos "calculado" correctamente y el paciente lo sabía cuando, ya en el hospital, una vez que le volvió la consciencia, reconstruyó lo acaecido. Había sido una prueba ejemplar de su trasgresión.

El hecho de que habíamos indagado correctamente los conflictos fue confirmado también un poco más tarde, cuando el joven con un videofilm ilustró a otra paciente su caso y su recaída: ante la telecámara funcionando tuvo una crisis epiléptica que comenzó con calambres del brazo derecho y de la pierna derecha.

Cuando al final de la crisis volvió en si mismo, sus primeras palabras fueron: "Ves, A., ¿no es esta la prueba definitiva de que la Nueva Medicina tiene razón?".

Este caso es muy interesante porque muestra como se puede superar sin grandes problemas, tal y como debería ser, un "tumor cerebral inoperable" y aquello que no se debe hacer, incluso después de cinco años. Es cierto que existe la posibilidad de la denominada "de sensibilización del conflicto", según el dicho "tras el accidente, rápido al volante". Pero eso sólo funciona en poquísimos casos excepcionales. Por lo general tenemos el problema de que no se pueden evitar los conflictos porque el paciente no consigue salir del ambiente en el que vive.

Por eso nosotros, los de la Nueva Medicina, somos muy prudentes también con los pronósticos, aunque la mayor parte de los pacientes consiga sobrevivir. Y los pronósticos sólo pueden ser buenos en la medida en la que el paciente ha entendido realmente los mecanismos de la Nueva Medicina, y aun así...